

中医精髓图解

汤泰元 主编

科学出版社

周易、符咒、中医交流群，免费资料分享群加微mqsnq55522

《中医精髓图解》编委会名单

主 编：汤泰元

审 阅：杨友信

撰 编：刘承权 陈灼华 南东求 汪 翔 洪文刚 周怡新
周顺心 江伏龙 王兴旺 柴良晖 杨晓华 杨幼华
宋 伟 张文俊 肖志林 汤立婷 汤 铭 汤泰元

绘图与设计：汤泰元

序

中国医学理论,是中国灿烂文化的重要组成部分。它古老而深奥,充满了哲理;在历史长河中,为炎黄子孙的却病延年、永葆青春作出过巨大的贡献;迄今,仍与千家万户的保健康复紧密相关。由于其学理文辞古奥,概念复杂,为后人的理解和继承带来了困难,给西医学习、研究、掌握带来了困惑,更为在世界上传播带来了障碍。对此,我感触颇深。几年前,我在国外指导和推广中医诊治工作时,依照中医的原貌,用形象的比喻、通俗的语言把阴阳五行、脏腑经络、气血津液等理论介绍给西方的同道。由于语言、思维方式等多方面的原因,人家就是听不懂,无法理解和接受。言谈中流露:承认其疗效,不理解其理论。因此,用现代医学术语和中西医结合的道理阐明中医学,是一项必要的、很有意义的工作,它有利于把中医学推广到世界各地。

汤君泰元等,在繁忙的教学工作中,抽出时间著成《中医精髓图解》一书,读后令人耳目一新。本书以中医基础理论为主线,吸取和融汇西医现代科学知识和技术,把“理趣幽深,难于穷究”的中医著述中的隐语、哲理、术语,用现代语言破译其内涵,并配以生动有趣、构思新颖的图解以启迪读者思路,引起读者联想,使形象思维与逻辑思维并举,集科学性、实用性、趣味性于一体,真乃巧妙之构思也。此举无疑给世人研习中医、发扬中医提供了极大的方便。同时,作者独辟蹊径,以图说形式,表述中西医理论上的结合也是首创。我认为这部书的出版,对进一步促进中西医结合和中医现代化具有现实的意义。清代著名温病学家王孟英说:“若能穷理有据,则不论何人言之,皆当信之。”我想:凡是有兴趣学习、研究中医的学者及中医药爱好者都是欢迎它的问世的。故乐以为之作序。

杨友信

1996年5月

于《大众中医药》杂志社

目 录

序	(i)
前言	(1)
第一章 阴阳五行学说	(2)
第一节 阴阳学说概述	(2)
第二节 阴阳学说在医学中的应用	(4)
第三节 五行学说	(6)
第二章 脏腑学说	(8)
第一节 五脏	(8)
一、心	(8)
二、肝	(10)
三、脾	(12)
四、肺	(14)
五、肾	(16)
六、心包与命门	(26)
第二节 六腑	(28)
一、胆	(28)
二、胃	(30)
三、小肠	(32)
四、大肠	(34)
五、膀胱	(36)
六、三焦	(38)
第三节 奇恒之腑	(40)
一、脑	(40)
二、髓	(42)
三、脉与脉管系	(44)
四、女子胞与子宫系	(106)
第四节 脏腑相关生理	(48)
一、五脏间的相互关系	(48)
二、五脏与六腑间的相互关系	(50)
三、六腑间的相互关系	(52)
第三章 精、神、气、血、津液	(54)
第一节 精、神	(54)
第二节 气、血	(56)
第三节 津液	(58)

第四节 精、神、气、血、津液的关系	(60)
第四章 经络学说	(62)
第一节 手三阴	(62)
一、手太阴肺经	(62)
二、手厥阴心包经	(62)
三、手少阴心经	(62)
第二节 手三阳	(64)
一、手阳明大肠经	(64)
二、手少阳三焦经	(64)
三、手太阳小肠经	(64)
第三节 足三阴	(66)
一、足太阴脾经	(66)
二、足厥阴肝经	(66)
三、足少阴肾经	(66)
第四节 足三阳	(68)
一、足阳明胃经	(68)
二、足少阳胆经	(68)
三、足太阳膀胱经	(68)
第五节 督脉、任脉、冲脉、带脉	(70)
一、督脉	(70)
二、任脉	(70)
三、冲脉	(70)
四、带脉	(70)
第五章 四诊方法	(72)
第一节 望诊	(72)
第二节 闻诊	(74)
第三节 问诊	(76)
第四节 切诊	(78)
一、脉诊	(78)
二、按诊	(80)
第六章 病因辨证	(82)
第一节 六淫	(82)
一、风邪	(82)
二、寒邪	(82)
三、暑邪	(84)
四、湿邪	(84)
五、燥邪	(86)
六、火邪	(86)
第二节 七情	(88)

第三节	饮食、劳逸·····	(90)
第四节	疫疔·····	(92)
第五节	外伤和虫兽所伤·····	(94)
第六节	痰饮·····	(96)
第七节	瘀血·····	(98)
第七章	八纲辨证·····	(100)
第一节	表证与里证·····	(100)
第二节	寒证与热证·····	(102)
第三节	虚证与实证·····	(104)
第四节	阴证与阳证·····	(106)
第八章	气血津液辨证·····	(108)
第一节	气病的辨证·····	(108)
第二节	血病的辨证·····	(110)
第三节	气血同病的辨证·····	(112)
第四节	津液病辨证·····	(114)
一、	津液不足、常见痰证·····	(114)
二、	常见饮证·····	(116)
第九章	脏腑辨证·····	(118)
第一节	心病辨证·····	(118)
一、	虚证·····	(118)
二、	实证·····	(120)
第二节	小肠病辨证·····	(124)
第三节	肝胆病辨证·····	(126)
一、	虚证·····	(126)
二、	实证·····	(128)
第四节	脾病辨证·····	(134)
第五节	胃病辨证·····	(138)
第六节	肺病辨证·····	(140)
一、	虚证·····	(140)
二、	实证·····	(142)
第七节	大肠病辨证·····	(144)
第八节	肾病辨证·····	(146)
第九节	膀胱病辨证·····	(152)
第十章	六经辨证·····	(154)
第一节	三阳阶段·····	(154)
第二节	三阴阶段·····	(156)
第十一章	卫气营血辨证·····	(158)
第一节	卫分证、气分证·····	(158)
第二节	营分证、血分证·····	(160)

第十二章 三焦辨证·····	(162)
第十三章 预防与治则·····	(164)
第一节 未病先防·····	(164)
第二节 治则·····	(166)
一、治病求本、因时因地、因人制宜·····	(166)
二、同病异治、异病同治、正治与反治·····	(168)
第三节 常用治法·····	(170)
一、解表法·····	(170)
二、清热法·····	(172)
三、泻下法·····	(174)
四、消散法·····	(176)
五、和解法·····	(178)
六、温里法·····	(180)
七、补益法·····	(182)
八、固涩法·····	(184)
九、理气法·····	(186)
十、利尿法·····	(188)
十一、开窍法·····	(190)
十二、重镇摄纳法·····	(192)

周易、符咒、中医交流群
免费资料分享群扫码加微



武道大师
南极洲



前 言

中医基础理论是以脏腑、经络为核心的独特理论体系,是中华灿烂文化的组成部分。在几千年中华民族繁衍昌盛中作出过巨大贡献,并将在今后世界医学的发展上发挥巨大的作用。

中国医学理论,古老而深奥,充满了哲理,为后人学习、理解带来了困难;给广大西医学习、研究、掌握带来了困惑;更为世界传播带来了障碍。为继承、发扬中医学伟大遗产,我们编著了这本图说。

图说以中医基础理论为主线,而书名之所以加上“精髓”两字,是从中西医学发展史的启迪而来的。西方医学在文艺复兴之后,随着自然科学的突飞猛进,很自然地哲学的范畴中脱颖而出,与现代的科学相结合。这种结合使西医的理论,由神秘、笼统、模糊和臆测走向了具体、清晰、客观和真实。她用科学实验代替了哲学思辨,以新的技术和理论不断地更新、充实整个医疗体系,使西医充满了活力,与时代息息相关。而中医理论至今仍“承袭”《内经》、《伤寒》等经典模式,医学观点和研究方法没有根本性的突破。含糊、笼统的术语和医古文必须借助《辞典》才能领会或理解——连国人都不能理解,西医都“望而生畏”,如何走出国门、走向世界?因此,我们只选用中医理论“精髓”部分,用现代科学的知识和理论,来寻找或解释中西融通的契机,架起彼此相通的桥梁,为中医现代化做点实际工作,则是编纂此书的主旨。

本书分十三章,以目录所载内容编排。共有 16 开图 96 幅,以一看就懂的图面将繁锁复杂的文字描述,用形象生动、内涵丰富的图形来表述。每一对页,右面为图,左面为文字说明。文字说明,力求“西为中用”,通俗易懂,重点突出,以供大中专医学院校师生和各级医院医护人员(尤其是西学中人员)及中医学爱好者参考使用。

本书在编纂过程中,得到了《大众中医药》杂志社主编杨友信教授的支持和指导。谨此致谢!

由于水平有限,不妥和错误在所难免,希望本书能起抛砖引玉的作用,激发中西医同道更多的思考、探索、研究和实践,踏出一条中西结合的康庄大道,让中医药的宝贵财富为全人类造福。

汤泰元

1996 年 5 月

第一章 阴阳五行学说

第一节 阴阳学说概述

〔简介〕

阴阳是中国古代哲学思想,是古人用以观察和解释自然现象的一对基本概念。阴阳概念渊源久远。《易传》即提出“一阴一阳之谓道”的哲学论断。把阴阳交替看作宇宙的根本规律,表达了任何事物都包含阴阳对立的两个方面。如自然界的昼和夜、热与寒、动和静、外与内、上和下等等。所有相互对立的阴阳,又是相互依存的:上为阳,下为阴,没有上,就无所谓下;左为阳,右为阴,没有右就无所谓左。所以《老子》中概括为“万物负阴而抱阳”。春秋战国时期,被运用于对人体和疾病的研究,赋予了医学的内容,形成了一套比较系统的理论思想。阴阳学说是中国医学的基础理论之一。

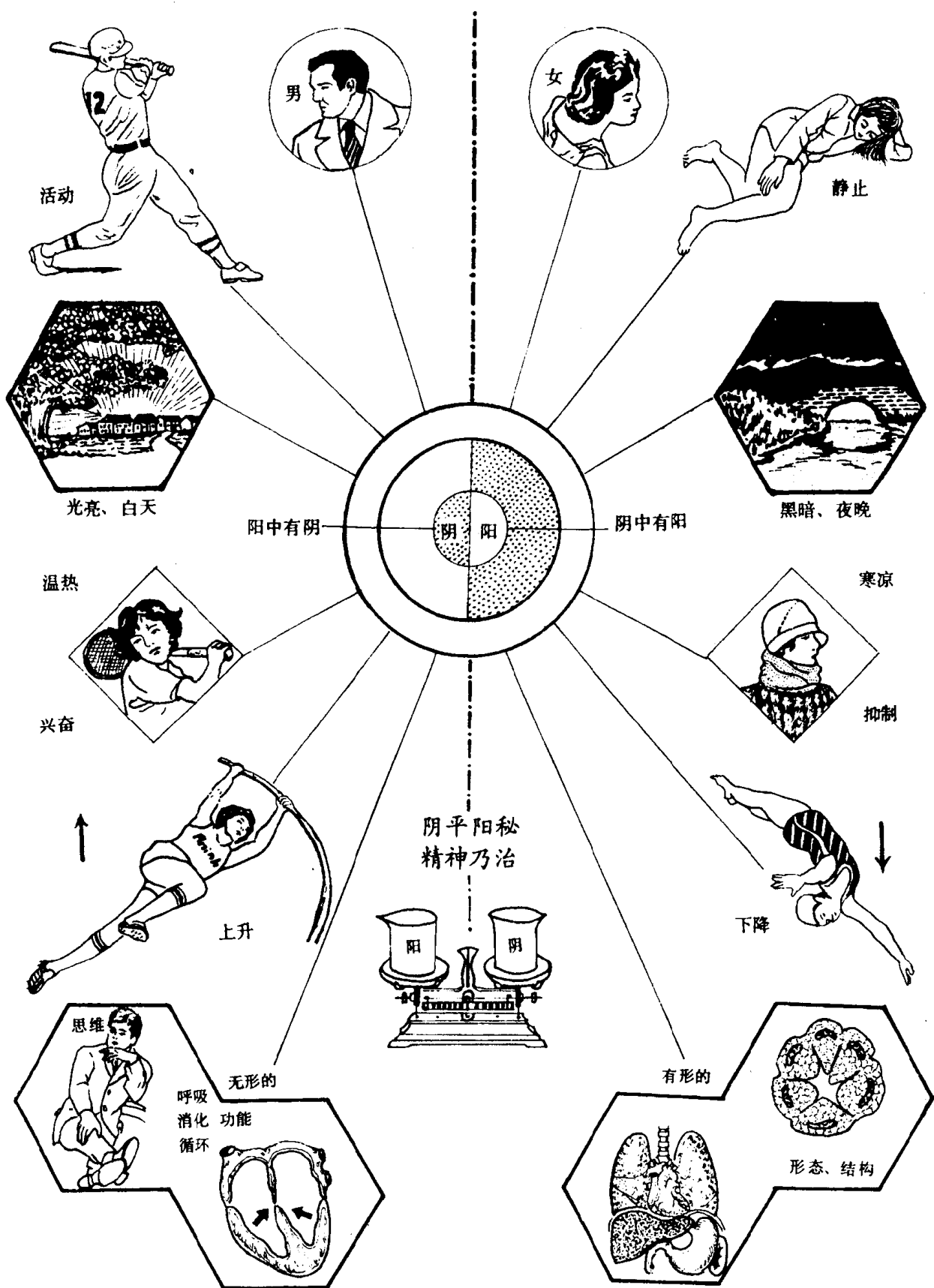
〔基本内容〕

1. 认为阴阳是客观世界、也是人体和疾病的基本规律,主张“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也。治病必求于本。”(《素问·阴阳应象大论》)。认为疾病发生的根本的原因是阴阳失调。任何病症,不论其临床表现如何错综复杂、千变万化,都可用“阴证”和“阳证”来加以概括。中医的“八纲辨证”是各种辨证的纲领,而阴阳是总纲,以统领表里、寒热、虚实。表、热、实属阳,里、寒、虚属阴。提出要做到正确诊断,首先要分清阴阳。疾病的发生发展根本原因是阴阳平衡的失调,疾病的治疗原则是调整阴阳,补偏救弊,促进阴阳秘,恢复阴阳相对平衡。阴阳也用来概括药物的性味功能,作为指导临床用药的依据:药味辛、甘、淡的,药性温热、燥烈及具有升散作用的药物属阳;药味酸、苦、咸,具寒凉、滋润及敛降作用的药物属阴。根据病情的阴阳偏盛偏衰,确定治疗方案,再结合药物的阴阳属性、作用,选择使用相应的药物,这就是“治病必求于本”的含意。

2. 认为在人体和疾病中,阴阳两个方面相互对立,相互制约,相互斗争。人体的组织结构、生理功能都以阴阳对立的属性来说明:人体的外部、上部、背部为阳,内部、下部、腹部为阴;六腑为阳,五脏为阴;各种功能为阳,器质为阴。功能(阳)与物质(阴)保持对立而统一的协调关系。一旦阴阳失去相对平衡,疾病如是发生。倘若“阴阳离决,精气乃绝”,泰国的变性人可以说明这条哲理。泰国一些男人由于谋生或性变态的需要,年幼即去日本做变性手术,割去男性的“根”,做了人工阴道,通过大量服用女性激素和长期的训练,变成了五官、身段胜似女性的美貌人妖。这种人为破坏阴阳平衡,导致了内分泌的严重紊乱,这些人妖的寿命一般都不超过40岁。

3. 认为阴阳是依存互根、消长、转化的。阴阳总是处于“阳消阴长”或“阴消阳长”的变化之中。在一定条件下,阳可以转化为阴,阴可以转化为阳。阴阳的这种转化消长运动是人体本身所固有的。它既可使阴阳失调,发生疾病,也可调节阴阳,使其恢复动态平衡,因而是把握病机的基本环节。大叶性肺炎的临床表现,中医归纳为阳证、热证、实证,要用寒凉(清热解毒)的药物来治疗。当热毒极重,大量耗伤机体正气时,阳气随津液外泄而亡脱,可突然出现面色苍白、四肢厥冷、脉微欲绝、血压下降等休克征象,中医称由阳转阴,实热转化为虚寒证,此时需急用温热药物来“回阳救逆”。

中医的阴阳学说含有朴素的唯物论和自发的辩证法思想,在观点和方法上对中医理论和临床实践,起到了一定的指导作用。但由于历史条件的限制,在理论上没有将哲学范畴和病理、生理范畴区别开来,以自然哲学抽象的物质观来解释生命的奥秘,说明和分析疾病的病因、病机、病理和药物,从时代的要求来说则显得“古老深奥”,急待现代研究,并加以整理和提高。



阴阳学说

第二节 阴阳学说在医学中的应用

〔在组织结构上的应用〕

阴阳学说在阐述、解释人体组织结构时,认为人体是一个有机的整体。构成人体的各个组成部分之间,在结构上是不可分割的,在功能上是相互协调、相互影响的。应用阴阳相互对立的属性,又可将人体划分为阴阳两个部分,如人体的上部为阳、下部为阴;体表为阳、体内为阴;外侧为阳、内侧为阴;背部为阳、腹部为阴;六腑为阳、五脏为阴。五脏之中又分阴阳,心、肺在上属阳,肝、脾、肾、在下属阴。具体到一个脏腑,又有阴阳之分,如心有心阴、心阳;肾有肾阴、肾阳等等。总之“人之有形,不离阴阳。”

〔在生理、病理、临床上的应用〕

1. 人体的结构和功能十分复杂。现代医学在研究人体生命活动的规律时,通常从三个层次来进行,即① 细胞或分子水平;② 器官、系统水平;③ 整体水平。近来由于科学的飞跃发展,从更微观的结构(即电子水平)来解释生命现象和研究生命进程。鉴于历史的原因,中医对生理方面研究尚停留于整体水平上解释,即一切的组织结构、物质基础为阴,所有的功能活动为阳;血为阴,气为阳。在功能活动中,又分阴阳:抑制、衰退为阴,兴奋、亢进为阳。在气中也分阴阳:卫气在外为阳,营气在内为阴。

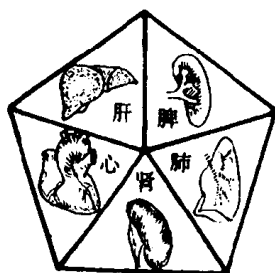
2. 中医认为疾病的发生,无非是阴阳任何一方偏盛或偏衰的结果:阳偏胜而阴伤,就会产生热症;阴偏胜而阳伤,则出现寒证。阴虚(如精血不足)不能制阳,则出现阴虚阳亢(肝阳上亢)的虚热证;阳虚(如心、肾阳衰)不能制阴,则出现阳虚阴盛的虚寒证。这就是“阳胜则热”、“阴胜则寒”、“阳虚生外寒”、“阴虚生内热”的概括。

3. 根据阴阳互根的道理,当阴阳任何一方虚损到一定程度,常可导致对方的不足,如功能活动的衰减造成营养物质生化不足称“阳损及阴”。治疗气虚、阳虚时,不仅要用补阳、补气药,还常加用补益精血药物。而营养物质消耗过多,则会出现功能活动衰减,即所谓“阴损及阳”。如治疗血虚时,除应用补血药物外常配合补气药。临床上某些慢性疾病,最后往往出现阴阳俱虚,就是这个缘故。

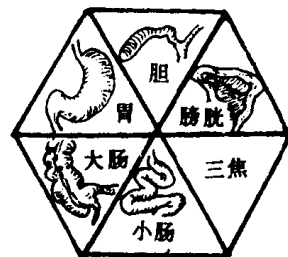
4. 中医提出“凡诊病施治,必须先审阴阳”,认为不论病证如何复杂,只要分清阴阳就能执简驭繁,抓住疾病的本质。如望诊见色泽鲜明者属阳,晦暗者属阴;闻诊声音洪亮者为阳,低微断续者属阴;切诊脉浮、数、大、滑、实者属阳,脉沉、迟、小、涩、虚者属阴。

5. 阴阳用于疾病的治疗:阳热过盛的,用寒凉药物治其热;阴寒过盛的,可用温热药物以治其寒,简称为“寒者热之,热者寒之”。阳气偏衰不能制阴而引起的阴盛,则以“助阳以消阴”之法,阴虚不能潜阳而所致阳亢,则取以滋阴以抑阳的方法,这就是“阳病治阴,阴病治阳”的原则。

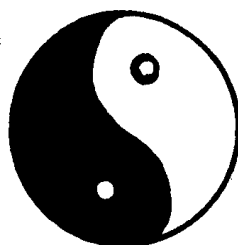
阴阳学说在生理、病理上的应用



五脏为阴



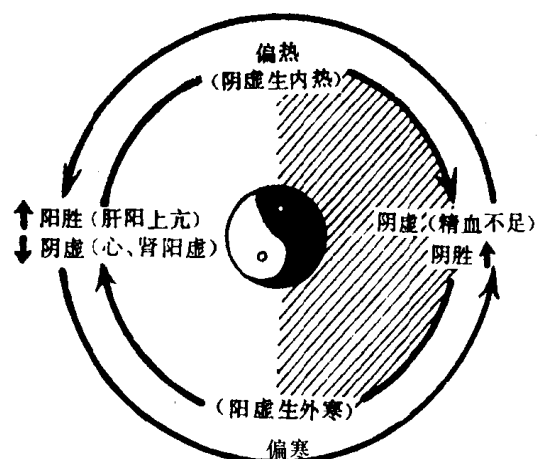
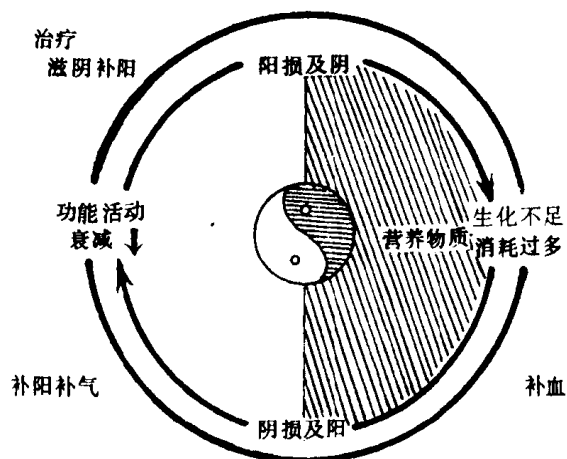
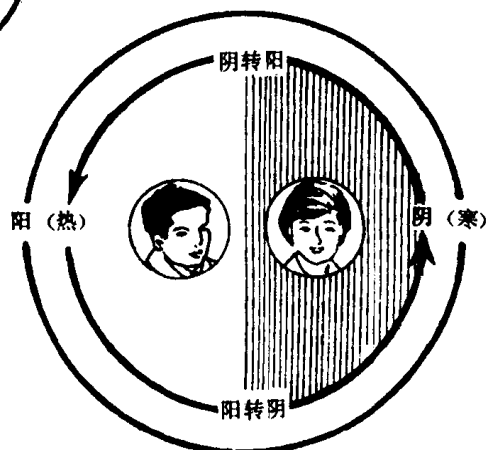
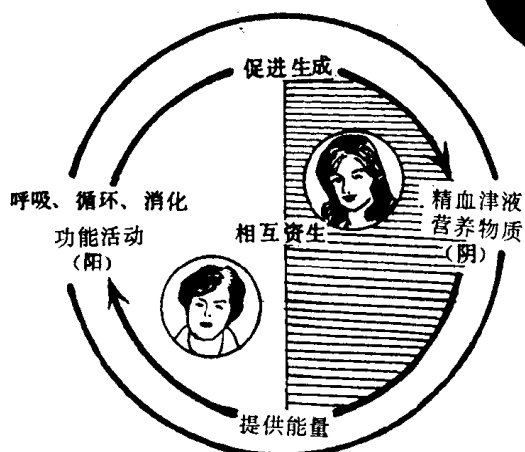
六腑为阳



气为阳



兴奋亢进为阳



第三节 五行学说

[简介]

五行是我国古代朴素唯物主义哲学的重要范畴,指木、火、土、金、水五种物质。古人认为,世界是由这五种物质构成的。战国时代“五行”学说颇为流行,并推演出“五行相生相胜”的关系。“相生”意味着相互促进,如“木生火、火生土、土生金、金生水、水生木”等。“相胜”意即“相克”,意味着相互排斥,如“水胜火、火胜金、金胜木、木胜土、土胜水”等。这些观点具有朴素唯物论和自发辩证法的因素,对古代的天文、数学、医学发生过重大影响。

[基本内容]

古代医学家应用五行学说,对人体的脏腑组织,生理、病理现象,以及与人类生活相关的自然界事物,作了广泛的联系与研究,以五行属性来区别和解释脏腑的属性:

自然界				五行	人体				
五味	五色	五气	五季		五脏	六腑	五官	形体	情志
酸	青	风	春	木	肝	胆	目	筋	怒
苦	赤	暑	夏	火	心	小肠	舌	脉	喜
甘	黄	湿	长夏	土	脾	胃	口	肉	思
辛	白	燥	秋	金	肺	大肠	鼻	皮毛	悲
咸	黑	寒	冬	水	肾	膀胱	耳	骨	恐

相生、相克是事物运动和变化的规律。相克太过,中医称“相乘”。“乘”,即乘虚侵袭之意。相克的反向(反克),中医称“相侮”。“侮”者,恃强凌弱的意思,即本来是自己所能克胜的,却反被其克胜。中医用这些相生、相克、相乘、相侮的规律,来说明五脏之间在生理、病理情况下的相互关系。

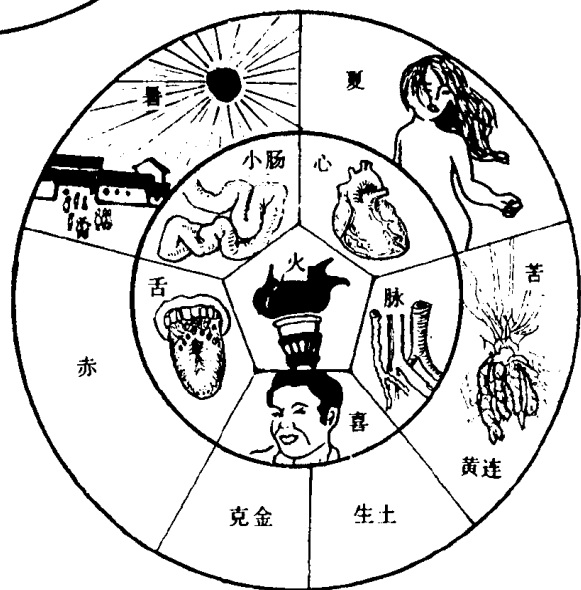
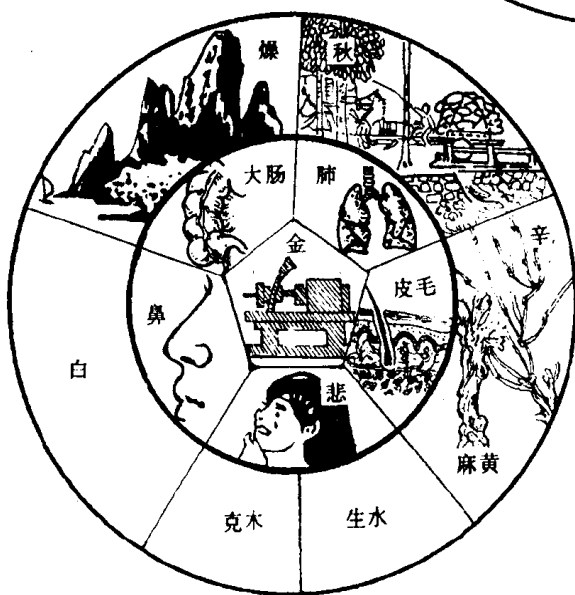
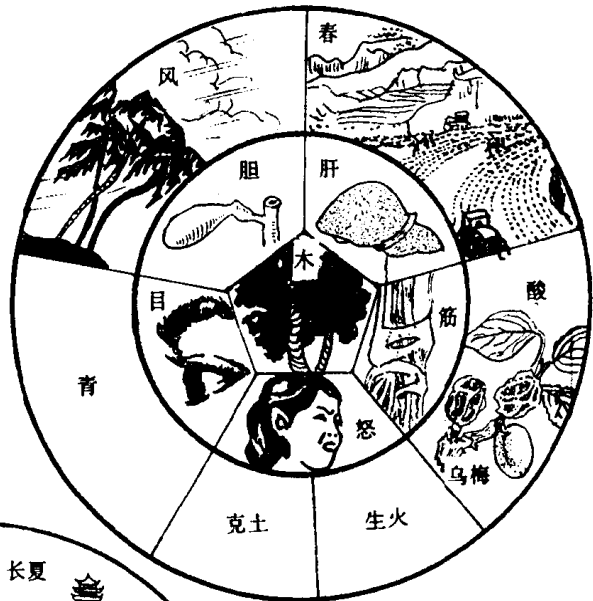
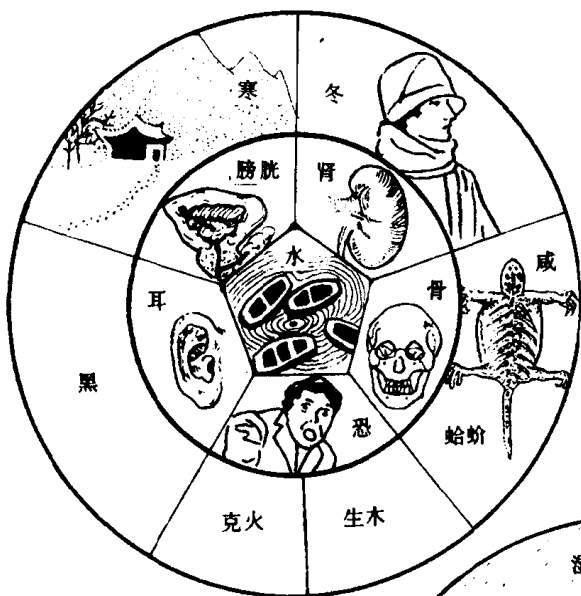
[在医学上的应用]

1. 以五行的特性说明五脏生理活动特点:如①肝喜条达,有疏泄的功能,木有生发的特性,故肝属木;②心阳有温煦的作用,火有阳热的特性,故心属火;③脾为生化之源,土有生化万物的特性,故脾属土;④肺气主肃降,金有肃收敛的特性,故肺属金;⑤肾有主水藏精的功能,水有润下的特点,故肾属水。五脏之间生理功能上的相互资生的关系为:①肾(水)之精以养肝;②肝(木)藏血以济心;③心(火)之热以温脾;④脾(土)化生水谷精微以充肺;⑤肺清肃下行以助肾水。相互制约的关系为:①肺(金)气清肃下降,可以抑制肝阳上亢;②肝(木)的条达,可以疏泄肺金的壅郁;③脾(土)的运化,可以制止肾水的泛滥;④肾(水)的滋润,可以防止心(火)的亢烈;⑤心(火)的阳热,可以制约肺(金)清肃太过。

2. 说明脏腑间的病理影响:如肝病可以传脾,即木乘土;脾病可以影响肝,是土侮木;肝脾同病,相互影响即木郁土虚或土壅木郁;肝病影响心,为母病及子,肝病影响肺,为木侮金;影响肾为子病及母等。

3. 用于诊断和治疗:临床诊断疾病时,可以综合望、闻、问、切四诊所知,根据五行的所属及生克乘侮的变化规律,来推断病情,指导治疗。例如滋水涵木、培土生金、壮水制火、扶土抑木等等,都是一些具体应用的体现。

五行学说



第二章 脏 腑 学 说

第一节 五 脏

一、心

[形态结构]

中医学对心脏的形态、位置早有描述,如“心为牡脏,其色赤”,“心象尖圆,形如莲蕊,“居肺管之下,膈膜之上”,“心之外体圆滑,内空如囊……中有直肌隔之,故有左房、右房之称。左右半截,又有横肉间之,故有上房下室之号。……中有门户,自能开合”。其记载与现代人体解剖学基本一致。具体说,心脏是一个运动的器官,色赤红,形似未开荷花倒置的圆锥体,位于两肺之间,气管交叉之下,膈肌之上。心脏内部被房中隔、室中隔及左右房室口而分为四腔:左右心房,左右心室。左房室口有二尖瓣;右房室口有三尖瓣。当心室收缩时,阻止血液逆流入房。在肺动脉口和主动脉口,分别有三个半月瓣组成的肺动脉瓣和主动脉瓣,在心室舒张时关闭以阻止血液逆流入室。

[生理功能]

(一) 心主血脉,其华在面 中医的“心”,称之为心系,实指西医的循环系统。如“心之系与五脏之系相连,输其气血”。它包括心脏、动脉、静脉和毛细血管等整个密闭的循环系统。“心主血脉”,指血液在心脏收缩的推动下,经动脉及其分支分布全身,借毛细血管联系五脏六腑,再由静脉回流心脏,如此周而复始。心脏是心系的中心动力器官,起唧筒和抽水机的作用。心气(指心脏收缩功能)推动血液在脉管内运行,循环不息。心气旺盛(心功能正常)、心血充足则脉搏充盈有力,面色红润光泽。心气不足,如心力衰竭、虚脱、休克、心肌梗塞时,由于有效循环血量减少,出现脉搏细沉、微弱,面色苍白无华。当血脉运行不畅、血液瘀滞如严重休克、心衰、心律失常(频繁早搏、房颤、房室传导阻滞)则出现面色青紫、脉象结代或弦涩。

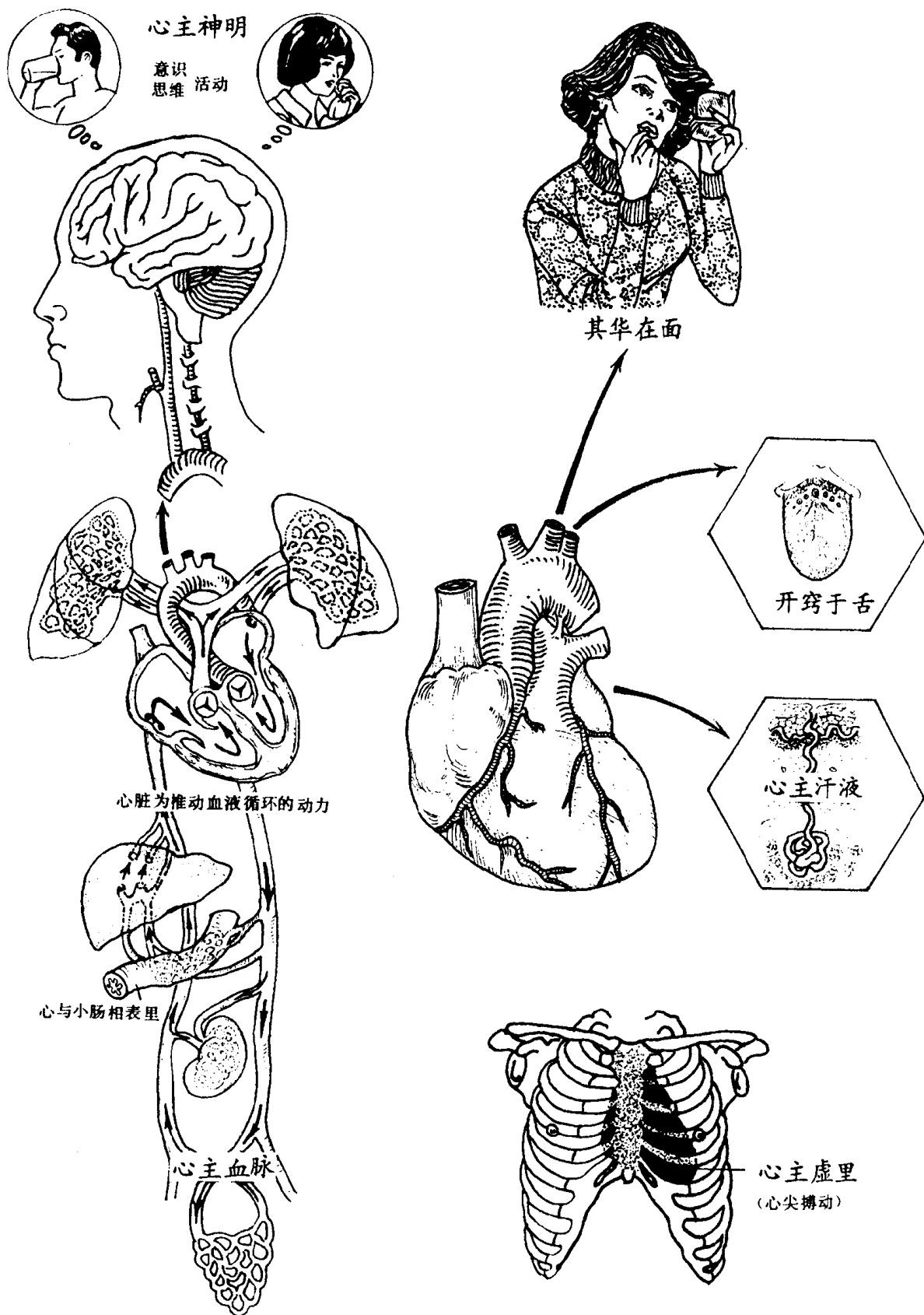
(二) 心主虚里 虚里脉实指心脏本身跳动,在左乳下心尖搏动处观察。心尖搏动是西医心脏望诊的重要内容,中医也极为重视,除望诊外还包括触诊。如正常人,“虚里脉按之应手,动而不紧,缓而不急”(意即搏动范围不大,搏动 60~100 次/分,节律一致)。在休克、心肌炎时,则“虚里脉动微不显,宗气内虚”(即心肌收缩力下降、搏动微弱)。若“动而应衣(隔衣可见)或节律紊乱(如各种心律失常)为宗气外泄之象。动而弹手,洪大搏指(相当西医主动脉瓣关闭不全、重症贫血、甲亢等脉压差大时)属危重症候,虚里脉绝(心跳停止)宗气绝也,必死。”

(三) 心主神明 神明,即神志意识(知觉、情感、思维、意志)等精神活动,属西医大脑功能。中医认为人的精神活动一刻也离不开血液的需要,只要心血充足,濡养脑髓才能有精神意识、思维活动。这完全符合现代医学理论:脑细胞对缺氧极为敏感,大脑血氧供应不足(不论属于哪种类型缺氧)均将导致脑的功能和代谢改变,甚至出现形态结构发生异常。轻度脑供氧不足(中医所指心血不足)即可出现心悸、失眠、多梦、健忘、思维迟纯、精神萎靡等类似神经衰弱的症候。若心血衰少或运行阻滞(如心源性脑缺血发作、严重休克、心衰、栓塞、血栓形成、一氧化碳中毒等)可出现健忘、不省人事、昏迷等症状。

(四) 心开窍于舌 中医认为舌为心之外候。心的病症往往可从舌的活动、颜色上反映出来。如血虚(各种原因贫血)时舌质淡白;血热(各种热性病)时舌质红绛;心火上炎则舌尖红赤或舌体糜烂;血瘀内阻(如心力衰竭、出血性疾病)时则舌质紫暗或出现瘀点瘀斑;热入心包或痰迷心窍(如脑血栓形成、中暑)则舌蹇、语言不畅等。

(五) 心主汗 汗在现代医学中是调节体温的组织,受下丘脑和植物神经控制。中医的“汗乃心之液”乃隐语,指汗与精神紧张和血管扩张相一致,完全符合现代科学理论。人体皮肤有 250 万个汗腺,受交感神经支配,当血液及皮肤温度升高、精神高度紧张时,会反射地作用于下丘脑中枢,引起汗腺分泌增强,汗液蒸发,散热增加。出汗过多会引起血容量减少,这就是中医的“血汗同源”。血虚津亏的病人不能用汗法。出汗过多的病人,也不宜用耗血药物,这是中医临床的治疗原则之一。

心



二、肝

〔形态结构〕

肝是人体最大的实质性器官,在人的生命活动中占有十分重要的地位,是体内物质的代谢、解毒、分泌胆汁的重要脏器。中医学对肝的形态、位置早有记载。《类经图翼》说:“肝者……其脏在右肋、右肾之前,并胃、着脊之节九椎。”《难经集注》曰:“肝者,据大叶言之,则是两叶也,若以小叶言之,则多叶矣。”其描述与解剖学记载基本一致。说明肝位于膈下,借镰状韧带分成大的肝右叶和小的肝左叶。整个肝脏由约 50 万个肝小叶所组成。肝的大部分位于右季肋(右肋)部。

〔生理功能〕

(一) 肝藏血 现代医学的肝不藏血,而脾是贮血器官,整个静脉系统也是一个大的储血池(尤其是腹腔内静脉),在正常情况下占全身血容量的 50%~70%。肝脏的血液供应 3/4 来自门静脉,1/4 来自肝动脉。门静脉由肠系膜上、下静脉和脾静脉所组成。这些静脉均分布有肾上腺素能 α, β 受体,当交感神经兴奋(较剧烈活动或运动)时,脾和肠系膜静脉收缩,血液经肝流至全身。当处于休息或睡眠时,这些血管扩张而贮血,故《素问·五脏生成篇》说:“肝藏血,心行之,人动则血运行诸经,人静则血归肝脏,肝主血海也。”从上述解剖关系推论“肝藏血”符合现代医学逻辑。同时也包括了神经、体液对血液调节的功能。

(二) 肝主疏泄 根据西医对肝脏功能的研究,结合中医学对肝的论述,疏泄包括:

1. 舒畅情志:情志即人的精神、意识、思维、知觉、运动等属于脑的功能,中医学认为与肝有关。从肝性脑病的发病机理、临床表现来认识这一论述,说明古代医学家对严重肝病时会出现情绪、行为、知觉等障碍已有极深刻的认识。严重肝细胞损害,对肠道吸收或体内产生毒物的解毒能力下降、毒物进入体循环并作用于神经系统会出现欣快、急躁、抑郁、沉默、智力减退、动作不灵等性格改变,还产生语无伦次、衣冠不整、无原因哭闹、吵叫甚至震颤、昏睡、昏迷等行为、神志异常。肝脏解毒功能失常中医称“疏泄失常”、“肝气郁结”、“气机不调”。

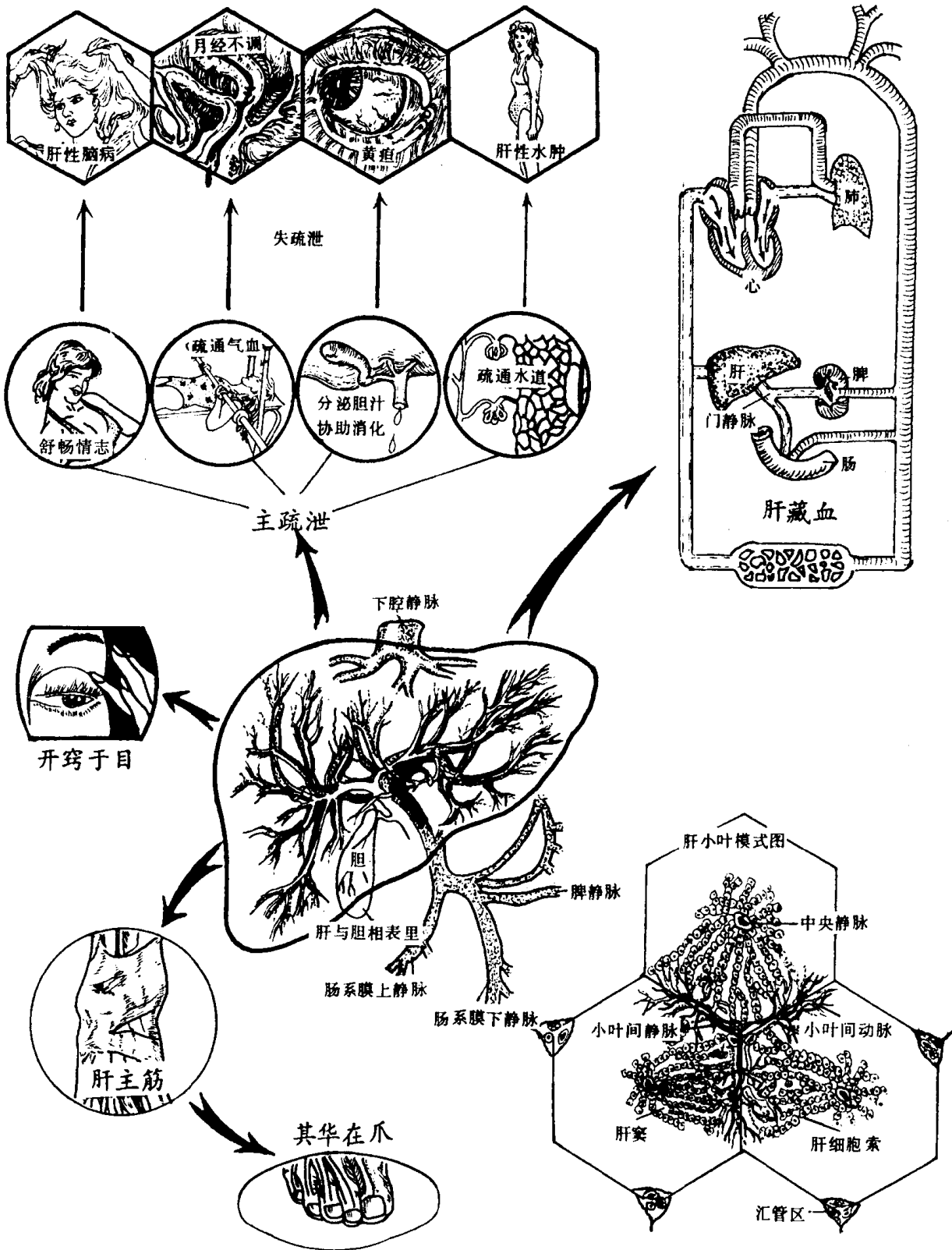
2. 疏通气血和水道:身体各种激素的生成与灭活处于相对平衡状态之中,激素的过多或不足可引起体内物质代谢的紊乱。多种激素的灭活,主要在肝脏内进行:如雌性激素、雄性激素、醛固酮、糖皮质激素、抗利尿激素等。当患肝脏疾病时,由于肝脏对激素灭活能力降低或其他因素可使某些激素在体内堆积。如雌性激素在体内过多时,女性可引起月经失调(功能性子宫出血、闭经、痛经、经前期紧张征、更年期综合征;男性引起乳房发育、睾丸萎缩以及肝掌、蜘蛛痣,中医学认为系“气滞血瘀”。醛固酮、抗利尿激素在体内堆积,引起水、钠潴留,出现腹水、水肿、小便少,中医认为系“气滞水停”。所以《血证论》说:“肝属木,木气冲和条达,不致遏郁,则血脉得畅。”元代医家朱丹溪说:“气行则水行,气滞则水停。”即此道理。

3. 分泌胆汁协助消化:胆汁由肝细胞生成经肝管总胆管而流至十二指肠(或经胆囊管贮于胆囊)。胆汁成分复杂,其中的胆盐既可使肠道脂肪乳化,又能激活胰脂肪酶,促使脂肪及脂溶性维生素(A,D,E,K)消化和吸收。胆汁又是肝脏排泄某些药物或毒物的通道之一,肝脏病变或胆道炎症、阻塞都会出现一系列消化道症状,甚至黄疸,中医称“横逆犯脾及胃”。

(三) 肝开窍于目 《灵枢·脉度篇》说:“肝气通于目,肝和则能辨五色矣。”精辟地说明肝与视网膜锥细胞和杆细胞的感光色素有关。现代医学证明视网膜上各种感光色素均由维生素 A 醛和视蛋白结合而成。维生素 A 属脂溶性维生素,其吸收与胆汁的胆盐有关,肝脏又是维生素 A 的代谢和贮存器官。同时,又是蛋白质合成的主要场所,肝合成蛋白质减少,必然影响视黄醇转运蛋白和视蛋白合成,肝的上述功能减退都将出现维生素 A 的缺乏症状,如暗适应时间延长、夜盲症,全身上皮组织角质变性;干眼症,角膜穿孔,指甲多纹,易折裂,毛发干枯。

(四) 肝主筋,其华在爪 筋是肌腱、关节韧带的俗称,肝主筋与肝为“物质代谢中枢”有关,现代医学已证实无论是消化道吸收的营养物质,或是体内贮存的其他物质,均通过肝脏加工合成,产生各种生理上的重要物质,并及时供给身体各部分需要,这些物质即中医之“肝血”。因之“肝血”的盛衰必然反映于肌腱、韧带、指甲的状态:肝血足,则筋强力壮,爪甲坚韧;肝血虚,则筋弱无力,爪甲薄枯易脆。

肝



三、脾

〔形态结构〕

《难经正义·四十二难》说：“脾居胃旁，形长方而扁软。……位在左胁下，与胃脂膜相连。……胰，附脾之物，形长方，横贴胃后。”《全体新论疏证》中说：此物（指胰）似脂非脂，似肉非肉，在吾国医籍，诚无其名。盖古人以其与脾脏联属，因而统之以脾”。上述文献说明，中医学的“脾”是现代医学脾和胰的合称，而其生理、病理又远非脾、胰所能概括。

现代医学的脾是人体最大的淋巴器官，由淋巴组织、大量血窦和各种血细胞所组成。新鲜脾切片，可见许多白色小点称白髓，是由淋巴细胞密集而成。其余红色部分称红髓，由脾窦和脾索构成。脾的功能有：①脾窦是个血库，可贮存和调节血量；②脾的淋巴组织具有造血功能，可产生淋巴细胞，参与人体免疫机能；③脾的网状细胞和窦内皮细胞具有吞噬功能（能吞噬血中异物、细菌、衰老红细胞）和过滤血液的作用。②和③中医精辟地概括为“脾之为卫”、“内伤脾胃，百病由生。”

胰是人体重要的消化腺，又是内分泌腺。外分泌部占大部分，由腺泡和排泄管组成，所分泌的胰液含淀粉酶、胰蛋白酶和脂酶，具有分解糖、蛋白质、脂肪的消化功能。内分泌部为散在腺泡之间的细胞团索，叫胰岛，有两种细胞：甲细胞分泌胰高血糖素，能促进糖原分解，使血糖升高。乙细胞最多，分泌胰岛素，有促进糖原合成、降低血糖的作用。

〔生理功能〕

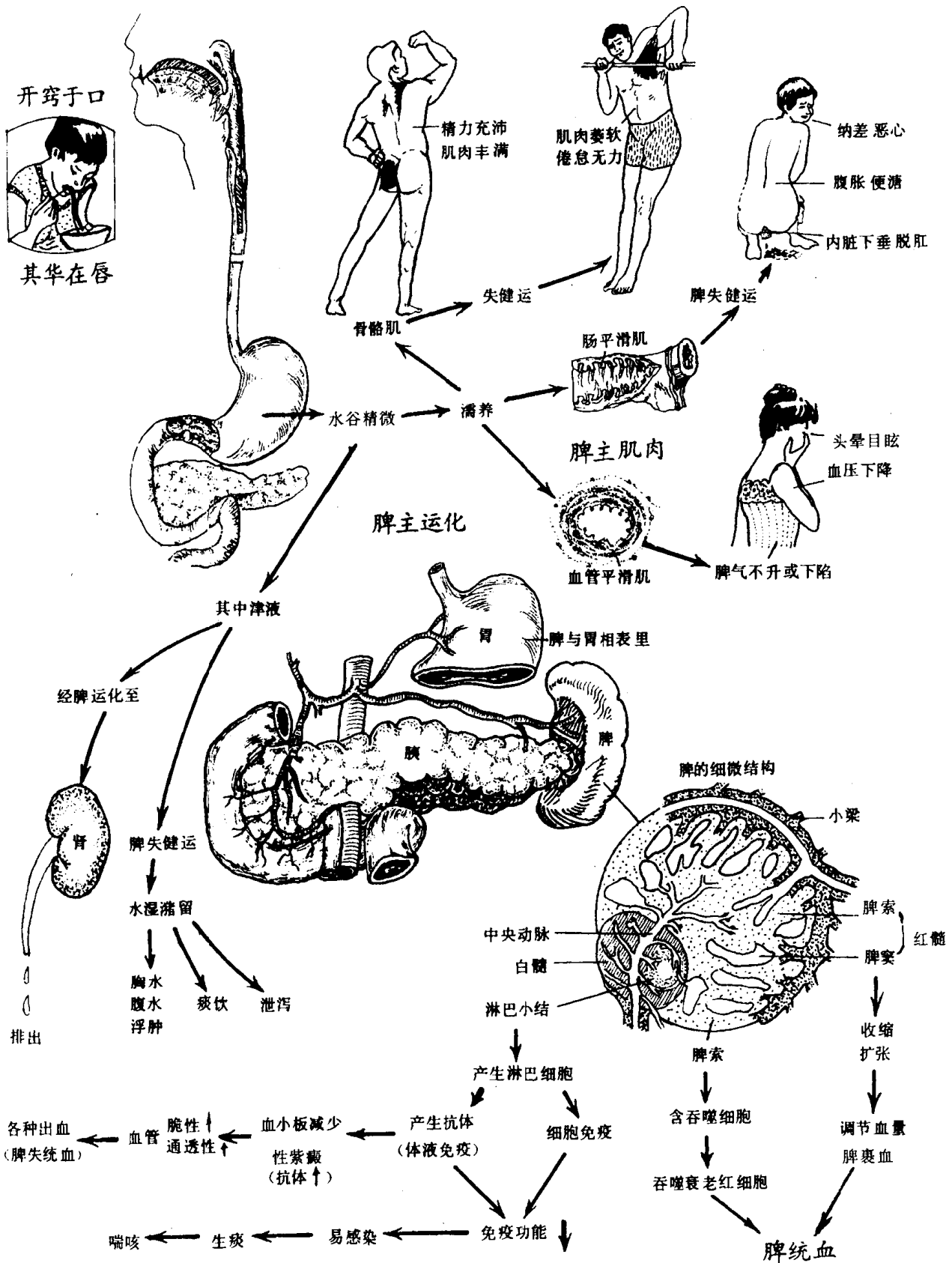
（一）脾主运化 食物在消化道内分解的过程称为消化。消化后营养物质透过管壁进入血液循环的过程称吸收。脾主运化含意有二：①概念上指上述消化、吸收的全过程。吸收的营养物质被称之为“水谷精微”，是人类从事劳动、维持体温的能量来源，并为生长、发育、生殖提供新建和重建的原料，以及生成“气、血”的主要物质基础。所以中医学认为“脾为后天之本”和“气血生化之源”。②运化水湿，参与水的转运和排泄；水和无机盐可直接经肠壁吸收进入血液循环供组织细胞利用，多余的部分经肾排出。水和电解质的摄入和排出受神经—内分泌的调节，这一调节相当复杂，时时处于变化之中，而又始终保持着一定的动态平衡，中医学归于“脾主运化”功能。因之，水、电解质平衡紊乱所致的浮肿，胸、腹水，痰饮，泄泻等，“诸湿肿满，皆属于脾。”

肠道和血管平滑肌受水谷精微的濡养，其管壁张力和收缩状态受副交感神经的调节、控制。副交感神经功能偏亢，则肠管分泌增加，蠕动增强引起肠鸣、腹痛、腹泻。内脏血管平滑肌扩张，使回心血量减少，则出现头晕、目眩、血压下降。副交感神经功能偏低时，则肠管张力低下，分泌液减少，肠蠕动减弱，临床出现纳差、腹胀、内脏下垂、脱肛。上述种种表现，中医统称“脾失健运”。

（二）脾主肌肉、开窍于口、其荣在唇 《素问集注·五脏生成篇》注解：“脾乃仓稟（米仓之意）之官，主运化水谷之精，生养肌肉；脾开窍于口，故荣在唇。”脾的运化功能强健，输送营养充足，则肌肉丰满、轻劲有力、知饥欲食、口唇红润光泽；反之，则肌肉消瘦乏力、不思饮食、口淡无味、唇色淡白或萎黄不泽。

（三）脾主统血 统，是统摄、控制之意。现代医学理解如下：①脾在胚胎期是主要造血器官，在胚胎4个月后骨髓才取而代之，但脾终身保持造淋巴细胞的功能。出生后，在某些病理情况下，又可恢复造血功能。②脾是衰老红细胞和血小板的主要破坏场所。脾的功能正常是维持红细胞、血小板正常值的重要环节。血小板是保持血管内皮完整性、促进止血和凝血作用的重要血液成分。当脾功能亢进或淋巴细胞产生抗血小板抗体（如血小板减少性紫癜、系统性红斑狼疮）时，血小板数量、质量减少，临床上则出现皮肤、粘膜瘀斑、鼻衄、龈血、月经过多等血溢脉外症候，中医称为“脾失统摄功能。”③脾窦是个血库，可贮存和调节全身血量，中医称为“脾裹血”《医林绳墨》说：“脾裹血，若脾无所裹，则肝无所藏，心无所主。”说明“肝藏血”以“脾裹血”为先决条件。

脾



四、肺

[形态结构]

《灵枢·九针篇》说：“肺者，五脏六腑之盖也。”《医学入门·肺脏赋》说：“形似人肩，又如磬（古乐器）。”“肺系有二：一系上通喉咙……一系自心入肺两大叶间。”《类经图翼》说：“肺叶白莹……虚如蜂窝，下无透窍，吸之则满，呼之则虚。”其位置、形态、结构的描述与西医的肺基本一致。具体说：肺左右各一，位于纵膈两侧，呈圆锥形。其动、静脉构成的肺循环和喉、气管、支气管树所构成的上、下呼吸道合称为“肺系”。肺由以亿计的肺泡所组成，其状如“蜂窝”，几个肺泡共同组成的肺泡囊是个盲端，肺泡表面有丰富的毛细血管网，是气体交换的重要场所。

[生理功能]

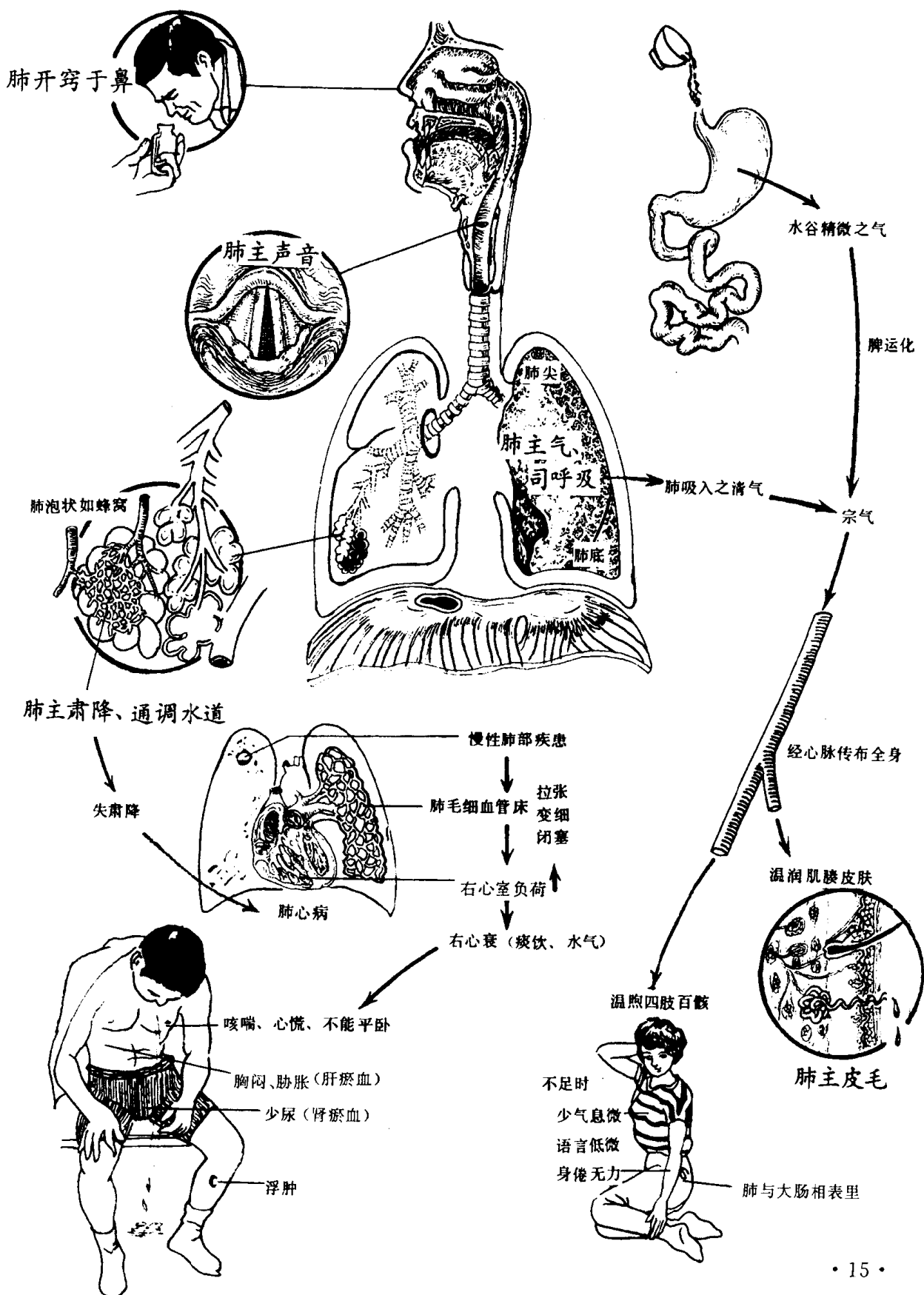
（一）肺主气，司呼吸 肺主气包括两层含意：①主呼吸之气，指的是现代医学的外呼吸。它包括肺通气（肺内与外界大气之间的气体交换）和肺换气（肺泡与血液之间的气体交换）两个过程。吸进的大气中的氧气，中医称为“清气”；呼出的二氧化碳称为“浊气”。故《类经图翼》说：“肺者生气之源……一呼一吸，消息自然，司清浊之运化。”②主一身之气，指现代医学的气体在血液中运输，中医称“通过心脉而布散全身”及内呼吸（血液与组织之间的气体交换）供给组织细胞以氧，并及时排出二氧化碳。各种营养物质在细胞内分解代谢供给能量和原料，必须经过完全的氧化，中医学将这二种能量物质称为“宗气”。宗气能“温润肌腠皮肤，温煦四肢百骸”，自然是理所当然的科学概括。不足时，少气息微、语音低微、身倦乏力，也就不难理解了。

（二）肺主肃降，通调水道 肃降，即清肃下降的意思。肺居胸中，位于上焦，其气以清肃下降为顺。现代医学理解是指呼吸道的通畅，只有通畅、清气才能抵达肺泡，进行清浊交换。肺失清肃，清气不能吸入，浊气不能呼出，即可出现胸闷、咳嗽、喘息等肺气上逆表现。所谓“水道”系指肺循环（血液→腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺毛细血管→肺静脉→左心房）而言，其通畅是整个循环系统周而复始、循环不已的一个重要环节。中医认为是由“肺气辅心以行血脉”的结果，故有“肺为水之上源”、“肺主行水”的说法。慢性支气管炎时，支气管粘膜腺体增生、肥大、分泌增多，临床出现多痰（中医称痰饮）、少尿是肺失肃降的表现。日久出现阻塞性肺气肿、肺泡毛细血管床被拉长变细甚至闭塞，“水道”发生不通畅，肺循环阻力增加，右心室负荷加重，一旦出现右心衰竭时，临床上出现咳喘、心悸、不能平卧、胸闷、胁胀（肝瘀血）、少尿（肾瘀血）及浮肿等水液停蓄的病证。

（三）肺主声音，开窍于鼻 喉是呼吸的通道和发音的器官，喉腔侧壁粘膜形成一对声带皱襞，其间裂隙称声门。声门大小，根据呼吸的需要：吸气时张大，呼气时微闭。发音时声带向中线移动，当声门闭合、气流自肺部呼出时冲击声带引起震动就发出声音。肺气充足，则声音洪亮；肺气虚，呼吸功能减弱，则声音低微，少气懒言。若风寒袭肺，肺气壅塞，则声音嘶哑。鼻是嗅觉器官，也是呼吸道的门户。鼻腔上部粘膜有嗅神经分布，可引起嗅觉。鼻的通气和嗅觉功能，中医认为主要依靠于肺气的作用，《灵枢·度脉篇》说：“肺气通于鼻，肺和则鼻能知香臭矣。”鼻为肺窍，鼻常常是邪气侵犯肺脏的通道。如外邪袭肺，肺气不宣，则常见鼻塞、流涕、嗅觉不灵等症状。

（四）主宣发，外合皮毛 宣发即布散的意思，所谓肺主宣发，主要是指通过肺的宣发使卫气和津液输布全身，以温润肌腠皮肤的作用。《素问·痹论》说：“卫者，水谷之悍气也。”卫气的分布，不受脉管的约束，运行于经脉之外，具有保护肌表、抗御外邪入侵、润泽皮毛、温煦脏腑、遍及全身的功能。是何物？！根据现代医学的理解系指存在于组织间隙的组织液，它是细胞生活的内环境。细胞与血液之间进行的物质交换，必须通过组织液。血液在通过毛细血管时，血浆中除血细胞和高分子蛋白质外，血浆中的水分和溶解其中的营养物质、代谢产物、无机盐都能透过脉管壁，而进入组织间隙形成组织液，在静脉端，组织液又透过管壁回流进血管。通过组织液，细胞可以不断地获得能量和营养物质。血中嗜中性粒细胞可以从血管内皮细胞间隙游出，吞噬外来微生物和坏死组织分解物。中医学认为：组织液的形成和白细胞的游出是由“肺气宣发”的结果。卫气司汗孔的开合，所以肺卫气虚可出现皮毛憔悴、自汗、易感冒等病证。

肺



五、肾

〔泌尿生殖系、肾上腺〕

中医学对“肾”的机能,两千多年前就提出了“肾主水”的理论,认识到肾与体内水电解质代谢有着密切的关系。但中医学的肾,并不只是现代解剖学所描述的肾,而是概括了一系列有关生理功能的总称,包括了现代医学的生殖、内分泌和神经系统等各方面。因此,在论述形态结构时,有必要概述有关部分的形态结构,以加深对中医肾生理功能的理解。

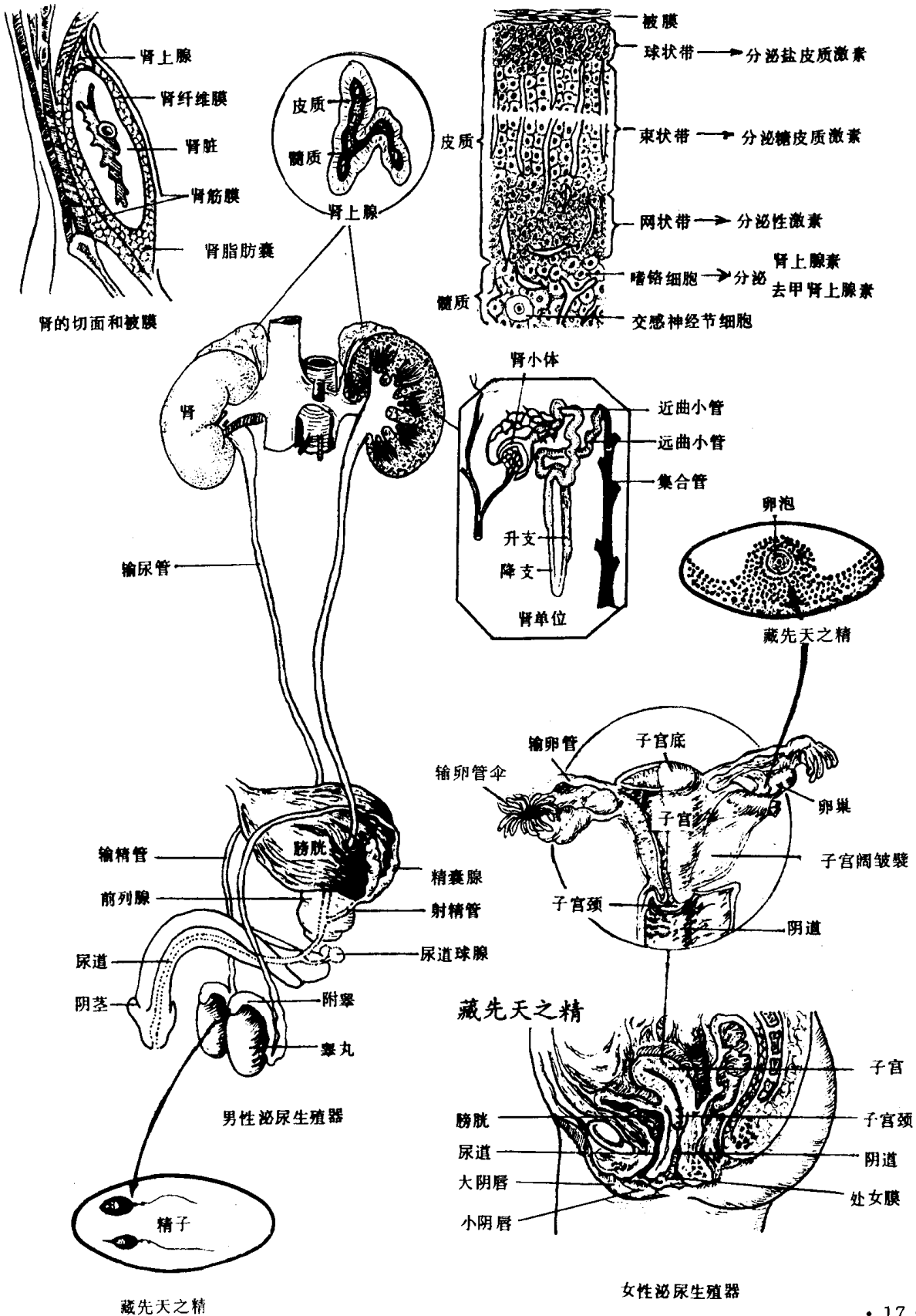
(一) 肾脏的形态结构 《类经图翼》说:“肾有两枚,形如豇豆,相并而曲附于脊之两旁,相去各一寸五分^①,外有黄脂包裹。”上述肾的位置和形态与现代人体解剖学的记载基本一致。具体地讲:肾形似豇豆,左右各一,分别位于腹膜后脊柱两旁。左肾略高于右肾。肾有三层被膜包裹:肾纤维膜、肾脂肪囊和肾筋膜。上述“外有黄脂包裹”即肾脂肪囊,有肾上腺包裹其中,所以中医的肾,包括了肾上腺的组织。肾的内缘中央凹陷而成肾门为血管、神经出入处。肾实质可分为肾皮质和髓质,由肾小体、肾小管和血管等构成,为泌尿和排尿的结构,肾小管最后开口于肾乳头,将尿排入肾盂内。输尿管为肌性管道,上接肾盂,沿腹后壁腹膜后下方下降与膀胱相连。膀胱为一肌性囊,前壁贴耻骨联合,其顶和后壁被腹膜遮盖。男性的后方与精囊输精管、直肠等接触。女性则与阴道、子宫颈邻接,下方男性邻接前列腺,女性接尿生殖膈。膀胱的两个侧角为输尿管口,前下方为尿道内口。男性尿道长约15~20cm,女性尿道长3~5cm。

(二) 生殖器的形态结构 ① 男性生殖器:由睾丸、输精管道、附属腺和外生殖器组成。睾丸是产生精子和雄性激素的器官,卵圆形,左右各一,位于阴囊内。青春期开始,精曲小管上皮产生精子,间质细胞分泌雄性激素,促进男性第二性征的发育。附睾、输精管、射精管组成输精管道,前列腺、精囊腺、尿道球腺为附属腺体。精子生成后,暂存于附睾内,射精时才排出体外。② 女性生殖器:由卵巢、输卵管、子宫、阴道和外生殖器所组成。卵巢呈现扁卵圆形,比拇指头稍大,成双,位于子宫两侧、盆腔侧壁的凹窝中,是产生卵细胞、分泌雌激素和孕激素的器官。在子宫两角有一对弯曲的长管,长约10~12cm,为输卵管,外侧端靠近卵巢,呈现漏斗状扩大,称输卵管伞,内侧开口于子宫腔。子宫呈倒置的梨形,分底、体、颈三部,子宫壁肌层肥厚,并交织排列,在妊娠期肌细胞变粗变长,即使子宫腔扩大几十倍,壁厚仍达0.5cm。分娩时呈阵发性收缩,为胎儿娩出的主要力量。阴道为一肌性管道,上端包围子宫颈阴道部,下连外阴。

(三) 肾上腺的形态结构 肾上腺位于肾的上端,左右各一个,共同包于肾筋膜内的脂肪囊中,分内外两层:外层为肾上腺皮质,无神经支配;内层为肾上腺髓质,由内脏大神经的交感神经节前纤维支配。两层结构与功能完全不同:1. 肾上腺皮质结构分三层:① 球状带,分泌盐皮质激素如醛固酮,它能促进肾小管、集合管水、钠重吸收。分泌过多引起水肿、血压升高;分泌减少产生脱水、高钾低钠血症。② 束状带,分泌糖皮质激素,如氢化考的松,它能促进肝糖原异生,增加肝糖原储备和抑制葡萄糖的利用,使血糖升高;能促进蛋白质分解,若过量可引起生长缓慢、消瘦、皮肤变薄和淋巴细胞减少,也能促进脂肪分解及水、钠重吸收。③ 网状带分泌性激素,主要是雄激素,也有少量雌激素。2. 肾上腺髓质分泌肾上腺素和去甲肾上腺素两种激素,其生理机能是使心率加快,心肌收缩加强,皮肤、内脏小动脉收缩,内脏平滑肌松弛,立毛肌收缩,汗腺分泌增加,脂肪和糖分解增加。

^① 指同身寸——编者注。

肾 (一)



[下丘脑-垂体-靶腺轴、植物神经]

中医学无内分泌腺及植物神经系统的描述,但医学界用现代医学知识和方法对中医“肾”本质的研究发现,中医的“肾”囊括了内分泌及植物神经系统的功能。此处简介其形态结构、功能,无疑会加深对中医学“肾”生理功能的理解。

(一) 内分泌腺 内分泌系统是人体机能调节的重要组成部分,它是由分散于全身不同部位的内分泌腺所组成。人体主要的内分泌腺有脑垂体、甲状旁腺、甲状腺、肾上腺、胰岛和性腺等。有些器官并未列入内分泌器官范畴,但也能产生激素,如肾脏能产生肾素、红细胞生成素,胃肠粘膜能产生胃泌素、促胰液素,很多器官可产生前列腺素。内分泌腺分泌的活性物质称为激素,由腺细胞直接释放进入血液,对机体的代谢、生长、发育和生殖功能起调节作用。

1. 脑垂体:体积小,形如豌豆,重约 0.5g,悬于丘脑下部,位于颅底蝶鞍内,是最重要的内分泌腺。结构上分前叶和后叶:① 前叶又称腺垂体,其中嗜酸性细胞能分泌促生长激素和促乳激素。促生长激素能促进蛋白质合成,促进骨骼生长,促进生长、发育;促乳激素促进女性乳腺发育。嗜碱性细胞能分泌促性腺激素,能刺激卵巢中卵泡发育和睾丸精子的生成;促肾上腺皮质激素具有刺激肾上腺皮质分泌糖皮质激素和性激素的功能;促甲状腺激素是维持甲状腺正常功能的重要激素;黑色素细胞刺激素促进皮肤合成黑色素。② 后叶又称神经垂体,其内贮藏:抗利尿激素,能促进肾小管集合管对水分重吸收,减少排尿量;血管加压素,能使小动脉收缩而升高血压;催产素,能刺激妊娠子宫肌内收缩,促进分娩后泌乳。

2. 甲状腺:如马蹄形,位于颈下部气管两侧,分泌甲状腺素,可促进细胞的氧化过程,促进全身物质代谢,调节机体的生长。

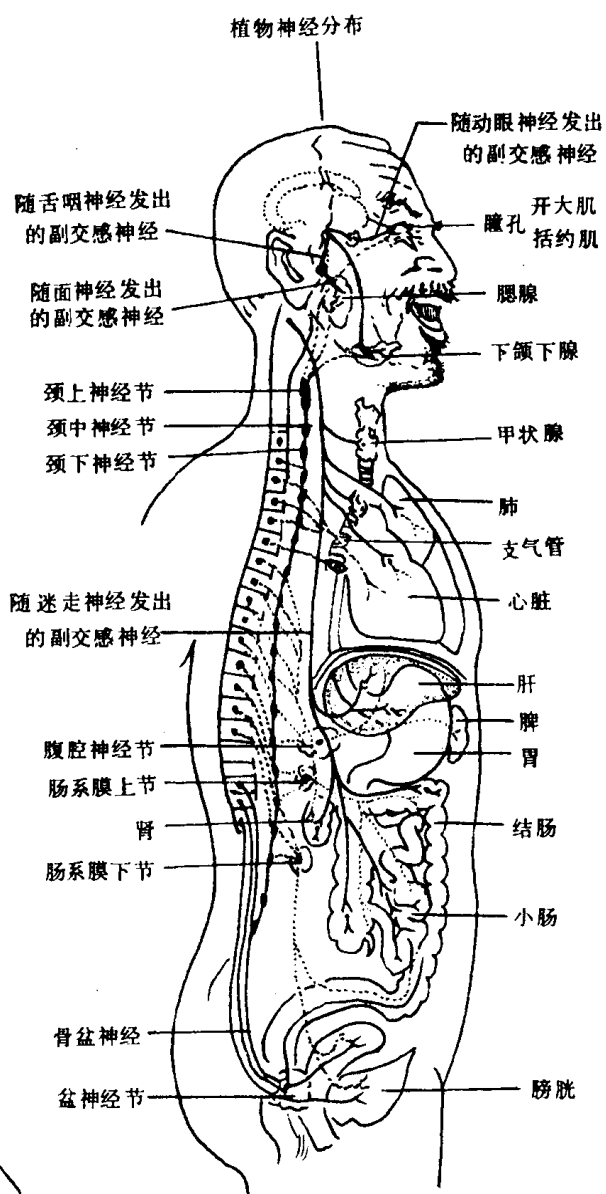
3. 甲状旁腺:扁圆形,高粱米粒大小,位于甲状腺侧叶后面,分泌甲状旁腺激素,能使血钙升高,血磷降低。

4. 性腺:男性分泌睾丸素,能促进男性性器官的生长和发育、第二性征出现、精子生成和蛋白质的合成。女性卵巢分泌两种激素:① 雌激素,能促进女性器官发育、成熟及第二性征的出现。② 孕激素能保证受精卵着床和正常妊娠的进行,促进乳腺发育。

5. 肾上腺皮质和髓质激素、胰岛激素已在前面有关内容中介绍。

(二) 植物神经系统 植物神经是整个神经系统的一部分,主要管理消化、呼吸、泌尿、生殖各器官的活动,司新陈代谢的机能,保证机体内外环境的平衡。因其机能不受意识支配,所以又称自主神经系统。它包括交感神经和副交感神经,内脏各脏器大多数接受交感和副交感神经的双重神经支配。有些器官如肾上腺髓质、汗腺、竖毛肌、皮肤和肌肉的血管,只受交感神经支配。植物神经与躯体神经不同,即从中枢发出的神经纤维并不直接到达效应器官,必须先进入一个神经节交换一次神经元,由节内神经元再发出纤维到达效应器官。由中枢到神经节的纤维称节前纤维;由神经节到效应器的纤维叫节后纤维。交感神经的节前纤维短,节后纤维长;而副交感神经节前纤维长,节后纤维短。交感和副交感神经兴奋时,对一个内脏器官所表现的作用是对立的:如交感神经兴奋可表现为瞳孔散大,心率加快,皮肤和内脏血管收缩,冠状动脉扩张,脾脏收缩缩小,血压升高,血糖浓度升高,消化道蠕动分泌减弱,括约肌收缩,支气管平滑肌舒张,呼吸加深,加快,汗腺分泌增加,肾上腺素大量分泌。副交感神经兴奋的作用表现为瞳孔缩小,心率减慢,血管舒张,胃肠蠕动增强,腺体分泌增多,括约肌松弛,支气管平滑肌收缩,胰岛素分泌增加,血糖降低。交感与副交感神经的生理作用既对立,又在大脑皮层的控制下统一协调,相反相成,从而保证了内脏和整个机体的正常活动。

A black and white line drawing of the human urinary system. Two kidneys are shown on either side of the spine, connected by two ureters that lead into a central bladder-like structure. The drawing is simple and schematic, focusing on the basic anatomy of the organs.

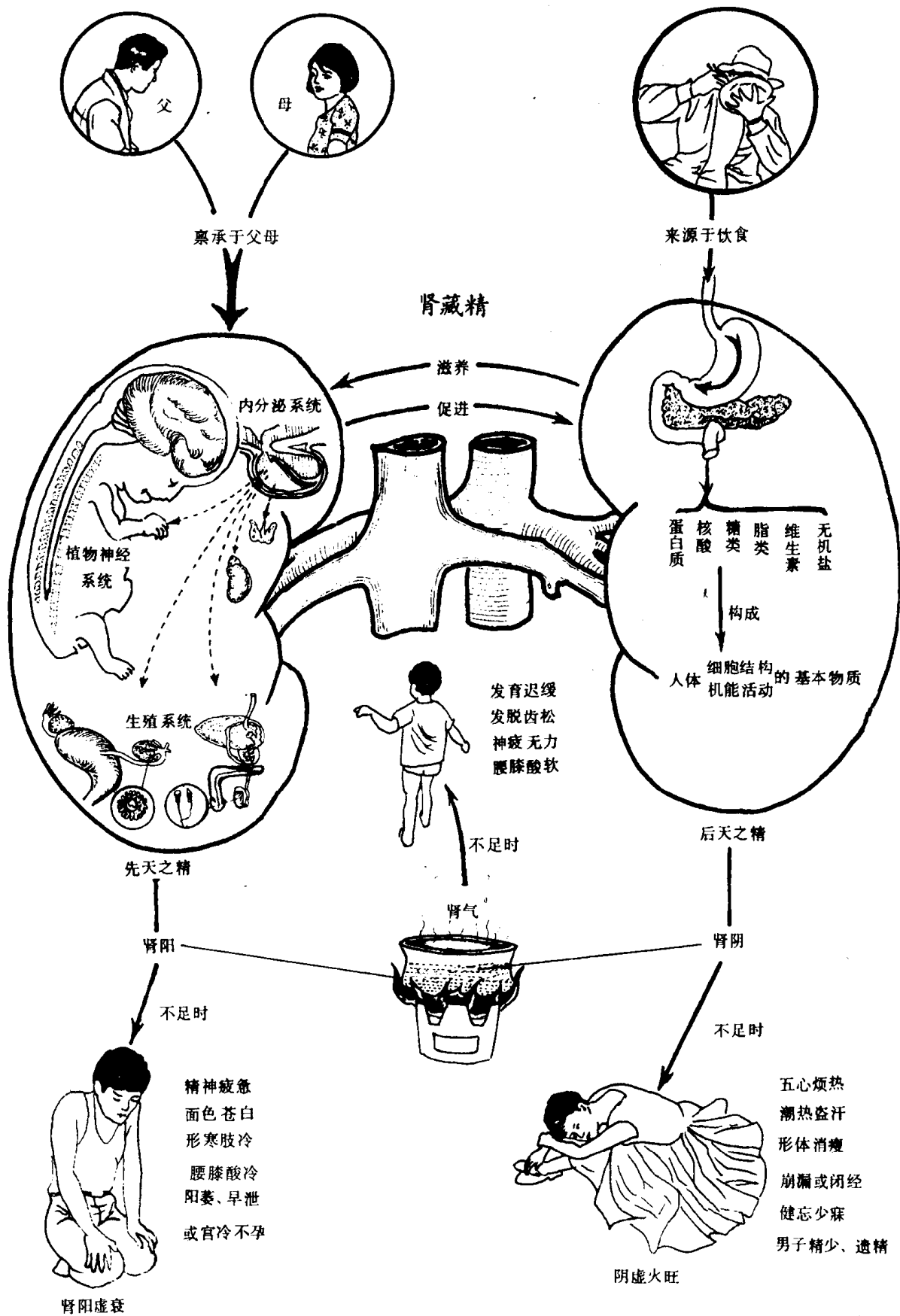


〔肾藏精〕

(一) 肾藏精,主发育与生殖 中医学的“精”是构成人体的基本物质,也是维持人体生命活动的物质基础,藏之于肾。肾精的来源有先天和后天之分:先天之精禀承于父母。《灵枢·经脉篇》说:“人始生,先成精。”这个“精”,用现代医学来解释,究竟指什么?指塑造人体一切细胞和各种组织结构的基本物质——蛋白质?还是指携带有父母遗传特性的脱氧核糖核酸(DNA)?或一个受了精的卵泡?看来都包括,但这还远远不够。从诸多中医文献来认识,先天之精,即肾阳,又称元阳、真阳、真火,是人体阳气的根本,对脏腑、经络、身形起温煦、生化作用。故《三十六难》说:“肾两者,非皆肾,其左为肾,右者为命门。”张介宾在《景岳全书》中说:“命门为元气之根,为水火之宅,五脏之阴气,非此不能滋,五脏之阳气非此不能发。”《石室秘录》说:“胃得命门而能受纳,脾得命门能转输,肺得命门而治节,大肠得命门而传导,小肠得命门而布化,肾得命门而作强。”《医部全录》注释说:“命门为配成之官。……男以此藏精,女以此系胞胎。”这些论述说明,先天之精具有促进机体物质代谢过程,调节机体生长、发育和生殖机能,以及管理呼吸、消化、泌尿、生殖各器官的功能,即现代医学的性腺、整个内分泌系统和植物神经系统的结构和功能。后天之精来源于饮食,由脾胃化生,即“水谷精微”,现代医学指已被消化、吸收的蛋白质、脂肪、糖类、维生素、无机盐和水等构成人体组织、维持机能活动的营养物质。中医学又称为肾阴、元阴、真阴、真水,是人体阴液的根本,对各脏腑、经络、身形起濡润、滋养的作用。肾中的阴阳犹如水火一样寄于肾,在人体内是相互依存、相互促进、相互制约的。先天之精为后天之精的摄取准备了物质基础,后天之精又不断供养先天之精,使之不断地得到补充,但又相互制约,维持着肾的阴阳动态平衡。一旦平衡遭到破坏,则出现肾的阴阳失调。如肾阴虚少,不足制阳时,就会出现阴虚火旺的病症,表现为五心烦热,潮热盗汗,形体消瘦,崩漏或闭经、健忘、少寐,男子精少遗精。若肾阳虚衰,温煦和生化功能不足,则出现精神疲惫,面色㿔白,形寒肢冷,腰膝酸冷,阳萎、早泄或宫冷不孕。

肾精能化气,肾精所化之气称肾气。肾气是由肾阳蒸化肾阴而产生。盖肾阴、肾阳都以肾所藏之精为物质基础,所以肾的精气包含肾阴和肾阳两个方面。肾的精气盛衰关系到生殖和生长发育的能力。肾精充足,则肾气旺盛,生长发育和生殖功能正常,精力充沛,体力强壮。反之,肾精亏耗,则精气渐衰,生长发育不良,或形体衰老,精神萎靡,性机能和生殖能力减退。临床上表现为肾虚而又无上述肾阳虚的寒象、肾阴虚的热象者,为“肾气虚”,也称“肾精亏损”,可以开始是肾阴虚或肾阳虚,发展到一定程度伤及肾阳或肾阴,为肾阴阳两虚,表现为小儿发育迟缓,筋骨痿软;成人则神疲,发脱齿松,腰膝酸软无力和某些不孕症。

肾 (三)



〔肾主水、肾主纳气〕

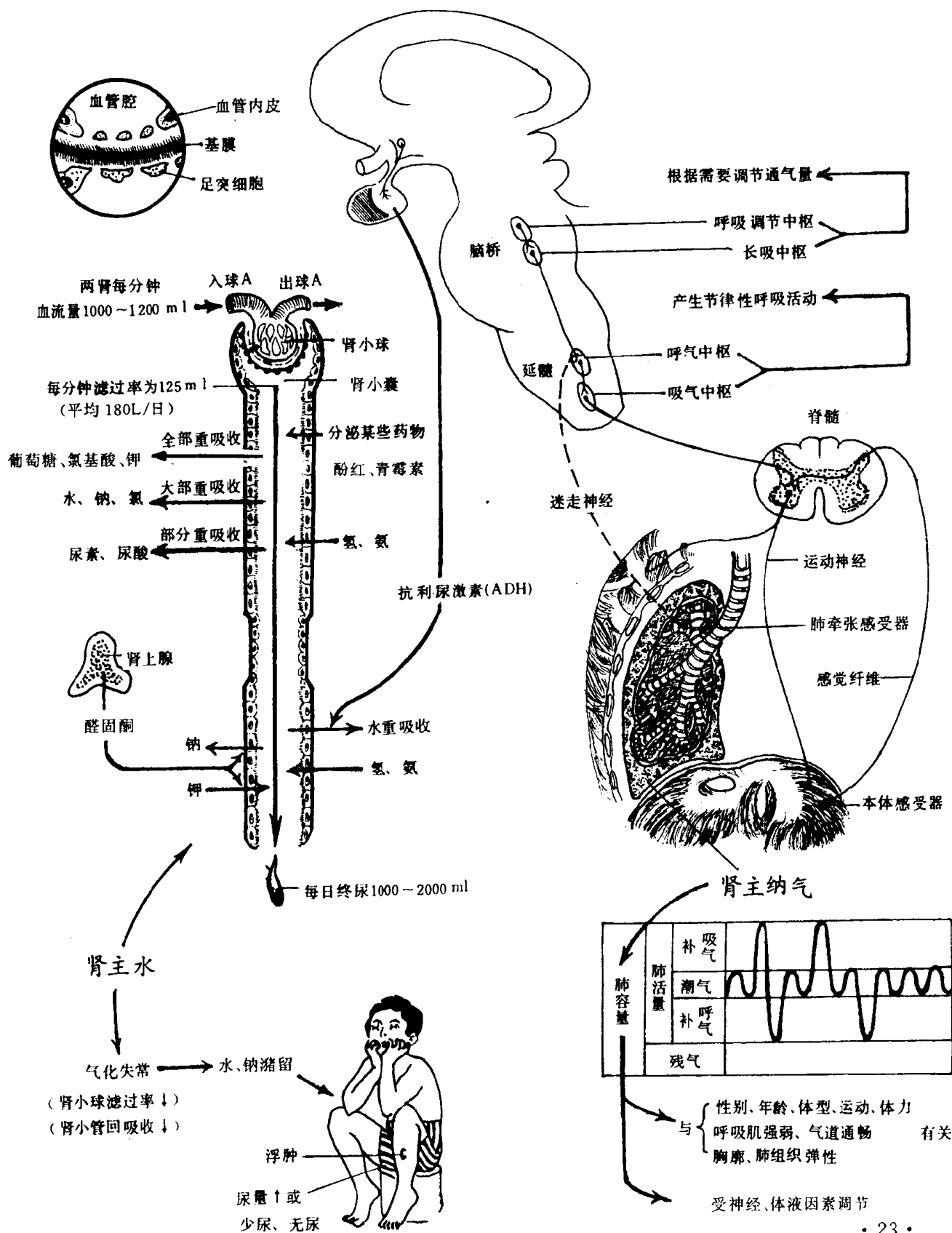
(二) 肾主水 肾脏是人体的重要排泄器官。人体新陈代谢过程中所产生的终末产物、多余的水和进入体内的异物,主要通过肾脏排出。肾脏在维持体内水、电解质和酸碱平衡,保证细胞内环境相对稳定方面具有特别重要的意义。故《素问·逆调论》说:“肾者水脏,主津液。”中医学认为体内水液平衡的调节,主要靠肾的气化作用。用现代医学知识理解“气化”的含意是:①推动血浆从肾小球滤过的力量,据科学的推算,每昼夜从两侧肾脏肾小球滤过的血浆总量为180L,称为原尿。②原尿流经肾小管、集合管时,99%的水和对身体有营养价值的物质被选择性重吸收:如葡萄糖、氨基酸、钾全部重吸收,钠、氯大部分重吸收,对身体无用或有害的物质,如尿素、尿酸只有少量重吸收,肌酐完全不吸收,这就是中医文献的“藏精排浊”。每日尿量仅1~2L,其成分与血浆有很大差别。③肾小管细胞排泄一些外来有机物(如酚红、青霉素)并分泌氢氨换回原尿中的钠,以保存体内碱储备,调节和维持身体酸碱平衡。气化正常则开合有度。这个“开关”是垂体后叶释放的抗利尿激素和肾上腺皮质分泌的醛固酮。抗利尿激素主要促进肾小管对水的重吸收,当人体缺水(血浆渗透压升高)和血容量减少时,抗利尿激素分泌增加,使水分保留于体内,尿量减少;相反则分泌减少,排尿增多。醛固酮主要是促进肾小管保“钠”排“钾”。钠重吸收增加,氯和水回吸收也增加。若醛固酮分泌减少,会使钠和水大量丢失,而钾在体内潴留;若醛固酮分泌过多,则造成水、钠在体内潴留,而引起浮肿、小便不利等病症。

(三) 肾主纳气 西医的肾与呼吸无关,只是在肾功衰时可出现深而快的 Kussmaul 氏呼吸。而中医的肾,隐含植物神经的结构与功能,主要分布于内脏,包括肺的运动和感觉神经。在肺根的前后方,由迷走神经的支气管支与交感干的2~5节组成肺丛,支配支气管和肺血管的舒缩,以及粘膜腺体分泌和参与肺牵张反射,因此“肾主纳气”就不难理解。

正常情况下,呼吸系统能够适应不同程度的体力活动要求和内外界环境的变化,而改变其活动水平,这种适应机能是在神经体液调节下通过改变呼吸运动和肺部血液循环的强度来实现的。成年人在安静时每分钟肺通气量为6L,而在强体力活动时可达100L。通气量增多是通过呼吸运动加深、加快和支气管、肺泡相应扩张来实现的。与此同时,肺部毛细血管也相应开放、扩张,血流速度加快。安静时,肺部毛细血管只有1/15~1/10是开放的,而在进行强体力活动时,可以全部开放,增加血氧饱和度。这是肾主纳气的含意之一。

呼吸运动直接受延髓呼吸中枢控制,它包括吸气中枢(支配吸气的肌肉,引起吸气活动)和呼气中枢(兴奋时,引起主动性呼气)两者彼此拮抗,相互抑制,从而产生节律性呼吸运动。但这种呼吸比较原始,不能根据机体活动需要改变通气量,在桥脑上端还有呼吸调节中枢和长吸中枢,能根据机体活动需要调节其通气量,同时也受大脑皮层高级中枢活动调节。在支气管和细支气管的平滑肌内分布有肺牵张感受器,当肺内气量达一定容积时,感受器兴奋,冲动沿迷走神经传入呼吸中枢,抑制吸气中枢,使吸气向呼气转化,防止吸气过度。当将实验动物迷走神经切断后,动物的吸气时间延长,呼吸深且慢。这是肾主纳气的含意之二。当慢支肺气肿时,肺牵张感受器处于持续兴奋状态,引起神经张力增高,故患者呼吸处于浅快状态,肺通气量减少,动则气喘,中医认为是“肾阳虚”,肾不纳气。

肾 (四)



〔主骨、肾生髓、开窍于二阴〕

（四）肾主骨生髓 骨骼是结构复杂、功能多样的一种组织。它对人体起支架作用，使身体成形。它保护重要的器官，还可支撑重量、参予运动。它还是一个造血器官。红骨髓能产生红细胞、白细胞和血小板。胎儿和幼儿骨髓腔全是红骨髓，随着年龄的增长，长骨干内红骨髓逐渐被脂肪所代替。《素问·四时刺逆从论》说：“冬气在骨髓中，冬者盖藏，血气在中，内著骨髓通于五脏。”张介宾在《类经》中说：“此津液之为精髓也，……以填补于骨腔之中……为精为血。”说明古代医学家早已认识骨骼的造血功能。《素问·平人氣象论》说：“肾藏骨髓之气也。”《素问·宣明五气篇》说：“肾主骨”，《灵枢·海论》说：“髓者骨之充也。”说明肾藏精生髓，骨髓滋养骨骼。

骨骼是一个活的结构，也在不断地修复生长。它由细胞间质和骨细胞所组成，细胞间质2/3是矿物质（主要是磷酸钙，是钙的仓库，当血液需要钙时，骨骼就供应），1/3为有弹性的、含胶原纤维的凝胶状物质。骨的表面有一层骨膜。血管和神经经骨膜进入骨骼内，骨膜对骨骼具有保护、营养和形成新骨的能力。中医学认为骨髓充足，骨骼得养，则小儿骨骼生长发育正常，成人骨骼坚固有力。若肾精虚少，骨髓的化源不足，不能营养骨骼，便出现骨骼变形（如佝偻病前囟迟闭，“罗圈腿”），主要原因是食物中缺乏钙、磷和维生素D不足。若肾为邪气所伤以致肾精不足，骨髓空虚，便会出现腰膝酸软，甚至脚痿不能行动。此处的“邪气”系泛指骨髓炎、骨结核、骨肿瘤，以及糖尿病的骨质疏松和经产妇的软骨病等。

从现代医学观点来阐述肾生骨、生髓，合乎情理：肾包含内分泌，其中生长激素、甲状腺素、雄激素均有促进骨骼生长、发育的作用：肾小球旁细胞能分泌促红细胞生成因子。该因子能促使肝、脾所产生的红细胞生成素原变成红细胞生成素，刺激骨髓中的红细胞分化成熟。

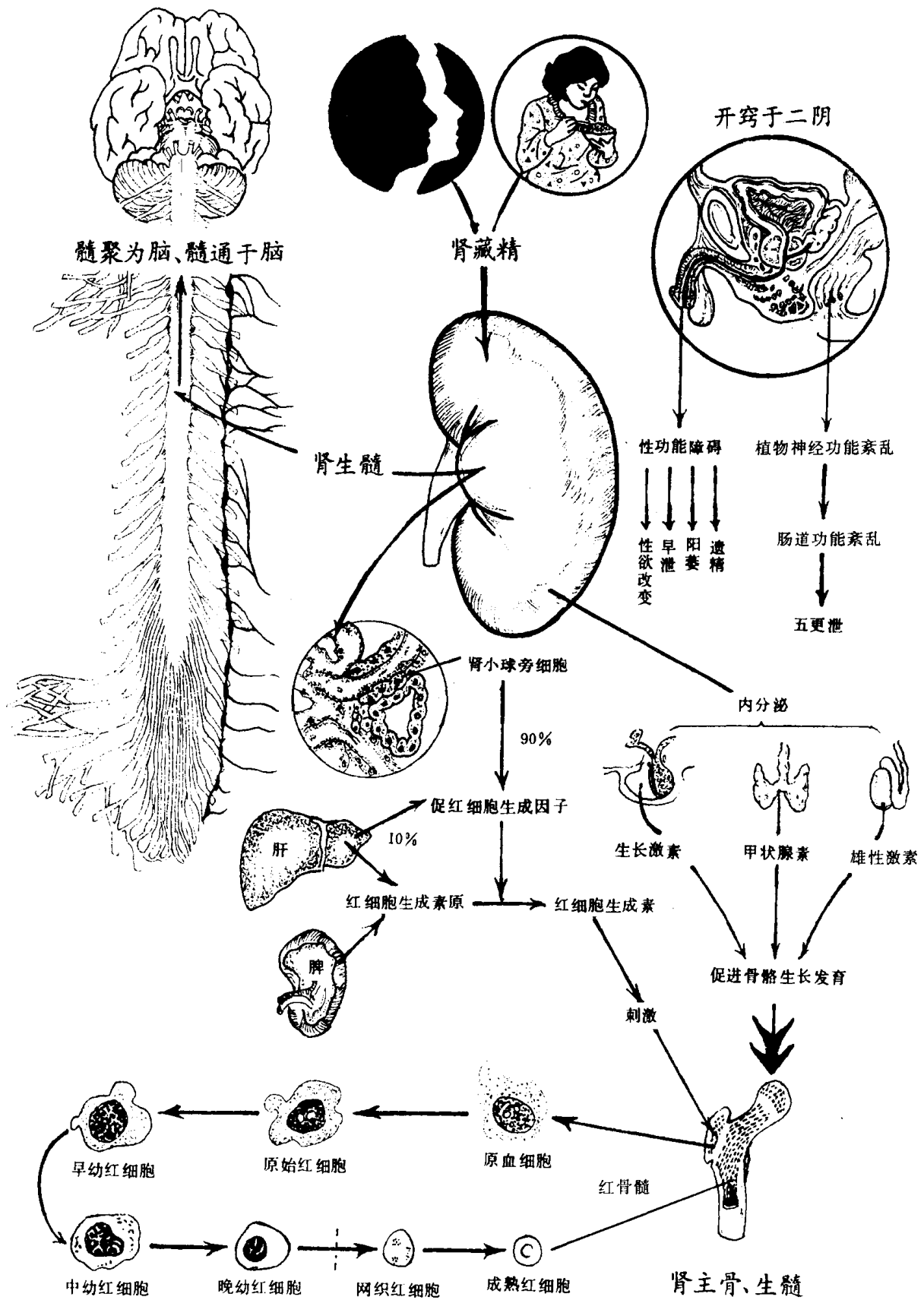
中医认为：“齿为骨之余”，“发为血之余”，牙齿有赖于肾精的充养，而毛发则由血来润养。精与血是互为资生的，精足则血旺，血旺则毛发光泽，精足则牙齿坚硬，老年肾气虚衰，故毛发变白、牙齿松动脱落。

髓有脊髓和骨髓之分，因皆藏于骨腔之中，古时统称为髓，认为脊髓也由肾之精气所生化和补充。

（五）肾开窍于耳及二阴 肾在上开窍于耳，在下开窍于二阴。《灵枢·脉度》说：“肾气通于耳，肾和则耳能闻五音矣。”认为耳为肾之官，肾气足则听觉聪敏，肾气衰则耳鸣、耳聋。用现代医学知识理论无法将肾与听力相联系。

所谓二阴，指前阴外生殖器和后阴肛门。前阴具排尿和生殖作用。中医将尿量过多而成的下消症（如糖尿病、尿崩症）视为阴虚阳盛造成肾的“开多阖少”，而将少尿、浮肿的肾性水肿视为阳虚阴盛所致肾的“阖多开少”。由于肾藏精，主人的生殖、生长发育、衰老。临床上所遇到的性功能障碍，男性精液稀少、阳痿、早泄、遗精和女性无月经、原发性不孕症者均可以补肾治疗。后阴表现于大便排泄，主要取决于大肠的蠕动、分泌与吸收功能。在正常情况下，大便的性状、次数和量受饮食和植物神经调控，中医“肾”既然囊括植物神经系统，因之胃肠功能紊乱所致的“五更泄”认为是肾虚引起，也包括食积、酒积、肝火等病因所致。肾阴虚可见大便秘结。

肾 (五)



六、心包与命门

〔简介〕

(一) 心包 是心的外膜,意同西医的心包脏层和壁层,脏壁层之间的空隙为心包腔,内含少量浆液,可润滑两层以减少摩擦。但中医学的心包,又是心的外围组织器官,附有络脉,是通行气血的道路,又称心包络。它是心的外卫,有保护心脏的作用,同时能代心受邪,远远超出了西医心包的功能。《灵枢·邪客》说:“心者,五脏六腑之大主也,精神之所舍也,……邪不能容,容则伤心……故诸邪之在于心者,皆在于心之包络。”此处的心,指的是脑,明确为精神之所舍。因此,心包络是否暗含现代医学的硬脑膜、蛛网膜、软脑膜?不敢妄断。但从现代医学理论来推测,可能性并非没有。由于血脑屏障的存在,很多物质,如青霉素、胆盐、 H^+ 、 HCO_3^- 、某些非脂溶性物质及病原体,不易透入脑组织,似为“邪不能容。”就脑炎与脑膜炎发病比率来看,后者明显多于前者,是否隐譬“邪之在于心者,皆在于心之包络”?

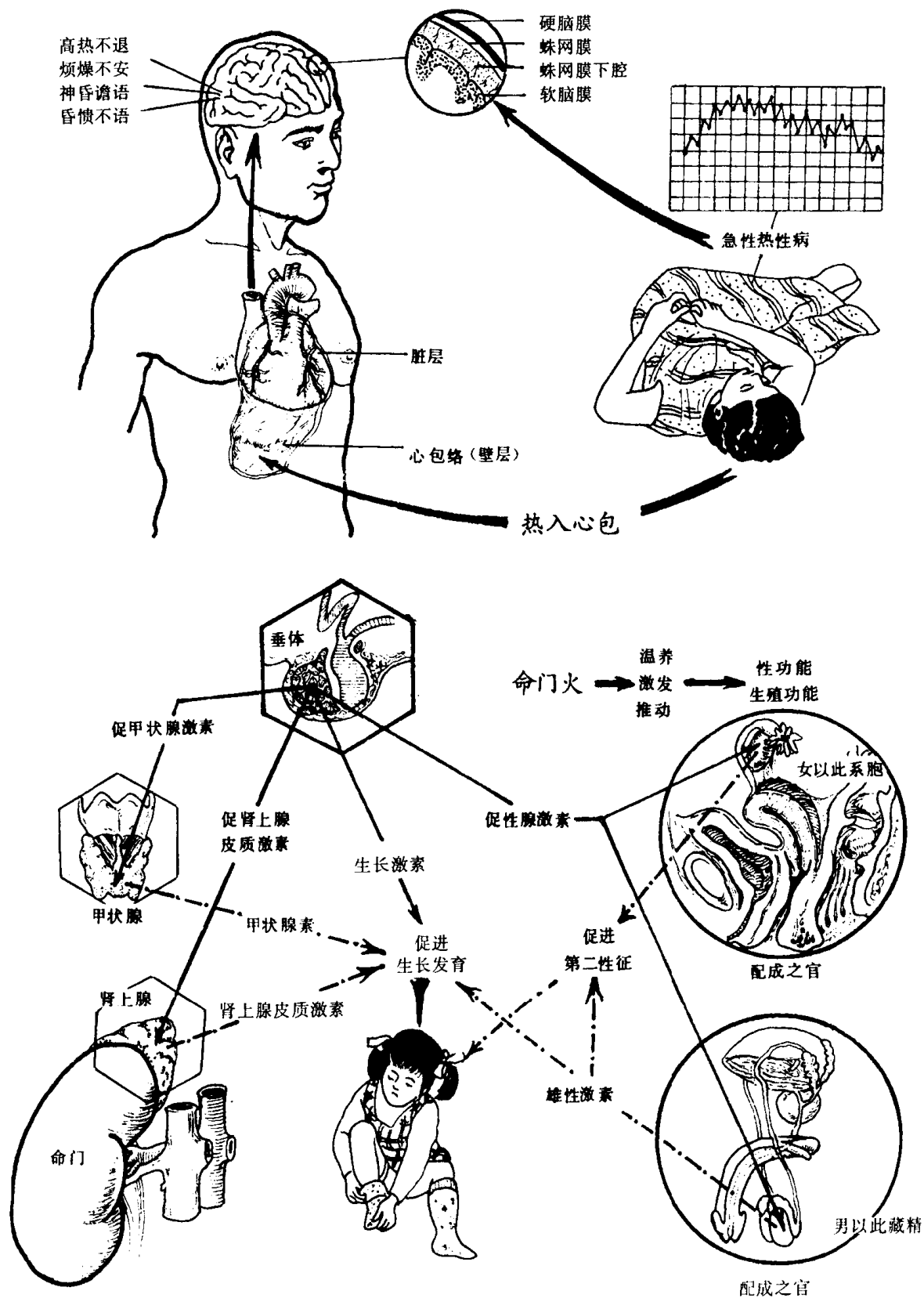
(二) 命门 含生命之门的意思,是先天之气蕴藏所在、人体生化的来源、生命的根本。命门之火体现肾阳的功能,包括肾上腺皮质功能。《难经·三十六难》说:“命门者,诸神精之所舍,原气之所系也,故男子以藏精,女子以系胞”,提出含生殖功能。命门有两个说法:① 指右肾。《难经·三十六难》说:“肾两者,非皆肾也,其左者为肾,右者为命门。”② 指两肾,具体体现于两肾之间的动气,《医部全录》注释说:“肾之两虽有左肾右命门之分,其气相通,实指肾而已。”认为命门的功能包括肾阴、肾阳两个方面。

〔生理功能〕

(一) 心包的生理功能 ① 它是心的外卫,具有保护心脏(包括现代医学的脑)的作用,有如心、脑的屏障,能遮蔽浊气,防御邪气对心脑的侵袭。临床上心包受邪的病症与心主血脉的有些病症相一致。② 代心受邪,各种病因所致急性热性病时出现的高热不退,烦躁不安,神昏谵语,或昏愤不醒等表现,中医学均列入“热入心包”诊断范畴,实则是囊括了西医急性高热的各种疾病及脑膜和脑病变的表现。

(二) 命门的生理功能 ① 是生命本元之火,即肾阳,寓于肾阴之中,是性机能和生殖能力的根本。《医学全录》具体指出:“命门为配成之官……男以此藏精,女以此而系胞。”说明命门包括了西医的性器官,与生殖有关。② 温养脏腑经脉,促进生长、发育。《景岳全书·命门余义》说:“命门为元气之根,水火之宅,五脏之阴气,非此不能滋,五脏之阳气,非此不能发”,说明命门之火能温养五脏六腑,对人的生长、发育、衰老有密切关系,脏腑有命门火的温养,才能发挥正常功能,尤其是脾、肾需要命门火的温煦,才能发挥正常的运化功能。《石门秘录·论命门》说:“胃得命门而能受纳,脾得命门而能转输,肺得命门而治节,大肠得命门而传导,小肠得命门而布化,肾得命门而作强。”按现代医学理论来理解,命门包括了脑垂体-肾上腺轴、脑垂体与其他内分泌腺轴,对人体代谢、生长、发育和生殖等重要机能起调节作用,并和体内的植物神经系统的机能活动相互调节、相互制约,共同组成体内神经体液调节系统。

心包与命门



第二节 六 腑

一、胆

[形态结构]

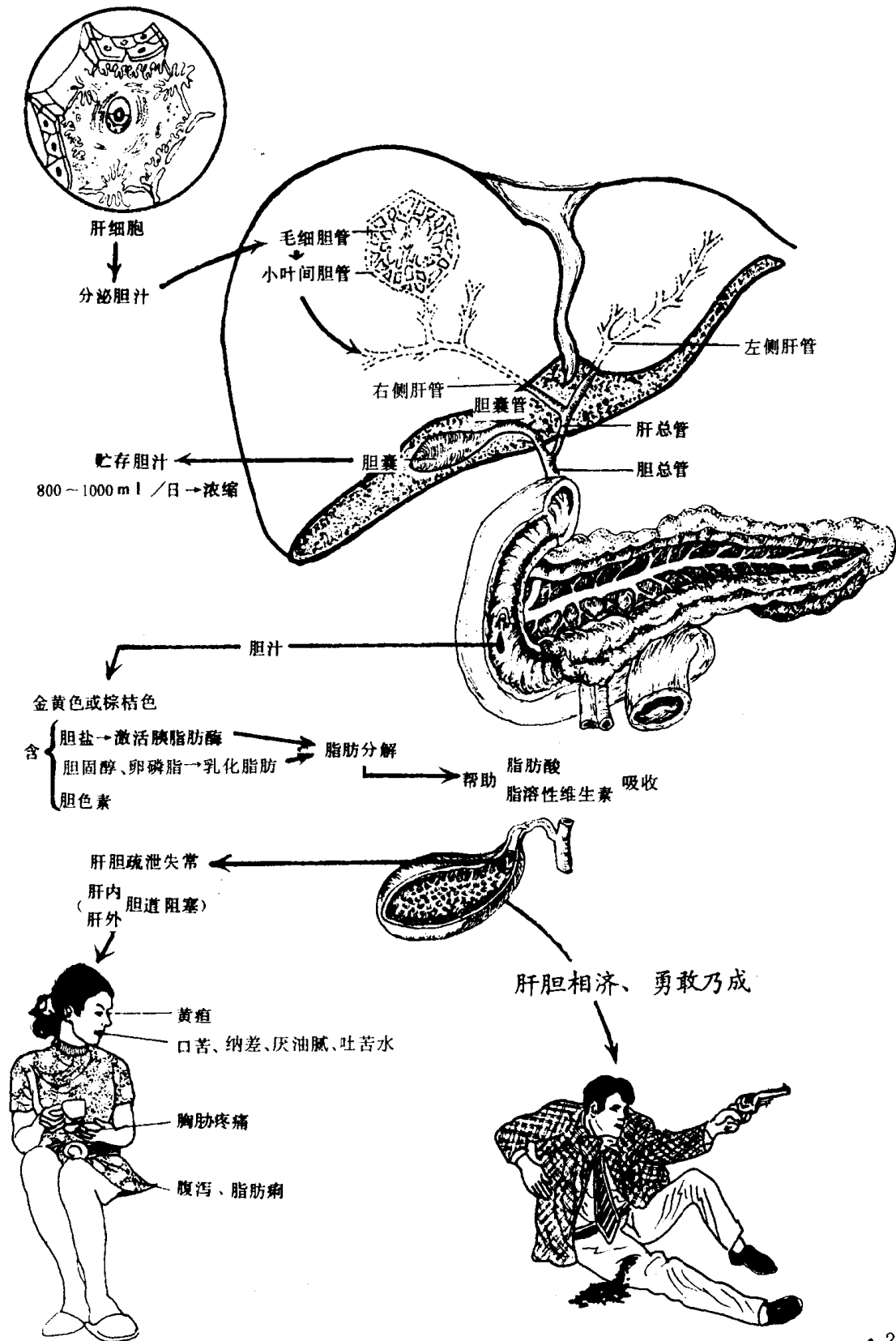
胆为六腑之一。因不与外界直接相通,不同于其他五脏,故又有“奇恒之腑”之称。胆附于肝,与肝相连,位于胁下。《难经·四十二难》说:“胆在肝之短叶间,重二两二铢,盛精汁三合。”《难经正义·四十二难》说:“胆囊式如梨,附于肝右之小方叶中,贮精汁……人食后小肠饱满。肠头上逼胆囊,使其汁流入小肠之内,以融化食物。”上述论述与现代解剖学一致。胆囊位肝下面的胆囊窝内,呈梨形,分底、体、颈三部。胆囊颈较细,内有螺旋瓣与胆囊管相连,该处易被胆石等阻塞,可引起胆囊炎或胆囊积液。胆的主要功能是贮藏胆汁。胆汁由肝细胞生成,经肝管注入胆囊管而贮存于胆囊,当消化时由胆囊排出至十二指肠,与胰液、小肠液配合,对小肠内的食糜进行消化。成人胆汁每日生成量约800~1000ml,呈金黄色,在胆囊内浓缩成40~60ml,色泽变深。《脉经》说:“肝之余气,泄于胆,聚而成精”精辟地说明了胆汁的生成和胆囊的浓缩功能。

[生理功能]

(一) 胆主贮藏与疏泄胆汁 胆汁由肝细胞所分泌,经小叶间胆管、肝管、胆总管而流入十二指肠,或经胆囊管贮藏于胆囊。胆汁成分复杂,除水和无机盐外,还有胆盐、胆固醇、卵磷脂、胆色素等。胆盐可激活胰脂肪酶,使脂肪分解加速。胆盐、胆固醇和卵磷脂等都有乳化脂肪使其变为微滴而分散于水溶液中,有利于胰脂肪酶分解并促进脂肪酸和脂溶性维生素的吸收。进食、食物对胃和小肠的刺激均可通过神经反射使肝分泌胆汁增加和胆囊轻度收缩,尤其是小肠内有脂肪、蛋白质分解产物和胃酸等,可引起胆囊强烈收缩而排空胆汁。若肝胆疏泄胆汁失常,多因肝内、肝外胆道阻塞,则出现黄疸、口苦、纳差、厌油腻、吐苦水、胸胁疼痛、腹胀、腹泻、脂肪痢等症状。

(二) 胆气与情志活动有关 中医学的胆与人的思维和情绪有关。《素问·灵兰秘典论》说:“胆者,中正之官,决断出焉。”决断出于思维,是人的大脑功能活动。思维不是在头脑中凭空产生的。思维的内容和源泉来源于客观现实。思维的结果——决断是否正确,需要从感性认识上升到理性认识等一系列思维过程才能实现,还要受实践的检验。思维的最重要部位在额叶,额叶也是人脑最晚形成、最为复杂的部分,与人的各种心理活动有密切的关系,除与人的智力(包括最简单的思维、直观思维、复杂的抽象推理思维)相关外,还与人的运动(如面部表情、体态表情、言语表情)和情绪(如喜、怒、哀、乐、悲、恐、惊等主观体验)相关。《类经》注释说:“胆附于肝,相为表里,肝气虽强,非胆不断,肝胆相济,勇敢乃成。”《灵枢·四时气篇》说:“善呕、呕有苦、长太息,心中憊憊恐,如人将捕之,邪在胆。”认为胆气虚怯者,会出现心悸、骇怕、惊恐、叹长气等情志症状。《中藏经》也说:“邪气客于胆,则梦斗讼。”“胆实则热,精神不守,胆热多睡,胆冷则无眠。”将觉醒状态(多睡和失眠)这个属于脑干网状结构对大脑皮层活动的校正与调节也划分到胆的生理功能上,并常从胆来治疗,其机理目前尚难于理解和解释。

胆



二、胃

〔形态结构〕

胃为六腑之一,其形态结构与现代解剖学相同。《难经正义·四十二难》说:“胃形纡曲如袋,容水三升许,横居膈下;上连食管,下通小肠……胃之左为脾,右为肝;胰附于胃后。”《类经图翼》说:“胃之上口,名曰贲门……胃之下口,即小肠上口,即幽门。”胃大部分位于左上腹,上经贲门连接食道,下经幽门连续于十二指肠。上缘称胃小弯,下缘为胃大弯,在胃小弯距幽门5~6cm处有一凹陷,叫角切迹,临床上以此分胃为三部分:①胃底,在贲门的左侧,高于贲门水平的部分;②胃体在胃底和胃窦之间,上述两部占全胃的4/5;③胃窦,位于角切迹与幽门之间。中医将胃腔称为胃脘,其中贲门部为上脘,胃体为中脘,胃窦部为下脘。胃的血液供应来源于腹腔动脉,静脉血流入门静脉。胃属植物神经控制;交感神经来自腹腔神经节的分支,作用是抑制胃的蠕动和分泌;副交感神经来自左、右迷走神经,主管胃的分泌和运动。胃壁从内向外,可分四层:①粘膜层,有不规则皱襞构成胃小区。粘膜层有三种分泌腺:a贲门腺,分布于贲门周围,主要分泌粘液;b胃底胃体腺,分布于胃底、胃体部,是胃的主要消化腺,由壁细胞、主细胞和粘液细胞所组成,分别分泌盐酸、胃蛋白酶原和粘液,其功能见图解;c幽门腺,分布于胃窦部,由粘液细胞和G细胞组成,G细胞分泌胃泌素进入血液循环后可刺激壁细胞分泌胃酸。②粘膜下层,较厚,溃疡大出血即此层血管受到侵蚀所致。③肌层。④浆膜层。

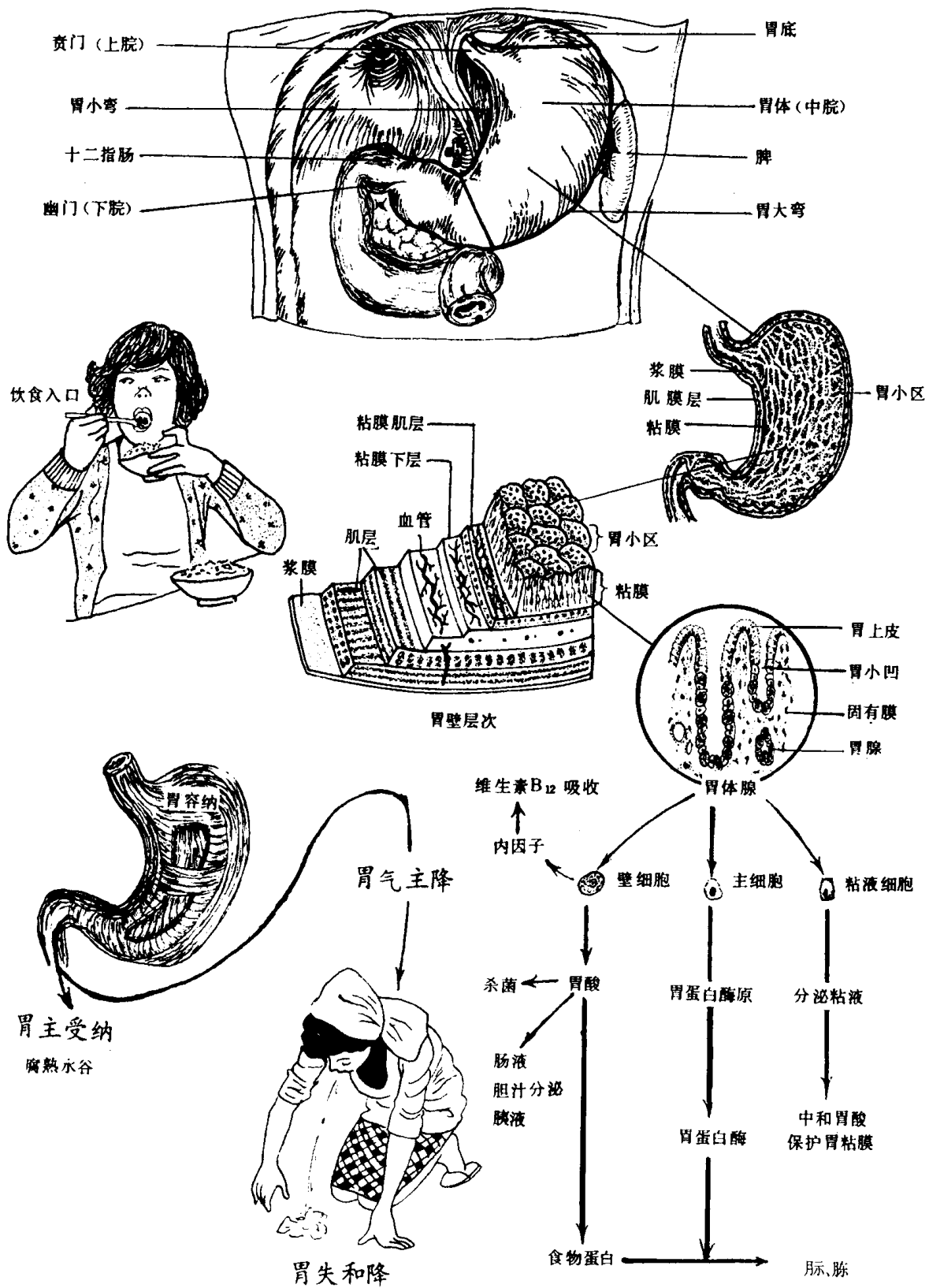
〔生理功能〕

(一)胃主受纳、腐熟水谷 指胃有暂时容纳和消化食物的功能。《血证论》说:“胃者,仓廩之官,主纳水谷。”《难经·三十一难》说:“中焦者,在胃中脘,不上不下,主腐熟水谷。”成年人的胃一般可容纳1~2L食物。食物进入胃内后,受到胃壁肌肉的机械消化和胃液的化学性消化,食物中的蛋白质部分被初步分解为肽和胨。胃酸能杀灭随食物进入胃的细菌,可促进小肠的胰液、肠液和胆汁等消化液的分泌和有助于铁、钙的吸收。胃对饮食的受纳、消化功能主要靠胃气的作用。《灵枢·五味篇》说:“五脏六腑皆禀气于胃。”当胃有病时会出现胃脘痛、食欲减退、食量减少、恶心呕吐等症状。《中藏经》说:“胃气壮,五脏六腑皆壮也。”指出了胃气对人体生命和健康的重要性。

(二)胃气主降 食物经过胃的机械和化学消化后,通过胃气的通降,胃内容即以粥样或糜状状态,少量地逐次通过幽门进入十二指肠。食物由胃排入小肠的过程,中医称降浊,西医称排空,其排空速度以流质最快,半流质次之,固体最慢。排空速度也与食物性质有关:以糖类排空最快,蛋白质次之,脂肪最慢。正常人进食混合性食物需4~6小时才能完全排空。若胃失和降,则会出现胃脘胀满、疼痛、便秘等症。若胃气上逆则见嗳气、呃逆、恶心、呕吐等症。所以临床上治疗胃病常用和胃降逆之法。

(三)喜润恶燥 胃属阳,胃的阳气与胃阴(胃分泌的液质)互相为用,共同维持胃的受纳化谷功能。若胃阴亏虚、津液不足或阳明燥热之证耗伤胃中阴液,则出现烦渴、咽干、舌红少苔、饥不欲食、大便干结等症。故《临症指南医案·脾胃》说:“知饥少纳,胃阴伤也”。若胃阳虚则寒,降纳失职,出现饮食不化、胃脘胀满、呕吐清液等症。

胃



三、小 肠

[形态结构]

小肠居于胃和大肠之间。《难经·四十四难》说：“太仓(即胃)下口为幽门，大肠小肠会为阑门。”《灵枢·肠胃篇》说：“小肠后附脊左环，回周叠积……长三丈二尺”。说明小肠被肠系膜固定于脊柱左环，即从第二腰椎左侧斜行至右髂髌关节之间，故活动性较大。小肠是消化管中最长的一段，上起于幽门，下接于盲肠，全长约5~7m，充满在结肠围成的方框内。从上到下，可分为十二指肠、空肠及回肠三部：① 十二指肠呈“C”定型，可分为十二指肠上部(又称球部)、降部和下部三部。球部肠壁较薄，粘膜平坦光滑，与胃酸接触密切，是溃疡好发部位；降部的后内壁上有十二指肠乳头，其顶部有圆形小孔，为胆总管和胰腺大管的共同开口，胆汁和胰液由此输入小肠之中。十二指肠与空肠交界处有一蔡氏(Treitz)韧带固定于膈角上，手术时可作为分界标志。② 空肠位于腹腔的左上部，管腔较大，壁厚，血供丰富。外观呈粉红色，占系膜小肠的2/5。③ 回肠位于腹腔的右下部，管腔小，壁薄，颜色较淡，占系膜小肠的3/5。但空肠、回肠无明显的分界标志。

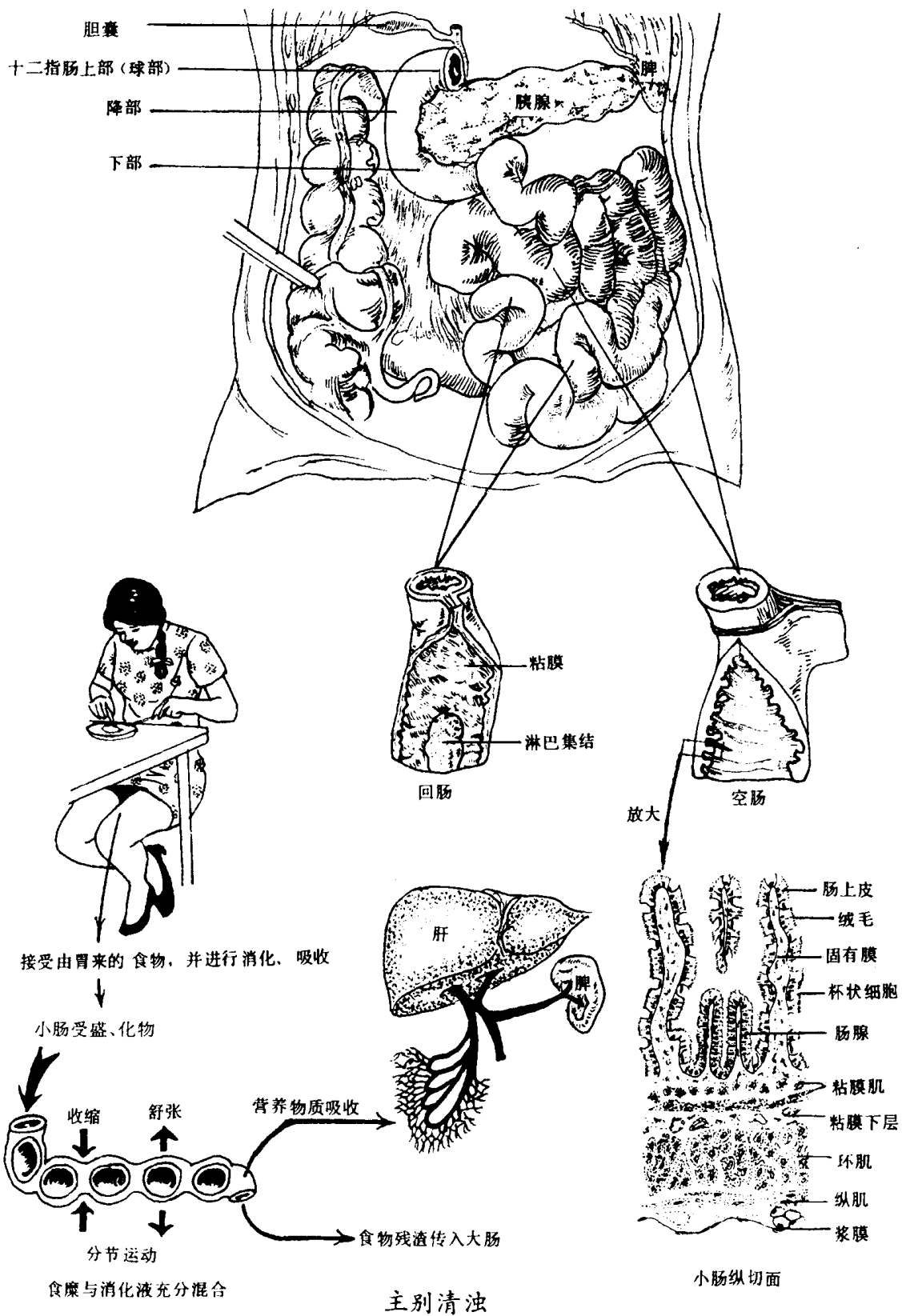
小肠壁由内向外可分四层：① 粘膜层，有很多环形皱襞，粘膜表面布满细小的绒毛。绒毛和皱襞使肠与食糜接触面积增大了30倍，有利于食物的充分消化和吸收。粘膜上皮向下凹陷形成小肠腺，分泌消化酶和粘液，帮助食物的消化并起润滑作用。小肠绒毛内含有丰富的毛细血管、乳糜管和平滑肌纤维，后者舒缩可使绒毛发生伸缩运动，促进营养物质的吸收与运送。② 粘膜下层由疏松结缔组织构成。③ 肌层由内环、外纵两层平滑肌构成。④ 外膜为浆膜。

[生理功能]

(一) 小肠主受盛、化物 《素问·灵兰秘典论》说：“小肠者，受盛之官，化物出焉。”指出小肠接受和容纳由胃传入的食物后，受到胆汁、胰液、小肠液的化学性消化和小肠的分节运动及蠕动，促进食糜与消化液充分混合，增加了小肠内容物与肠粘膜的接触机会，最后，基本上都变成可吸收的小分子物质，经绒毛的毛细血管、乳糜管而吸收。食物通过小肠后绝大部分消化产物被吸收，只留下未经消化的食物残渣推入大肠。若小肠发生病变，既影响食物的接受、容纳，又影响食物的消化、吸收，则会出现纳差、腹胀、腹痛、便溏、消瘦等证。

(二) 小肠主泌清别浊 《医学入门·小肠腑赋》说：“小肠上接胃口，受盛，其糟粕传化，下达其膀胱，广肠，泌别其清浊，宜通。”其意思说，小肠承受胃腐熟的饮食，经其消化而使其精华(“清”的部分)吸收后，通过脾的运化功能，运转到全身各部。“浊”的部分(消化后的糟粕)，下注大肠或渗入膀胱，变成大、小便排出。若小肠病变不能分清别浊，则会出现大便泄泻、小便不利、水谷不分、腹部疼痛等证。

小肠



四、大 肠

[形态结构]

大肠是消化管的末段。《难经·四十二难》说：“大肠重二斤十二两，长二丈一尺，广四寸，径一寸，盛谷一斗，水七升半。”《难经·四十四难》谓：“大肠小肠会为阑门，下极为魄门。”文中“阑门”指结肠瓣处，“魄门”指肛门。这些关于大肠起止、重量、长度的描述，与现代解剖学的记载基本一致。大肠在右髂窝内起至回肠，全程形似方框，围绕于空、回肠周围，末端止于肛门。全长1.5~1.8m。大肠解剖形态有三个特点：①有三条宽约1cm由肠壁加厚的纵肌所构成的结肠带。②由于结肠带短于肠管长度，使肠管呈袋状膨出，两个结肠袋间的粘膜向内突出形成结肠半月襞，此处环形肌较发达。③结肠表面沿结肠带散在许多大小不等的脂肪突起，叫肠脂垂。以上特点是区别大肠与小肠的标志。

在大小肠交界处(阑门)，结肠粘膜形成上、下两个唇状皱襞，叫结肠瓣。该瓣具有阻止结肠内容物逆流回肠的作用，同时该处环形肌显著增厚，起括约肌作用，控制小肠内食糜不致过快地进入大肠，有利于食糜在小肠内得到充分地消化吸收。

阑门下方的结肠盲端叫盲肠，其下端后内侧壁伸出一形似蚯蚓的管状器官，即阑尾。阑门上方的结肠，根据其行走方向和位置，分别称为升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠和直肠。

大肠壁由内向外分为粘膜、粘膜下层、肌层及外膜四层：①粘膜上有结肠半月襞，无绒毛，固有膜内肠腺发达，能分泌大量粘液，起保护粘膜、润滑肠管的作用。一般无消化作用。②粘膜下层为疏松结缔组织。③肌层由内环、外纵两层平滑肌组成。④外膜为浆膜或纤维膜。

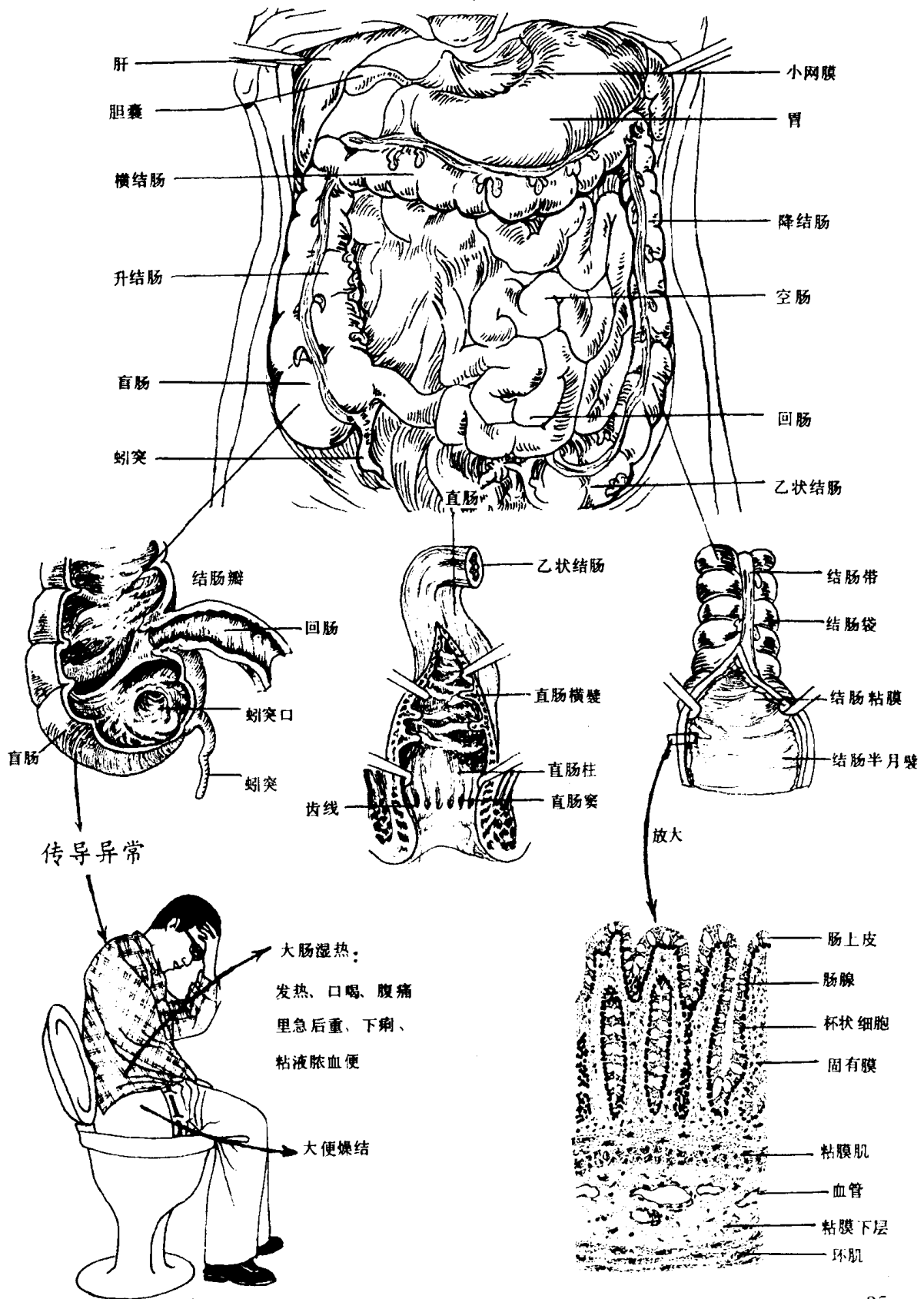
直肠在盆底以上部分肠腔膨大，称直肠壶腹。该处可见2~3个半月状的横襞，作乙状结肠镜检时，较易受到损伤。盆膈以下长约3~4cm缩窄部分，称肛管。该处粘膜形成6~10条纵行皱襞，称直肠柱，各柱下端之间借半月形皱襞相连，构成开口向上的浅凹陷，叫直肠窦。窦内常存积粪屑，易诱发感染。直肠窦与直肠柱下端连成锯齿状的线，叫齿线。该线为粘膜与皮肤移行部，线上为柱状上皮，受植物神经分布，无痛觉，形成的痔为内痔。线下为复层扁平上皮，受脊神经支配，有痛觉，形成的痔为外痔。

[生理功能]

(一) 大肠主传导糟粕 《素问·灵兰秘典论》说：“大肠者，传导之官，变化出焉。”说明大肠是接纳小肠食物残渣、负担传导的器官。所谓“变化出焉”，是指食物残渣在肠内继续吸收水分，同时经过细菌的发酵和腐败作用变成大便。若大便传导失常，则可见：①肠结(急性肠梗阻)，出现呕、痛、胀、闭四大主证。②大肠湿热，出现发热、泄泻、痢疾、腹痛等证。③大肠津亏，出现便秘不通、腹胀痛等证。④肠虚滑脱，出现溏泻、腹痛以及便后脱肛等。

(二) 粪便暂时贮存和排便 大肠的运动少而缓慢，蠕动也较弱，这有利于粪便暂时贮存和水分的吸收。还有一种蠕动强、推进快的蠕动，叫集团运动，它从横结肠中段开始，把粪便迅速推送到降结肠、乙状结肠，当粪便扩张直肠时，引起排便反射，若条件允许则出现排便。

大 肠



五、膀 胱

〔形态结构〕

膀胱又名“尿泡”、“净府”、“水府”、“玉海”、“脬”，是一个肌性囊状贮尿器官。《难经·四十二难》记载：“膀胱重九两二铢，纵广九寸，盛溺九升九合。”说明膀胱位于下腹部，是储存和排放尿液的器官。成人的平均容积约350~500ml。《类经图翼》说：“膀胱当十九椎，居于肾之下，大肠之前，有下口。”正常成人膀胱非充盈状态时，位于盆腔，相当于骶、尾骨前方。男子膀胱后方是精囊与直肠；女子膀胱则位于宫胞与直肠之前。膀胱下口，处于膀胱底部的膀胱三角前下方的尿道内口。《医学入门·膀胱腑赋》说：“膀胱上口阔二寸……无出窍也。”膀胱上口有二个，即左、右输尿管口。所说“上口阔二寸，”可能是指左、右上口之间距离而言。所谓“无出窍也”可能是一种谬误。

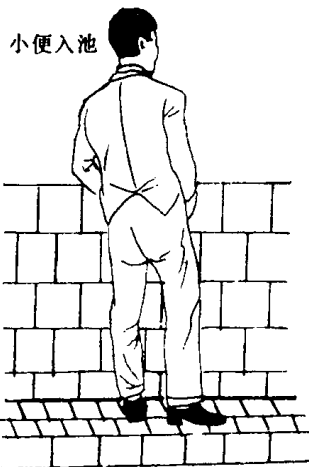
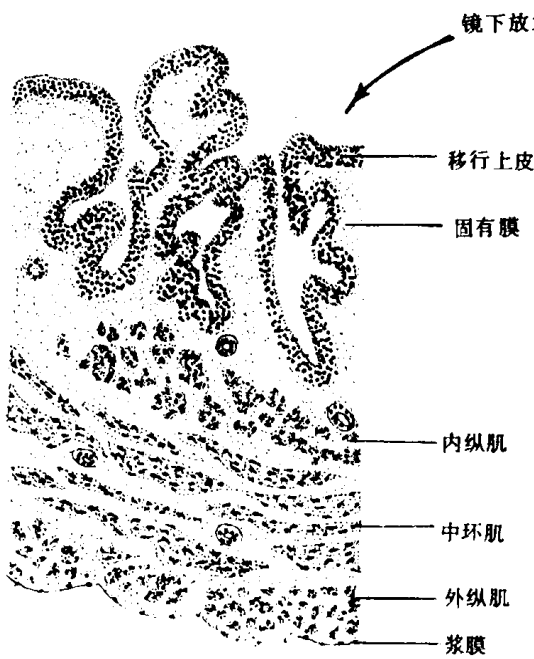
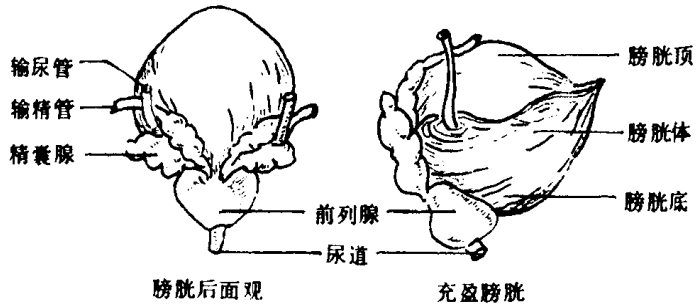
膀胱壁结构分三层：① 粘膜层由移行上皮和固有膜构成。粘膜形成很多皱襞，在膀胱充盈时皱襞消失，这种结构使膀胱富于伸缩性。在膀胱底部，有一三角区，称膀胱三角。该区粘膜无论空虚或充盈状态均无皱襞，此三角区是肿瘤或结核的好发部位，也是作膀胱镜检查时内部定位的标志。② 肌层较厚，由内纵、中环和外纵三层构成，排尿时收缩，故称逼尿肌。在尿道内口处肌肉交叉环绕构成膀胱内括约肌。③ 外膜，大部分为纤维膜，只在膀胱顶附近有浆膜覆盖。

〔生理功能〕

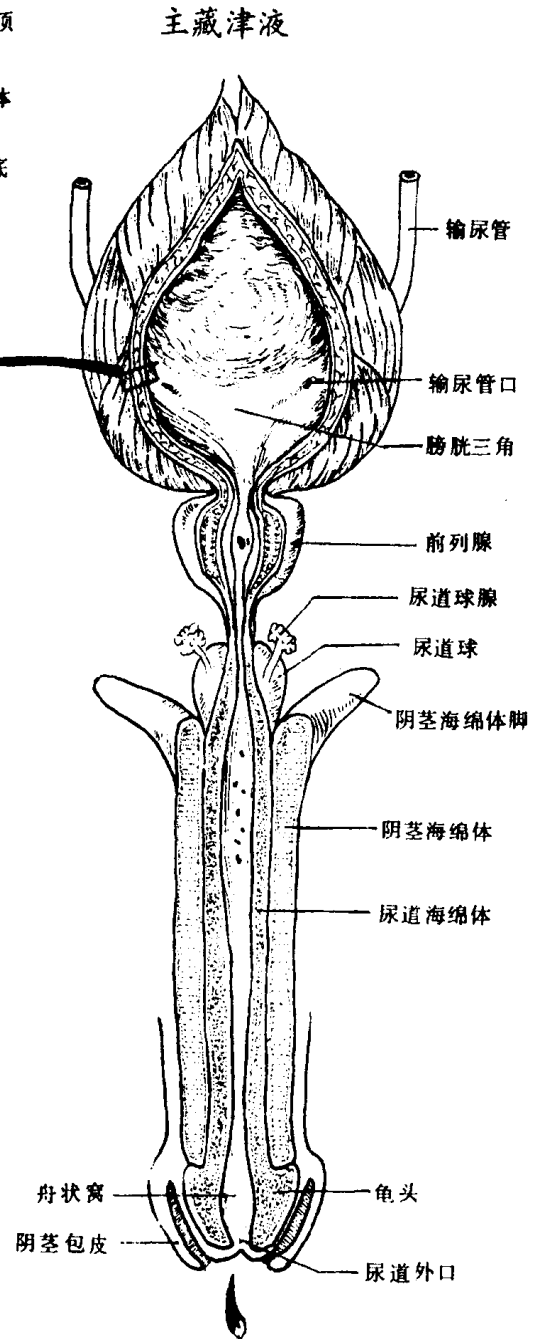
（一）膀胱主藏津液 《素问·灵兰秘典论》说：“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。”《中藏经》说：“膀胱者，津液之腑也，与肾相表里，号水曹掾，名玉海也。”指出膀胱有贮藏津液的功能。此处“津液”是指体液及代谢产物，而非指饮食精微，通过胃、脾、肺、三焦等脏腑的作用生化的营养物质。所以《灵枢·五癯津液别篇》说：“水下留于膀胱，则为溺与气。”溺者，尿液也。气者，可能指尿中含有的容质。清代医家张志聪注：“气者，……，化生太阳之气”也。膀胱是贮尿器官，当膀胱与肾的气化功能减弱时，则出现津液代谢障碍，见下腹胀、小便不利、水肿等症。

（二）膀胱主排泄尿液 排尿是一个复杂的反射过程。肾脏不断地生成尿液，而膀胱排尿是间歇性的。当膀胱内尿贮量达400ml左右时，膀胱内压升高而刺激了膀胱压力感受器，通过盆神经传入腰骶髓排尿初级中枢并上传大脑皮层产生尿意，再由大脑皮层向下发出指令，引起盆神经兴奋，使膀胱壁收缩，内括约肌松弛而促成排尿。这一复杂反射的全过程，中医以“三焦气化”而概括之。《类证治裁·小便不通》说：“是知膀胱主藏溺，必待三焦气化，乃能出水也。”《素问·灵兰秘典论》说：“三焦者，决渎之官，水道出焉。”此处三焦泛指水液通行的通道，意思是说膀胱贮藏的尿液，通过三焦气化作用，才能经尿道排出体外。若膀胱气虚时，可出现遗溺；如膀胱湿热时，则出现尿频、尿急、尿痛、尿液混浊、血尿或尿路结石等症。

膀胱



- 尿量异常 { 多尿
少尿
无尿
- 尿色异常 { 血尿
乳糜尿
尿液混浊
- 排尿障碍 { 尿滴滴
尿滞留



主藏
主排泄 小便

六、三 焦

〔形态结构〕

三焦，中医六腑之一，是人体最大的腑，是上、中、下三焦的统称。《类经》说三焦是“藏府之外，躯体之内，包罗诸藏，一腔之大府也。”因位脏腑之外故有外腑、孤脏之称。《灵枢·营卫生会篇》说：“上焦出于胃上口，开咽以上，贯膈而布胸中。”“中焦亦并胃中，出上焦之后。”“下焦者，别回肠，注于膀胱，而渗入焉。”《难经·三十一难》说：“三焦者，水谷之道路，气之所终始也。”《素问·灵兰秘典论》说：“三焦者，决渎之官，水道出焉。”上述论述，大体将人体躯干所辖的脏腑，划分为上、中、下三个部分。从咽喉至胸膈属上焦；脘腹属中焦；少腹及二阴属下焦。其功能为主持诸气，疏通水道。现代医学无“三焦”名，引起诸多学者的研究探讨，以“胸腹腔说”令人信服，其说要点为：人体胸腹腔即中医学的三焦，系“一腔之大府”，位“躯体之内”，“包罗诸藏”、“藏府之外”的间隙。通过横膈膜将胸腹腔划分为胸腔和腹腔。通过腹膜将腹腔划分为腹膜内腔和腹膜后腔。胸腔相当于上焦，上界为口咽，下界为横膈，内包罗心、肺、心包三个脏腑外，尚包括出入心脏的大血管、气管、支气管、神经和胸导管等“血、气、水谷之道。”腹膜内腔为中焦，上界为横膈，下界为下腹膜，内包罗脾、胃、肝胆、小肠等五个脏腑。腹膜后腔为下焦，上界为下腹膜和横膈的后部，下界由提肛肌、尾骨构成，包罗的组织有肾、肾上腺、膀胱、大肠等脏腑外，尚有输尿管、腹主动脉、下腔静脉、腹腔神经丛及腰交感干等“水道”、“血道”、“气道”。肝脏按解剖位置位于腹膜内腔，但其生理、病理与肾密切相关，古有“肝肾同源”之说，故肝、肾同属下焦。

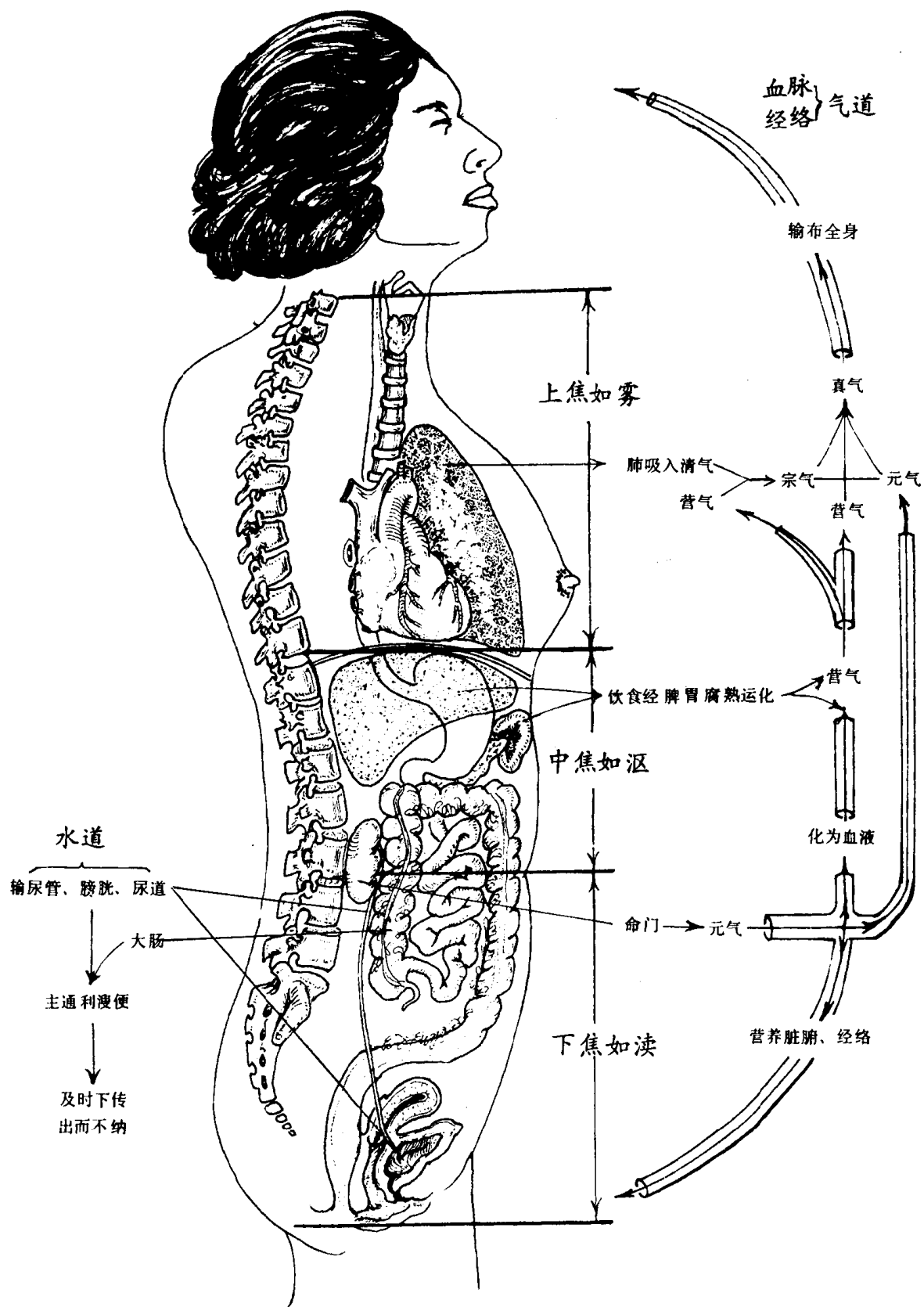
〔生理功能〕

（一）三焦有主持诸气，总司人体气化作用 中医学认为，肾生化的元气是生命活动的原动力，必须经三焦的通道，敷布全身，以激发、温煦、推动各脏腑组织器官的功能活动。所以《难经·六十六难》说：“三焦者，原气之别使也。主通三气，经历于五脏六腑。”所谓“元气”者，相当于现代医学的神经——体液调节系统（详见生理学有关内容）。

（二）三焦是运行水液的通道 中医学认为：脾运化水湿，肺通调水道，肾主管水液代谢，膀胱藏津液，浊者成尿排出，清者由肾阳蒸腾化气上升，运化和濡养全身，均需借三焦为道路，包括通行水谷的食道、胃肠道和水液代谢的输尿管、尿道及动静脉系统。

（三）三焦的分段功能 元气通过三焦运行全身，在上、中、下三焦，经过不同的脏腑发生不同的气化作用。上焦主宣发敷布，即通过心脏的舒缩、肺部的气体交换，将饮食物的水谷精微和肺部的精气布散全身，以温养脏腑、经络、身形，通调腠理。《灵枢·营卫生会篇》形容为“上焦如雾”，按现代医学理解，即肺吸入的清气（氧气）与脾胃腐熟运化的营气充分地如“雾”样地混合、渗透。中焦主腐熟水谷，是指脾胃的消化饮食、吸收精微，蒸化津液，使营养物质生化为营血。《灵枢·营卫生会篇》将这一功能形容为“中焦如沤”。沤，形容水谷腐熟为乳糜状的精微，有利于吸收。下焦的主要功能是分别清浊，渗入膀胱，排泄尿粪，其气主下行。所以《医学入门·三焦腑赋》说：“下焦主通利溲便，以时传下，出而不纳，开通秘塞，故曰下焦如渌。”“渌”是渠道，水道的意思。

三焦



第三节 奇恒之腑

一、脑

[简介]

脑,为奇恒之腑之一,又名神脏、髓海、脑筋、头髓等,指颅腔中的髓质,下通脊髓。《灵枢·海论》说:“脑为髓之海,其输上在于其盖,下在风府。”明确指出脑的范围是上至顶盖,下至风府穴(相当于枕骨大孔与第一颈椎之间凹陷处,其深部为小脑延髓池)。说明中医学的脑与现代解剖学的脑相同。

脑可分为脑干、小脑、大脑两半球三部分:① 脑干自下而上又分为延髓、脑桥、中脑和间脑。延髓在枕骨大孔处与脊髓相连,内有重要的呼吸、心血管等中枢。脑桥位于延髓与中脑之间,其两侧有桥臂以连接小脑。在脑桥、延髓和小脑之间的腔隙即第四脑室。中脑介于脑桥与间脑之间,中脑背面有四个小丘:一对上丘是视觉反射中枢;一对下丘为听觉反射中枢。间脑被两侧大脑半球掩盖,可分为丘脑、丘脑下部,间脑的室腔为第三脑室。整个脑干含有第Ⅲ~XII对颅脑神经核及脑干网状结构。② 小脑,位于颅后窝,在延髓及脑桥的背侧,小脑的功能是稳定身体重心,维持躯干平衡及保证肢体共济运动。③ 大脑由两侧大脑半球、基底节和侧脑室所组成,两半球由胼胝体相沟通。大脑半球表面凸凹不平,隆起部称回,凹陷部称沟。最显著的沟是大脑外侧裂和中央沟,由这些裂、沟将大脑分为额、顶、颞、枕四叶。半球的表层为大脑皮层,由大量的神经细胞分层排列,细胞之间有广泛的突触联系,皮层是具有对外界输入信息进行加工、储存、分析、综合及产生调节、控制心理活动的重要部位,也是构成意识、思维和语言、文字书写的物质基础。

[生理功能]

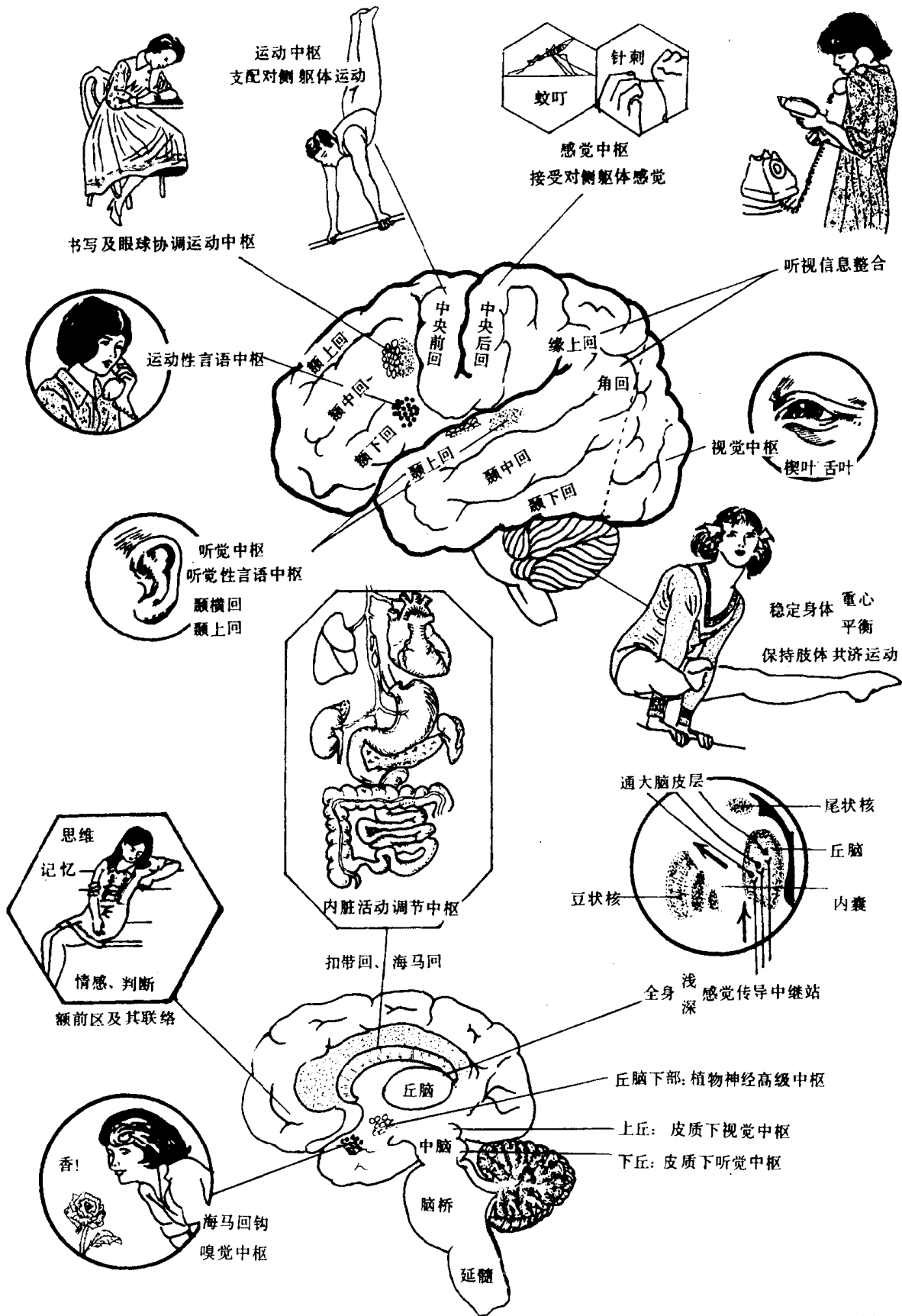
中医学对脑的生理功能有一定的认识,如明代李时珍首次提出“脑为元神之府”,说明了脑与精神活动有关。《医林改错》进一步发挥说:“灵机记性在脑者……两耳通脑,所听之声归于脑;两目系如线长于脑,所见之物归入脑;鼻通于脑,所闻香臭归于脑。”把智力、记忆、视、听、嗅等感官功能,统归于脑。但在中医脏腑学说中,把感觉、动作、思维等精神活动分别归于五脏。如心藏神(指精神状态),肝藏魂(指听,视等知觉),肺藏魄(指运动,即所谓魄力),脾藏意(指思维意识),肾藏志(指意志)。这是长期实践基础上的总结,因而在辨证和治法中常与脏腑相联系。如“痰迷心窍”、热入心包、“肝气郁结”、“肾精不足”等证都有现代医学“脑”功能或器质病变的表现。在治疗上也采用“清心开窍”、“养心安神”、“疏肝理气”、“填精补髓”等,包括了“脑”病症的治疗。

1. 大脑皮层各部位在功能上有一定的分工,构成了不同的中枢,如额叶的中央前回为对侧躯体运动中枢;额中回后部为书写和眼球协调中枢;左侧额下回后部是运动性语言中枢;额前区与人的记忆、判断、抽象思维及情感有关;顶叶的中央后回,接受对侧躯体感觉;缘上回和角回将视、听所获得的信息进行整合;顶叶还与人的定时、定位、定向功能有关;颞叶的颞上回、颞横回为听觉性言语中枢;枕叶的楔叶、舌叶为视觉中枢;大脑半球内侧面的扣带回、海马回为内脏活动调节中枢;海马回钩为嗅觉中枢。

2. 脑干中的丘脑,是全身浅、深感觉传导中继站。丘脑下部为植物神经系统高级中枢;脑干和间脑中的网状结构的上行激活系统可促进大脑皮层兴奋、保持清醒,抑制其冲动传导则引起睡眠。

3. 小脑的主要功能是保持肢体共济运动的协调,维持躯干平衡和重心稳定。

脑



二、髓

[简介]

髓为奇恒之腑之一,指现代医学的脊髓和骨髓。因皆藏于骨腔之中,中医学统称为髓,直到《全体新论疏证》才将其区分为:“脊中之髓,本是脑之一系,下行以分布神经于肢体百骸者,原与胫臂骨中之髓,绝非同类。”中医认为髓由肾的精气与水谷精微所化生,有充养骨骼、补益脑髓的作用。故《素问·脉要精微论》说:“骨者髓之府”,《素问·逆调论》说:“肾不生则髓不能满”。

(一) 脊髓 位于椎管内,呈扁圆柱形,长40~45cm,上端平枕骨大孔与延髓连续。下端尖细称脊髓圆锥,止于第一腰椎下缘。有两处较膨大:①颈膨大(颈₄~胸₁)。②腰膨大(胸₁₂~腰₂)。内含多量与上、下肢神经有关的神经元。脊髓表面前、后正中处各有一条纵沟,分别称为前正中裂和后正中沟。脊髓全长分31个节段(8个颈节、12胸节、5个腰节、5个骶节、1个尾节),发出31对脊神经。每对脊神经含有感觉和运动神经纤维,胸₁~腰₃对脊神经还含交感神经纤维,骶₂~4节含有副交感神经纤维。因此,每对脊神经分段管理身体一定部位的皮肤、肌肉、内脏的感觉和运动。脊髓横断面观:正中有一中央管,管周围可见呈蝶形的灰质,是神经元胞体聚集的地方。前端两翼膨大称前角,含运动神经元,发出轴突组成脊神经前根,主要支配骨骼肌,蝶形后端称后角,为联络神经元,接受后根传入感觉信息。胸₁~腰₃节段前后角之间有侧角,是交感神经元聚集处,其轴突经前根出脊管后组成交感神经。脊髓骶₂~4节无侧角,但含副交感神经元,发出轴突经前根出脊管后组成盆内脏神经。脊髓灰质周围为白质,是上、下神经束的通道。

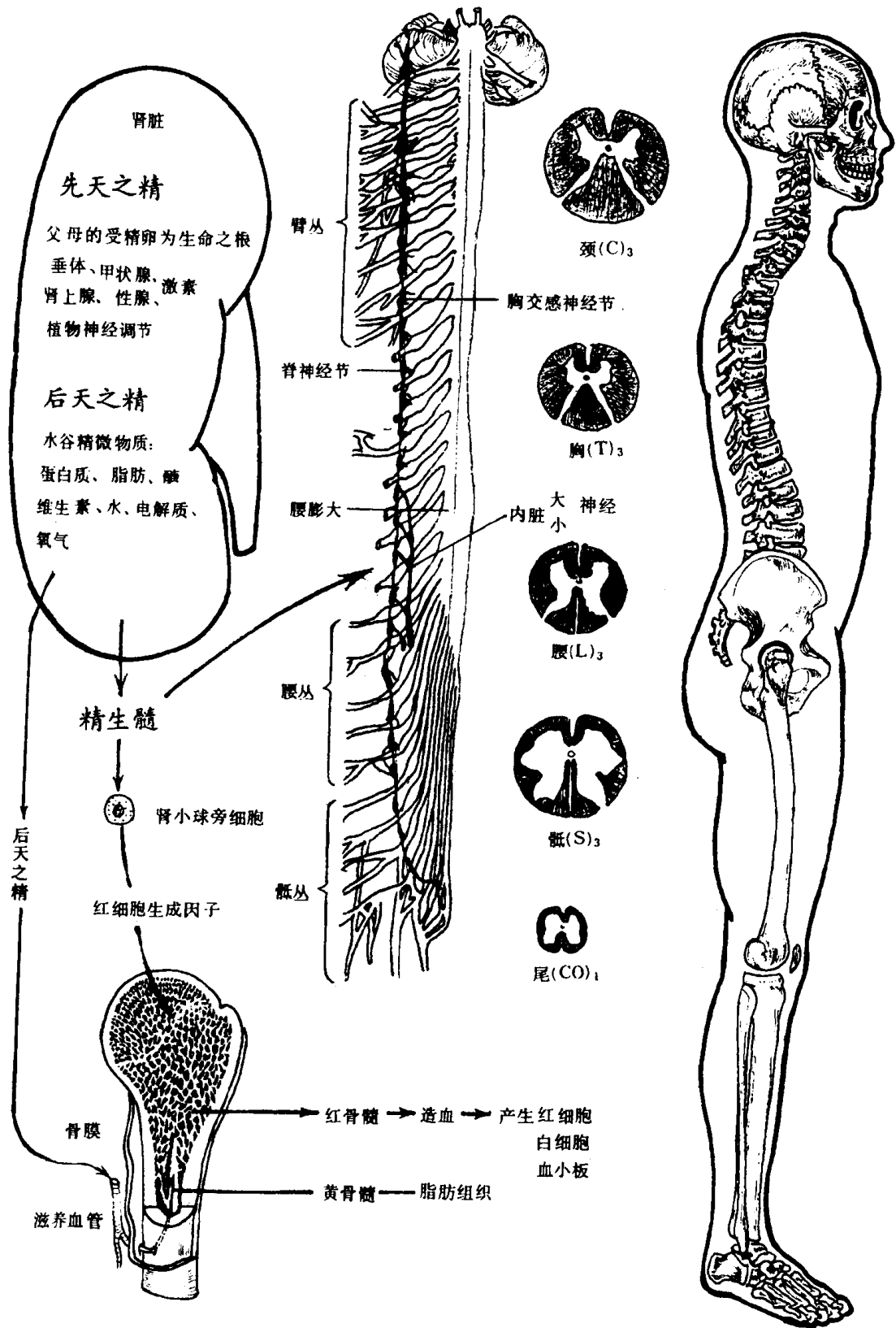
(二) 骨髓 位于骨髓腔中,充填于骨松质内。有红骨髓和黄骨髓之分。红骨髓为造血器官,能生成红细胞、白细胞、血小板。在胎儿和幼儿期全为红骨髓,随年龄增长,长管骨干腔红骨髓为脂肪所代替,成为黄骨髓,失去造血功能。但长骨的骨骺、短骨和扁骨终生为红骨髓。

[生理功能]

(一) 脊髓的生理功能 ① 传导功能:人从内外环境接受的信息,都通过脊神经的感觉纤维传入经上行纤维传到大脑皮层的相应区域,经过高级神经中枢的整合,加工,形成感觉、知觉和表象,然后经下行纤维传递到脊髓前角,通过传出神经引起相应的躯体和内脏活动。脊髓是上、下行神经纤维的中继站,一旦脊髓横断性受损,立即出现受损以下躯干的运动、感觉丧失,相应的内脏功能也发生障碍。② 脊髓也是神经反射的初级中枢,能完成骨骼肌和某些内脏活动的简单反射,如生理反射中的腹壁反射、提睾反射、肱二头肌反射、膝腱反射,以及排便、排尿反射都可不经脑的神经通路而发生,但仍受脑的调节、控制。一旦脑或锥体束受损,上述反射也会出现亢进或消失改变,临床上通过检查生理反射、病理反射及痛、温、本体感觉检查和轻瘫试验等,来了解中枢神经系统病变。

(二) 骨髓的生理功能 主要是造血,不断地生成红细胞、白细胞和血小板,另外,骨髓又是人体网状内皮系统的器官之一,参予机体的免疫防御机能。

髓



三、脉与脉管系

[简介]

脉属奇恒之腑之一。中医学对脉的研究有独特之处,切脉是重要的诊断手段。《灵枢·邪气藏府病形》说:“按其脉,知其病”。对脉管的形态、结构也早有论述,认为是气血运行的通道。《素问·脉要精微论》说:“夫脉者,血之府也”,称为血脉。《黄帝内经灵枢集注》对脉管内的血液循环不息的流动作了精辟的概述:“昼夜环转,无所违逆,是谓脉……循于脏腑身形。”与现代医学对心血管系的概述完全一致。血管系包括心脏、动脉、静脉和毛细血管。中医学用“心主身之血脉”一句话说明了心脏的收缩推动了血液的流动。动脉的名称与现代医学相同,如《难经·一难》说:“十二经皆有动脉。”“寸口者(桡动脉),……手太阴之动脉也。”“颈侧之动脉人迎(颈总动脉)……足阳明也。”还有趺阳脉系足背动脉等等。静脉被称为“血络”、“青脉管”,如《全体新论疏证》谓:“青脉管,不跳动”指的是表浅部位的静脉血管,对脉管细小的分支称为“孙络”或“孙脉”。如《类经》七卷说:“凡人遍体细脉,皆肤腠之孙络也。”意思是细小的脉管分支,遍体密布、纵横交错,相当于现代医学所指的细小动脉、毛细血管、细小静脉与淋巴系的统称。鉴于历史的原因,中医对脉管的论述仍停留于表面的、宏观的范畴,没有及时地将现代医学有关知识溶于中医的理论体系,既妨碍了中医学走向世界,又使中医独特的、精湛的切诊,披上了神秘的色彩,难于被广大西医掌握。

[生理功能]

由心脏输出的血液,通过血管系统输送到全身各组织,并通过细胞间液与组织细胞进行物质交换,然后血液又经血管系统回到心脏。因此,脉管的机能就是输送血液,分配血量和进行物质交换。各类血管的特征是与其机能相适应。

(一) 大动脉 管壁较厚,含弹力纤维较多,故坚韧而富有弹性。心脏收缩时管壁扩大;心脏舒张时,管壁弹性回缩,可推动血液继续流动。这类动脉包括主动脉、头臂动脉、颈总动脉和肺动脉。

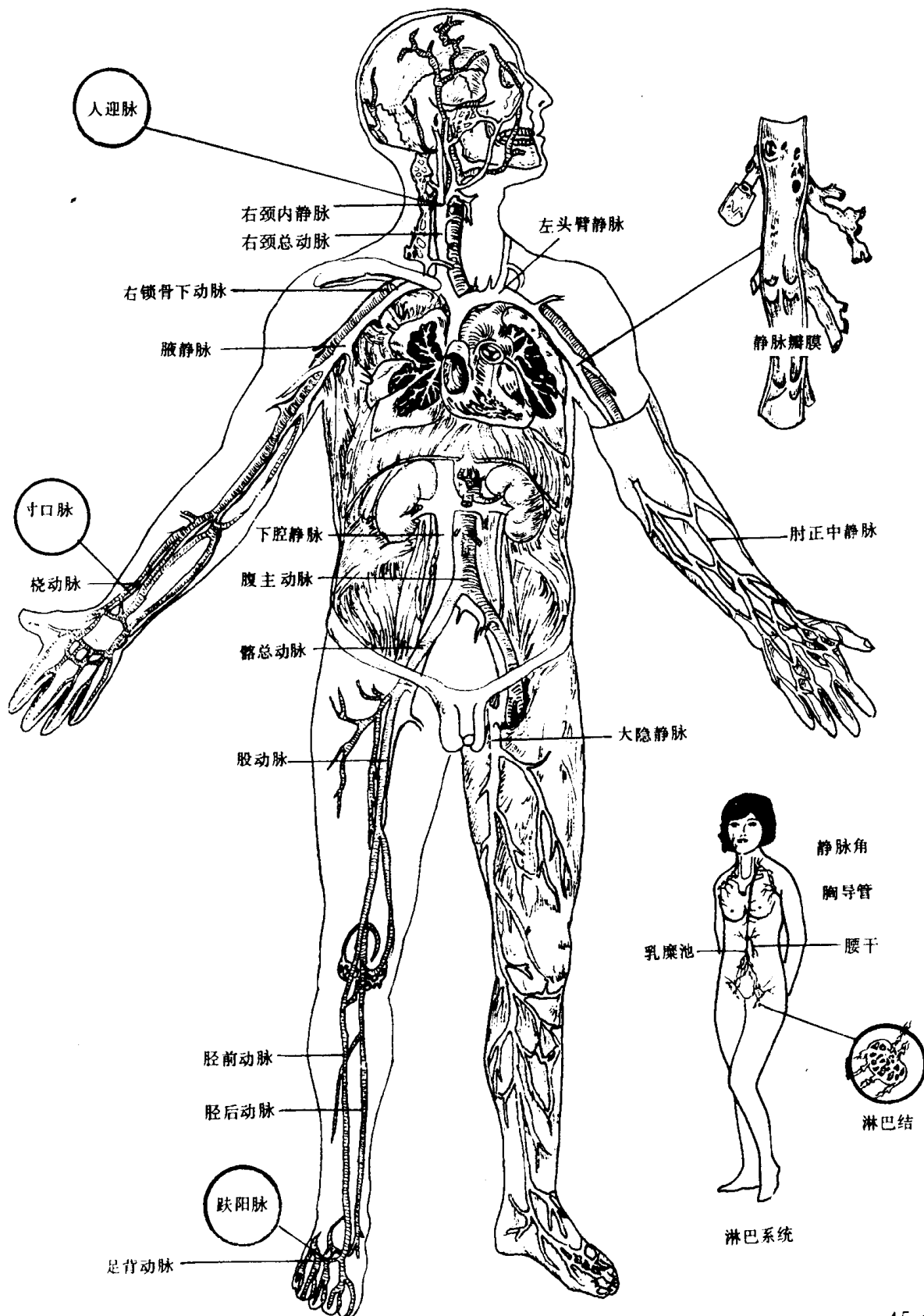
(二) 阻力血管 由中动脉(解剖学上有名称的动脉)和小动脉(解剖学上无名称,直径在 $20\mu\text{m}$ 以上的动脉)组成,这类动脉的特点是中膜平滑肌丰富,血管口径逐渐缩小,血液流动时遇到的摩擦力较大,是调节血压和控制微循环血流量的主要部位。中医的切脉就是在这类血管上触诊的。西医对中医的数脉、迟脉、洪脉、细脉、浮脉、沉脉,以及结代脉的产生机理都能够从心脏收缩的速率、节律和强度上进行解释,但对滑脉、涩脉、弦脉、紧脉等产生机理迷惑不解,这无疑影响了西医的掌握。

(三) 毛细血管 数量极多,其管壁仅由一层内皮细胞组成,管壁极薄,通透性大,是血液与组织细胞间进行物质交换的部位。中医学所称的“卫气”(组织间液)即在此处溢出血管。

(四) 静脉 汇集由毛细血管来的血液,由微静脉→小静脉→中等大静脉→大静脉(如上、下腔静脉、肺静脉)→心房。整个静脉系统是一个大储血池,正常情况下容纳全身血量的50%~70%,故又称容量血管。四肢的静脉管内有瓣膜,可防止血液逆流。

(五) 淋巴系 是脉管组成部分,起源于组织间隙的毛细淋巴管,回吸收约10%的组织液成为无色透明的淋巴液,毛细淋巴管逐渐汇集成较大淋巴管,途中流经淋巴结后有大量淋巴细胞加入淋巴液,最终经淋巴导管流入静脉角。它也是一个分布全身的管导系统。淋巴结具有产生淋巴细胞、过滤淋巴液、扣留和吞噬淋巴液中微生物和癌细胞的作用。

脉及脉管系



四、女子胞与子宫系

[简介]

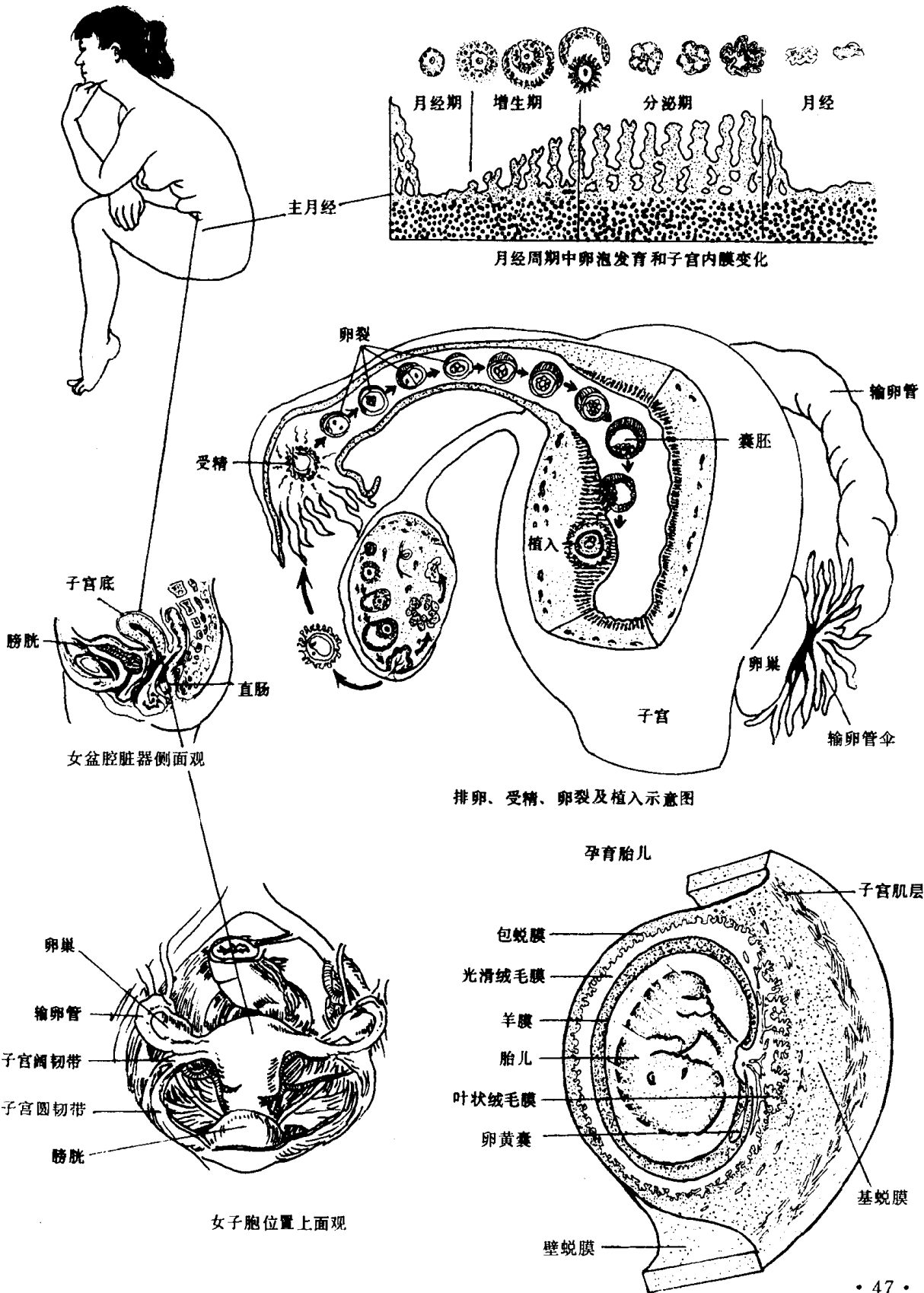
女子胞，奇恒之腑之一。又名胞宫、胞脏、子宫、子脏等。女子胞有主月经、受孕、孕育胎儿的功能，它包括妇女整个内生殖器官：卵巢、输卵管、子宫、阴道。① 卵巢，是一对拇指大小的生殖腺，可产生卵细胞和女性激素，位于子宫两侧，盆腔侧壁的凹陷中，中医学称为“子核”。② 输卵管是一对弯曲的长管，长约10~12cm，内侧端与子宫角相连，开口于子宫腔，外侧端靠近卵巢，开口于腹腔。内侧1/3较细窄，叫输卵管峡。外侧2/3管腔较宽大，称输卵管壶腹。末端扩大如漏斗状，周缘有锯齿状突出，叫输卵管伞。③ 子宫，形如倒置的梨形，为一厚壁的肌性器官，其上端圆凸，称子宫底，中部为子宫体，子宫体的内腔为子宫体腔，呈前后扁的倒置三角形，下端缩窄称子宫颈，其下半突入阴道。④ 阴道为前后略扁的肌性管道，其壁富伸展性。上述形态结构在《类经》描述为：“子宫，一系在下，上有两歧，中分为二，形如合钵，一达于右，一达于左。”所谓“上有两歧，中分为二”指上有二条输卵管，中分细窄和宽大两部分。“形如合钵”似指卵巢，“一系在下”为阴道。

[生理功能]

(一) 主月经 月经中医又称月事、月信，为女子胞的卵巢所主。《类经治裁》说：“谓之月事者，女子属阴，其血如潮，应月之盈亏，有常期者也，故谓之经。”《素问·上古天真论》说：“女子……二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。……七七任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏而无子也。”所谓“天癸”，指性成熟分泌性激素。上述论述说：女子十四岁，性成熟，子宫内膜发生周期性增生、脱落出血，形成月经。此时起女子具有生育能力。至49岁，卵巢分泌性激素功能停止，不再排卵，进入绝经期。

(二) 受孕、孕育胎儿 《类经》三卷说：“男女，阴阳之仪象也，阴阳交媾，胎孕乃凝，所藏之处，名曰子宫。”《沈氏女科辑要笺正》说：“男女媾精……归于左右子宫之系”，指出成熟的精子与卵子在输卵管壶腹部结合受精。《类症治裁》说：“妇人受孕，则月事不行”，“受孕一月名胚胎，……四月形体成……五月男女分……十月……脏腑齐通，纳天地气于丹田，俟时而生。”所述受精部位、胚胎在子宫内孕育成足月胎儿的过程，与现代医学妊娠生理研究的成果一致。卵子与精子在输卵管壶腹部结合受精，孕卵靠输卵管的蠕动和内膜纤毛的摆动，逐渐移向宫腔。在运送过程中，孕卵不断分裂，约3~4天呈桑椹状为桑椹胚，继续分裂6~8天形成囊胚，分泌一种蛋白酶能溶解子宫内膜并逐渐埋入，在11~12天完全植入。妊娠开始的8周为胎体的主要器官发育形成时期，称胚胎；8周后称为胎儿；胚16周末(胚4周)骨骼系统发育，孕妇能感胎动，从外生殖器已可辨认男女；胚20周已可听到胎心音，早产后有心跳、呼吸、排尿及吞咽能力；第40周末，完全成熟，身长约50cm，体重约3000g以上，皮肤呈粉红色，皮下脂肪丰满。正常的孕妇乳房已充分发育。在分娩前2~3周自觉腰酸，伴有不规则宫缩，分娩开始前24~48小时，阴道“见红”，预示不久将临产，即所谓“脏腑齐通，纳天地气于丹田，俟时而生”矣。

女子胞与子宫系

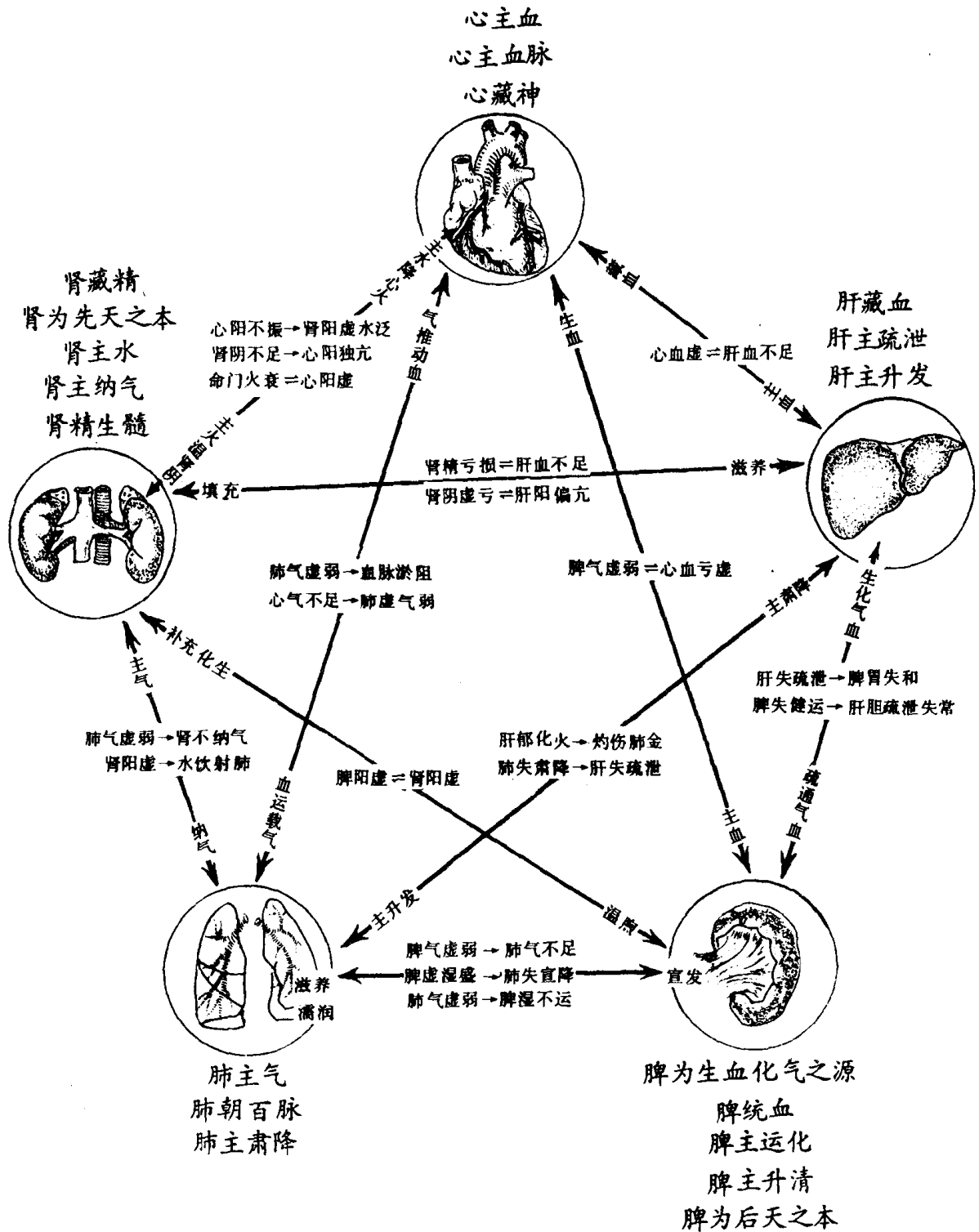


第四节 脏腑相关生理

一、五脏间的相互关系

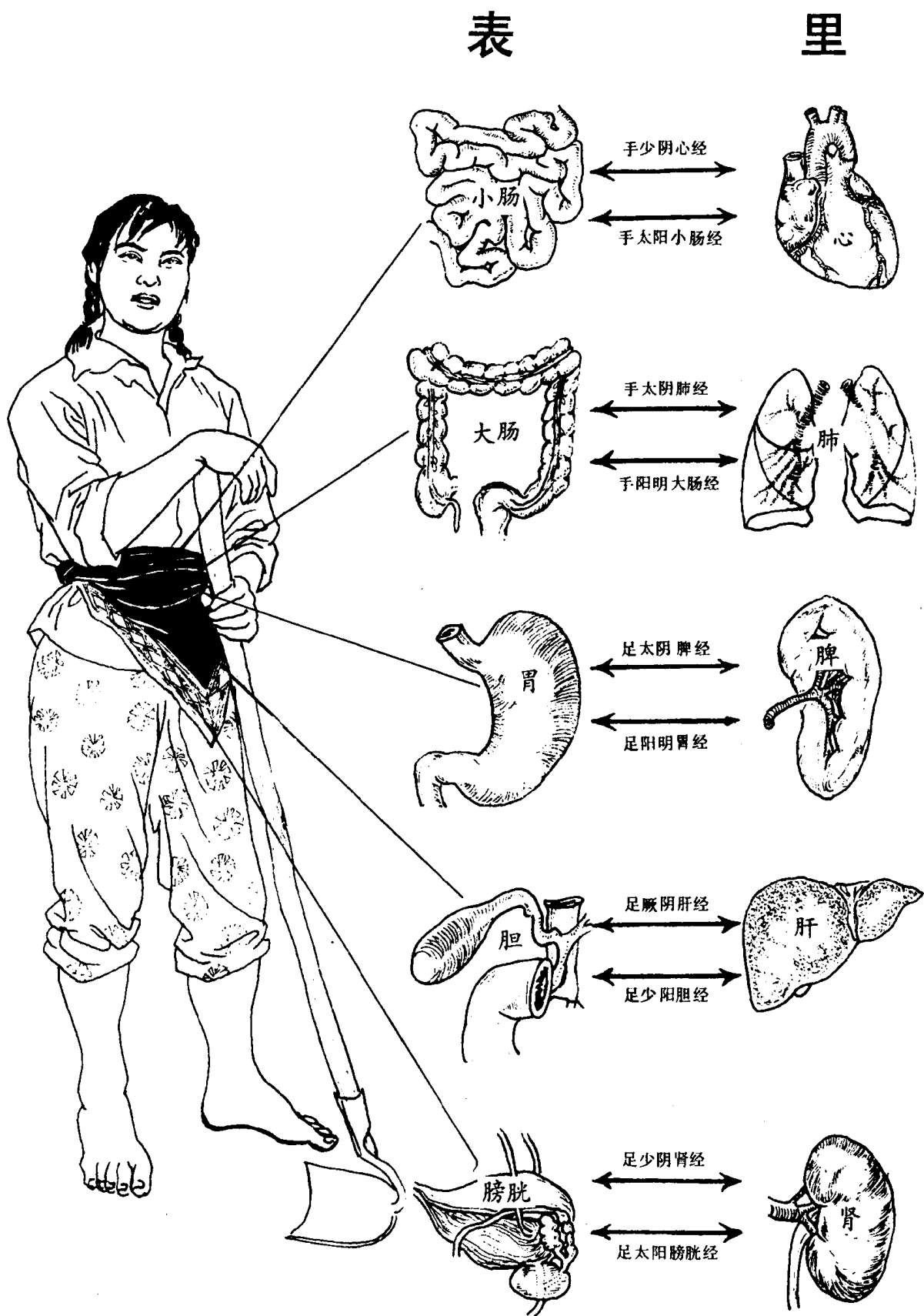
	生理上联系	病理上影响
心与肺	心主血,肺主气;心主血脉,肺朝百脉。同居上焦,位置比邻。 气推动血的运行,血运载气,相互依存。气为血之帅,血为气之母。	肺气虚弱,宗气不足→血脉瘀阻,见胸闷、气短、心悸、唇舌青紫等证候。 心气不足或心阳不振→肺虚气弱,见咳嗽喘息、心悸怔忡、心胸憋闷等症。
心与脾	心主血,推动血液在经脉里运行。 脾统血,统摄血液循环正常轨道运行。 脾气健运则心血充盈。 脾气与心血,相互促进,相互依存。	脾气虚弱,化源不足→心血虚亏→心脾两虚 心血虚脾失所养 脾两虚,见心悸、失眠、食少、腹胀、面色无华等证候。
心与肾	心居上焦,属阳,主火;肾居下焦,属阴,主水。心火降于肾以资肾阳,共同温煦肾阴。肾水上济于心以资心阴,共同濡养心阳。肾阳(命门火)与心阳(心火)相互温养、协调。	心阳不振,不能下温肾阳→肾阳虚水泛,见心悸、水肿、气短等水气凌心病症。肾阴不足,不能上济于心→心阳独亢。见心烦、失眠、多梦、遗精、腰酸等心肾不交证候。命门火衰,不能温养心阳→心阳虚。
心与肝	心主血脉,推动血行;肝藏血,调节血量。肝主疏泄,疏通气血,使血液不致瘀滞,有助于心对血的推动。	心血虚→肝血不中→导致心、肝血虚,见头晕目眩、心悸、失眠、面色无华、视力减退、月经涩少等证候。
肝与脾	脾气健运→生化水谷精微充足→则肝血来源旺盛。肝主疏泄,分泌胆汁→则保持食物消化、吸收转输正常。肝藏血,脾统血,共同维持血液正常运行。	肝失疏泄,气机郁滞→肝胃不和或肝脾不调。见胸胁、胃脘胀痛、易怒、郁闷、嗳气吞酸、食少、腹泻、大便失常等症状。脾失健运→肝胆疏泄失常,见黄疸、脘腹痞闷、呕恶厌食、便溏、尿黄等症。
肝与肺	肝主升发 } 升降协调→保持人体气机升降正常 肺主肃降	肝郁化火→灼伤肺金,见胁痛、急躁易怒、咳逆、气急、咯血等肝火犯肺证候。肺失肃降→肝失疏泄,见咳嗽、胁痛、头晕、头痛、面红目赤等症。
肝与肾	肝藏血、肾藏精同属下焦,相互资生。肝血有赖于肾精的滋生化。肾精有赖于肝血所化之精的填充。	肾精亏损→肝血不足,见腰脊酸痛、遗精、耳鸣、头晕、目眩、眼干涩等症。 肾阴虚亏→肝阳上亢,见头痛、目赤、急躁易怒、腰痛、遗精、耳鸣等证候。
脾与肺	脾主运化,需肺气宣发和通调水道。肺宣发,需脾运化水谷精微不断滋润濡养。	脾气虚弱→肺气不足,见少气懒言、语言低微、食少、体倦无力等症状。 肺气虚弱→脾湿不运,见咳嗽、痰多、腹胀、便溏、浮肿等证候。
脾与肾	脾为后天之本,肾为先天之本。脾运化有赖于肾精促进和肾阳的温煦。肾藏精有赖脾运化水谷精微的滋养补充。	脾阳虚→肾阳虚,见形寒肢冷、食少、神疲、周身浮肿、小便不利等症。
肺与肾	肺主呼吸之气,肾主纳气。肺为气之主,肾为气之根。肺气肃降、通调水道。肾为水脏,主管水液代谢。	肺气虚弱→肾不纳气,见呼多吸少、喘促气短、声低气怯等证候。肾阳虚→水饮射肺,见畏冷、浮肿、小便不利、咳痰、喘息等症。

五脏间的相互关系



二、五脏与六腑间的相互关系

	生理上联系	病理上影响
心与小肠	小肠为阳↔心为阴。 小肠为表↔心为里。手少阴心经属心络小肠。手太阳小肠经属小肠络心。心火下降→有助于小肠分清别浊。小肠下行→有助于心火下降。	心火上炎,通过经脉下传→移热于小肠。引起尿少、尿赤、排尿灼热、涩痛等小肠实热症状。 小肠实热,循经脉上熏→于心引起心烦,舌赤糜烂等症状。
肺与大肠	大肠为阳↔肺为阴。 大肠为表↔肺为里。手太阴肺经属肺络大肠。手阳明大肠经属大肠络肺。肺气肃降、津液四布→濡养大肠、传导糟粕正常。大肠传导通畅→有助于肺气肃降下降。	肺热壅盛、津液不能下达→大肠传导不及。引起发热、咳痰、喘息、大便秘结等症状。 大肠实热,腑气不通→累及肺失肃降。引起胸满、喘逆等症状。
脾与胃	胃为阳↔脾为阴。 胃为表↔脾为里。足太阴脾经属脾络胃。足阳明胃经属胃络脾。脾主运化,胃主受纳。脾主升清,胃主降浊。脾宜升则健,胃宜降则和。脾喜燥恶湿,胃喜润恶燥。	脾被湿困,脾失健运→胃失和降,受纳失职。引起纳呆、呕恶、脘腹痞满、肢体困重等症状。 食滞胃脘、浊气不降→脾不升清、脾失健运。引起厌食、噯腐吞酸、腹胀、泄泻等症状。脾胃气虚,外病不愈→发展成脾胃虚寒。引起脘腹隐痛、喜温喜按、食少腹胀、便溏、形寒肢冷等症状。
肝与胆	胆为阳↔肝为阴。 胆为表↔肝为里。足厥阴肝经属肝络胆。足少阳胆经属胆络肝。肝分泌胆汁,胆囊贮藏胆汁。肝主疏泄、调畅情志→保持胆气宁静,勇敢刚毅。	肝病常累及胆,形成肝胆同病,如肝胆湿热,胆汁外溢。引起黄疸、口苦、胁痛、纳呆、呕恶等症状。 胆病常累及肝
肾与膀胱	膀胱为阳,肾为阴。膀胱为表,肾为里。足少阴肾经属肾络膀胱。足太阳膀胱经属膀胱络肾。肾为水脏,主管水液代谢。膀胱主藏津液和排泄小便。	肾阳虚不能化气行水→膀胱气化不利。出现形寒肢冷、肢体浮肿等症状。 膀胱湿热、尿有砂石→累及于肾出现尿频、尿急、尿涩与尿痛、剧烈腰痛等症状。



五脏与六腑间的相互关系

三、六腑间的相互关系

六腑的主要功能是传导化物,对饮食的消化、吸收与排泄并参与水液代谢,故《灵枢·本脏篇》说:“六腑者,所以化水谷而行津液者也。”

[饮食物的消化、吸收、排泄]

人类在生命活动中必须不断从外界摄取营养物质,作为从事劳动、维持体温的能量来源和提供生长、发育、生殖的重建及新建的原料。

饮食经口腔咀嚼,搅拌,吞咽,经食道入胃。胃受纳,腐熟成为食糜,下降于小肠,经小肠肌肉收缩运动,将食物磨碎,使食物与消化液充分混合,通过各种消化酶,将食糜中的蛋白质、脂肪和糖类进行化学分解,使之成为可吸收的小分子物质,通过蠕动,食糜缓慢向下移动,这一过程,中医学称为“小肠受盛及泌别清浊”,同时胆囊分泌胆汁,以促进脂肪的分解吸收。胃及小肠吸收的水谷精微,靠脾的运化转输全身。小肠内的消化极为重要,食物通过小肠后,消化过程基本完成,只留下未经消化的食物残渣(糟粕)经小肠进入大肠。大肠的主要功能在于吸收水分,并作为糟粕暂时贮存场所,中医学称之为“传导、燥化”,形成粪便,由肛门排出体外。上述食物的摄入、消化、吸收、排泄过程均经历上焦、中焦、下焦。吸收的水谷精微也通过三焦而分布全身。

[参与水液的代谢]

人体新陈代谢过程中产生的代谢终产物和多余的水,通过以下途径排出:① 经肺呼出二氧化碳和少量水分。② 通过汗腺排出一定量的水、氯化钠和尿素、尿酸。③ 经肠道排出混入粪便的消化液、无机盐、胆色素。④ 经尿液形式排出水和溶于水的尿素、肌酐、尿酸。以上四个排泄水液的途径,以中医学的肺、脾、肾三脏为主体。但六腑也有密切关系。胃为“水谷之海”吸收食物部分的水,化为津液,也分泌胃液。“小肠主液”。人体每日饮水约1~2L,连同胰液、胆汁、小肠分泌的消化液含水分总量可达8L左右,除每日大便中含水约150ml,绝大部分被肠道重吸收。中医将重吸收的部位称为“闸门”,然后经血液循环渗入膀胱,膀胱贮藏津液和排出小便。上述水液代谢也是经历上、中、下焦,以三焦为通路。

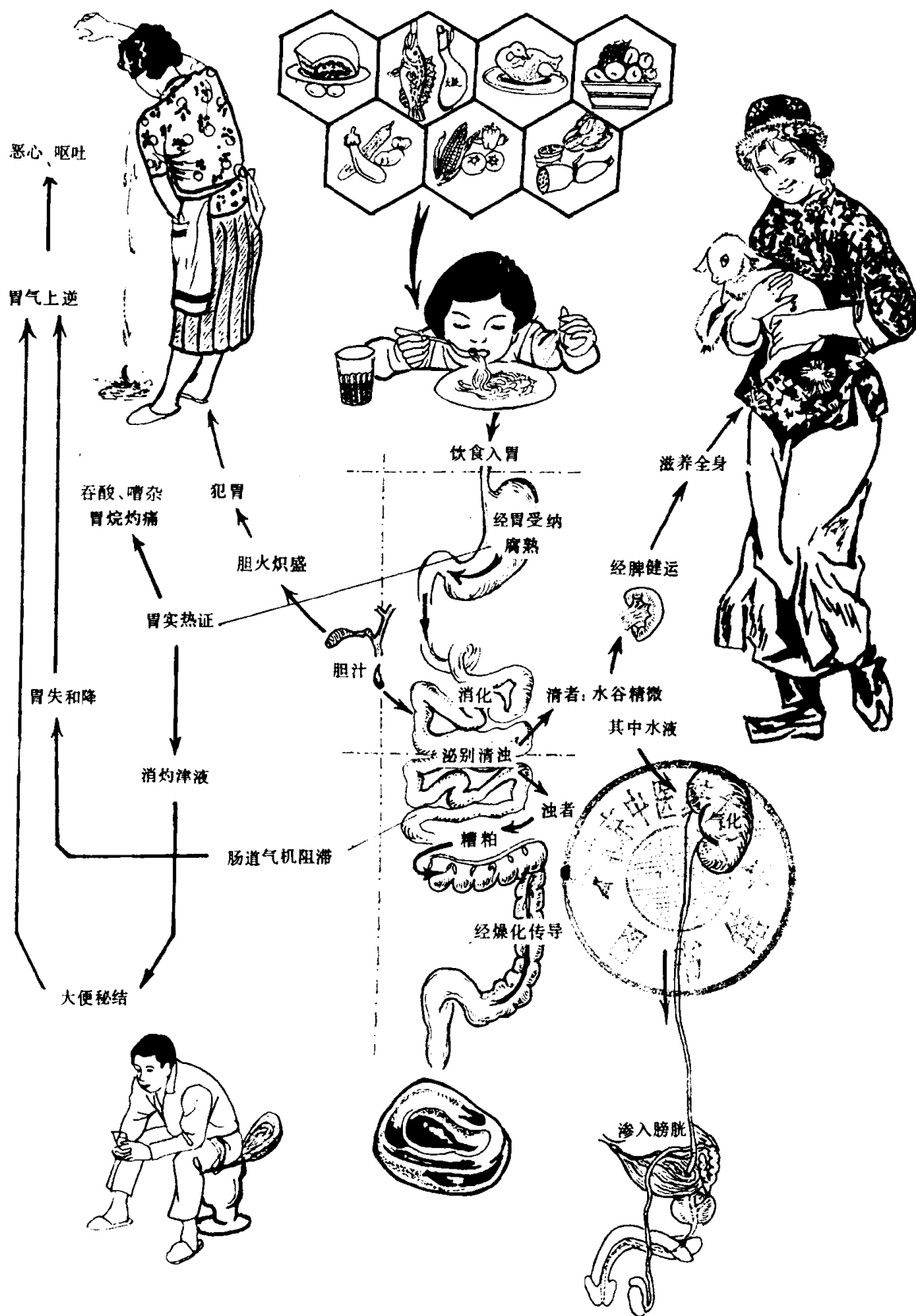
[六腑以通为用]

胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦等六腑具有出纳、转输、传化水谷的共同功能,故宜畅通,不宜阻滞,以下行通降为顺,以滞塞上逆为病。所以中医有“六腑以通为用”,“腑病以通为补”,不管气、血、寒、热、湿、食、虫、石,任何病因造成通降失常,都可出现“痛”、“闭”病症。“痛则不通”、“通则不痛”是中医学对空腔脏器梗阻、梗阻上方管腔平滑肌阵发性痉挛以期解除梗阻的精辟概括。多年来,广大中西医通力协作,运用上述理论,采用中西医结合的非手术治疗急性阑尾炎、急性胆囊炎、胆石症、胆道蛔虫病、急性胰腺炎、急性肠梗阻等急腹症,采用通里攻下、行气活血、消结导滞、和胃降逆等通下法为主,配以清热解毒、活血化瘀、燥湿泻火等治法取得了良好的疗效。

[病理上的影响]

六腑在生理上的密切关系,也造成了在病理上的相互影响,如胃实热证能消灼津液引起大便秘结,而肠燥便秘也可使胃失和降、胃气上逆,引起恶心、呕吐。又如胆火炽盛,常可犯胃,出现呕恶、吐苦水等胃失和降的病症等。

六脏间的相互关系



第三章 精、神、气、血、津液

第一节 精、神

[含义]

(一) 精 是构成人体和维持生命活动的基本物质。构成人体之精,叫做“生殖之精”。维持生命之精,叫做“水谷之精”。生殖之精来源于父母,是指繁衍人类、具有生殖能力的物质,也是人体生命的原始物质。故《素问·金匱真言论》说:“夫精者,生之本也”,当男女两性之精相结合后,在母体内孕育构成身形,所以又叫先天之精。水谷之精是指饮食物中的营养物质,经脾胃化生而成,是人体维持生命活动的能量和原料,所以又称后天之精。两精均贮藏于肾。

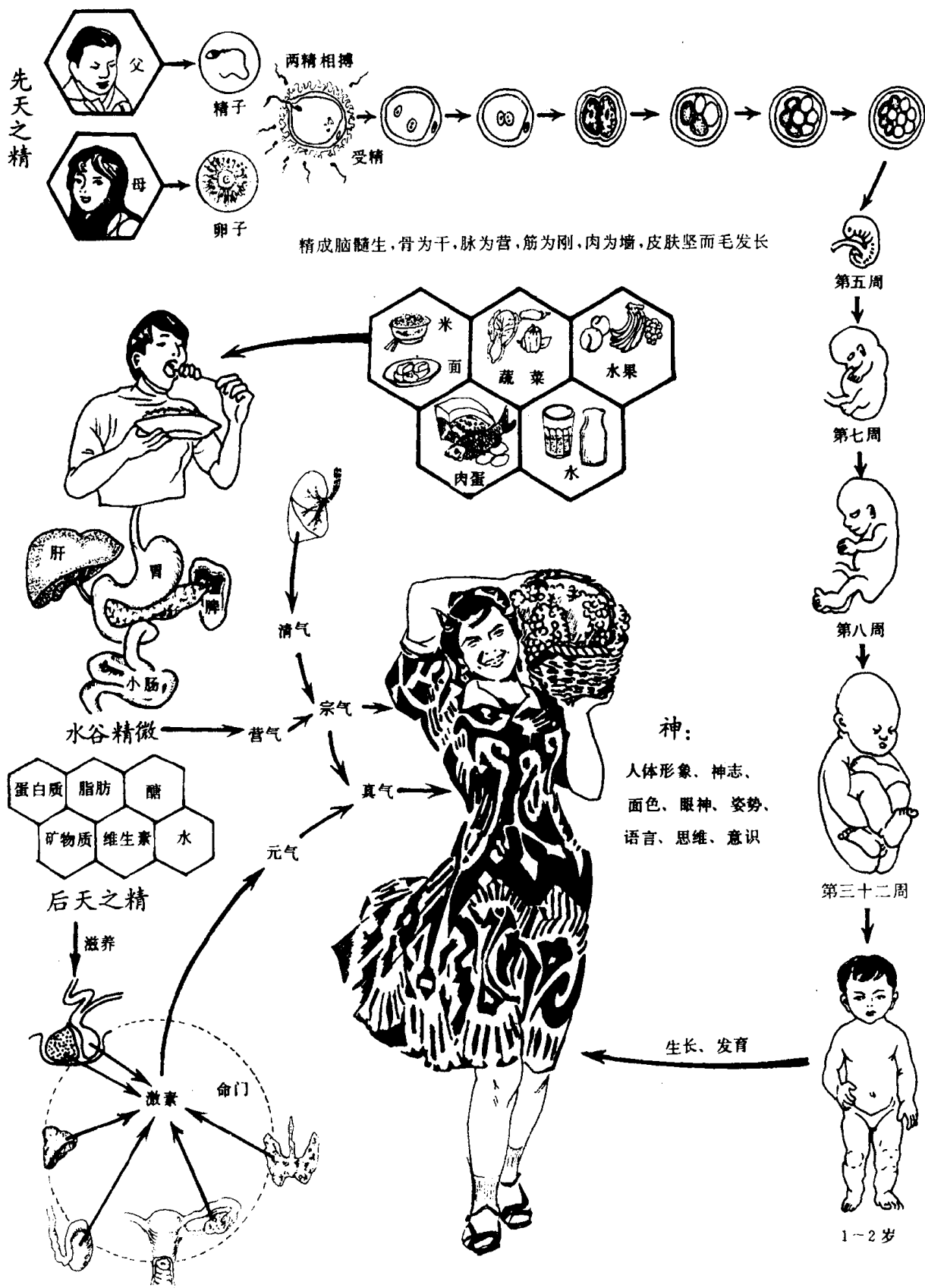
(二) 神 是指人体生命活动的外在表现,也就是人的精神状态。它包括了整个人体的形象、神态、意识、思维、面色、眼神、语言、气息、姿态和动作等。中医学认为精气是神的物质基础。《灵枢·平人绝谷篇》说:“神者,水谷之精气也。”它与人的脏腑气血盛衰有关:凡神气充旺,一般反映脏精充足、机能协调;若脏精将竭、气机衰败,则神气涣散。故《素问·移精变气论》说:“得神者昌,失神者亡。”

[作用]

(一) 精的作用 有三:① 精是构成人体的基本物质。《灵枢·经脉篇》说:“人始生,先成精,精成而脑髓生。骨为干,脉为营,筋为刚,肉为墙,皮肤坚而毛发长。”指出人的胚胎由父母的生殖之精所生成,其后脑、髓、骨、脉、筋、肉、皮毛等脏腑身形都在胚胎基础上孕育形成。② 精是供给人体生长、发育和维持人体生命活动的基本物质。在出生前,胎儿的生长、发育和生命活动的维持有赖于母体精血的供养。胎儿出生后从出生至终身,全赖饮食的水谷精微和呼吸的自然清气,即所谓后天之精的不断供给和补充,才能够进行生长、发育和维持呼吸、循环、消化等各种生命活动的正常进行。③ 人体发育到青春期,生殖之精成熟,并产生一种具有生殖功能叫“天癸”的精微物质(现代医学的性激素)。至此,男子出现遗精,女子出现月经。生殖之精为繁衍生育提供了物质基础。

(二) 神的作用 有二:① 形与神俱,中医学认为神是父母阴阳两精媾合形成胚胎之际,即已开始产生并不断发育的。人体出生之后,其脏腑、经络、身形必须得到水谷精气和自然清气的温养和补充才能进一步生长发育,逐渐成熟完善,而神始终附于形,形神统一,即所谓的“形与神俱”。形和神都是以精气为物质基础的,所以观察一个人的形神状况,包括观察这个人的精神好坏,意识是否清楚,动作是否矫健协调,反应是否灵敏,可以了解这个人的健康状况,判断其脏腑阴阳气血的盛衰以及正气内存情况。② 观察病人眼神的变化是判断病情轻重、预后好坏的重要内容。中医学认为:“神藏于心,外候在目”,目为五脏六腑之精所注。如患者两眼有神,即使病情较重,因正气未伤,预后良好。在疾病过程中,一旦病人目光呆滞,两眼失神,多提示正气已伤,病情严重,预后不良。

精、神



第二节 气、血

[含义]

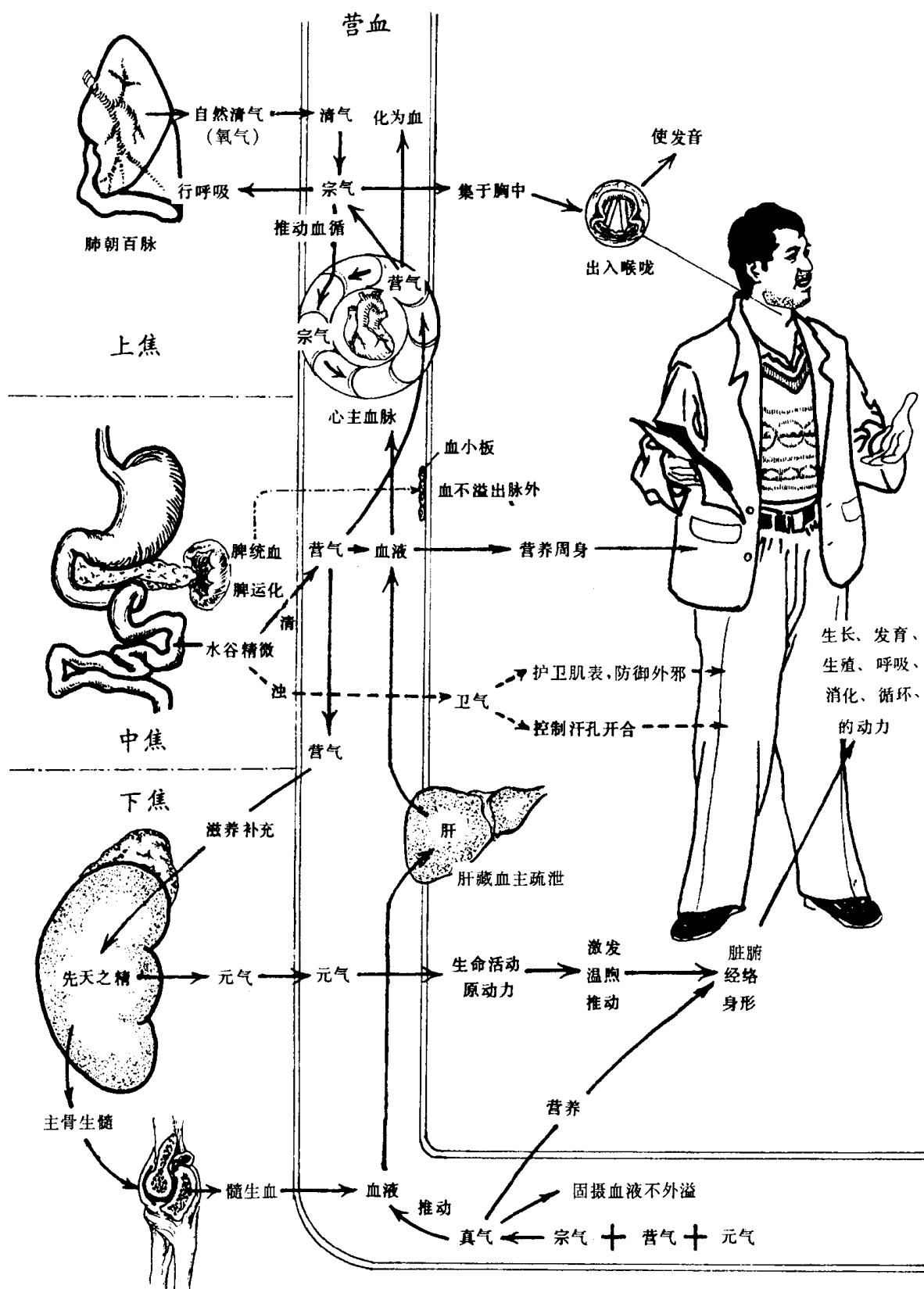
(一) 气 含义有二:① 体内流动着的有营养的精微物质,如水谷之气、呼吸之清气等。② 泛指脏腑的机能,如五脏之气、心气、胃气等。根据来源分布、功能不同,可分为元气、宗气、营气、卫气、真气等。

(二) 血 指血液。《灵枢·决气》说:“中焦受气取汁,变化而赤是谓血。”说明血是由食物精微通过气化作用而生成的一种红色液体,它的生化之源在中焦的脾胃,循环流动于脉管内,能将机体需要的氧、蛋白质、糖类、脂类、维生素、水和无机盐运送到身体各部,以奉养全身。

[生成与作用]

(一) 气的生成与作用 分述如下:① 元气,又称原气,根源于肾(含命门),主要由肾藏的先天之精所生化(隐含体内各内分泌所分泌的激素),有赖水谷精气的濡润滋养和补充。元气藏于肾叫肾气。元气以三焦为通路而运行至周身,具有激发、温煦、推动脏腑、经络、身形的功能,是人体生长、发育、生殖、呼吸、消化、循环的原动力。② 宗气,是由肺吸入的自然清气和脾胃运化的水谷精气结合而成,其合成在肺,而聚于胸中,其作用为推动肺的呼吸和心的搏动,并影响声音的强弱,是一身之气运动、输布的出发点。③ 营气,是营运于脉中的水谷精气,来源于食物,由脾胃生化,出于中焦,具有生化血液和营养周身的功能。④ 卫气,也来源于饮食物,由脾胃所化生,与营气同源,但行于脉外。《灵枢·营卫生会》说:“其清者为营,浊者为卫,营在脉中,卫在脉外”,即现代医学的组织液,在毛细血管的动脉端透出血管壁进入组织间隙,是细胞与血液进行物质交换的内环境,其分布昼夜之间有所不同。《灵枢·大惑论》说:“卫气者,昼日常行于阳,夜行于阴”,与现代医学微循环开闭完全一致:安静状态下,真毛细血管网大部分处于关闭状态,开放的只占全身循环血量5%左右,其开放区与关闭区也是交替的,轮换的。白天肌肉组织活动增加,真毛细血管大量开放,循环血量大增。而夜间,骨骼肌毛细血管只有1%开放。此时内脏的消化吸收活动相对增强,血供相对增多。卫气作用三:a 温养脏腑与肌腠皮肤,启闭汗孔调节体温;b 卫气昼行于阳,使人体保持清醒,夜行于阴,使人体进入睡眠;c 保卫肌表、抗御外邪作用,指血液中的粒细胞、单核细胞可透出血管壁,向炎症区域渗透,移动并具有吞噬能力。⑤ 真气,是由先天的元气和后天的营气及宗气结合而成。《灵枢·刺节真邪篇》说:“真气者,所受于天,与谷气并而充身者也。”其生化合成、贮藏主要在脑髓和五脏,在人体无处不到,无处不有,中医所称之“阳气”、“阴气”、“正气”、“肺气”……均为真气在各不同部位的别称。

(二) 血的生成与作用 脾胃是气血生化之源。生成血液的基本物质主要来自脾胃的水谷精微。血细胞的生成场所在骨髓、脾、淋巴结。血液通过脉管运行全身。《难经·二十二难》说:“血主濡之”,即血液将机体所需要的营养物质送到身体各部的组织细胞。血液的正常循行,是各内脏共同作用的结果:“心主血脉”心气推动血液运行不息,“肺朝百脉”循行周身的血脉,都要汇聚于肺,进行气体交换,“肝藏血”起调节血量和主疏泄(解毒)功能,“脾统血”具有固摄血液不外溢(血小板保护血管壁的完整性)。因之,其中任何一个脏器的功能失调都将引起血行失常的病证。



气、血

• 57 •

第三节 津 液

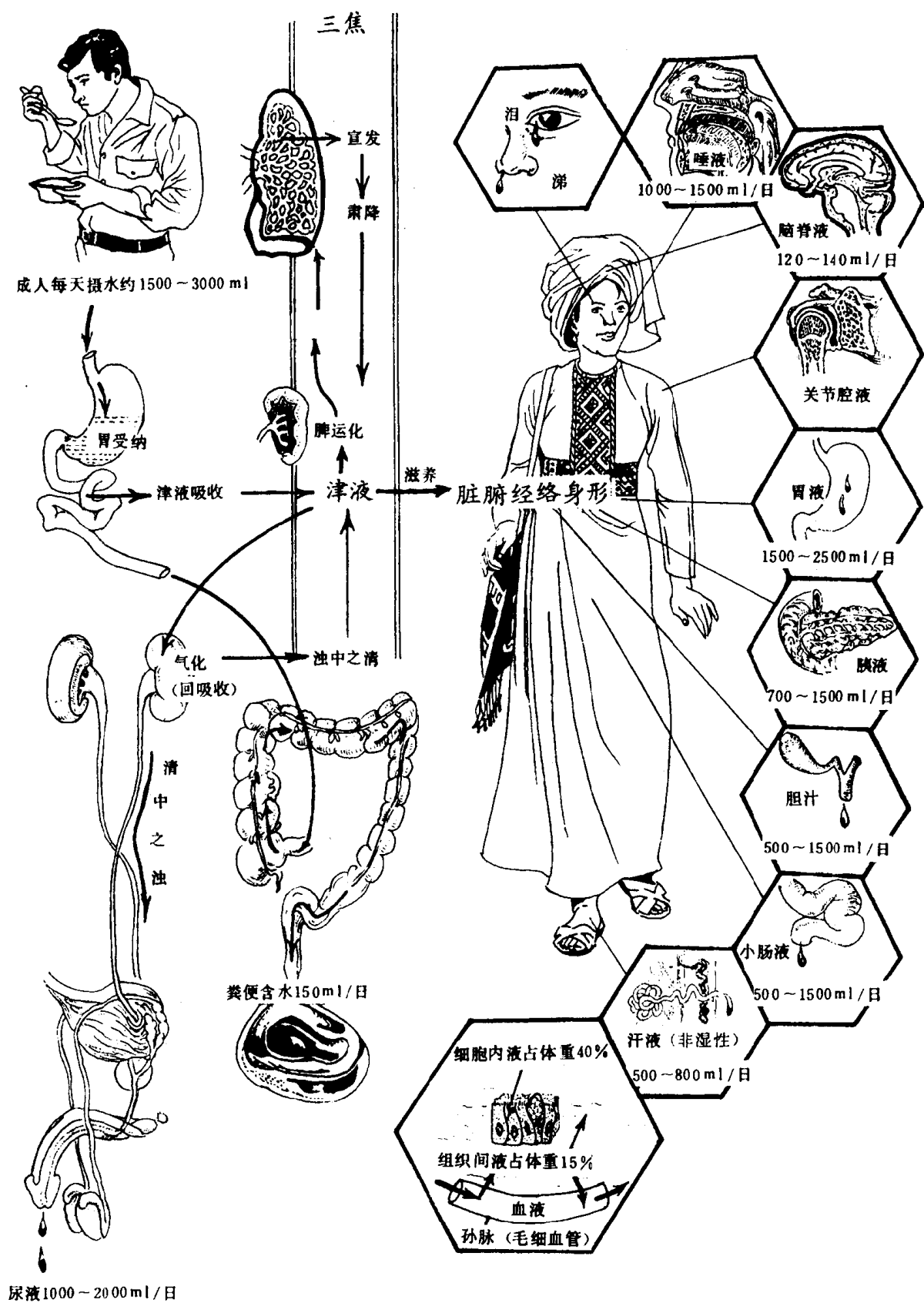
[含义、生成、输布与排泄]

津液在现代医学称体液,由水和溶质(无机盐、葡萄糖、蛋白质)组成。无机盐和葡萄糖为晶体物质,蛋白质为胶体物质。因无机盐和蛋白质在水中能离解成带正、负电荷的离子,又称电解质;葡萄糖在水中呈分子状态,被称为非电解质;体液是多种晶体、胶体或电解质液、非电解质液的混合体。体液是人体内除血液以外的一切液体及代谢物的总称,包括一切组织间液(占体重 15%)、细胞内液(占体重 40%)、血浆(占 5%),以及唾液(每日分泌 1000~1500ml)、胃液(1500~2500ml/日)、胰液(700~1500ml/日)、胆汁(500~1500ml/日)、小肠液(500~1500ml/日)、脑脊液(120~140ml)、关节腔液和汗、尿、泪、涕等。因体液含蛋白质和其他溶质多少不同,中医将清而稀的称津,主要指输布体表的汗、唾液、泪和存在于气血之中(血清)。浊而稠厚的叫液,专指关节液、脑脊液、消化液、尿液等。因均来源于饮食物通常合称为津液。

津液来源于食物和饮水,经食道入胃、小肠。各种营养物质的消化产物(中医称水谷精微)和水、无机盐、维生素等,通过肠粘膜上皮细胞进入血液和淋巴液,这个过程中医学称为“脾的运化。”食道是上焦,胃肠为中焦,全身主要的动静脉、胸导管,以及输尿管、结肠、直肠均位于中医的“三焦”。所以中医说:“津液以三焦为通道”。在三焦中升降循环,上输肺脉时呼出二氧化碳和水分称“肺气宣发”,经肺循环后入体循环称为“肺气肃降,通调水道”。清中之浊(代谢废料)由三焦水道下行,归于肾。浊中之清(指原尿中营养物质)经肾阳的蒸化(回吸收)后藏于膀胱,并形成尿液排出。运行于三焦的津液于孙脉渗入组织间隙,这部分津液称为卫气,是滋润、濡养组织、细胞的体内水库,现代医学称功能性细胞外液,具有蓄水和供水作用。通过以上各有关脏腑的作用,津液的输布可以外达皮毛内注脏腑,滋灌全身各组织器官,中医学称之为“水精四布,五经并行。”全身的津液,由于神经-内分泌的正常调节,每日摄入和排出的水量是平衡的,消化液每日分泌总量可达 8000ml 左右,但绝大多数在回肠末段和右半结肠重新回吸收,只有 100ml 左右水由粪排出。汗液是汗腺的分泌物,其分泌由温性刺激或精神紧张所引起,前一种称温热性发汗,后一种称精神性发汗。正常人每天通过皮肤蒸发水分达 600ml,这种蒸发失水比较恒定,并在不知不觉中进行,称非湿性发汗。中医学对汗比较重视,认为是由津液所化,津液与血液相互渗透,故称“汗为心液”,心阳虚则自汗,心阴虚则盗汗。总之,中医学认为津液的生成、输布、排泄是一个复杂的过程。许多脏腑病变都可造成津液平衡失调:如生成不足或丧失过多就会出现伤津、脱液。如输布障碍、水液停滞就会出现痰饮、水肿。同时,也会影响某些脏腑的功能,如水饮凌心则心悸、射肺则出现咳喘、津伤肺燥则咳、胃燥则渴、肠燥则便结等。

[津液的作用]

① 津液是人体重要的组织成分 占人体总体重的 60%,其中 40%分布于细胞内。② 人体从外界摄入的营养物质必须通过细胞外液,才能进入细胞,细胞的代谢产物,也通过细胞外液,再经有关器官排出体外。③ 参与体温调节、酸碱平衡调节及某些体液因素(激素)的转运。④ 起润滑(关节液、胸腔、心包腔液、泪、唾液)保护(脑脊液、体液免疫物质)功能。



津 液

第四节 精、神、气、血、津液的关系

以人体血液为主题,来论述中医学精、气、血、津液与神的相互关系,可以发现其理论独特、严谨,且具有科学性。

血液是一种红色、混浊、带有一定腥味和粘滞性的液体,由有形成分(红细胞、白细胞、血小板)和血浆(由90%~92%水和蛋白质、糖类、脂肪、无机盐、维生素、各种内分泌激素、酶类以及代谢的废物)组成。由于血液在脉管内不停息的循环流动,其血细胞和血浆在功能上对身体起着运输生命需要的养料和带走废物;调节机体水、电解质和酸碱平衡;负担机体防御保卫的功能。血浆中的水、蛋白质、糖类、脂肪、无机盐、维生素等有形成分均由机体摄取饮食物,经“胃的受纳”、“小肠的化物”、“脾的运化”进入血液的水谷精微,在血液中又称营气,均溶于水之中,这种体液即津液。由此可见“血、精、气、津液”同源於水谷精微,有时候是“一物多名”。如水谷精微的“精”指溶于津液的营气,而含于水的营养物质,在血中称血清,中医又称为津液。可见它们是相互联系、相互生化的。

[精与血]

“血”中除上述水谷精微的后天之“精”外,尚含有各种内分泌激素和各种酶类,从功能讲,是维持机体生长发育和生殖功能、促进新陈代谢的基本物质,属于藏于肾(命门)的先天之“精”。在血液中又称为“元气”,它的生成、补充有赖于后天之精的濡养。由此中医的“血者,水谷之精也”,“精者,血之所成”就很易理解了。

[气与血]

血浆中的营养成分称为营气,红细胞的功能是运输氧和二氧化碳。氧气中医学称为清气,进入血液后一部分溶于血浆中,中医将这种血浆(含营气清气)称为宗气,认为它是推动呼吸活动和心脏搏动的动力,即“气行则血行”。红细胞等血细胞在血中有一定的生存期,如红细胞是100~120天;白细胞寿命2~4天;血小板寿命5~7天,在血中均保持一定的数量。血细胞衰老破坏后由骨髓制造释放新的血细胞,制造新的血细胞所需要的原料和能量(如氧、铁、钴、叶酸、蛋白质,及有关激素)等物质均由血液中的清气、宗气、营气所供给,中医学称为“气能生血”。粒细胞和单核细胞能游出血管内皮的间隙,负起吞噬细菌和抗原抗体复合物功能。淋巴细胞(T、B淋巴细胞)能释放淋巴因子与免疫球蛋白,直接杀死靶细胞和增强免疫,中医学称为“卫气”和“正气”。这些所谓的营气、宗气、卫气、正气,溶于血中,随血而流动。此所谓“血行气亦至”,“气由血化”。血液中的血小板是保持血管壁脆性、完整性的重要物质。血浆中尚含有各种凝血因子等都是止血、凝血、使血液运行于脉管中不溢脉外的物质,中医称“脾统血”、“气能摄血”。气血濡养脏腑,使脏腑功能正常(即脏腑之气)提供了保证,也称为“血能化气”或“气由血化”。

[气与津液]

上述营气、宗气、卫气、正气均源于水谷精气。脾胃气旺,运化水谷精气充足,津液也充足,此即“气旺生津”。上述“阳气”也均溶附于津液而温润全身,此即“津液化气”。

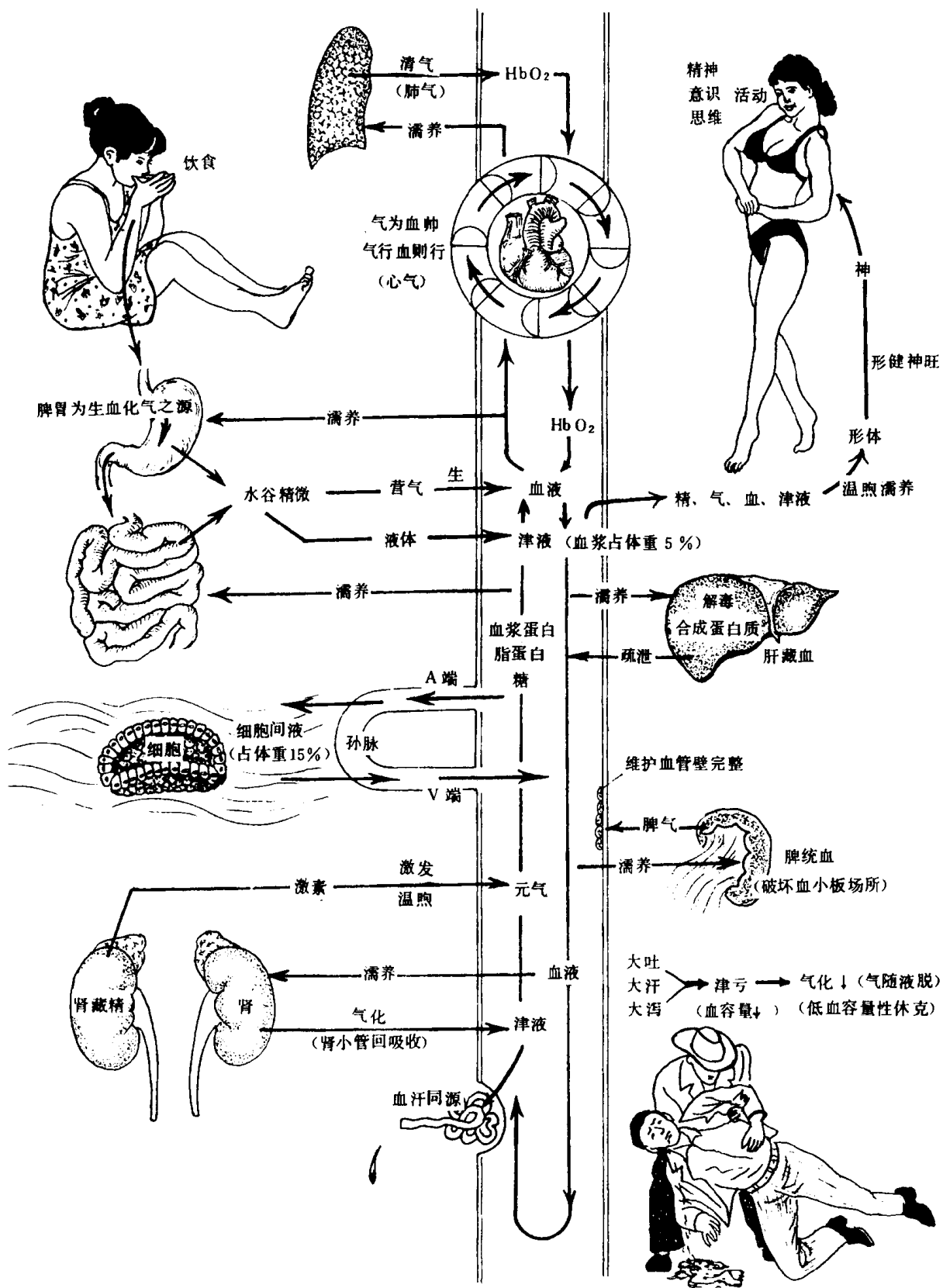
[血与津液]

血与津液皆属阴液,均源于水谷之气,在血液中,血清与津液实系一物,也可说是互相渗透转化,此即“津血同源”,于毛细血管处渗出脉外生成组织液(卫气),于汗腺生成汗液,此即“血汗同源”,全身血液总量相当恒定(总量约5000ml或70~100ml/kg),血浆容积为全血的50%~60%。这有赖于脾、胃、肺、肾、膀胱、三焦的功能正常和调控,当大汗、大吐、大泻引起“津亏”(血容量下降)时就会出现“气随液脱”(低血容量休克)的证候。

[精、气、血、津液与神]

神是人体生命活动的外在表现,精、气、血、津液是神产生和表现的物质基础。人体有精、血、气、津液的濡养、温煦、推动脏腑的功能活动,才有人体的生命活动及精神、意识、思维活动。它们之间的关系,是物质基础与功能活动的辨证关系,是人的形体与精神辩证统一的关系。

精、神、气、血、津液的关系



第四章 经络学说

第一节 手 三 阴

“经络”是人体经脉和络脉的总称,是人体组织结构的重要组成部分,是沟通表里、上下,联络脏腑组织和运行气血的独特系统。

每一脏腑都发出一条经络,每一经络都有它络属的脏腑。脏腑为本,经络为标。“经”,有路径的意思,是纵行的干线,多循环于人体深部。“络”有网络的意思,是经脉的分支,它纵横交错,网络全身,无处不至,分布部位较浅。经络遍布全身,把五脏六腑、四肢关节、五官九窍、筋骨皮肉紧密地联系成一个统一的整体。

一、手太阴肺经

[走向、分支]

起于中焦,下络大肠,还循胃的上、下口,通过横膈膜、属肺,至喉部,横行至胸部外上方(中府),出腋,沿上肢内侧前缘向下,过肘,至腕,直至拇指之端(少商)。

分支:从手腕的后方(列缺),直行至食指桡侧端(商阳),交于手阳明大肠经。

[主要病证]

胸闷胀满、喘咳、气逆、肩背及臂内侧缘痛、咽喉肿痛、怕冷或手心发热等。

二、手厥阴心包经

[走向、分支]

走于胸中,属心包,下行,依次络于上、中、下三焦。

分支:从胸中分出,横行至腋下胸壁的三寸处(天池),延胸壁上抵腋下,沿上肢内侧中线入肘,过腕,至掌中(劳宫),循中指出其端(中冲)。

分支:从掌中分出后,沿无名指出其尺侧端(关冲),交于手少阳三焦经。

[主要病证]

心悸、心前区疼痛、腋下肿胀、癫狂、胸满闷感、上臂肘关节痉挛、掌心发热等。

三、手少阴心经

[走向、分支]

起于心中,属心系,下膈,络小肠。

分支:从心系分出,上挟食道,连于目系。

直行:从心系上肺,出腋下(极泉),沿上肢内侧后缘过肘,经掌后锐骨,至小指内侧端(少冲),交于手太阳小肠经。

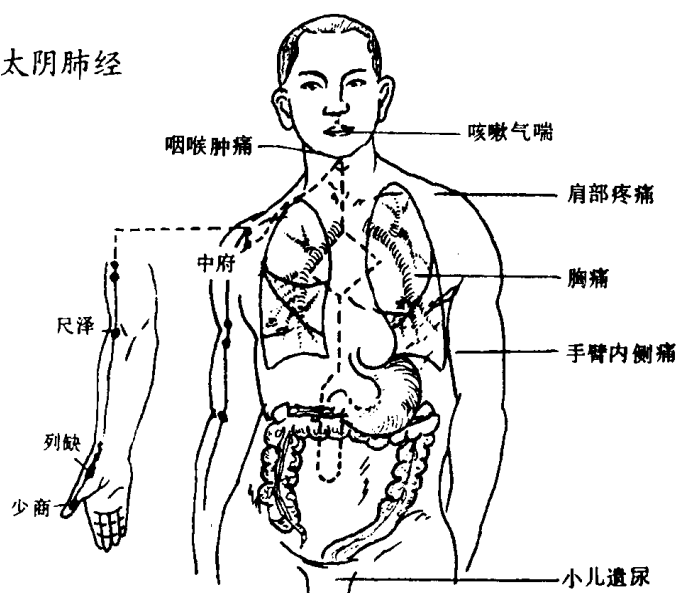
[主要病证]

心前区疼痛、胸胁痛、咽喉痛、口干渴、目黄、健忘失眠、癫痫、上肢内侧疼痛、掌心发热等。

手三阴经分布于上肢的内侧,前后分布次序是:太阴在前,厥阴在中,少阴在后。

手三阴循行的规律是:从胸走手,交手三阳经。

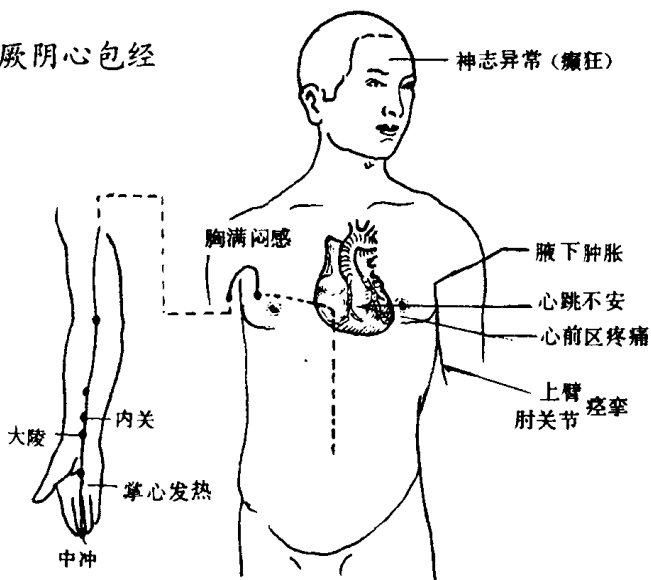
手太阴肺经



多用于治疗

喉、胸、肺等处疾病

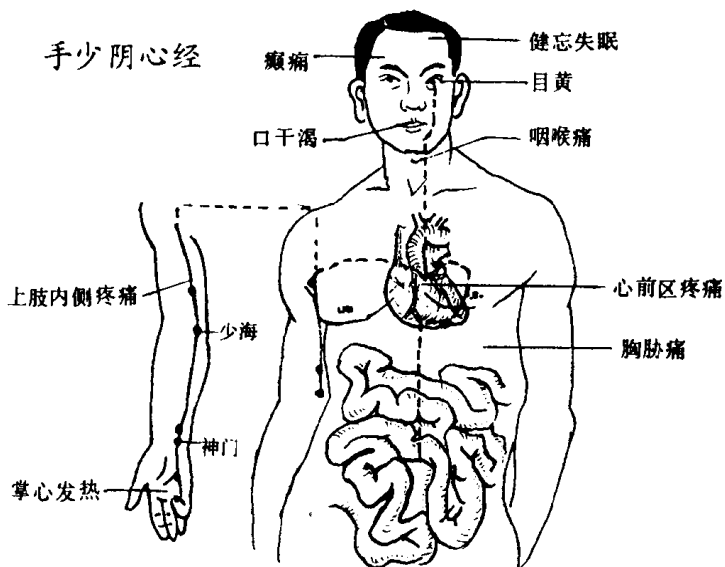
手厥阴心包经



多用于治疗

心、胸、胃等处疾病
及精神病

手少阴心经



多用于治疗

心脏、胸部
及精神方面的疾病

第二节 手 三 阳

十二经脉是以阴阳来表明它的属性：凡是与腑相属，循行于肢体外侧的经脉，叫做阳经；凡是与脏相连属，循行于肢体内侧的经脉，叫做阴经。

由于经络循行路线有一定的身体部位和脏腑络属，因而可以反映所属脏腑经络的病证。如头痛症，根据头痛的部位，结合经脉在头部的循行分布规律，可辨别和诊断病在何经：前额连眉棱骨痛，属阳明经头痛；头部两侧疼痛，属少阳经头痛；后头部及颈项部疼痛属太阳经头痛，以此类推。

一、手阳明大肠经

〔走向、分支〕

起于食指桡侧端（商阳），沿食指背面的前缘，上行于一、二掌骨之间，上腕，沿上肢外侧前缘入肘，上肩（肩髃），交于第七颈椎（大椎），前下入缺盆，下行络肺，过横膈膜，属大肠。

分支：从缺盆上颈，过颊，入下龈，还出夹口，左右交叉于人中，至对侧的鼻旁（迎香），交于足阳明胃经。

〔主要病证〕

下颌牙痛、流清涕、鼻衄、喉痛、颈肩部疼痛、上肢外侧疼痛及上肢瘫痪。

二、手少阳三焦经

〔走向、分支〕

起于无名指尺侧端（关冲）。向上沿无名指尺侧至手腕背面，经前臂外侧中线，过肘，上肩，向前行入缺盆，布膻中。散络心包，过膈膜，依次属于上、中、下三焦。

分支：从膻中分出，上行出缺盆，至肩（大椎）上项，沿耳后（翳风），直上出耳上角前行颈额至目眶下。

分支：从耳后分出，进入耳中，出走耳前，至目外眦（童子髻）交于足少阳胆经。

〔主要病证〕

耳后疼痛、眼外角疼痛、耳聋、耳鸣、面瘫、咽喉肿痛、肩痛、上肢外侧部疼痛及小指、次指运动障碍。

三、手太阳小肠经

〔走向、分支〕

起于手小指外侧端（少泽），沿手背上肢外侧后缘，过肘，上行绕肩胛，交肩上（大椎），前行入缺盆，络心脏，沿食道下膈过胃，属小肠。

分支：从缺盆沿颈上颊，至目外眦，转入耳中（听宫）。

分支：从颊经眼下缘至目内眦（睛明），交于足太阳膀胱经。

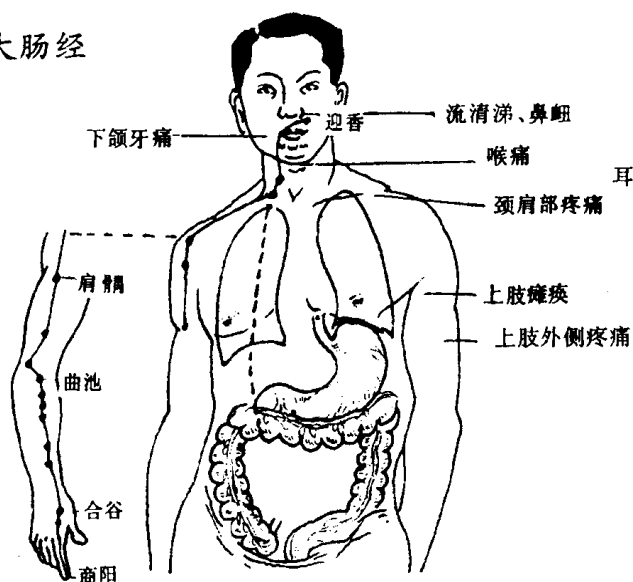
〔主要病证〕

耳鸣、耳聋、目翳、巩膜发黄、牙齿颊肿、咽喉疼痛、肩胛部疼痛、上肢外侧后缘疼痛。

手三阳经分布在上肢外侧，前后分布的次序：阳明在前，少阳在中，太阳在后。

手三阳循行的规律：从手走头，交足三阳经。

手阳明大肠经



多用于治疗

耳、鼻、喉、头、颈等部器官疾病

经

络

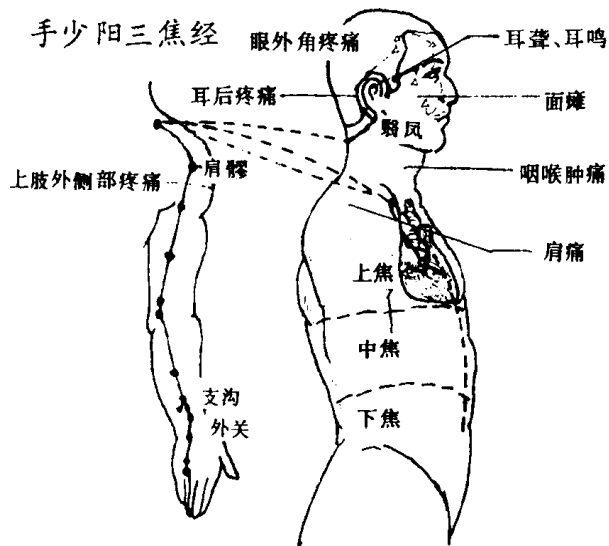
(二)

手

三

阳

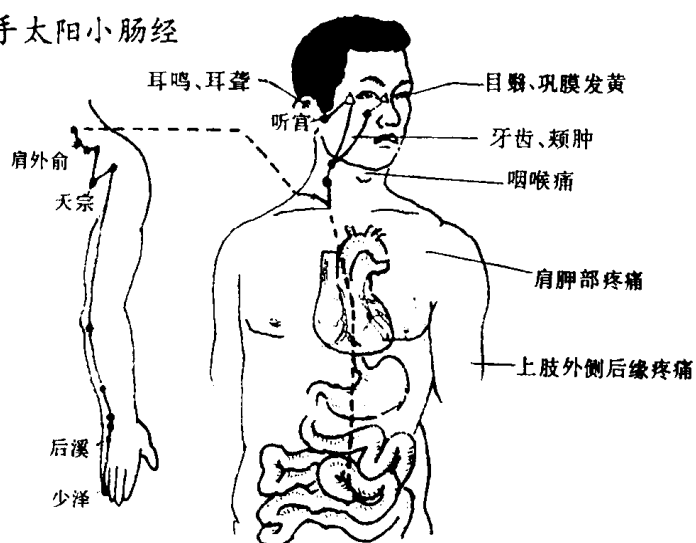
手少阳三焦经



多用于治疗

耳、心、胸等处疾病及精神病

手太阳小肠经



多用于治疗

眼、耳、喉、头颈部的疾病

一般有发汗退热作用

第三节 足 三 阴

经络学说是研究人体经络系统的生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的学说,是中医理论体系的重要组成部分。它不仅是针灸科的理论基础,而且能指导中医内外各科的临床实践。如张仲景所创立的六经辨证,就是在经络学说基础上发展起来的辨证体系,是分析辨别外感病的经络、脏腑病位及其病变性质的辨证方法。如阳明病症,包括足阳明胃和手阳明大肠两经、两腑的病变。少阴病证,包括足少阴肾和手少阴心两经两脏的病变,以此类推,易于记忆。

一、足太阴脾经

〔走向、分支〕

起于足大趾内侧端(隐白),沿内侧赤白肉际,上行过内踝之前缘,沿小腿内侧正中线上行,在内踝上 8 寸(26 厘米)处交出足厥阴肝经之前,上行沿大腿内侧前缘,经腹至腹哀穴入腹属脾络胃。

分支:从腹哀穴处分出,向外上方行至腋,再折向后下方至腋下大包穴,再折向上前方经中府入里上行挟咽,连舌本,散舌下。

分支:从胃直上过横膈,注入心中,交于手少阴心经。

〔主要病证〕

下肢浮肿、大便稀或下痢、消化不良、上腹痛、腹胀、疲倦、四肢沉重感、呕吐、噎气、舌痛、黄疸等。

二、足厥阴肝经

〔走向、分支〕

起于足大趾爪甲后丛毛处,下至大趾外侧端(大敦)。向上沿足背内踝前缘上行,至内踝上 8 寸处交出足太阴脾经之后,上行过膝,沿股内侧中线进入阴毛中,绕阴器,至小腹,向外上方行至十一肋端入腹,挟胃,属肝,络胆,上贯膈,分布于胁肋,沿喉咙进入鼻之内窍,上行连目系,出于额,上行与督脉会于头顶部。

分支:从目系分出下行于颊里,环绕口唇。

分支:从肝分出,上贯膈,注肺中,交于手太阴肺经。

〔主要病证〕

膝关节疼痛、股内侧疼痛、遗尿或小便不通、下腹部肿、疝气、腹泻、腰痛不能俯仰、胸闷满、呕吐等。

三、足少阴肾经

〔走向、分支〕

起于足小趾下,斜行于足心(涌泉),至内踝后(太溪),下入足跟,上沿小腿内侧后缘,至腓内侧,上股内侧后缘入脊内(长强)贯脊至腰,属肾,络膀胱。

分支:从脊内分出,由会阴上经腹[正中旁开五分(1.6 厘米)],走胸[正中旁开 2 寸(6.5 厘米)],止于俞府穴。

直行:从肾上贯肝膈,入肺,沿喉咙,挟舌根部。

分支:从肺中分出,络心,注入胸中,交于手厥阴心包经。

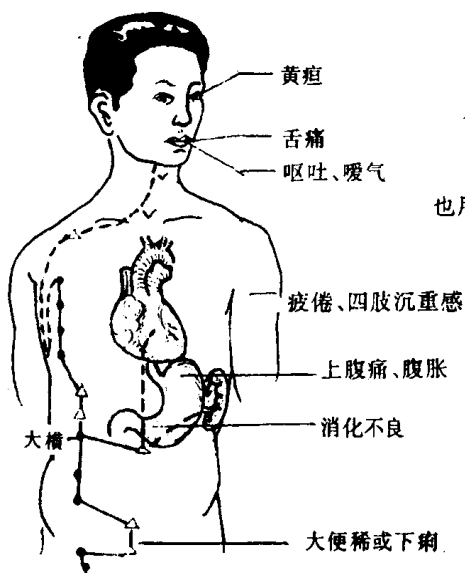
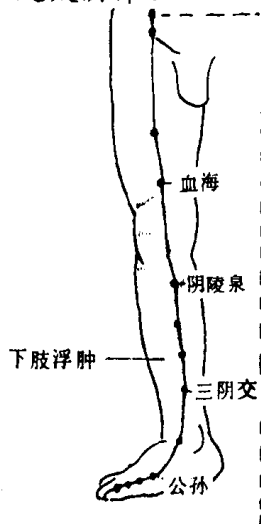
〔主要病证〕黄疸、咳嗽、咯血痰、气喘、心悸、恐慌感、饥不欲食、腰背部疼痛、腹泻、小便短小或尿闭、下肢软弱乏力、冰冷、下肢内侧后缘疼痛。

足三阴经分布在下肢内侧,前后分布的次序:太阴在前,厥阴在中,少阴在后。

足三阴循行的规律:从足走腹,交手三阴经。

经
络
(三)
足
三
阴

足太阴脾经

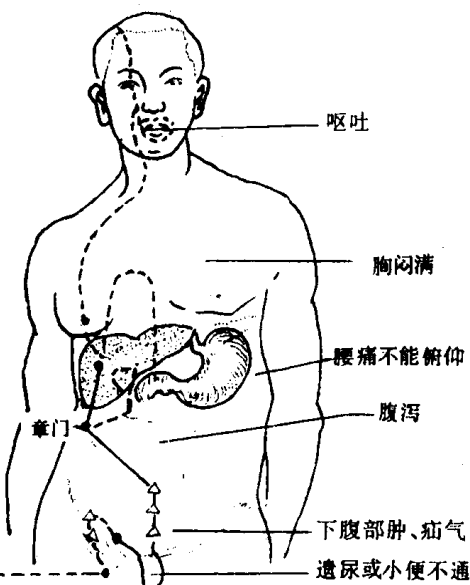
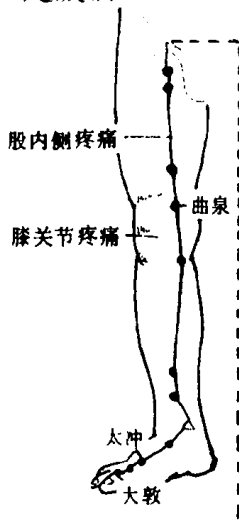


多用于治疗

胃肠道疾患

也用于月经不调、闭经、遗精

足厥阴肝经

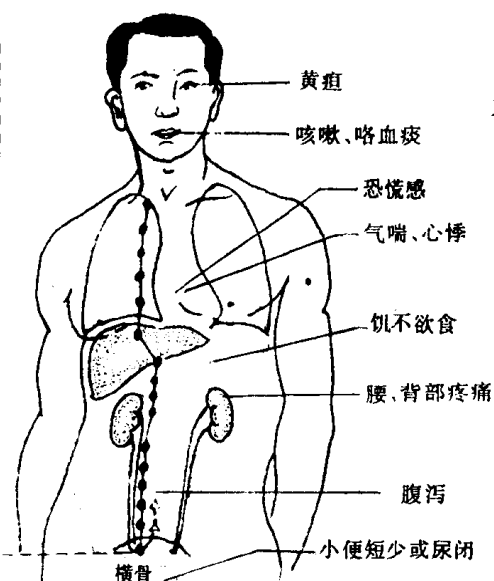
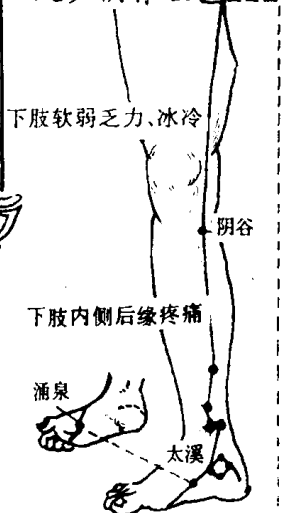


多用于治疗

泌尿生殖系统疾病

及眼、胸等处疾病

足少阴肾经



多用于治疗

肾及生殖系统疾病

也用于神经衰弱、

神经精神症状治疗

第四节 足 三 阳

一、足阳明胃经

[走向、分支]

起于鼻旁(迎香),挟鼻上行,相交于鼻根部,旁行入目内眦,与足太阳经脉相会,下行沿鼻外入上齿中,还出,环口绕唇,下交承浆,分别沿下颌的后下方,经大迎,过耳前,沿发际至前额。

分支:从大迎前下至人迎,沿喉咙向下后行至大椎,折向前行,入缺盆,下膈,属胃,络脾。

直行:从缺盆出体表,沿乳中线下行,挟脐(旁开二寸),下行至腹股沟处的气街穴。

分支:从胃下口分出,经腹部深层,下行至气街穴,与直行之脉相结合,而后下行大腿前侧,至膝腘,沿足胫外侧前缘下行至足背,入足第二趾外侧端(厉兑)。

分支:从足三里穴起,下行入中趾外侧端。

分支:从足背上冲阳穴分出,前行入足大趾内侧端(隐白),交于足太阴脾经。

[主要病证]

高热、鼻衄、面瘫、喉痛、颈肿、身体虚弱、胸部疼痛、易饥饿、腹胀、肠鸣、大腿前面疼痛、小便黄等。

二、足少阳胆经

[走向、分支]

起于目外眦(瞳子髎),过听会,上至头角(颌厌),下耳后(完骨),折回上行,经头额至眉上(阳白),又向后折至风池穴,下行至肩(大椎),前行入缺盆。

分支:从耳后分出,进入耳中,出于耳前,至目外眦后方。

分支:从目外眦分出,下行至大迎,折行至目眶下,又折向后下方,过颊,下颈,与前脉合于缺盆,入里下行至胸中,贯膈,络肝,属胆,沿肋下内出气街,绕毛际横行至环跳穴处。

直行:从缺盆下腋,沿胸侧,过季肋,下行至环跳穴处与前脉会合,再下行,沿下肢外侧中线,过股,膝,胫至外踝之前,沿足背行出于第四趾外侧端(窍阴)。

分支:从足背(临泣)分出,前行出于大趾爪甲后丛毛处,交于足厥阴肝经。

[主要病证]

恶寒发热、口苦、下颌痛、眼外角痛、胸痛、季肋区疼痛、偏瘫、腋下肿、腰骶疼痛、下肢外侧疼痛。

三、足太阳膀胱经

[走向、分支]

起于目内眦(睛明),经额上行,交会于头顶(百会)。

分支:从头顶分出,向两侧下行至耳上角。

直行:从头顶部分别向后行至枕骨处,进入颅内,络于脑,复出于外,分别下项(天柱)下行会于大椎,再分左右挟脊(一寸五分),抵腰(肾俞),络肾,属膀胱。

分支:从腰分出,挟脊下行,穿过臀部,从大腿后侧外缘下行至腘窝中(委中)。

分支:从后项分出,下经肩胛内侧,从附分穴挟脊(三寸)下行至脾枢,经大腿后侧至腘窝中与前一支脉会合,下至腓肠肌中(承山),向外下至足外踝后,沿足背外侧至小趾外侧端(至阴),交于足少阴肾经。

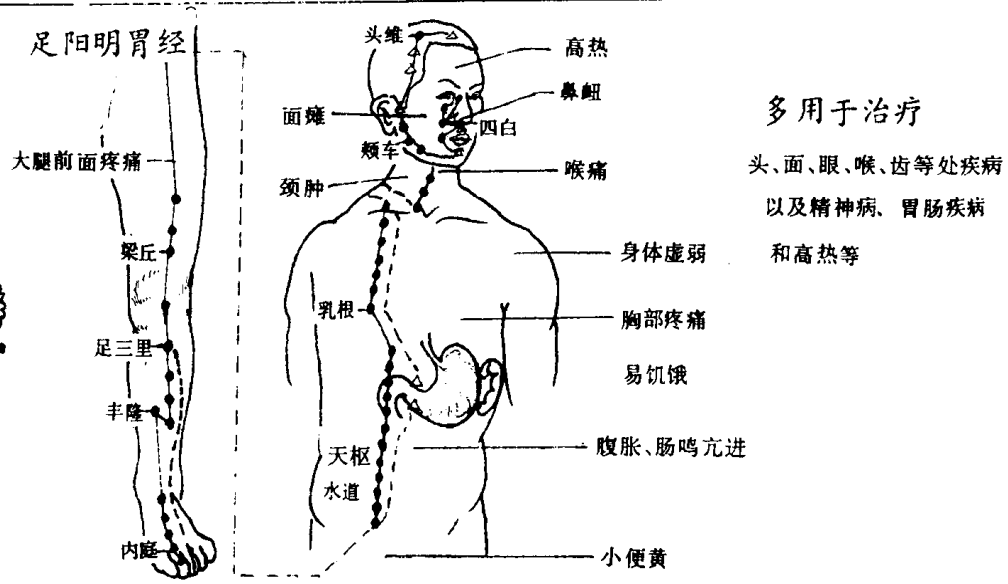
[主要病证]

头痛、颈痛、癫狂、眼痛、鼻塞流涕、鼻衄、背痛、腰痛、小便短少、遗尿等。

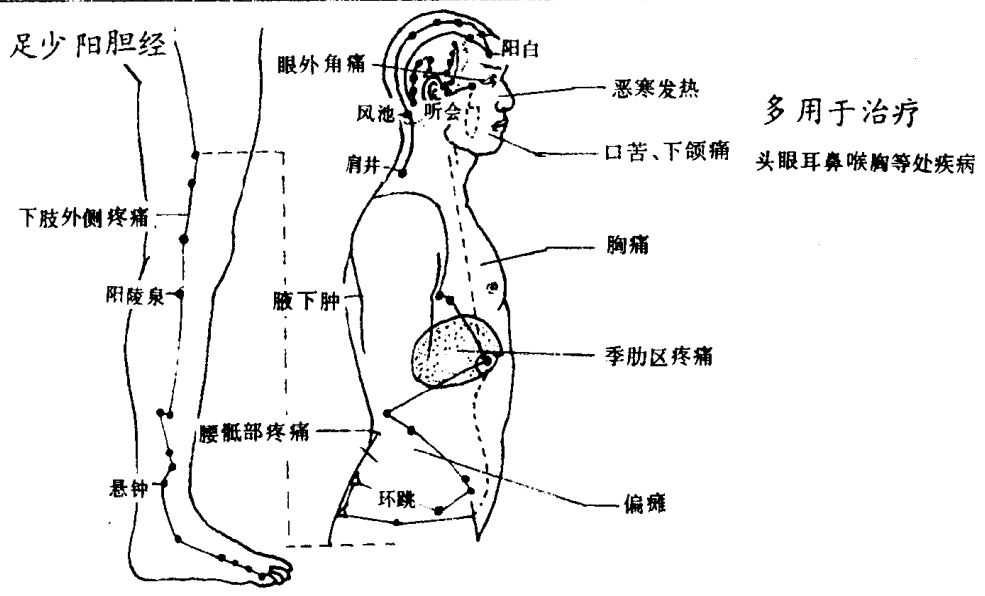
足三阳经分布在下肢外侧,前后分布的次序:阳明在前,少阳在中,太阳在后。

足三阳循行的规律:从头走足,交足三阴经。

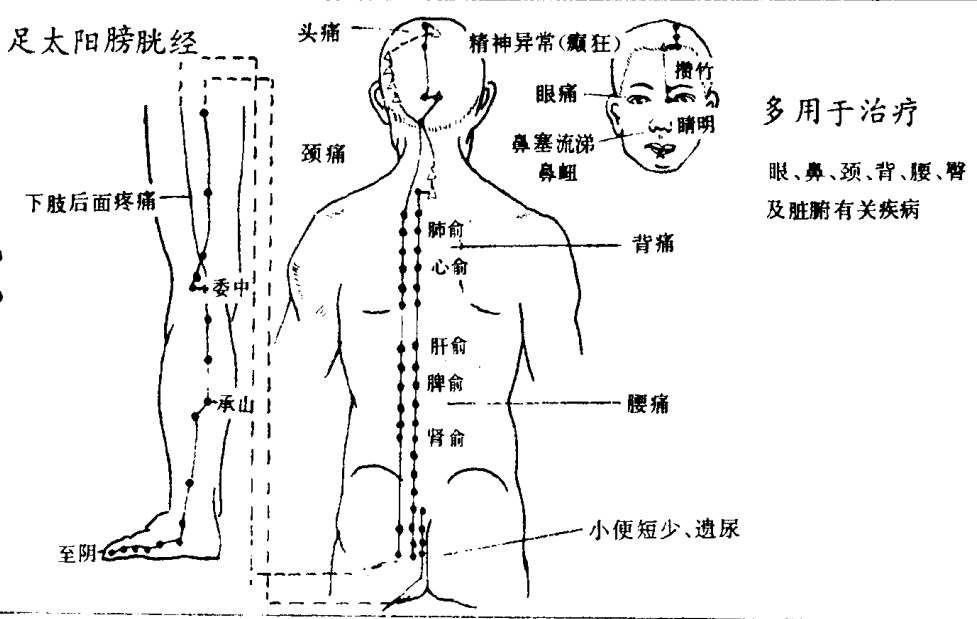
经
络
(四)
足
三
阳



多用于治疗
头、面、眼、喉、齿等处疾病
以及精神病、胃肠疾病
和高热等



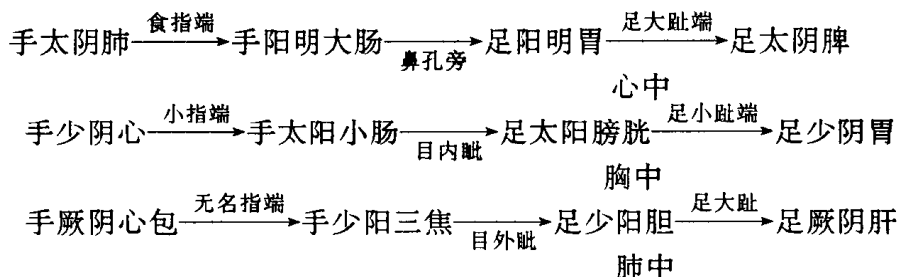
多用于治疗
头眼耳鼻咽喉等处疾病



多用于治疗
眼、鼻、颈、背、腰、臀
及脏腑有关疾病

[十二经脉流注次序]

十二经脉分布在人体内外,其经脉中的气血运行是循环贯注的。每一经脉都在一定部位上受它经之气,并在一定部位上交于另一经。一般说,阴经与阳经交接于四肢末端,阳经与阳经交接于头面,阴经与阴经交接于内脏,其流注次序示意图如下:



第五节 督脉、任脉、冲脉、带脉

一、督脉

[名称]

督,有总督的意思。督脉行于背正中,能总督一身之阳经,所以有“阳脉之海”的说法。

[循行部位]

起于胞中,下出会阴,后行于腰背正中,经项部,进入脑内,属脑,并由项沿头部正中线,经头顶、额部、鼻部、上唇,到上唇带处,并有支脉络肾、贯心。

[主要病证]

癫痫、惊风、聋哑、脊柱强直、角弓反张、腰痛腹泻、白带、月经不调。

二、任脉

[名称]

任,即担任。任脉行于胸腹部的正中,能总任一身之阴经,所以有“阴脉之海”的称号。任,还有“妊养”的意思,其起于胞中,在女子具有孕育胎儿的作用,故也有“任主胞胎”的说法。

[循行部位]

起于胞中,下出会阴,经阴阜,沿腹部正中线上行,通过胸部、颈部,到达下唇内,环绕口唇,上至龈交,分行至两目下。

[主要病证]

面瘫、牙痛、胸痛、哮喘、胃痛、消化不良、腹部肿块、下腹部痛、疝气、白带。

三、冲脉

[名称]

冲脉,为总领诸经气血的要冲。其脉上至于头,下至于足,能调节十二经气血,故冲脉有“十二经之海”和“血海”之称。

[循行部位]

起于胞中,在此分三支:一支沿腹腔后壁,上行于脊柱内;一支沿腹腔前壁挟脐上行,散布于胸中,再向上行,经喉,环绕口唇;一支出会阴,分别沿股内侧下行到大趾间。

[主要病证]

吐血、气逆上冲、少乳、月经不调、闭经、崩漏。

四、带脉

[名称]

带脉循环围腰一周,如束带状,能约束诸脉,所以有“诸脉皆属于带”的说法。

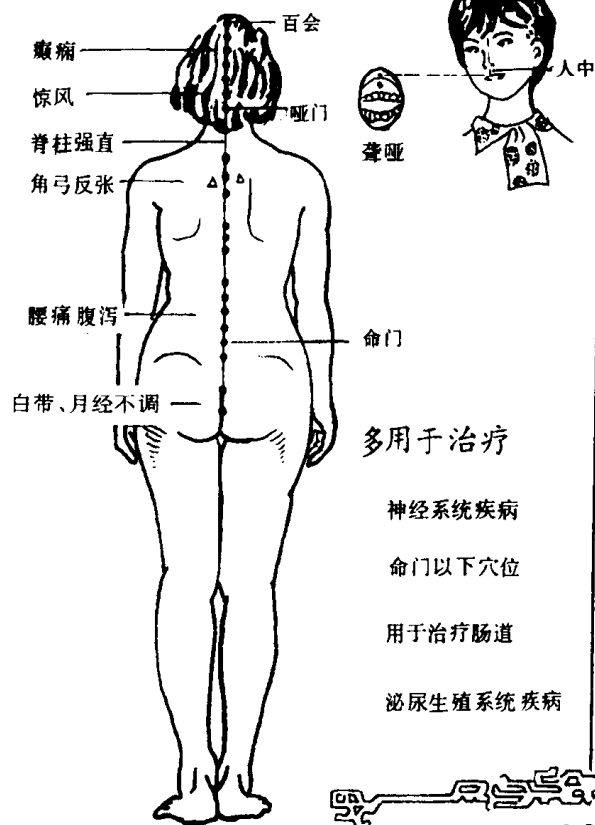
[循行部位]

起于季肋下的章门穴,向后下方至带脉穴,环绕腰腹一周,再向前下方斜行至维道穴。

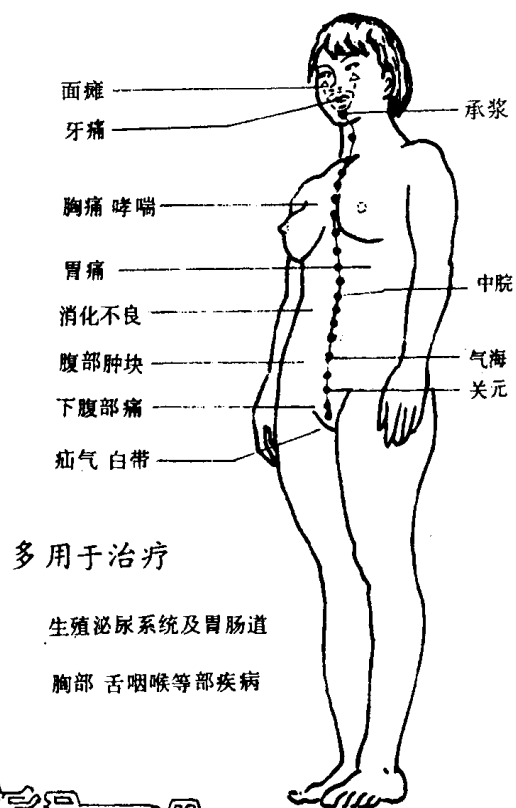
[主要病证]

腰部胀满,腰软无力,子宫脱垂,带下。

督脉



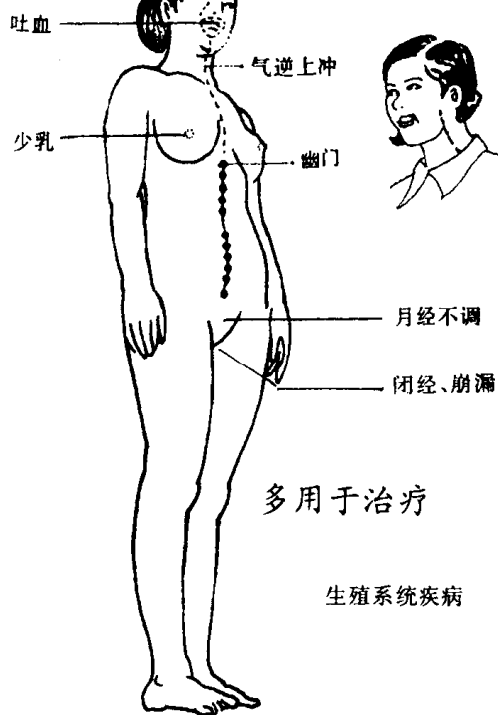
任脉



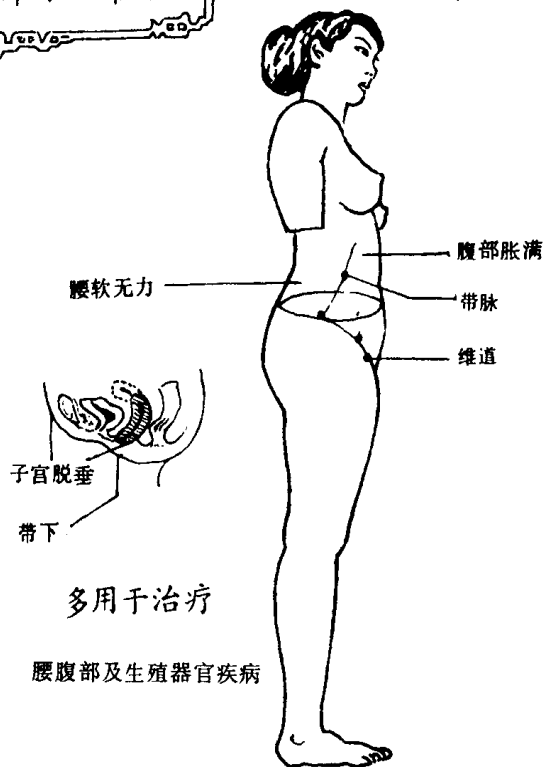
经络 (五)

督脉 任脉 冲脉 带脉

冲脉



带脉



第五章 四诊方法

第一节 望 诊

望诊是通过观察病人神、色、形、态来了解一般情况,具有中医特色的是观察舌。通过舌诊来判断疾病性质。对3岁以下小儿常用望指纹辅助切诊。

[望神]

观察病人精神、意识、动作和反应情况:凡精神充沛,神志清醒,两眼有神采,面色润泽,说明正气尚存。若精神萎靡,意识障碍,两目无神,面色晦暗,表示正气已伤。

[望色]

观察面部和皮肤的颜色和光泽,中医认为能反映脏腑气血盛衰和病理改变。中国人正常为微黄红润,有光泽。若呈苍白色,主虚寒证,失血证(西医证见,参阅图解);萎黄色,主虚证、湿证;潮红色主热证;青紫色,多系危症,主寒证,瘀血证;暗黑色,多见慢性疾病,主肾虚,瘀血证。

[望形体]

主要观察壮弱、胖瘦。中医认为胖人多半阳气偏虚、多湿,瘦人多半阴血偏虚,多火,故胖人易生痰、中风;人易生虚热。

[望姿态、体位]

病人动静姿态和体位是疾病的外在表现之一。中医学认为:喜动者,属阳证;喜静者属阴证。卧位者,若转动自如,喜面向外侧,多为阳、热、实证;蜷缩成团,身重思睡,面向里侧,多为阴、寒、虚证。坐不得卧,卧则气闭,多为心阳不足,水气凌心或内有伏饮,肾不纳气等。

[舌诊]

是望诊中的重要内容,观察脏腑气血的寒热、虚实,重点是看舌质。正常人舌体淡红色,活动自如,不燥不腻。观察病邪的深浅和寒、热、湿、燥的变化,以及消化功能的病变,重点是看舌苔,正常人苔薄白。① 舌体:淡白舌,胖嫩有齿痕,多为脾肾阳虚,气不生血,可见于慢性肾炎,各种病因的贫血。红绛舌,多为热盛和肺肾阴虚津液不足,见于各种发热性疾病和慢性消耗性疾病。青紫舌,多为瘀血阻滞,可见于心脏病、血液病和恶性肿瘤。② 舌苔:白苔,主表证、寒证,见于上感初起,慢性腹泻患者。黄苔,多属里热,多见于热性病热盛期和消化系统疾病。灰黑苔,主里证、里热证、寒湿证,可见于慢性腹泻与慢性肾炎患者。厚苔提示病邪传里,痰湿积滞。燥苔说明热盛伤津,阴液亏耗。滑苔、腻苔,多属水湿内停,湿邪壅阻。舌光无苔为胃气衰败或胃阴大伤。

[局部望诊]

包括:① 头的外形、动态及毛发色泽、分布。② 望目,除观察眼神外,还应注意外形,颜色,动态。③ 望耳,注意耳轮色泽及耳道情况。④ 望鼻,注意鼻的外形及鼻内分泌物。⑤ 观察唇的颜色、润燥和形态,注意牙齿形态及润燥和牙龈色泽,咽喉的外观、颜色等。⑥ 望皮肤,注意皮肤的肤色和外形变化,包括浮肿、皮疹、疔疖痈疽。⑦ 对病人排泄物和痰、尿、粪、呕吐物、白带等观察其量和性状,以协助辨证。

[望小儿指纹]

指纹是浮露于食指掌侧前缘的脉络,属于局部望诊,用于3岁以下小儿。由于小儿脉部短小,切诊时常啼哭躁动,影响脉象的真实性,指纹是用手太阴肺经的一个分支,因此望诊指纹与诊寸口脉意义相同。

指纹分“风”、“气”、“命”三关:食指近端第一节为风关;第二节为气关;第三节为命关。望诊时医生用左手固定小儿食指末端,用右手拇指在观察部位由指端向根部推几次,以便指纹显现。观察内容有三:① 色泽正常指纹呈浅红色,隐现于风关之内。若色鲜红,多属外感风寒表证。色紫红,多为热证。色紫黑提示病情危重。若色淡,多属虚证。色滞暗者,属实证。色青者,见于惊风或痛证。② 长短:指纹在风关者,示病轻邪浅。指纹透气关,说明邪已深入。若指纹达命关则提示病情严重。③ 浮沉,指纹浮现明显者,为病邪在表,若沉隐不显则多属病邪在里。

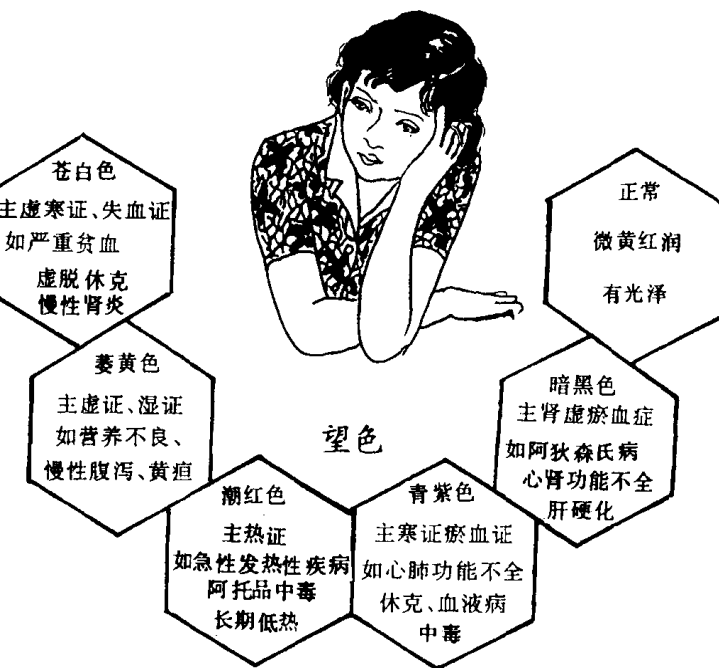


望神

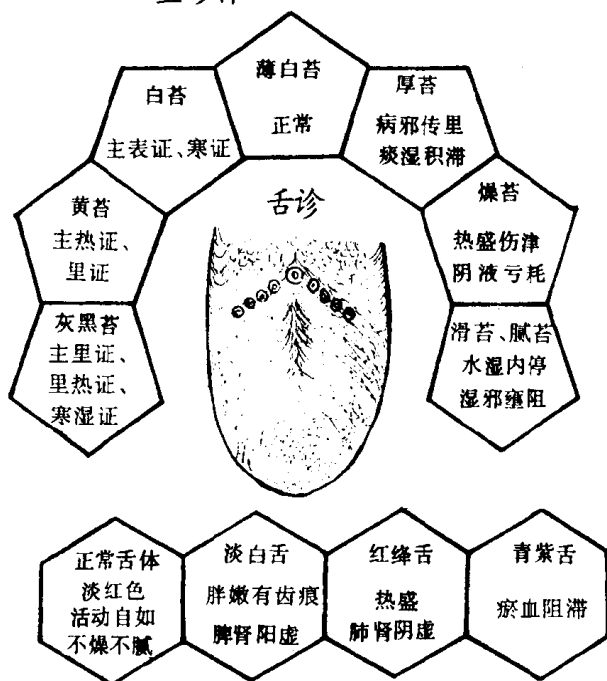
观察精神、意识、动作、反应



望形体



望姿态、体位



望 诊

第二节 闻 诊

闻诊,四诊之一,包括听声音和嗅气味两方面,医生凭听觉了解病人的语音、呼吸、咳嗽、呻吟等声音变化和借助嗅觉嗅取病人口腔和排泄物的气味,用以协助辨别疾病的寒、热、虚、实。

[听声音]

喉是发声的重要器官,发声时声带向中线移动,声门闭合,当气流自肺部呼出冲击声带,就发出声音(称为基声),再经过喉腔、咽腔、鼻腔及胸腔的共鸣作用,以及唇、舌、牙、软腭及颊部在神经系统协调下的运动,才发出各种不同的声音和语音。喉部产生音调的高低取决于声带紧张度、长度及呼出气流的力量。因此病人说话声音的强弱,反映正气的盛衰,也与人的情志变化有一定的关系。例如喜气在心的声音会欣舒、悦耳;怒气在心的声音,必定愤怒严厉;而哀事在心的声音必然悲哀而嘶哑,也一定在病理上反映出来。

1. 辨别阴阳、寒热、虚实:凡声音高亢宏亮、多言好语,或怒骂叫号、语无伦次、狂言奔走不定等,多属阳证、热证、实证的声态。凡无声懒言、语言无力、断断续续或言而颤抖者,多属阴证、寒证、虚证的声态。

2. 辨内伤外感:外感风寒者,语言声重如从瓮中所出,同时见鼻塞、流涕。外感实证,语言响亮急躁。热证语言粗厉,高声谵语或多言。内伤劳倦者,语言迟缓,懒不欲言或勉力回答也声不振奋。发不出音有虚实之分:凡外感风寒、风热或感邪后又伤于饮食者,多为实证;而内伤,肺肾阴虚,津液不能上承,反复发作或持续日久者,多属虚证。

[听呼吸]

喉的声门,是空气出入肺部的必经之路。平静呼吸时声门较小;呼气时声门微闭,吸气时声门张大。用力吸气或体力劳动时,声门扩张。因此呼吸声音也有强弱、虚实、热寒之分。

1. 气微与气粗:呼吸有力,气粗而大,多是热邪内盛、气道不利的实热证;呼吸微弱、短促,多是肺气不足的内伤的虚证。

2. 哮与喘:呼吸急促、喉中有哮鸣声响的中医称为“哮”。呼吸困难、张口抬肩、不能平卧者称为“喘”。喘有虚实之分:呼吸气粗、声高息涌、惟以呼出为快,属实证;凡声低息短、呼气延长、张口抬肩,属虚证。

[咳嗽声]

是肺气上逆的表现。咳声重浊多为外感实证;久病咳嗽无力、声低气怯多为内伤虚证;咳嗽嘶哑,新病为实证;久病为肺虚。

[闻气味]

包括闻身体、口腔和各种排泄物的气味,临床虽不常采用,但对某些疾病的诊断,可提供重要的依据。

1. 身上发出异常臭味,如散发特殊的肝腥臭气味,多属热毒内盛,见于肝昏迷患者。身上发出烂苹果样臭味,多属脾虚肾衰的危症,见于尿毒症、糖尿病酮症酸中毒患者。

2. 口腔秽臭多见胃热、消化不良、龋齿、化脓性扁桃腺炎、坏疽性口腔炎、肺脓肿。口气酸馊多见幽门梗阻、胃有宿食。

3. 各种排泄物及分泌物如二便、痰液、脓液、白带等有恶臭,多属实热证。稀薄、略带腥味,多属寒证。

闻 诊



闻诊



嗅诊



语音



呼出气味



呼吸



痰液



排泄物



咳嗽



分泌物



呃逆 暖气



第三节 问 诊

问诊：四诊“临症之首务”。通过问诊了解起病时间、发病原因、病情经过、现在自觉症状、饮食、睡眠及既往病史，再结合其他三诊，作出判断。问诊涉及内容广泛，与西医问诊基本相同，但从中医辨证论治需要出发，应问清下述内容。

〔问寒热〕

要问清有无发热、畏寒。若有，要分清恶寒发热、但寒不热、但热不寒及寒热往来的差别。①恶寒发热是指恶寒发热同时存在，多属表证，其中发热重、恶寒轻，多为外感风热的表热证；若恶寒重、发热轻，多为外感风寒的表寒证。两者均可见于上感、流脑、麻疹等传染病的前驱期。②但寒不热，指不发热，反恶寒，病人怕冷，四肢不温，多伴纳差、腹泻或水肿，属阳虚恶寒，可见于内脏机能衰退的疾病。③但热不寒，指不恶寒反恶热，多有高热口渴、汗多、脉洪大或大便秘结，属实热病证，见于热性疾病的热盛期。若久病低热不退，或伴盗汗、五心烦热，多属阴虚发热，见于慢性消耗性疾病。④寒热往来，指发热和恶寒交替发作，常伴有恶心呕吐、胸胁苦闷等症，称“半表半里”，常见于疟疾和某些肝胆疾病。

〔问汗〕

包括问有无汗、出汗时间、性质及出汗多少。热性病初起，表证无汗多为外感寒邪；表证有汗，多属外感风邪；经常出汗，活动后更甚，为自汗，多为阳虚表卫不固，见于内脏功能衰退的慢性疾病。睡着时出汗，醒则汗止为盗汗，多属阴虚，见于肺结核。大汗淋漓，常见于热性病高热欲退时，若伴四肢厥冷，脉微欲绝，为阳虚气脱的危症，可见于感染性休克患者；半身汗可见于霍纳氏综合征；头汗，手足心汗，多为情绪紧张所致的精神性出汗。

〔问痛〕

①头痛、伴恶寒发热、骨节酸痛，多为外感表证。一侧头痛，多为内风或血虚，见于血管性和神经性头痛。头痛眩晕，并有恶心、呕吐，多为痰饮内阻，见于美尼尔氏综合征。头痛如布裹，并有恶心、厌食、胸闷多为湿热，见于肝炎、肠伤寒初起。持续头痛，过劳时加重，并有心悸、气短困倦者，多属气虚，见于神经官能症。②胸痛、咳嗽、深吸气加重，为悬饮，可见于胸膜炎；胸痛、咯脓血为“肺痛”，见于肺脓肿；胸骨后剧痛，自觉挤压、闷胀感，称为“胸痹”，可见于冠心病。③腹痛病因繁多，病症各异，概括为：暴痛多实，久痛多虚，食后胀痛为实，食后痛减为虚。部位固定，按之加剧或拒按为实；隐隐作痛，无固定部位，按之痛减或喜按为虚。④腰部酸痛，多属肾虚。四肢肌肉、关节、筋骨疼痛或酸麻，关节肿胀，疼痛或游走，多为风寒湿痹，可见于风湿、类风湿关节炎或结缔组织疾病。

〔问睡眠〕

难入睡，多由思虑过度所致，常属心脾两虚。老年人或大病之后因气血两虚，常致少睡。失眠多梦，头痛口苦，性燥易怒，多是肝火亢盛。梦中惊呼，多为胆气虚或胃热。神倦多睡为气虚。身重、脉缓、多睡，多为湿胜。

〔问饮食口味〕

病中饮食如常，多说明胃气未伤，多食易饥，多为胃有实火或消渴症。口渴喜冷饮多为胃热伤阴，口渴喜热饮多为胃阳不足，口苦为肝胆有热，口淡多为虚证。

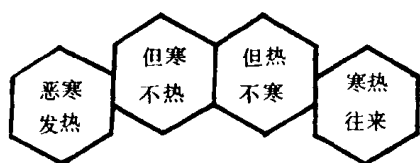
〔问二便〕

便秘多为实、热证，久病老年、大便困难，多为血少津亏或气虚。大便稀溏多属脾虚寒。水泻为湿重，大便为脓血粘液，有里急后重，常为痢疾和直肠癌。小便少黄，为实热；黄赤混浊、尿频、尿痛，多为湿热，见于尿路感染；尿血，多为内火；尿失禁，为肾气虚弱。

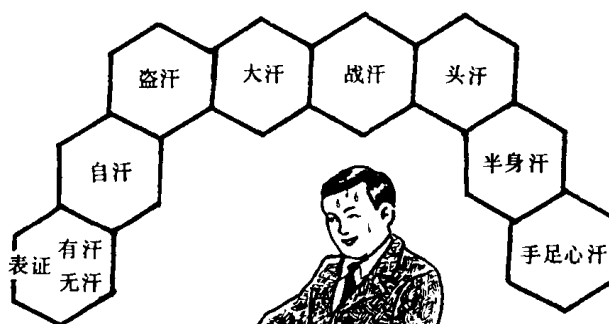
〔问经带〕

①月经提前、量多、色鲜，多是血热；量多色淡，多为气滞血虚；经暗色紫有块、小腹胀痛，多为气血瘀；量多不止，称崩证；量少，持续不断，称漏证。②白带清、稀无臭，多是脾虚湿重；带色稠黄、秽臭，多为湿热下注。

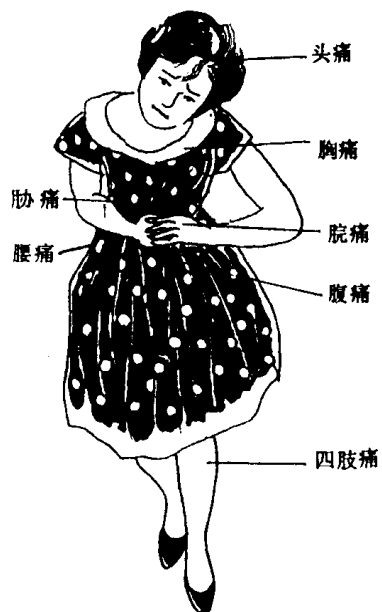
问诊



一问寒热



二问汗



三问痛



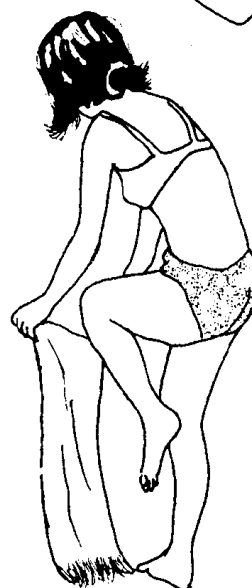
四问睡眠



五问饮食口味



六问二便



七问经带

第四节 切 诊

一、脉 诊

中医的切脉,有许多独到之处,为西医所叹止。如何为西医所共享,尚须进行很多的努力和发掘。

[切脉的方法]

病人手掌向上放平,医生用一手的食指、中指、无名指的前端,按顺序按压在病人腕部桡动脉搏动处,将中指端正对桡骨茎突处,为关部;关之前,食指所对为寸部;关之后,无名指所按处为尺部。按压时,应先轻后重,进行“浮、中、沉”三取。轻按脉为“浮取”,稍加力按为“中取”,重按至骨上为重取。中医学认为左、右手六部脉象分候(诊察)不同脏腑:左手寸部候心和小肠,关部候肝和胆,尺部候肾和膀胱;右手寸部候肺和大肠,关部候脾和胃,尺部候命门和三焦。

[正常脉象]

正常脉搏节律规则,不浮不沉,不大不小,均匀和缓,成人一呼一息4~5次。小儿一息7~8次,称为缓脉(和缓之意非西医的心动过缓)。若缓脉兼浮、兼沉、兼大、兼小则为病脉,如缓而迟者主寒;缓而有力主实;缓而无力主虚。

[异常脉象]

在病理情况下,心脏收缩力的强弱、快慢、节律、血流的速度、血容量的多少、血管壁硬度的、血管的阻力大小,以及血压高低,无疑都会引起脉象的变化。

1. 浮脉:手指轻按肤表,即能清楚触到脉搏跳动,稍加重按反而觉脉搏减弱,称浮脉,多属表证。浮而无力为表虚,见于流感、上感。浮而有力为表实,见于热性病初起。

2. 沉脉:轻按不明显,重按才感到脉搏起伏称为沉脉,沉而无力为里虚,见于心力衰竭和慢性肾炎。沉而有力为里实,见于慢性阻塞性肺气肿。

3. 迟脉:节律规则,但跳动缓慢,一息少于四至,称为迟脉,迟而无力,属虚寒,见于房室传导阻滞。迟而有力为冷积实证,见于阻塞性黄疸,窦性心动过缓。

4. 数脉:节律规则,脉搏快,一息多于五至,称为数脉,多为热证。数而细弱为虚热,见于心动过速或甲亢。数而有力为阳盛,见于发热性疾病。

5. 虚脉:浮、中、沉取均无力,脉管柔软,张力低下,见于气血俱虚,如消化不良或暑证,见于病毒性肝炎。

6. 实脉:浮、中、沉取均有力,脉盛大满指,张力明显,多属热证、实证,见于各种热性病热盛期。

7. 细脉:脉细小似线,来势不盛,可见于诸虚劳损(如心力衰竭)和湿邪阻遏脉道(如热性病昏厥)。

8. 滑脉:脉波充实,来去流利,有圆滑感,称滑脉,多为气盛痰湿,见于美尼尔氏综合征,以及内分泌功能失调所致的经前紧张综合征和子宫功能性出血,但健康人和孕妇也可见,孕妇滑脉一般以寸部较明显,有停经史。

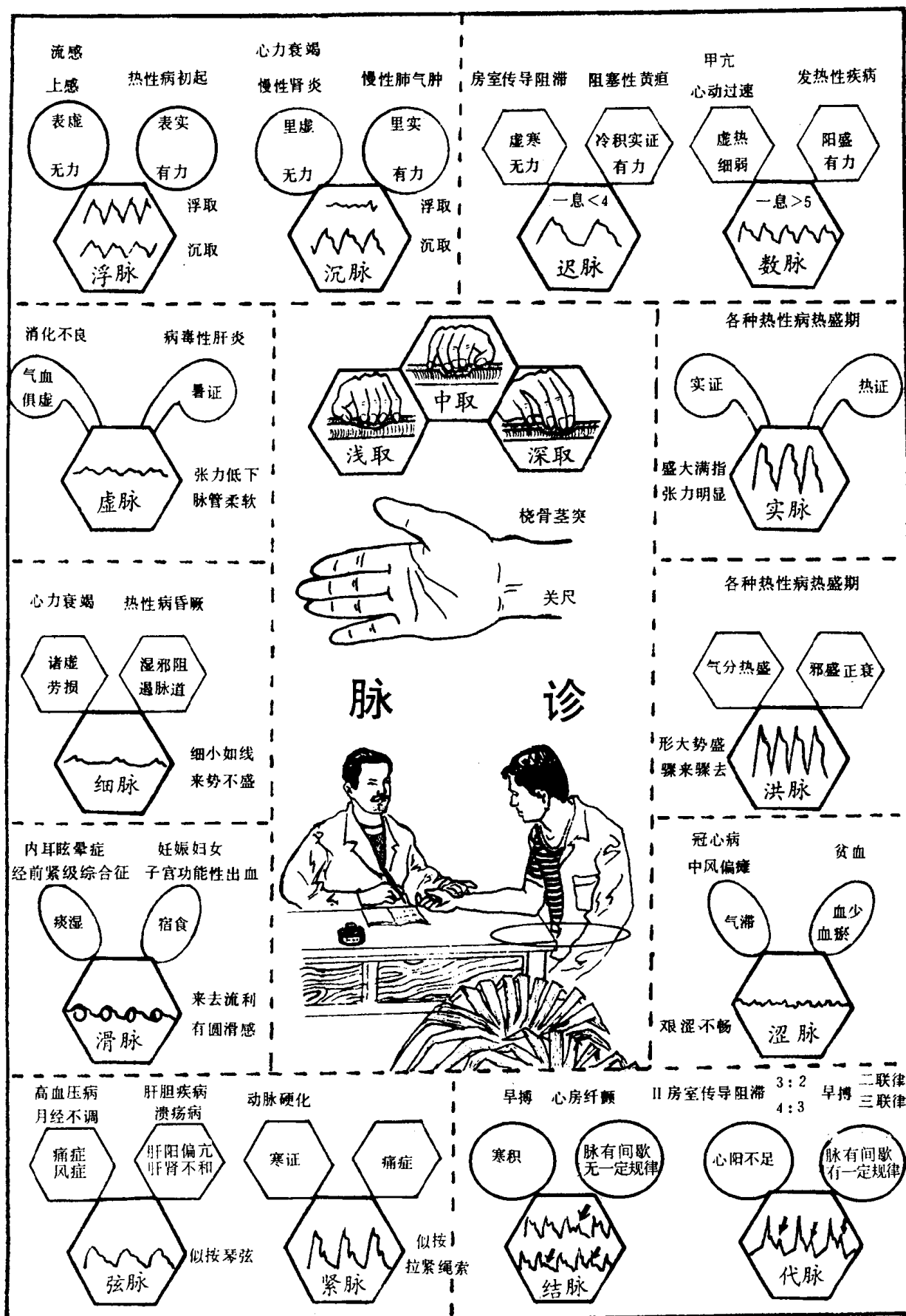
9. 洪脉:脉形大势盛,骤来骤去,称洪脉,多属实证、热证,见于各种热性病热盛期。

10. 涩脉:来去涩滞,有欲来而未来,欲去未即去感者,称涩脉,多属血少、气滞、血瘀,见于冠心病、中风偏瘫,贫血及束支传导阻滞。

11. 弦脉:脉管张力增加,似按琴弦之感,多属痛证、风证,如高血压病、月经不调,以及肝阳偏亢、肝肾不和,如溃疡病、肝胆疾患。

12. 紧脉:如按拉紧的绳索,脉势紧急,应指有力,主寒证、痛证,见动脉硬化、肢体关节剧烈疼痛者。

13. 结代脉:脉搏间有歇止,无一定规律者,称为结脉,见于早搏、心房纤颤,多为寒积。脉有间歇,但有一定规律者,称代脉,多为心阳不足,见于Ⅱ度房室传导阻滞及二联律、三联律。



二、按 诊

按诊,也称触诊,与西医触诊相同,虽不如西医的细致、详尽,却有中医特色,分为肌肤触诊、脘腹触诊、俞穴触诊。

〔肌肤触诊〕

用手直接接触病人体表,审察体表温凉、润燥及肿胀等。

1. 皮肤冷暖:皮肤灼热,体温升高,多为热证、实证,可见于各种热性病热盛时,初按热甚,久按热反轻的是热在表;若久按热更甚,是热在里。如果体温虽高,而四肢反冷,称为“热厥”,可见于高热惊厥前兆和感染性休克。皮肤湿冷,体温下降,多为虚证、寒证,可见于甲状腺功能减退症,慢性消耗性疾病,重度营养不良;若同时有四肢厥冷、唇甲发钳者称为“冷厥”,见于低血容量性、创伤性休克及心力衰竭、虚脱。若手足心烦热,午后体温升高,多为阴虚潮热,可见于肺结核等消耗性疾病。

2. 皮肤润燥:皮肤柔润,多是津液未伤。枯燥甲错,多属津液已伤,汗腺分泌功能障碍,或见于甲状腺功能减退及植物神经受损。

3. 肌肤疮疡,是中医外科皮肤疾患总称,包括疔、痈、疖、疮、疥、癣、溃疡等。凡疮疡肿痛拒按的,多属阳证。平坦按之疼痛较轻的,多属阴证。按之固定、坚硬,无论局部热否,为无脓;按之边硬顶软,多为有脓。

〔腹部触诊〕

剑突下的部位中医称之为脘部,即西医的上腹部。

1. 轻触脘腹表面,若按之局部坚硬、压痛、拒按者,多属实证和瘀血,提示腹部有炎症、脏器扭转、栓塞。若脘腹疼痛,按之反觉舒服、局部柔软者,多为虚证气滞,见于胃肠痉挛、痉挛性结肠。

2. 腹胀满,叩之如鼓,若小便自利为气胀,见于胃肠功能紊乱的肠胀气。若小便不利,见于尿潴留。若如囊裹水,则见于腹水或囊肿。

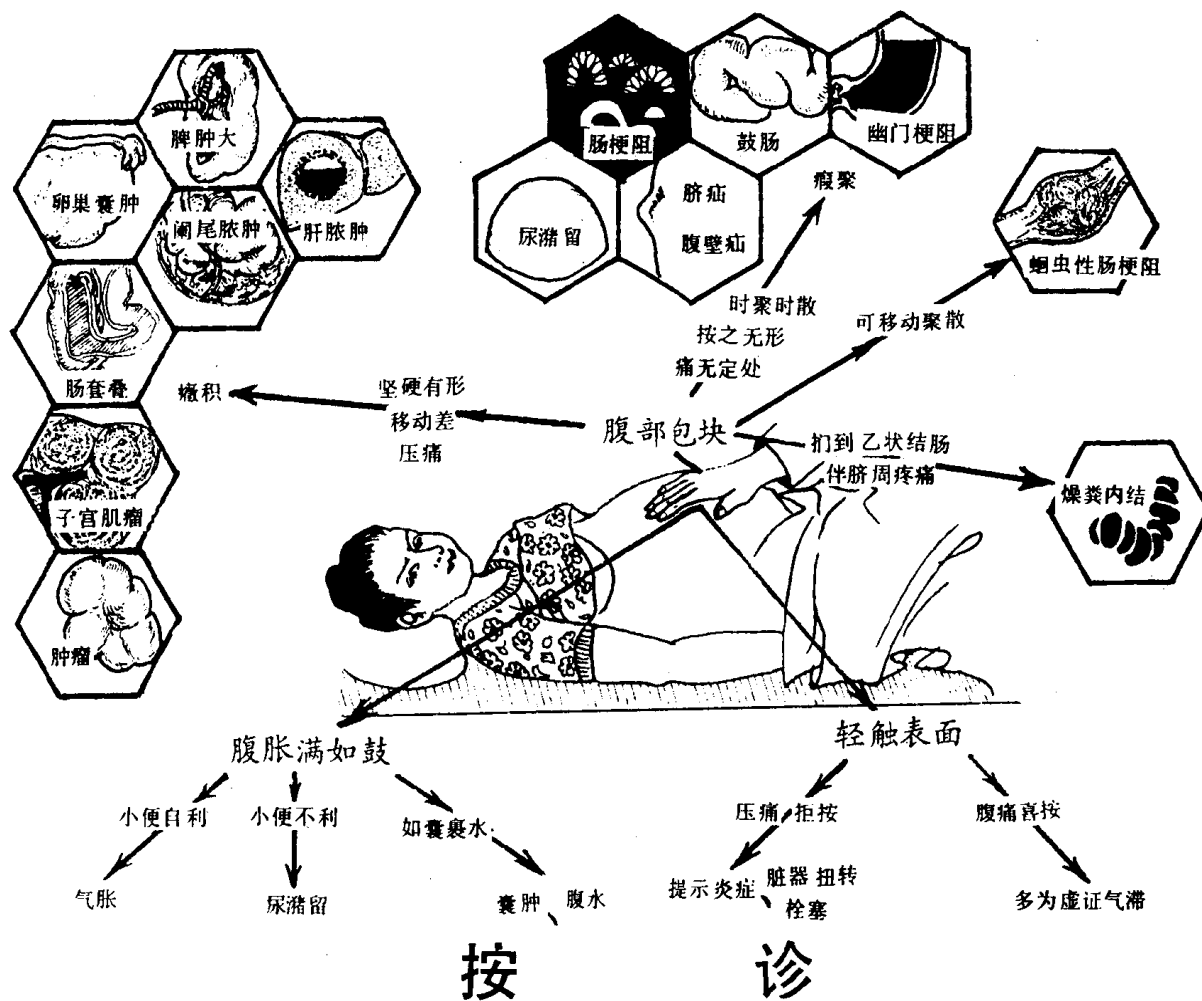
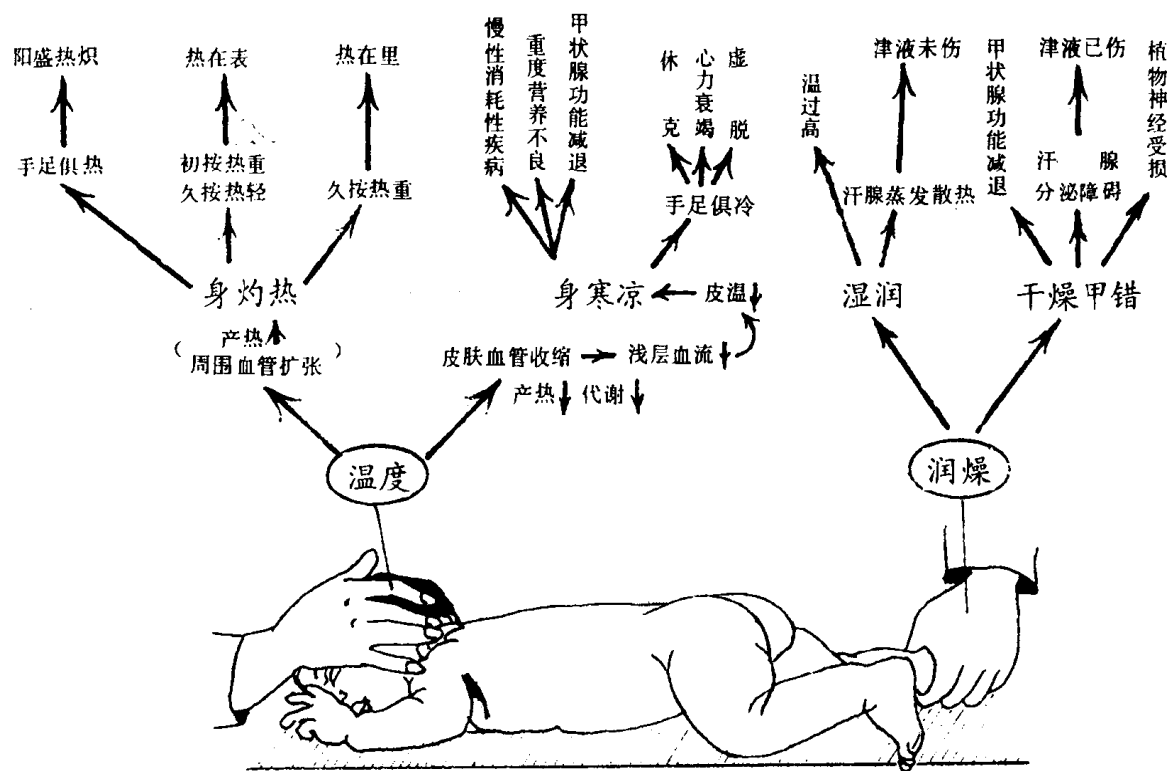
3. 腹内有肿块,若坚硬有形,移动差且有压痛者,中医称“症积”,见于肝脓肿、脾肿大、阑尾脓肿、卵巢囊肿、肠套叠、子宫肌瘤和肿瘤。若按之无形,痛无定处,时聚时散,中医称“瘕聚”,可见于肠梗阻、幽门梗阻、鼓肠、尿潴留、脐疝、腹壁疝。若打到乙状结肠,伴有脐周疼痛者,多为燥粪内结;若腹有结聚可移动聚散者,多为虫积,见于蛔虫性肠梗阻。

〔按俞穴〕

俞穴是经络气血在身体表面输注或通过的重点部位,也是五脏六腑之气所转输的地方。因此按俞穴,也作为诊察内脏疾病的依据。

方法:在经络循行的通路上或经气汇聚的穴位处进行触按,若有明显压痛或敏感反应,甚至摸到结节状、条索状反应物者,根据所在的俞穴部位,可提示脏腑的疾病。

1. 肺俞穴摸到结节或中府穴有压痛,提示肺部有病。
2. 肝俞穴和期门穴有压痛,提示肝脏有病。
3. 胃俞穴和足三里穴有压痛,提示胃部有病。
4. 阑尾穴有压痛,提示急性阑尾炎。



第六章 病因辨证

第一节 六淫

风、寒、暑、湿、燥、火是自然界的六气。六气的反常变化如太过或急骤发生,抵抗力或适应性差的人就可致病,成为疾病发生的病因。中医文献称这种“不正之气谓之邪”。所以又有风邪、寒邪等六邪之称。过多、过甚谓之“淫”,也有六淫称谓。六淫在中医临床辨证施治方面,占有相当重要的地位。它的含义有两个方面:一是指引起疾病的直接刺激;二是指证候的归类方法。

一、风邪

风为春季的主气,但一年四季均可发生。风邪有外风、内风之分:外风指风邪直接侵袭人体而得病,例如伤风。风具有流动的特性,因此是生物性病原体 and 过敏性疾病过敏原的运载工具,容易引起传染病的流行和过敏性疾病的发作。中医学精辟地概括为“风者,百病之长也。”内风是由肝脏功能失调所引起,把起病急骤、变幻无常的症候群如卒然昏倒、震颤、抽搐、眩晕、摇头等都归纳为内风的范畴,所以《至真要大论》有:“诸风掉眩,皆属于肝”的说法。

[性质特点]

① 风为百病之长,风邪是外邪致病的先导,寒、燥、湿、热等邪气多依附风而侵袭人体。如风寒、风热、风湿、风燥等。② 风属阳邪,其性开泄,善动,具有升发向上的特点,易侵犯人体上部,出现头痛、颜面浮肿等症均与风邪有关。③ 风邪多侵犯肌表或从口鼻而入,使皮毛腠理开泄,出现恶风发热、汗出、咳嗽、咳痰、咽痛等“表证”症候。④ 风有善行和数变特点,因之中医学将游走性关节疼痛的风湿、类风湿性关节炎列入“风、寒、湿”三邪引起的“痹证”。皮肤瘙痒、发无定处、此起彼伏的过敏性皮疹,如风疹、荨麻疹、湿疹均属于风邪范畴。⑤ 风行主动,“动”具摇摆不定特征,故将惊厥、项强、两眼上翻、角弓反张诸症表现列为肝功能紊乱所致的“热极生风”,将头目眩晕、卒然昏倒、半身不遂、西医的脑血管意外、面神经麻痹视为肝脏的“阳生风”;而有视物模糊、肢体麻木、震颤或肌肉跳动归为“血虚生风”。可见所谓内风实际是一种症候学的归类。

[常见病证]

外风有① 伤风、② 风寒、③ 风热、④ 风湿、⑤ 风痹、⑥ 风水、⑦ 风疹等;内风已在“风行主动”中提及,不再赘述。

二、寒邪

寒为冬季主气,其他季节也可见到。寒邪也有外寒、内寒之分。外寒指寒邪直接侵袭人体,根据深浅又有伤寒和中寒之分。伤寒(并非西医的肠伤寒)指寒邪伤及肌表,也包括生物性病原体侵袭。中寒则指机体阳气衰虚,表现为机能减退,多与肾阳有关。

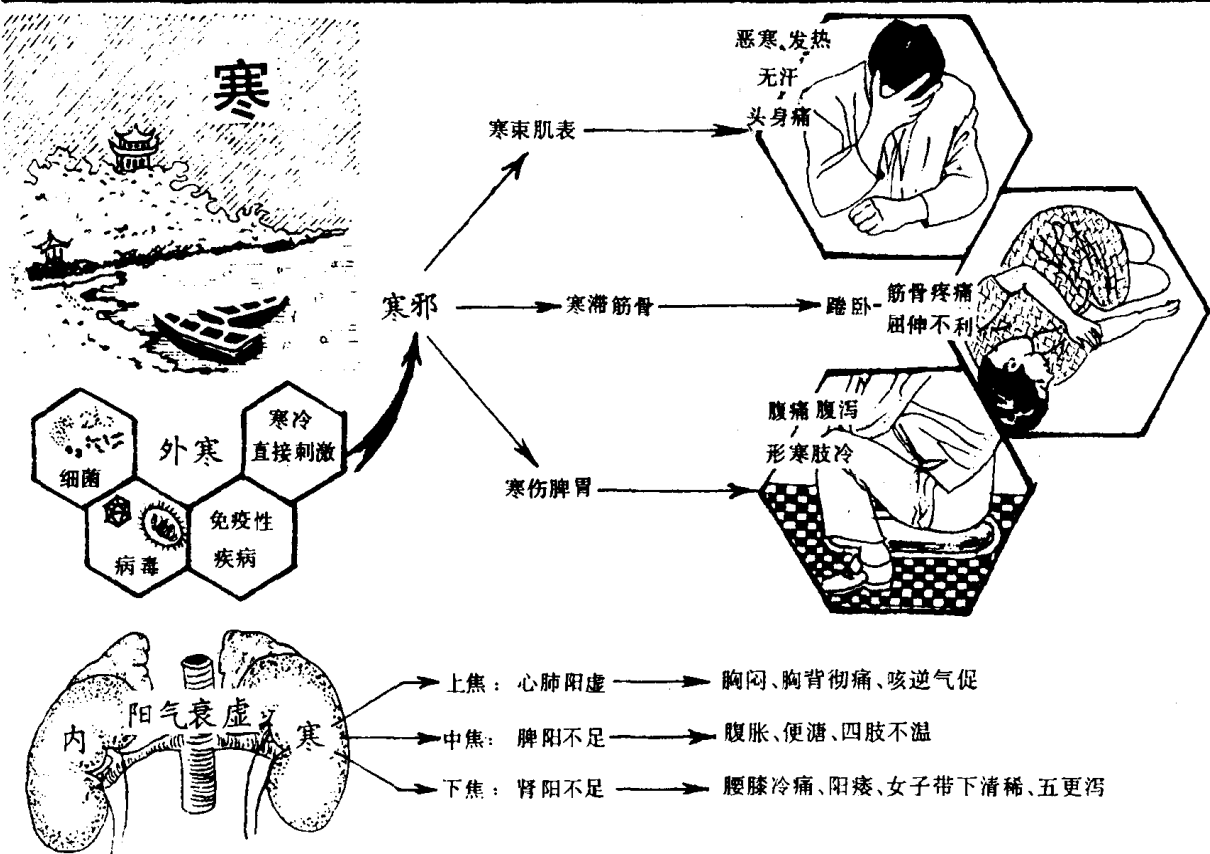
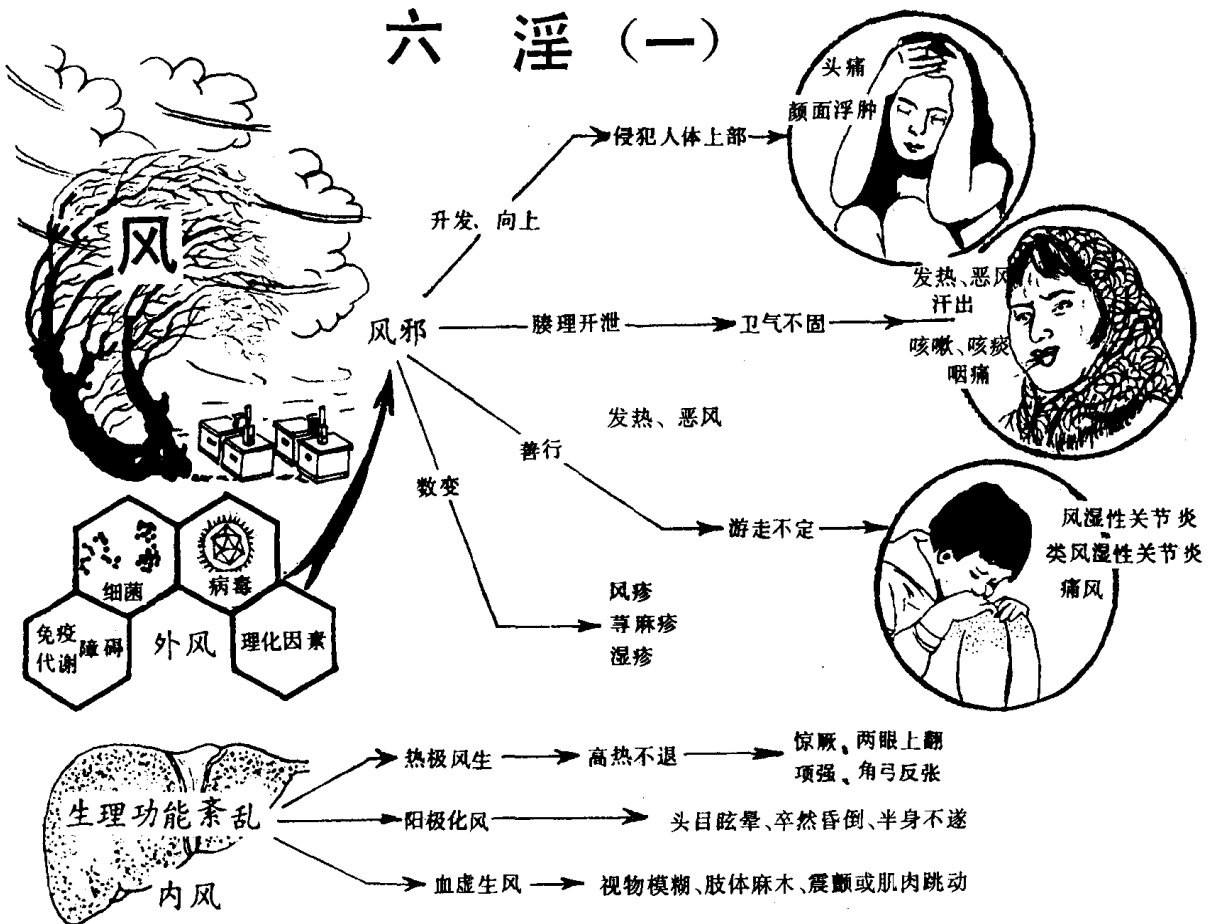
[性质特点]

① 寒为阴邪、易伤阳气。阳气主指元气,它以三焦为通路而运行全身,具激发,温煦,推动脏腑、经络、身形功能。阳气受损,则必定出现机能减退的寒证。如寒邪侵袭肌表则出现发热、恶寒、无汗、头身疼痛等“卫阳被郁”症候。若伤脾胃(恣食生冷的“冰箱症”)则发生腹痛、腹泻或饮食不洁,出现严重吐泻,导致脱水和低血容量性休克,均为“中寒”,可见于霍乱、急性胃肠炎的严重脱水。② 寒性凝滞,所谓凝滞就是闭塞不通之意。若客于脉外引起血供减少,病人常取蜷缩而卧体位。客于脉中则气不通,产生筋骨疼痛、肢体屈伸不能自如症状。③ 内寒表现为上焦心肺阳虚、胸闷、胸背彻痛、咳喘气促;中焦脾阳不足,同“中寒”表现;下焦肾阳不足,则出现腰膝冷痛、阳萎、女子带下清稀、五更泻等。

[常见病证]

外寒有① 风寒、② 寒痹(痛痹)、③ 寒伤脾胃。内寒主要有阳衰气虚、机能减退的表现。

六淫 (一)



三、暑 邪

暑是夏天炎热的气候,为夏季的主气。人在这样炎热的环境里,如果不能适应,就会感受暑邪而生病,也包括生物性病原体所致的肠道传染病,如病毒性肝炎、脊髓灰质炎、细菌性食物中毒、霍乱、细菌性痢疾、阿米巴痢疾等有明显的季节性的疾病。暑邪纯属外邪,无内暑之说。

[性质特点]

① 暑为阳邪,其性炎热。人体体温相对恒定是机体产热和散热过程保持动态平衡的结果。人体依靠辐射、传导、对流及皮肤出汗蒸发等四种方式散热,当外界温度超过皮肤温度($>32^{\circ}\text{C}$)时,辐射、传导和对流散热将降至零,唯一依赖皮肤出汗蒸发散热,若出汗尚不能将身体所产生的热散发出去,则出现高热、口渴、多汗、脉洪等表现。② 暑邪易耗气伤津,暑天体温升高,氧气消耗量增加,大量出汗失液,则会出现呼吸加快、血液浓缩、身倦无力、口燥唇干、尿少、便秘等症状,中医称为“耗气伤津。”③ 暑邪多挟湿:一因夏季多雨,二因暑日乘凉露宿,恣饮生冷,易伤脾胃而生内湿,出现恶心、欲吐、食欲不振、胸闷、腹泻等。

[常见病证]

① 伤暑,常见于暑令流行性感冒。② 暑热,以持续低热为主要特征,到秋凉后,体温常自行恢复正常,多见于小儿。③ 暑温,常见于乙脑、脊髓灰质炎、钩端螺旋体病等。④ 暑泄,见于病毒性肝炎、伤寒、菌痢、阿米巴痢等。⑤ 中暑,可分日射病、中暑痉挛、中暑高热、中暑衰竭。

四、湿 邪

湿为长夏主气。空气中含水湿过多,即湿邪,也包括生物性病原体,有外湿、内湿之分。外湿为病与季节、环境有关:黄梅季节多雨,土地潮湿,物体易霉,早晨雾气弥漫,居处潮湿,长期水中作业,涉水淋雨,人在此时易病。内湿为脾失健运,属于症候归类范畴,中医有“诸湿肿满,皆属于脾”,将现代医学的慢性肠炎、慢性菌痢、慢性肾炎,以及肝性、肾性、营养不良性水肿时表现的面色苍白、食欲不振、恶心、呕吐、腹胀、腹泻、小便量少、浮肿等均归为脾失健运,水湿内停所致。

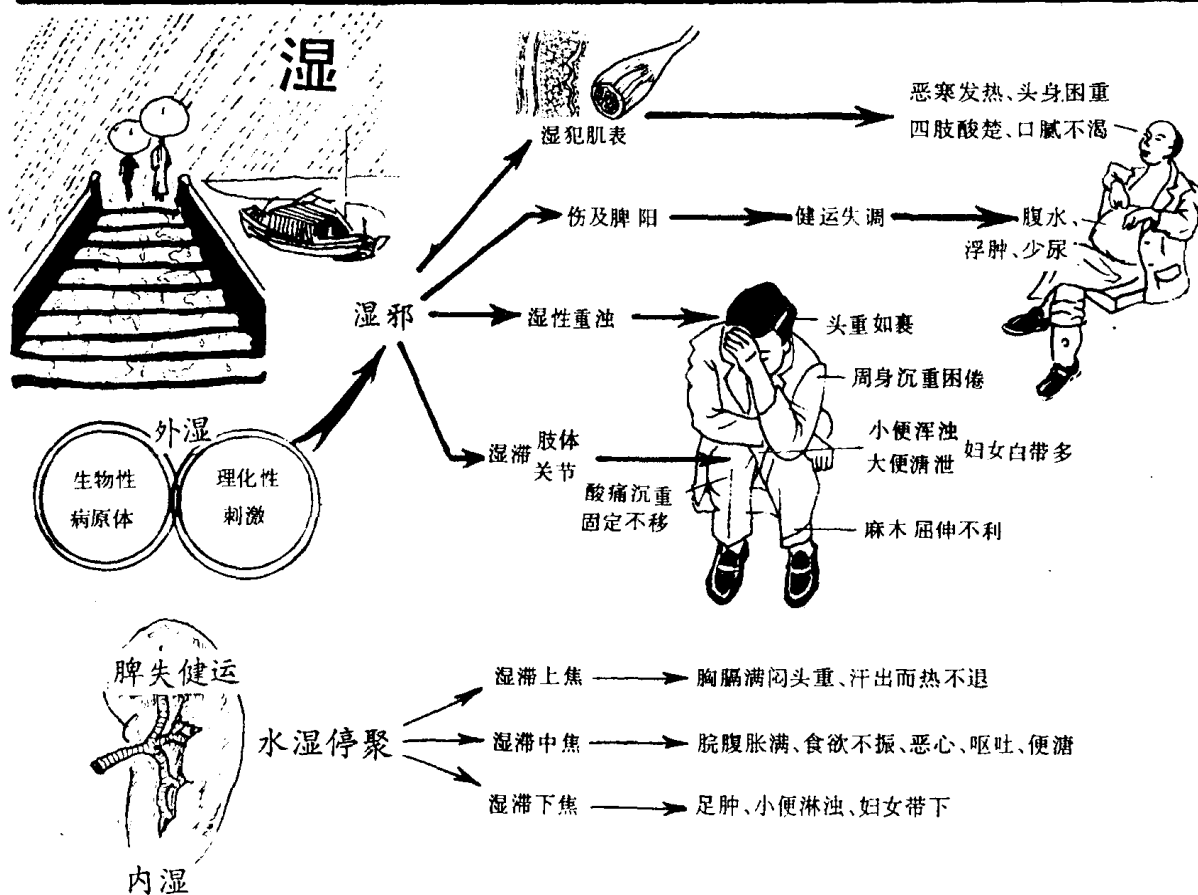
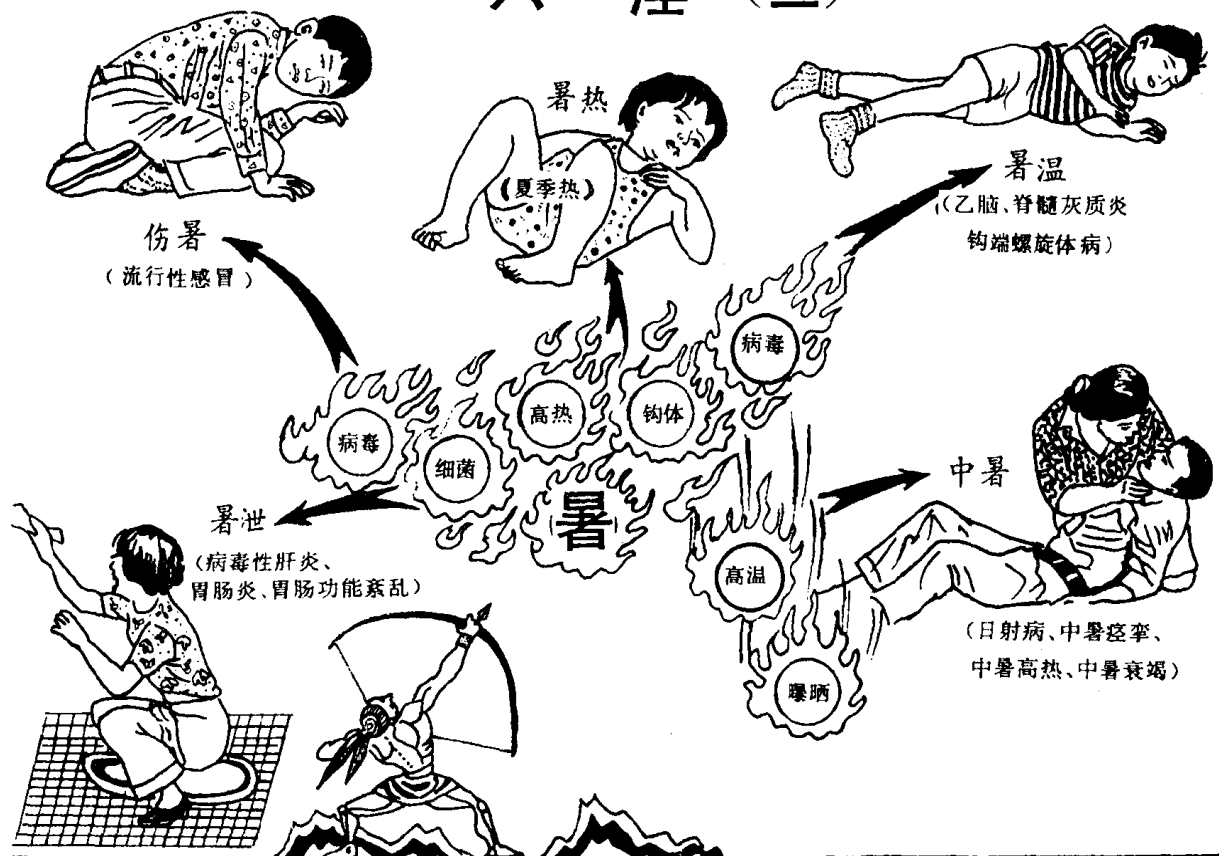
[性质特点]

① 湿性粘滞,所以病程较长,缠绵难愈。② 湿为阴邪。脾是运化水湿的主要脏器,性喜燥恶湿,如果湿邪留滞,常伤及脾阳,使水湿内停,而出现腹水、尿少、浮肿、腹泻等症。③ 湿性重浊,所谓“重”即重着之意,指头重如裹,周身沉重困倦,若湿犯肌表有恶寒、发热、四肢酸楚、口腻不渴;若湿滞关节、肢体,则四肢酸痛、漫肿、固定不移或肢体麻木、伸屈不能自如。所谓“浊”即秽浊,如面色污秽、眼屎多、大便稀薄、小便浑浊、妇女白带过多、湿疹流水等。④ 湿热下注,常有尿频、尿急、小便涩痛、疮疡流水、流脓等。

[常见病证]

外湿有① 湿犯肌表。② 湿留关节。内湿常见证型有三:① 湿滞上焦,可见胸膈满闷、头重、头昏、汗出而热不退。② 湿阻中焦,可见脘腹胀满、食欲不振、恶心、呕吐、便溏、四肢沉重。③ 湿注下焦,可见足肿、小便淋浊、妇女带下等症。

六淫 (二)



五、燥 邪

是秋天的主气,与湿的意义相反,是指空气中水分减少、湿度降低而形成的干燥现象。燥有外燥、内燥之分;人体感受外界燥邪,包括生物性病原体而发病,称为外燥。外燥为病,多见于气候干燥的秋季,所以中医有“秋燥”之称。燥邪多从口鼻而入,其病常从肺卫开始。外燥又有温燥、凉燥之分。初秋气温高而干燥,是为温燥;深秋气温凉而干燥,易感凉燥。内燥指津液或精血亏损所表现的症候。

[性质特点]

① 燥邪干涩,易伤津液。无论外燥、内燥都表现有体表肌肤和体内脏腑缺乏津液,如口鼻干燥,咽干口渴,皮肤干燥、裂,毛发干枯、失去润泽,大便秘结,小便短少等。所以《素问玄机原病式》说:“诸涩枯涸、干劲皴揭,皆属于燥”。② 燥易伤肺:肺为娇脏,外合皮毛,外感燥邪,最易伤肺,使肺失宣降而出现干咳少痰,或痰稠难于咯出,痰中带血、喘息,胸痛等症,见于急性咽炎、白喉、呼吸道感染、胸膜炎、肺结核等呼吸道疾病。

[常见病证]

外燥有① 燥邪犯目,常见于睑缘炎、急性结膜炎、泡疹性结膜炎。② 燥犯咽喉,常见于急性咽炎和白喉。③ 燥邪犯肺,见于秋令上呼吸道感染与肺结核反复发作。内燥见于剧烈吐泻、失血、高热、汗出过多造成水、电解质紊乱及老年人功能衰退等所致津枯血燥表现。

六、火 邪

又称“热邪”,指光和热的物理刺激,但在很大程度上是指外感热性病(包括生物性病原体)在热盛期的症候群。火与热经常并称。火邪有外感和内生之分。直接侵入人体为病的属于外感;由于情志活动异常或气机不畅,郁而化火以及阴液损耗,形成阴虚火旺者皆属内生。

[性质特点]

① 热邪蒸发炎上,所以火热为病,可见高热、恶热、烦渴、汗出。若扰乱神明,则有烦躁失眠、狂燥妄动、神昏谵语、四肢抽搐、颈项强直等表现,以及五官部位的红肿热痛,如牙齿肿痛、目赤涩痛、舌尖独赤、咽喉疼痛等症。② 消灼津液、火热邪气最易伤津,故除上述蒸发热象之外,同时可见口干渴、喜冷饮、大便干结、小便短赤表现。③ 迫血妄行、火热之邪可使血流加快,甚至迫血妄行,使血液溢于脉外而导致各种出血,如衄血、吐血、便血、尿血、皮肤紫癜、妇女月经过多、崩漏等,且可聚于局部,腐蚀血肉而发生痈肿疮疡。

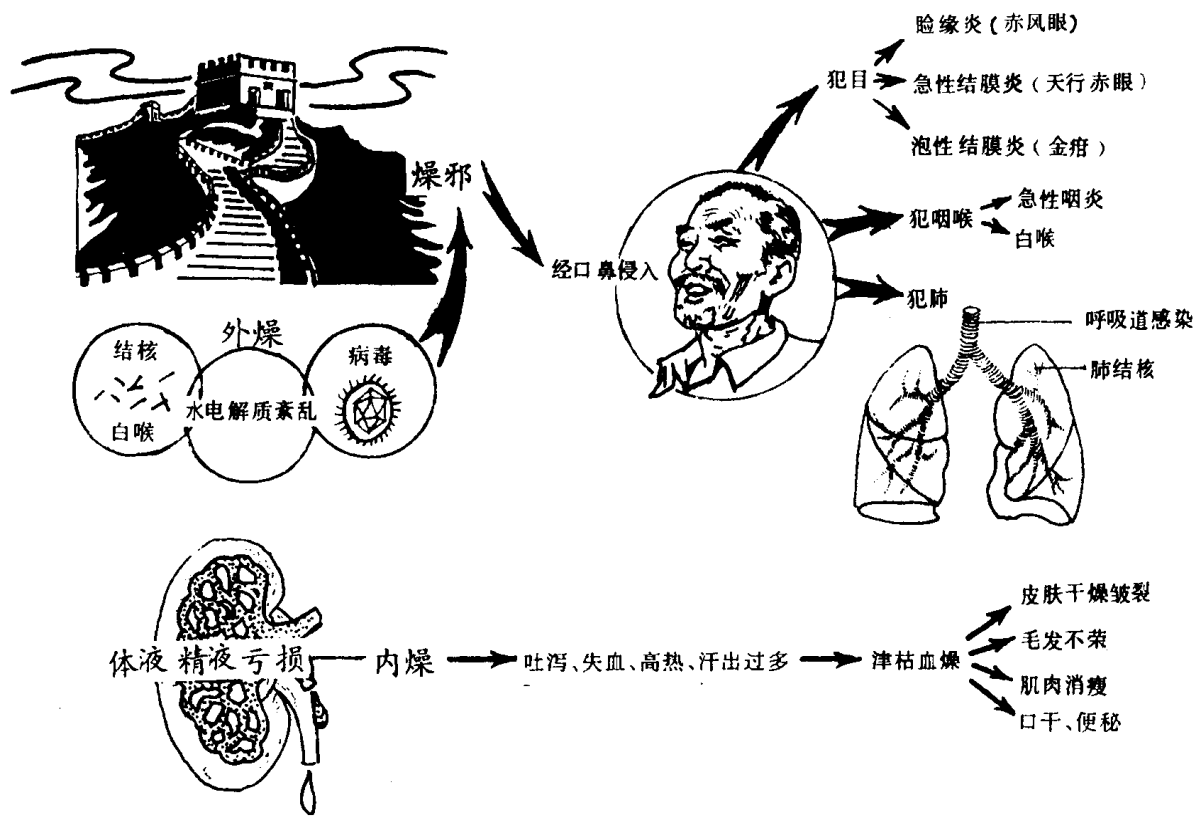
[常见病证]

外感火热证,常见于温热病,初起有发热、恶热、口渴、头痛、咽喉肿痛等感染性和非感染性发热。高热引起神经机能紊乱,在发热早期,神经兴奋性升高出现不安、失眠、幻觉谵妄;至极度高热时,大脑皮层抑制,皮层下兴奋而出现热性昏迷、抽搐。所谓迫血妄行,多由于生物性病原体及其毒素损伤血管内皮而出现各种出血症状。

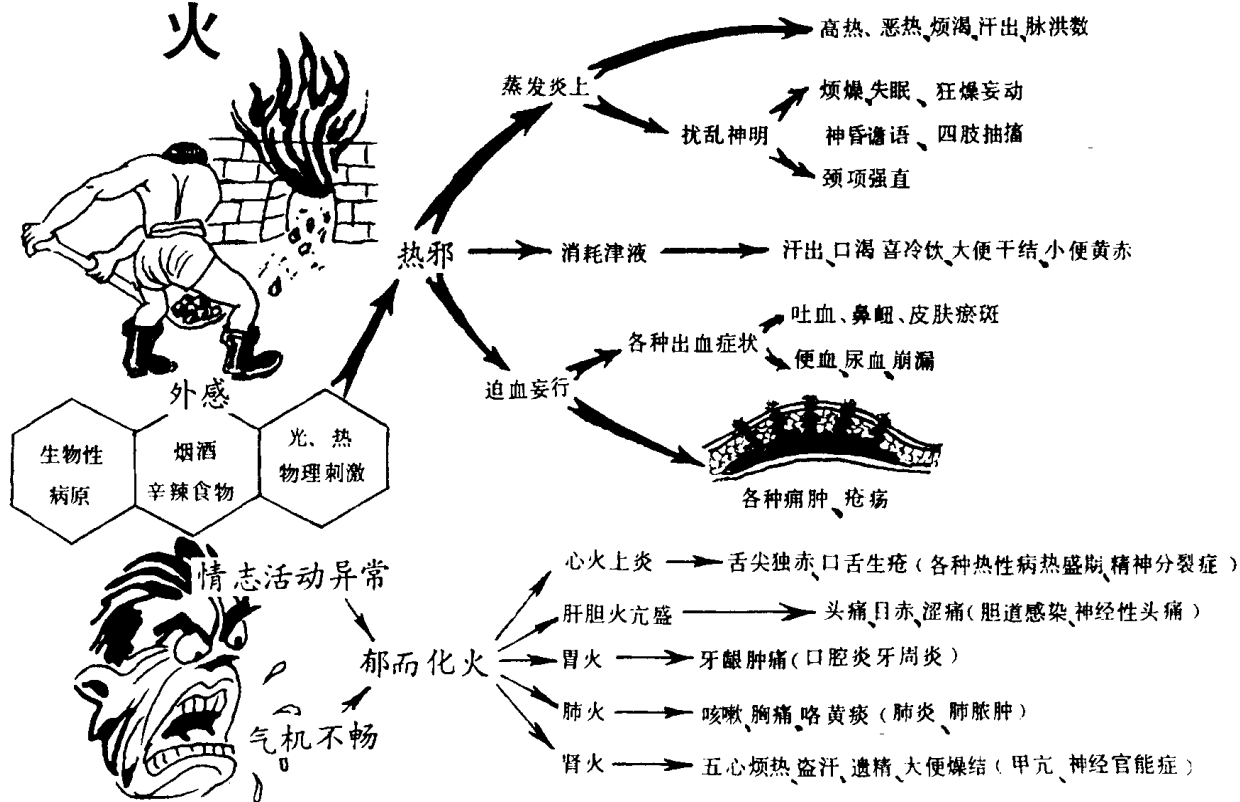
内生火热证,主要有① 心火,常见于某些热性病热盛期、精神分裂症。② 肝胆火,见于胆道感染、神经性头痛、结膜炎、中耳炎。③ 脾胃火,常见于口腔炎、牙周炎。④ 肺火,常见于急性支气管炎、大叶性肺炎、肺脓肿。⑤ 肾火,常见神经官能症、甲状腺机能亢进症。

六淫 (三)

燥



火



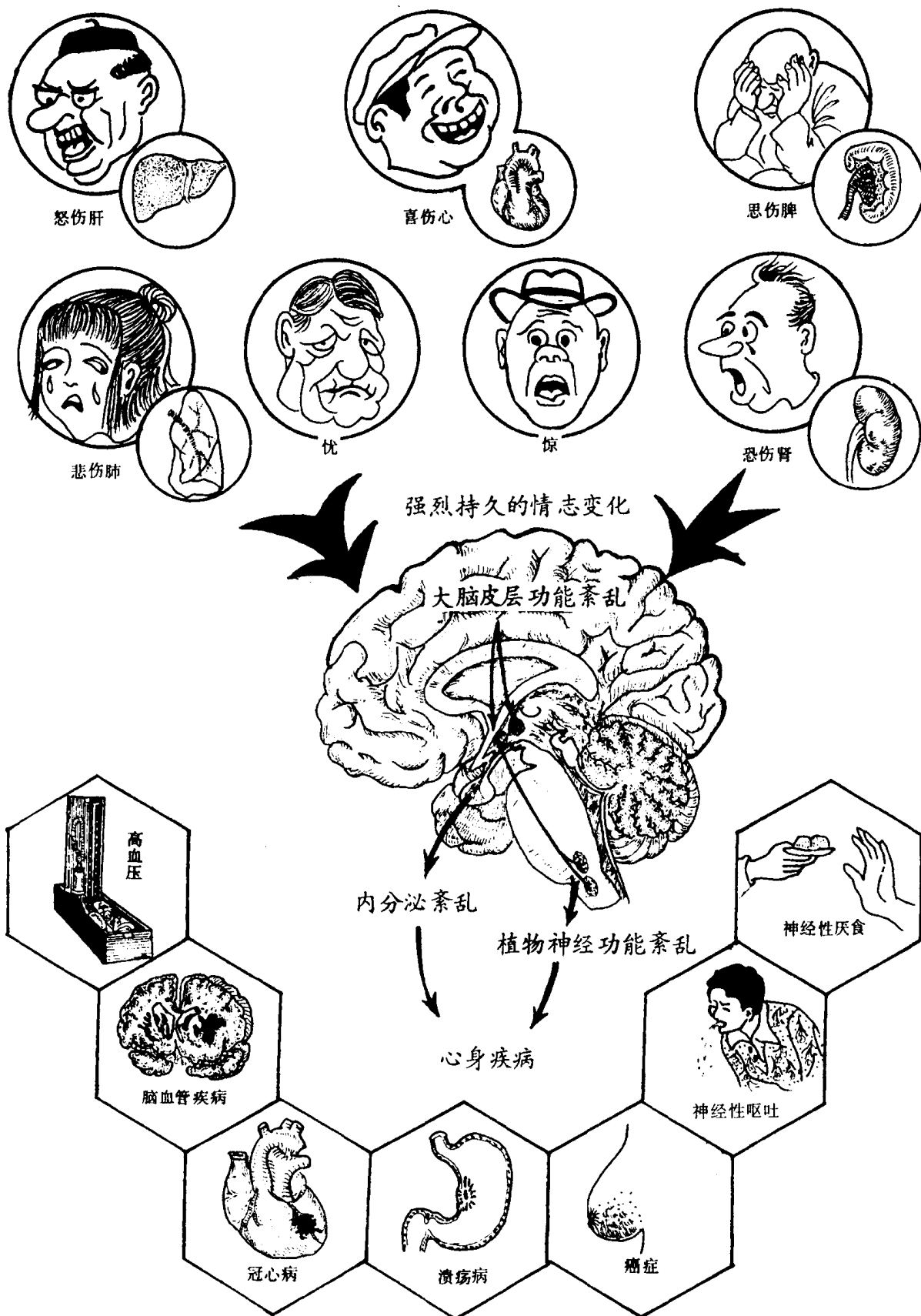
第二节 七 情

〔概述〕

七情,即喜、怒、忧、思、悲、恐、惊的总称,中医称为“情志”,现代医学称为情绪反应。通常是由于生活事件(如家庭、恋爱、婚姻矛盾,亲人死亡或疾病,子女的学业不佳或离家,天灾和政治动荡造成的损害,某种委屈,抱负或才能不能实现和发挥,工作不顺心,人际关系紧张等等)所引起。人们在日常生活中,生活事件总是不可避免。一般来说,情绪上的不愉快,甚至痛苦或愤怒、悲伤、恐惧等感受,持续时间不长,不会影响人体发生疾病。如果这种情绪反应过强或持久,超过人体生理活动所能调节的范围,可引起人体内分泌功能和植物神经功能紊乱,使相应的内脏器官发生器质性病变,现代医学称为心身疾病。这是20世纪才逐步形成和建立的心身医学。但早在2000多年以前,我国古代中医学就对心身概念及心与身的关系有过许多精辟的论述。如“形与神俱”的身心统一学说,认为人的心理现象与生理现象是不可分割的统一体,提出了情绪能致病,在《素问·阴阳应象大论》中总结为“怒伤肝”、“喜伤心”、“思伤脾”、“悲伤肺”、“恐伤肾”。同时强调,情绪也能治病,即“以情胜情”,如“怒伤肝,悲胜怒;喜伤心,恐胜喜;思伤脾,怒胜思”等。这些形神合一、身心统一观,为现代心身医学提供了最早的理论根据。

〔七情与内脏的关系〕

生活事件引起的情绪反应是不同的,例如提升、结婚、搬进新居都会引起愉快的情绪,而受诬陷、灾害性事件则引起忧虑、悲伤、愤怒甚至惊慌、恐惧。值得注意的是,不管是愉快的或不愉快的情绪反应,所引起的应激反应都没有差异。这两种完全相反的感受,产生相同的身体影响,看起来似乎是矛盾的。不过,研究表明确属如此。在现实生活中,不乏这种事例。例如一位家长,骤闻自己子女遭强暴而凶犯在逃消息后,倾刻倒地,不久气绝,尸检结果系脑溢血。这是愤怒夹杂以悲伤的情志带来的悲剧。再如一位中学历史教师,1979年,在事前没有通知的情况下,突然听到大会议宣布摘掉戴在头上23年的“右派分子”帽子,工作调任,提升工资,可以说是数“喜”临门,但就在他散会回家不久,发生脑溢血,在送医院途中不救而死。此可谓“喜伤心”的典型例子。中医学认为情志的异常变化伤及内脏,主要是影响内脏的气机升降失常,气血功能紊乱。这也是现代医学身心疾病发病机制假说的基础,即心理因素→大脑皮质功能变化→植物神经功能变化→内脏功能障碍→内脏形态学改变。植物神经功能改变,如面部苍白或潮红(血液重新分布)、呼吸加快、血压升高,是引起上述病例发生脑血管破裂出血的原因。情绪反应时内分泌变化是全面的。研究表明在情志改变时,肾上腺皮质激素、肾上腺素、去甲肾上腺素、甲状腺素、生长激素、抗利尿激素都是增高的,而胰岛素、雄激素、雌激素水平是下降的。这些内分泌激素的改变也是引起内脏功能活动改变,即中医学所说的气机升降失常、气血功能紊乱的原因。



七 情

第三节 饮食、劳逸

〔概述〕

饮食与劳动是人类赖以生存和保持健康的必要条件。饮食是供给人体营养物质的源泉,是维持人体生长、生育,完成各种生理功能,保证人体正常生命活动的最基本的条件。早在西周时期,人们对饮食与健康二者之间的关系,就已有较为科学的认识。提出:“未饥先食,未饱先止”、“饮食有节”的经验之谈,告诫人们饮食要定时定量,不过饥过饱,不过冷过热,不暴饮暴食。食物的种类要调和,搭配要合理,不偏嗜等。若饮食失宜则可致人生病。

劳动不仅是人们谋生的手段,也是归属和自我实现的需要,特别是这种高层次的需要,常常使人废寝忘食、忘乎所以。日常生活中,睡眠、工作、学习、劳作要有规律。《黄帝内经》中提出“不妄作劳”的主张,要人们“不欲太劳,不欲太逸。”正常的劳动,有助于气血疏通,增强体质。只有劳不知疲、思不知倦或乐不知足、色不知频、起居无常、过劳、过逸者才能成为致病因素。

〔常见病症〕

(一) 饮食致病:

1. 饮食不洁:“病从口入”是饮食不洁最概括的写照。伤寒、霍乱、病毒性肝炎、痢疾、急性胃肠炎等各种肠道传染病和蛔虫等肠道寄生虫病都是进食不洁食物或饮水引起的。若进食腐败变质食物或误食毒物,可导致食物中毒。临床上会出现腹痛、吐泻、痢下脓血,以及水电解质紊乱、发热,甚至危及生命。

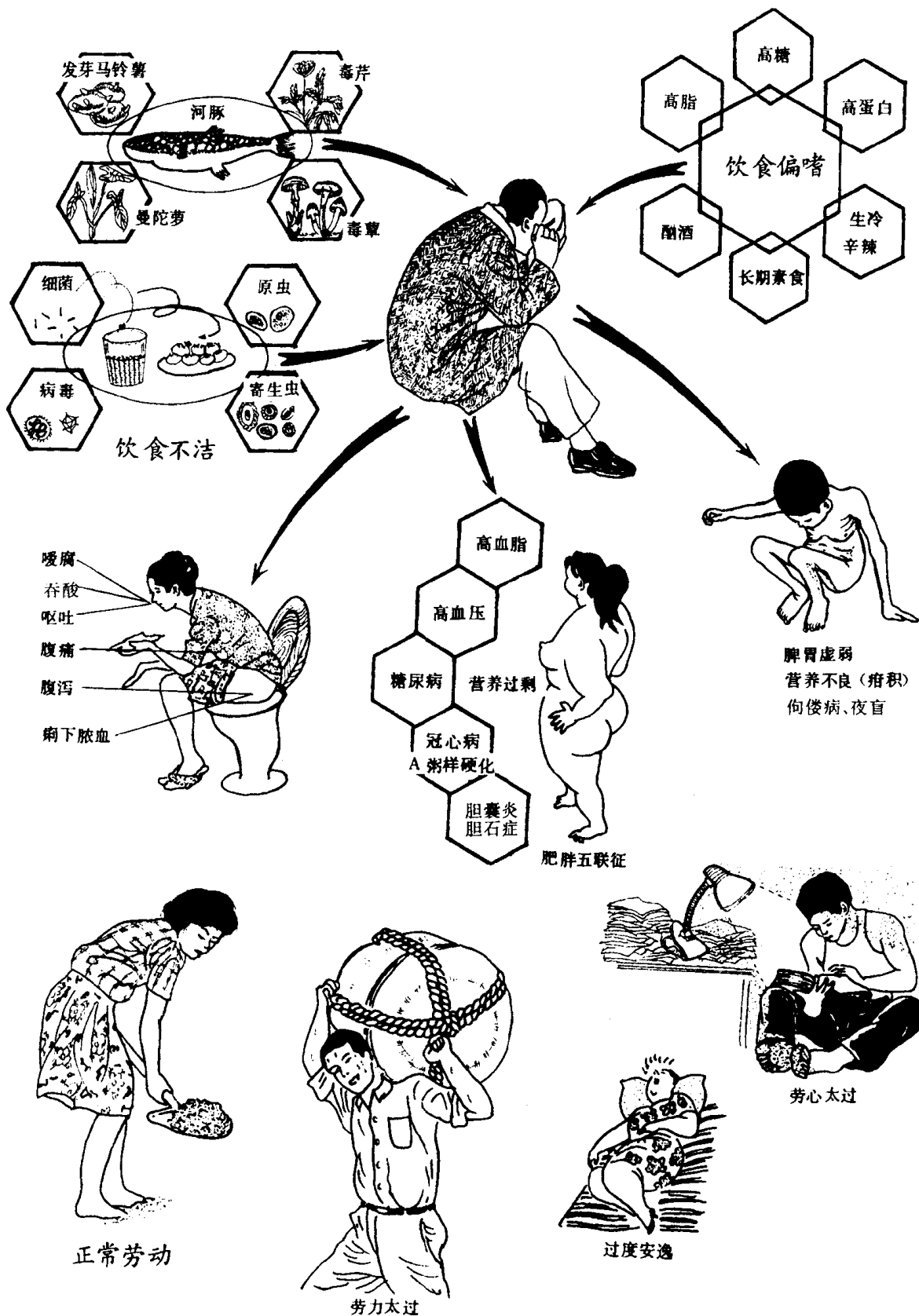
2. 饮食偏嗜:人体需要有充足的营养,以保证生命活动的需要。中医有“五谷为养,五肉为宜,五果为助,五菜为充”的论述,提倡谷物、肉食、蔬菜、水果合理调配。饮食偏嗜,多指:① 过食生冷引起消化功能紊乱,损伤脾阳、寒湿内生、发生腹痛、泄泻等症,属于急性胃肠炎一类。② 嗜酒无度,喜食姜、葱、辛辣、油煎、火烤等刺激性食物,可使肠胃积热、灼伤津液,导致大便干结或酿成痔疮下血等症。③ 过食肥甘厚味,如高脂、高糖、高蛋白类食物常与饮食过量并存,超过脾胃的运化功能,可聚湿、生痰、化热或生痼,常见于出现糖尿病、高血压、脑血管意外等症。

3. 饮食不节:泛指营养不足和营养过剩。当今社会尚有部分人口尚未解决温饱问题,发生营养不良、体弱多病。即使在生活富裕的家庭中,由于喂养知识缺乏,或盲目追求“健美”减肥,以及患有慢性消化道疾病,营养不足仍非罕见,表现为面黄肌瘦,皮肤干燥,多种维生素不足、缺铁性贫血、佝偻病和疳积等。营养过剩引起肥胖,其摄入能量超过消耗能量,使剩余的热能转化为脂肪而积聚体内。此外休息过多、缺乏运动;遗传因素(包括有遗传倾向的疾病);内分泌功能异常和代谢性疾病均可引起肥胖。肥胖者常伴有高脂血症、高血压、糖尿病、动脉粥样硬化和胆囊炎胆石症,泛称肥胖五联症。

(二) 劳逸致病:

1. 过劳:包括体力和脑力过度及性生活不节。① 中医学认为劳力过度则耗气,导致脾失健运,肺气不充,其表现为疲乏无力、食少、气短、面黄肌瘦以及自汗、发热等症。② 思虑过度、劳心太过,常使阴血暗耗、心神失养,可引起心悸、健忘、失眠、多梦等症。③ 性生活不节、纵欲好色、房事过度,耗伤肾气,出现腰膝酸软,神疲乏力、眩晕耳鸣,男子兼见遗精早泄,女子可有月经不调、带下等症。

2. 过度安逸:不参加体力劳动和体育锻炼,会使气血运行不畅,脾胃功能呆滞,机体抵抗力降低。除可致肥胖外,常有食少、乏力、好静恶动、精神不振等表现。



饮食、劳逸

第四节 疫 疔

〔概述〕

“疫”，瘟疫的简称，指急性、流行性传染病。“疔”有极为毒烈之意，疫疔就是现代医学的传染病。

中医文献早在 2700 年前，已有疫疔的记载，又有“瘟疫”、“疔气”、“戾气”、“异气”、“毒气”、“乖戾之气”等称。疫疔致病具有起病急骤、病情重笃、传染性强的特点。如《素问遗篇·刺法论》说：“五疫之至，皆相染易，不问大小，症状相似”。《诸病源候论》说：“人感乖戾之气而生病，则病气转相染易，乃至灭门”。说明我国古代对疫疔的传染性、严重性、危害性的认识和观察是深刻的。公元 196~204 年间，东汉著名医学家张仲景总结了多种急性传染病的症候变化和治疗经验，写成了《伤寒杂病论》，后被整理成《伤寒论》及《金匱要略》两书，至今仍为研究传染病的重要文献。晋代葛洪所著《肘后方》说：“伤寒、时行、瘟疫，三名同一种耳”。隋代巢元方（公元 7 世纪初）的《诸病源候论》说：“时行病者是春时应暖而反寒，夏时应热而反冷，秋时应凉而反热，冬时应寒而反温，非其时而有其气，是以一岁之中，病无长少率相似者，此则时行之气也。”指出疫疔的发生与流行，与自然界气候的反常有关。续有明代吴有性著《瘟疫论》，是我国传染病的专著，清代吴鞠通的《瘟病条辩》、王士雄的《温热经纬和霍乱论》、罗芝园的《鼠疫约编》等有关传染病的记载不胜枚举。

中医学对传染病的辨证施治，是以卫气营血作为温病的辨证纲要。温病的范围包括了大部分急性传染病，即散在发生为温热，发病急剧、呈大的流行为瘟疫。

中医学对传染病的预防思想，远在 2000 多年以前已经奠定。《内经素问》提出：“圣人不治已病治未病”，提出“避其毒气”，“虚邪贼风，避之有时”。唐代已认识传染病隔离的重要性，已设立“厉人坊”隔离麻风病人。宋朝发明了种人痘预防天花，于 17 世纪已传到欧洲，比英国人琴纳发明牛痘苗预防天花早 200 多年。

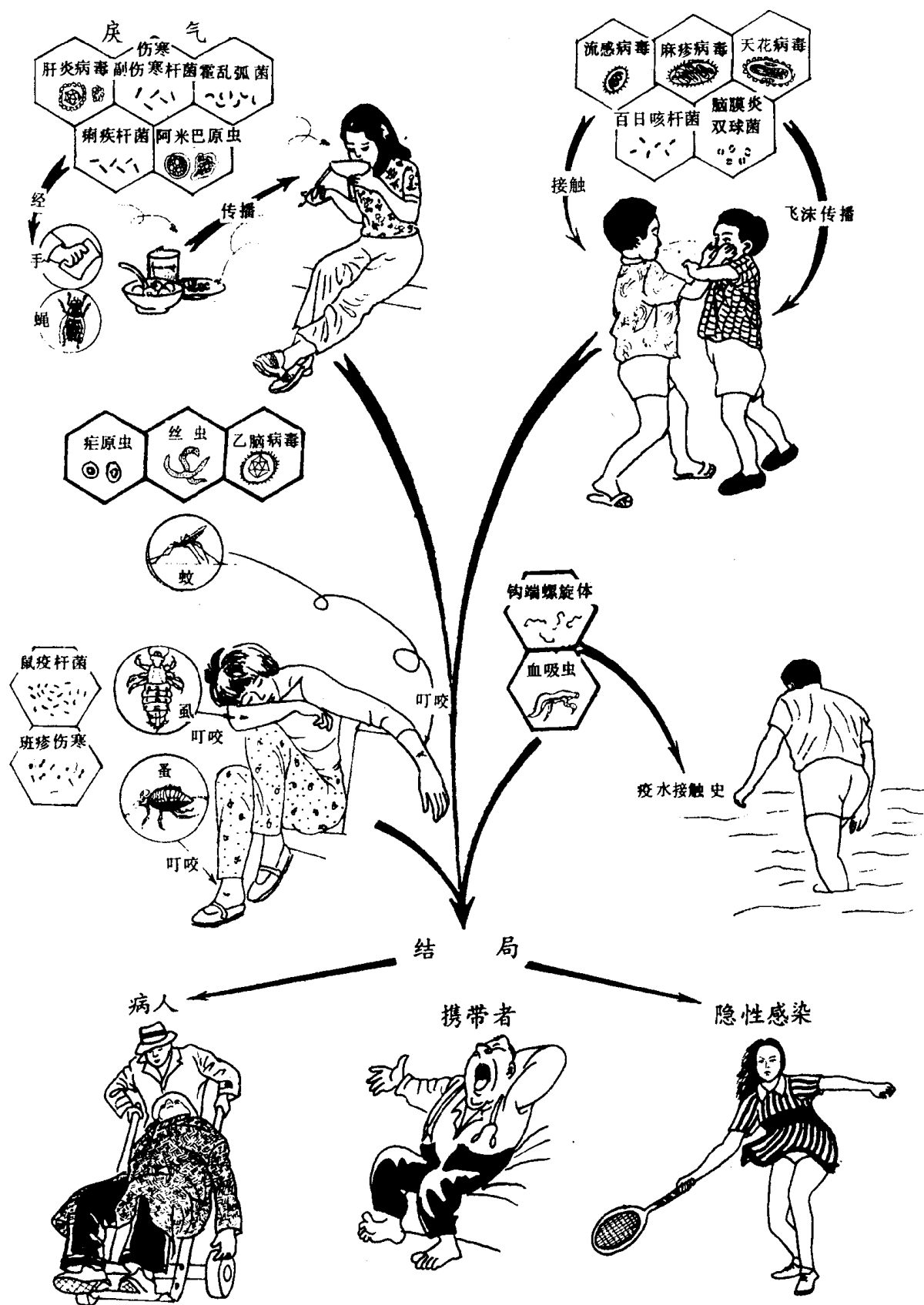
总之中医学有关传染病方面的丰富理论和经验，对传染病的诊断、治疗、预防以及世界医学的发展都作出过卓绝的贡献。

〔中西医结合〕

中西医结合是中国医疗卫生事业的一个独创。40 多年来，中西医在传染病领域内对流行性乙型脑炎、流行性出血热、病毒性肝炎、脊髓灰白质炎、麻疹、肺炎等诸多疾病的治疗采用取长补短，发挥中医药的特点和优势，运用现代医学先进的科学方法，进行了不少科学性强、方法严密的临床观察和实践研究，取得了临床疗效。

传染病领域内的中西医结合，具有广阔的前景：① 在临床研究上，辨病与辨证相结合，在辨病基础上进行辨证，辨证标准有待统一化，规范化。② 在理论研究上，重点在于基础与临床相结合，进行“证”的实质性研究，找出中西医理论上的结合点。③ 加强中药研究，医药结合，对取得确切疗效的方剂与药物进行机理研究和有效成分的提取。

疫 疔 (传染病)



第五节 外伤和虫兽所伤

〔概述〕

致伤物作用于人体,引起组织破坏和功能障碍,称为外伤。按其性质可分:① 机械性损伤;② 物理性损伤;③ 化学性损伤;④ 生物性损伤。中医学将生物性损伤单列为虫兽所伤,其理论与实践与西医雷同。

〔常见病证〕

(一) 机械性损伤 致伤物来自于外界环境,多见于斗殴、战伤、生产与交通事故和自然灾害,其发病率、致残率、死亡率均较高。

1. 致伤物的性质可分为:① 锐器与钝器的打击;② 爆炸和实物的冲击;③ 人体从高处坠下;④ 强力的牵拉和挤压。由于机械力性质、强度、作用部位和范围不同可引起挫伤、切伤、穿刺伤、撕裂伤、扭伤、骨折、脱臼等。

2. 按损伤处皮肤与粘膜是否完整分为:① 闭合性损伤:受伤处的皮肤粘膜仍保持完整,但出现深层组织或脏器严重损害。常见病症有挫伤:钝力作用所致,伤处有青紫、瘀斑、肿痛。若发生脏器损伤,可有咳血、呕血、血尿、昏迷、休克(如肝、脾破裂)。扭伤:关节韧带、肌腱和关节囊损伤,引起关节过度屈伸、旋转和移位,局部皮肤青紫肿胀,活动受限。挤压伤:多见房室倒塌、地震、车祸等重物长时间对人体挤压,引起广泛肌肉组织损伤,出现肌红蛋白尿、高血钾及急性肾功衰。② 开放性损伤:外伤处皮肤、粘膜破坏,常有外出血和继发感染,常见的病症有:擦伤、切伤、裂伤、刺伤和撕脱伤。常因出血多而致面色苍白、头晕眼花或脉细微等虚脱、休克征象。

(二) 物理性损伤 致伤物来自烧伤和冻伤。

1. 烧伤:由于火焰、热气、热水、灼热的固体等热力所引起的损伤,不仅限于皮肤,还可深及肌肉、骨骼,范围广泛者常导致休克、感染而危及生命。中医学对烧伤的分度(同于西医),分第一度红斑,第二度水疱,第三度腐痂。重者火毒内损脏腑,早期出现烦躁作呕、脉细数或脉伏欲绝、四肢厥凉、尿少、尿闭,即西医的休克期。后期可以火毒内攻,发生高热、神昏、谵语、腹胀、烦渴、尿短而赤,齿舌干剥甚至出现衄血等症,即临床出现继发感染和急性肾功衰。

2. 冻伤:指手、足、耳垂、鼻尖长期暴露于低温和潮湿情况下,引起组织的冻结,出现受冻部位瘀斑、肿胀、麻木、痒痛、水疱、坏疽等。

(三) 生物性损伤 中医学主要指虫兽所伤。

1. 毒蛇咬伤:我国有 40 余种毒蛇,分布地域广泛,常见的毒蛇有蝮蛇、竹叶青、银环蛇、五步蛇、眼镜蛇、蝰蛇等。分泌两种主要的毒素:① 神经毒素:轻者引起声音嘶哑、言语不清、流涎继而头昏、眼花、视物模糊、复视;重者呼吸、循环停止而死亡。② 血液毒素:轻者咬处红肿热痛,并迅速向肢体或躯干上端蔓延,不久皮肤出现紫斑、水泡、血泡并破溃;重者高热、烦躁、黄疸、尿少、全身出血;最后休克、心衰、肝昏迷、急性肾功衰死亡。

2. 疯犬咬伤:可患狂犬病,咬伤初期无特殊症状,只有伤痕或有腐烂疼痛或痕迹消失后发病(10 天至一年以上),发病后主要表现为兴奋狂躁、恐水怕风、咽肌痉挛及进行性瘫痪。病情进展迅速,多于 3~6 日内死于循环和呼吸衰竭,病死率几乎 100%。

3. 蜈蚣咬伤:咬伤处微肿剧痛,可有浑身麻木感。

4. 蜂螫伤:工蜂腹部末端有一根螫针,跟毒腺相通。毒腺能够分泌毒液。螫伤后该处疼痛难忍、红肿;重者可有昏厥、荨麻疹,也有致死的报道。

5. 蝎螫伤:蝎螫伤后局部红肿剧痛,可有头昏、头痛、恶心、呕吐、荨麻疹等症状。



外伤与虫兽所伤

第六节 痰 饮

痰和饮是脏腑功能失调的两种病理产物,但同时又能成为病因直接或间接地作用于某些脏腑,引起各种疾病。原因产生结果,结果在一定条件下又转化成原因。由于这种因果相互联系,相互作用,纵横交错,不少疑难怪症的辨证常与痰有关。痰和饮都是水液代谢局部障碍所引起的病理产物,从形态上分为有形和无形两类:① 有形的痰饮是指视之可见、触之可及、听之有声的痰或饮。根据浓度将浊稠的叫痰,清稀的叫饮,合称“痰饮”。② 所谓无形的痰饮是指某些特殊症状,如头晕目眩、恶心、呕吐、气短、心悸、精神错乱、神志失常、猝然昏倒、不省人事等中医均认为系痰饮所引起的。这类病证如按痰饮治疗,常可奏效。

〔痰饮的形成〕

痰饮是由人体的津液凝聚而形成的,是由于肺、脾、肾三脏的气化功能失常或三焦水道失于通调,影响了津液的正常敷布和排泄,以致水湿停聚而形成。如① 肺受外邪,肃降失常,水液不能通调输布,便可停聚而成痰饮。② 脾脏受病,或脾气本虚,使脾失健运,津液不能正常输布,水湿停聚而形成痰饮。③ 肾主蒸化水液,肾阳不足,则蒸化无力,水不得气化,停聚而成痰饮。④ 三焦为水、气运行的通道,若三焦失于通调,则水停气聚,气水互结,形成痰饮,痰饮在三焦的各个部位停留,外可至皮肉筋骨,内可达五脏六腑,无所不至,加之上述因果关系,从而形成各种痰饮病变。

〔痰饮病的范围与证候特点〕

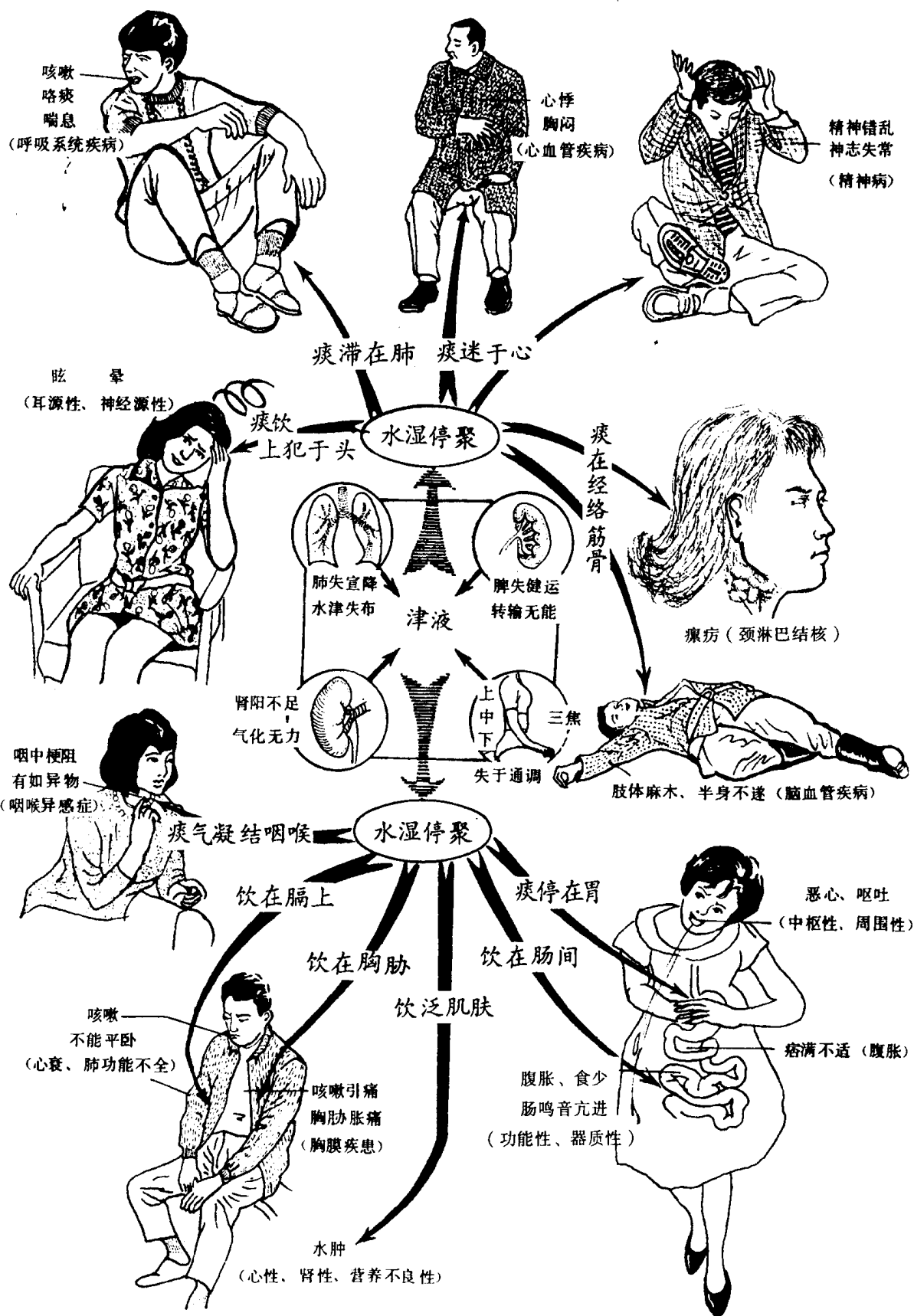
痰饮所致的临床病症很多,尤其是“痰”相当广泛,它不仅指呼吸道咳出的有形之痰,也包括某些特殊症状的疾病在内,故有“百病多由痰作祟”的说法。痰饮根据停滞的部位不同,常有不同的见证:如① 痰滞在肺,可见咳嗽、咯痰、喘息(证见呼吸、循环系疾病)。② 痰迷于心,可见心悸、胸闷(心血管疾病)、精神错乱、神志失常(精神病)。③ 痰在经络筋骨,可致瘰疬痰核(颈淋巴结、皮样囊肿、腱鞘囊肿)及肢体麻木或半身不遂(脑血管意外)。④ 痰饮上犯于头,引起眩晕(耳源性眩晕或神经源性眩晕)。⑤ 痰停在胃,可见恶心呕吐。⑥ 痰气凝结咽喉,可致咽中梗阻,如有异物(咽喉异感症-神经官能症表现)。⑦ 饮在膈上,常见咳喘、不能平卧(心衰、肺功能不全)。⑧ 饮在胸胁,可见咳嗽引痛、胸胁胀痛(胸膜疾患)。⑨ 饮泛肌肤,则出现水肿(包括心性、肾性、营养不良性水肿等)。⑩ 饮在肠间,出现腹胀、纳差、肠鸣音亢进、便溏(肠道功能性或器质性病变)。

〔常见的痰饮病证〕

常见的痰证:① 风痰:证见于脑血管意外及癫痫大发作。② 热痰:证见呼吸道与肺部细菌性感染。③ 寒痰:证见慢性支气管炎、肺郁血。④ 痰核瘰疬:证见颈淋巴结、腱鞘囊肿等。⑤ 梅核气:证见神经官能症。

常见的饮证:① 悬饮:证见渗出性胸膜炎。② 溢饮:证见右心衰、肾性、营养不良性水肿。③ 支饮:证见肺郁血及呼吸道疾患、肺功能不全。

痰 饮



第七节 瘀 血

全身血液运行不畅或局部血液停滞于经脉内、瘀积于器官内,或溢出经脉外而积存于组织间隙,都称为瘀血。瘀血形成后,可以阻塞经脉,或在经脉之外压迫经脉又影响气血的运行,导致脏腑失去濡养出现功能失调,引起许多疾病。因此瘀血也是一种重要的致病因素。

〔瘀血的形成〕

瘀血的形成可见于以下原因:① 因外伤出血,血液流出脉管积存于体腔或组织间隙。如血疝(外伤性阴囊血肿)、皮下瘀斑。② 因气滞血停而成。“气为血之帅”,气行则血行,气滞则血滞,诸如阴气虚损,鼓动无力,血的运行因之迟滞(如二尖瓣膜疾患和高血压时引起左心衰,则导致肺瘀血。肺原性心脏病引起右心衰时,可导致体循环瘀血)。③ 有因寒在血脉,血凝成瘀,寒入于经,经脉蜷缩而拘急(如休克性肺炎微血管收缩期)。④ 有因热盛迫血妄行,血液离开脉道,积而成瘀(如流行性脑脊髓膜炎、败血症等,有高热、皮肤、粘膜瘀点、瘀斑)。⑤ 有因热极伤阴、伤血、血热互结成瘀(如白血病、再障、恶网时高热、血细胞异常,同时有多处出血)。⑥ 肝气郁结、疏泄不利(重症肝炎、肝硬化时肝脏合成凝血酶原、纤维蛋白原等凝血因子减少),出现鼻衄、龈血、皮下瘀斑。

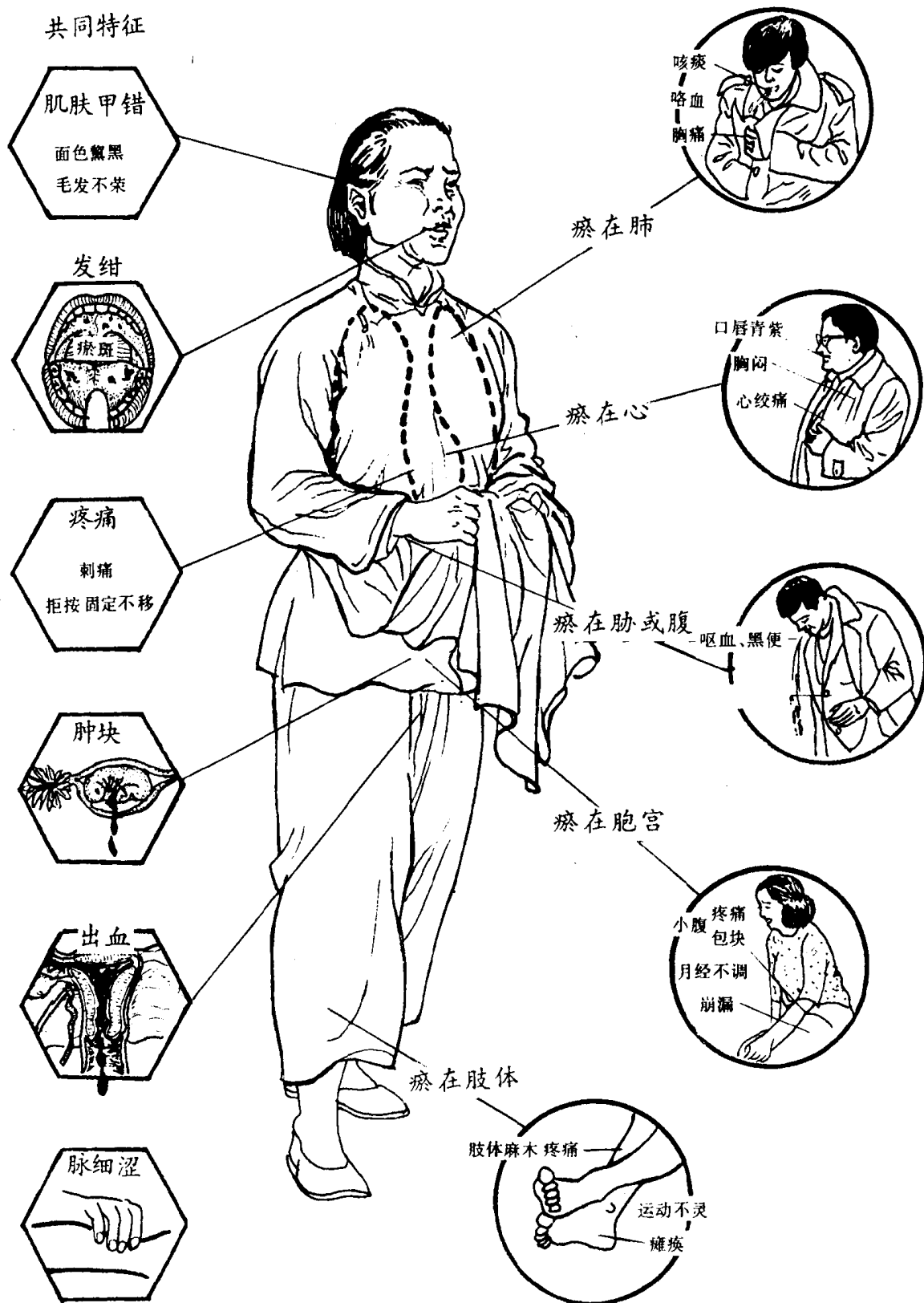
〔瘀血的常见病证〕

瘀血的病症,根据其所瘀阻的部位不同而产生不同的症状。如① 瘀阻于肺,可见咳痰、咯血、胸痛,证见大叶性肺炎、肺脓肿、支气管扩张继发感染、肺结核、肺癌、肺梗塞等。② 瘀阻于心,可见口唇青紫、胸闷、心痛,证见冠心病心绞痛、心肌梗塞。③ 瘀阻于肝,可见胁痛、痞块,证见门脉性肝硬化、坏死后性肝硬化、血吸虫病性肝硬化、原发性胆汁性肝硬化、肝癌等。④ 瘀阻于肠胃,可见呕血、便血,证见胃、十二指肠溃疡,胃癌,胆道出血,肝硬化食道,胃底静脉曲张破裂,腹型过敏性紫癜等。⑤ 瘀阻于胞宫,可见小腹疼痛、月经不调、痛经、闭经、经色紫黑有块,或见崩漏,证见功能失调性子宫出血、闭经、痛经、子宫肌瘤、子宫颈癌、子宫体癌、子宫内膜异位症等。⑥ 瘀阻于肢体局部,可见肢体麻木、疼痛,或运动不灵、瘫痪等,证见中枢及周围神经系统的炎症、肿瘤、出血、栓塞及血栓闭塞性脉管炎、雷诺氏病等。

〔瘀血病证的共同特点〕

瘀血病证繁多,但临床表现有以下的共同特点:① 由于瘀阻,肌肤经脉失于濡养,可见患者肌肤甲错、面色黧黑、毛发不荣、脉搏细涩或结代等。② 由于瘀阻经脉,血行障碍(血中氧合血红蛋白下降,还原血红蛋白浓度增高),故见紫绀,如唇甲青紫、舌色紫暗。血液漏出管壁则见紫斑瘀点。③ 瘀血阻塞经脉,气血不能通利,不通则痛。瘀血致痛的特点,多呈针刺样或刀割样,疼痛固定不移,痛处拒按。④ 肿块可见于腹部及四肢等处,推之不移,按之痛甚,证见外伤血肿、某些病因所致的肝脾肿大、阑尾脓肿、宫外孕破裂形成的肿块以及肠扭转、肠套叠等。⑤ 出血,瘀血阻塞脉道,血流受阻,以致血溢脉外的各种瘀血性出血,如咯血、呕血、血尿、黑便、鼻衄、龈血、月经过多、产后恶露不尽。⑥ 脉细涩或结代。

瘀 血



第七章 八纲辨证

第一节 表证与里证

八纲是中医辨证的八个基本纲领。《医学心悟》说“病有总要，寒、热、虚、实、表、里、阴、阳八字而已”。运用阴阳、表里、寒热、虚实八纲对四诊收集起来的病史、症状、体征等资料加以归纳、分析、综合，才能作出正确的诊断。这个过程叫辨证。表里辨别病位的深浅；寒热辨别病证的性质；虚实辨别邪正的盛衰；阴阳则为统摄其他六纲的总纲。表、热、实属阳，里、寒、虚属阴。八纲辨证是各种辨证的基础，下面把八纲分成四组，对比地加以介绍。

〔表证〕

表证，是病位浅在皮肤、肌肉、经络的一类症候，一般是指六淫之邪从皮毛、口鼻侵入人体而引起外感病的初起阶段，具有起病急、病程短的特点。其证候表现：以发热、恶寒、舌苔薄白、脉浮为主，常兼见鼻塞、咳嗽、头痛、四肢酸痛，其中，发热、恶寒、脉浮是表证的特征，可见于多种热性病，如上呼吸道感染及流感、麻疹、流脑等疾病的早期。表证中有表热、表寒之分。

（一）表热 外感热邪。

1. 主要证候：发热、恶寒、热重寒轻、无汗或有汗不畅、口微渴、咽痛、喉痒、咳嗽、气促、舌尖红、苔薄白薄黄、脉浮数。

2. 治疗参考：辛凉解表。药物如菊花、薄荷、桑叶、葛根、牛蒡、连翘、桔梗等。

（二）表寒 外感寒邪。

1. 主要证候：发热、恶寒、寒重热轻、头痛无汗或少汗、骨节酸楚、舌苔白、脉浮缓或浮紧。

2. 治疗参考：辛温解表。药物如麻黄、桂枝、荆芥、防风、杏仁等。

〔里证〕

里证，是指病邪由表入里累及脏腑。此时表证已解，已无恶寒症状而出现高热或潮热、神昏、烦躁、口渴、腹胀或痛、大便泄泻或秘结、小便短赤或不利、舌苔黄、脉沉数等。另一方面，各种内伤病都是里证。如肝病的眩晕、胁痛；心病的心悸、怔忡；脾病的腹胀、腹泻。里证的临床症状多种多样，不仅有寒、热、虚、实之分，而且因不同脏腑而异。里证一般不恶风，不恶寒，一般为沉脉，舌质多有改变，舌苔多黄或黑，可见于热性病中后期和内脏疾病如溃疡病、慢性肝炎、慢性肠炎等。

（一）里热 内热炽盛。

1. 主要证候：面红身热、口渴渴、喜冷饮、烦躁多言、便秘溲赤、舌质红苔黄、脉洪数或弦数有力等。

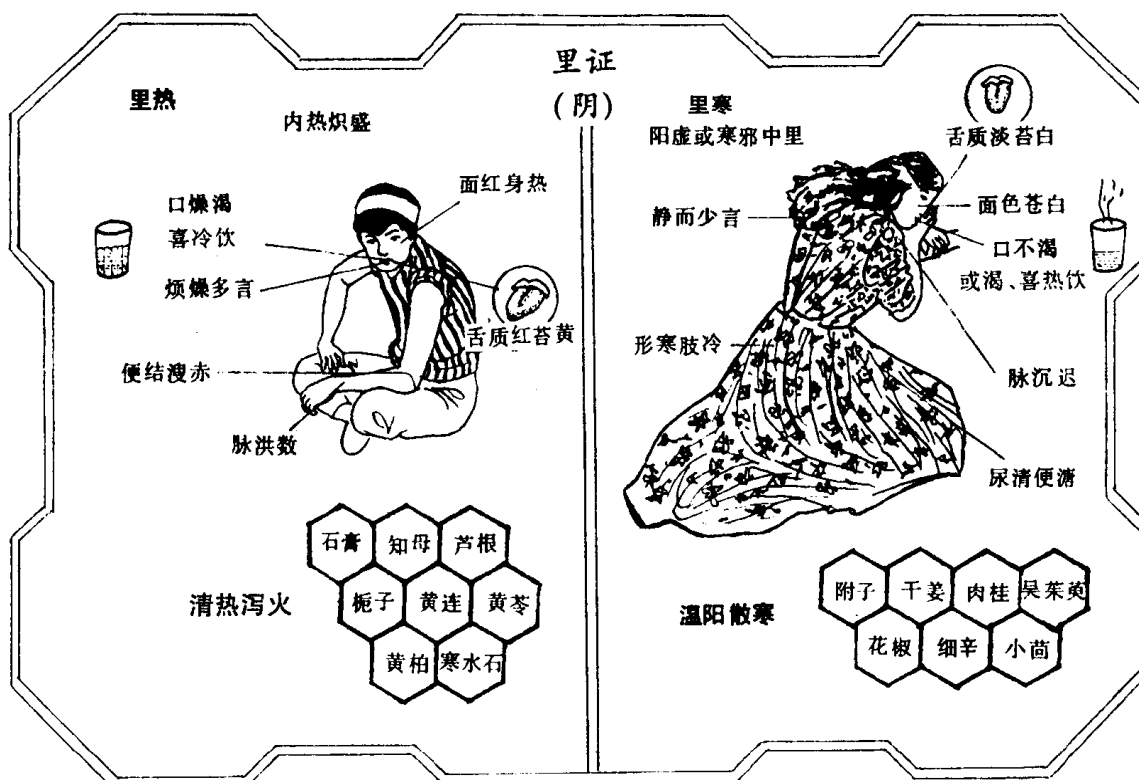
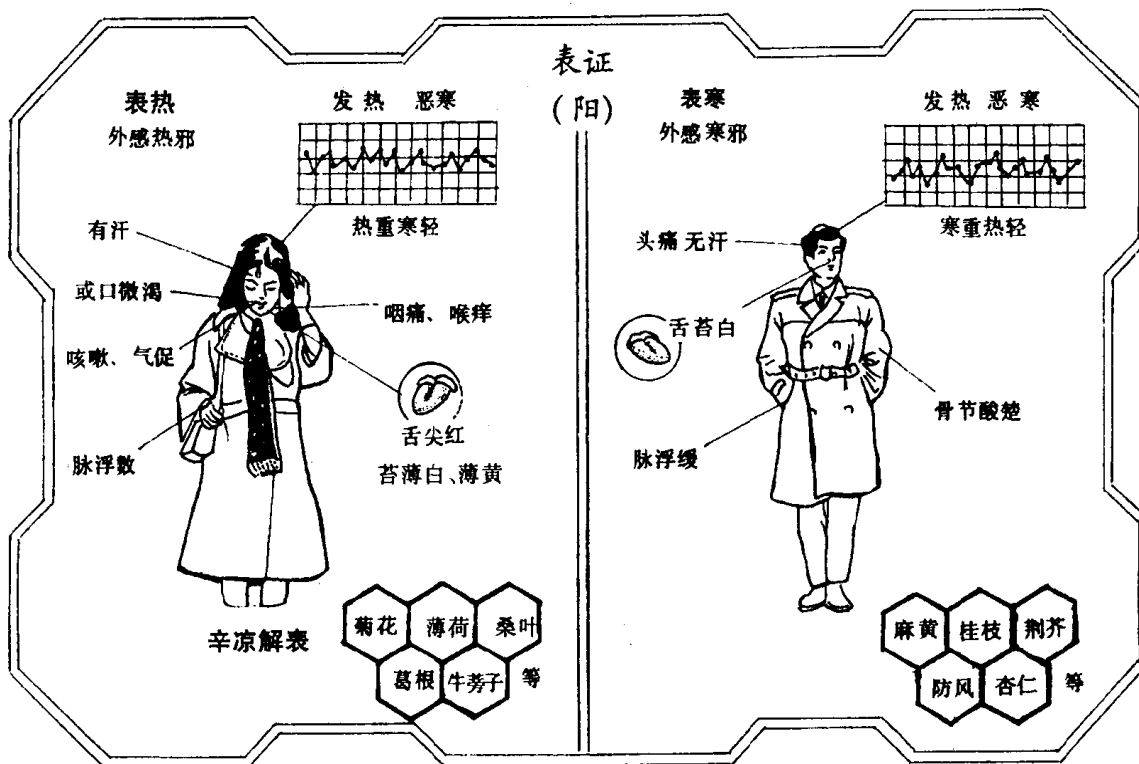
2. 治疗参考：清热泻火。药物如石膏、知母、芦根、栀子、黄连、黄芩、黄柏、寒水石等。

（二）里寒 阳虚或寒邪中里。

1. 主要证候：面色苍白、口不渴或渴、喜热饮、静而少言、形寒肢冷、尿清便溏、舌质淡苔白、脉沉迟等。

2. 治疗参考：温阳散寒，药物如附子、干姜、肉桂、吴茱萸、花椒、细辛、小茴等。

八纲辨证 (一)



第二节 寒证与热证

寒、热是指疾病的性质。《素问·阴阳应象大论》说“阳盛则热，阴盛则寒”，辨明寒热，实际上就是辨别阴阳的盛衰，凡由寒邪引起或因阳气不足所产生的机能减退，阴气偏胜的症状，是为寒证；凡由热邪引起，或因其他病理变化所产生的机能亢奋，阳气过盛的症状，是为热证。辨明寒证、热证，是临床确定用温热药或寒凉药的重要依据。

〔寒证〕

寒证，是外感阴寒之邪，或内伤久病（如慢性支气管炎、慢性腹泻、慢性肾炎等脾、肺、肾功能减退）引起阳气耗伤，阴邪内盛所表现的证候。

1. 主要证候：恶寒喜暖，不发热，口淡不渴，腹痛喜热按，面色苍白，肢冷蜷卧，大便溏泻、小便清长，舌淡苔白而润滑，脉沉迟无力。

2. 治疗参考：温以祛寒，用温性、热性药物，如附子、干姜、肉桂、吴茱萸、葫芦巴等。

〔热证〕

热证，多由外感火热之邪（如急性扁桃腺炎、肺炎、急性肺脓疡或外科感染），或因七情过激，郁而化火，或饮食不节，积蓄为热（如急性胃肠炎、细菌性或阿米巴性痢疾）所致。

1. 主要证候：高热、烦躁谵语、多汗、口渴喜冷饮、咳嗽黄痰、喘运气粗、腹痛拒按、小便短赤、灼痛、大便秘结、舌质红、苔黄而干燥、脉数等症状。

2. 治疗参考：清热泻火，一般采用凉性、寒性的药物如石膏、知母、黄芩、银花、大青叶、大黄、黄连、黄柏、板蓝根、山栀、蒲公英、连翘。

〔寒证热证的鉴别〕

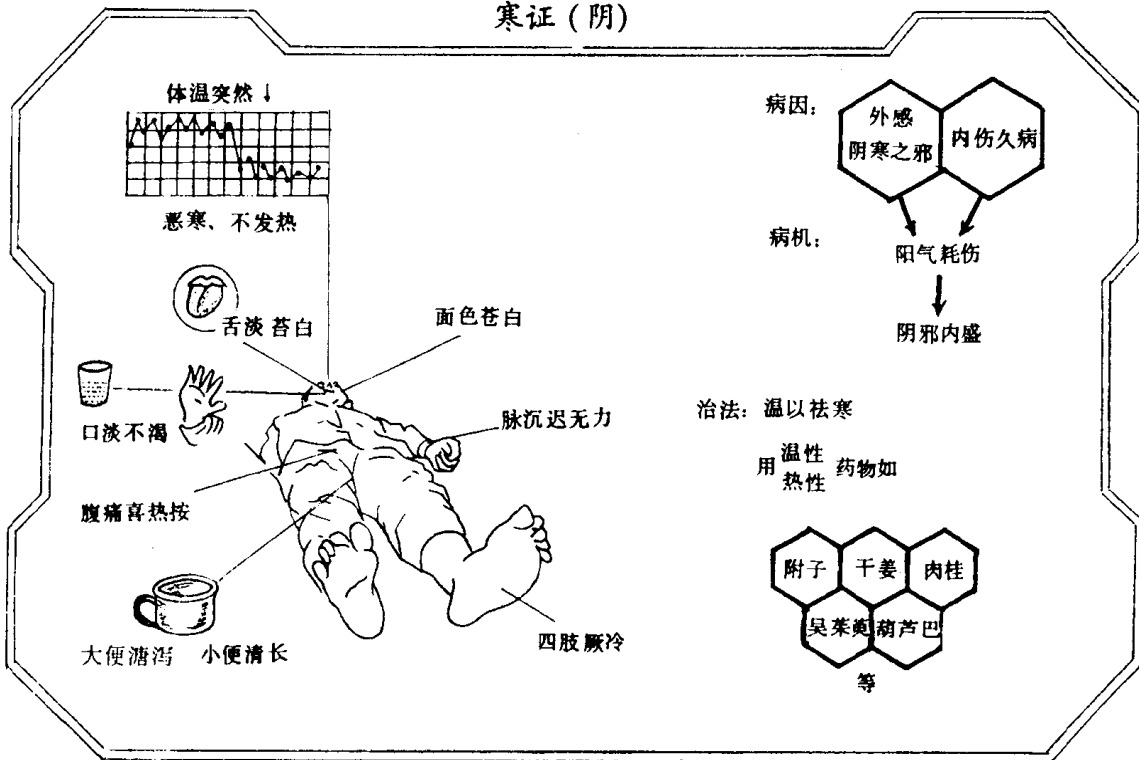
辨别寒证与热证，必须根据具体病情进行全面分析，不能孤立地根据某一症状作判断。主要根据：恶寒与恶热、口渴与不渴、面色的红与白、四肢的冷与热，以及二便、舌苔、脉象作综合判断，才能得出正确的结论。

	恶寒与恶热	口渴与不渴	面 色	四 肢	二 便		舌 苔	脉 象
寒 证	恶寒喜热	口淡不渴	面 白	手足厥冷	小便清长	大便稀溏	舌淡苔白	脉沉迟
热 证	恶热喜寒	口渴喜饮	面 红	手足烦热	小便短赤	大便燥结	舌红苔黄	脉数滑

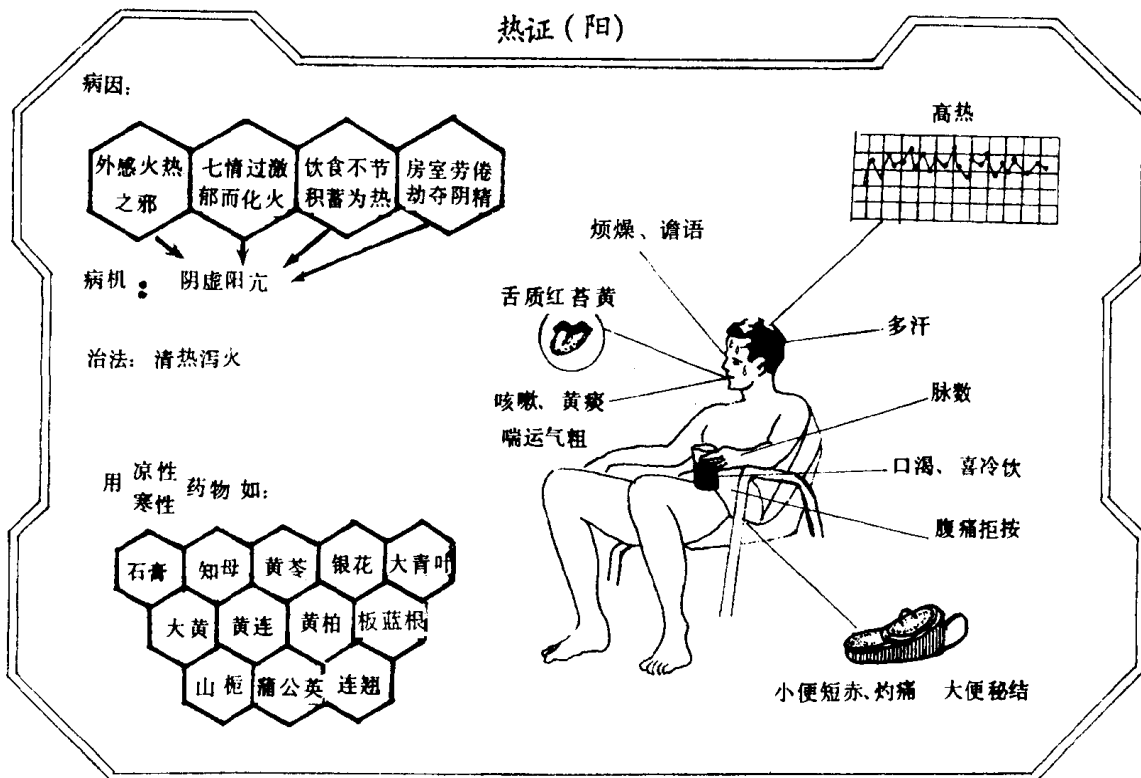
寒证和热证可能反应于人体全身，也可能只反应于局部。如热在上，多见头痛、目赤、咽喉肿痛、口干、喜冷饮。热在下，多见大便秘结、小便灼热、疼痛。寒在上，多见饮食不化、上腹隐痛、口吐清涎。寒在下，多见下肢清冷、大便稀薄、小便清长。局部的寒证和热证可单独出现，也可以参差出现，如上寒下热或上热下寒，这与人体各局部器官对同一致病因素产生不同的反应有关，形成寒热错杂。有时还会出现表寒里热（寒在于表、热在于里）或表热里寒的寒热错杂的表现，或出现一些假象，如热证见寒象或寒证见热象，出现真热假寒或真寒假热的错综复杂证象，需要认真仔细去辨证。

八纲辨证 (二)

寒证 (阴)



热证 (阳)



第三节 虚证与实证

虚、实是指正、邪的盛衰。虚指人体正气(抗病能力)虚;实指邪气(致病因素)盛。“正气”与“邪气”的虚实消长,是互相联系的,如正气充足,就能驱除邪气;邪气过盛,也会消耗正气。所以虚证与实证的互相消长,取决于正气与邪气力量的强弱。辨别虚实,是临床治疗采用扶正或祛邪的依据。

[虚证]

虚证,多发生于重病、久病之后,身体虚弱,正气不足,多表现为生理功能减退的症候:如面色苍白、少气懒言、消瘦乏力、食少自汗、精神不振、动则心悸、舌淡无苔、脉细弱无力等,可见于多种慢性疾病:如慢性支气管炎、肺结核、肺源性心脏病、内脏下垂、肝硬化和各种原因的贫血,以及热性病后期(如伤寒、出血热的恢复期)。虚证又有阴虚(虚热)、阳虚(虚寒)、气虚、血虚及五脏虚之分,其临床表现不一,难于概全,下面介绍气虚与血虚。

(一) 气虚

1. 主要证候:倦怠无力,动辄自汗,面色虚浮,声音低沉,气短,或不思饮食,或食后脘腹胀满,脱肛,舌苔白,脉弱或虚大。
2. 治疗参考:补气,药物如黄芪、党参、白术、甘草。

(二) 血虚

1. 主要证候:面白或萎黄,唇淡,指甲无华,心悸,头晕,四肢发麻,舌淡无苔,脉芤或沉细。
2. 治疗参考:养血,药物如当归、熟地、阿胶、白芍等。

[实证]

实证,多发生于疾病新起,病势较凶。由于病邪过盛,机体功能及代谢亢进以及部分器质性病理改变所出现的病证。其表现为:形体壮实,精神兴奋,声高气粗,胸腹胀满,疼痛拒按,或肿块积聚,大便秘结,舌苔较厚,脉宏有力等。可见于多种热性病(如大叶性肺炎、胸膜炎)和肿瘤、胃扩张、肠扭转、卵巢囊肿、痛经等。实证又分寒热。如肺脓肿、发热、口渴、喘咳胸痛、脓痰壅盛、舌红苔黄厚、脉数有力是里热实证。如肠扭转,有阵发性腹部绞痛、辗转呻吟、呼号转侧、面青肢冷、舌苔白厚、脉沉紧有力,属里寒实证。下面介绍气滞和血瘀。

(一) 气滞

1. 主要证候:声高气粗,胸闷胁痛,痰多气促,脘腹胀满,腹痛便秘,舌苔多黄,脉弦滑有力。
2. 治疗参考:行气导滞,药物如郁金、枳实、半夏、厚朴、橘红、苏子等。

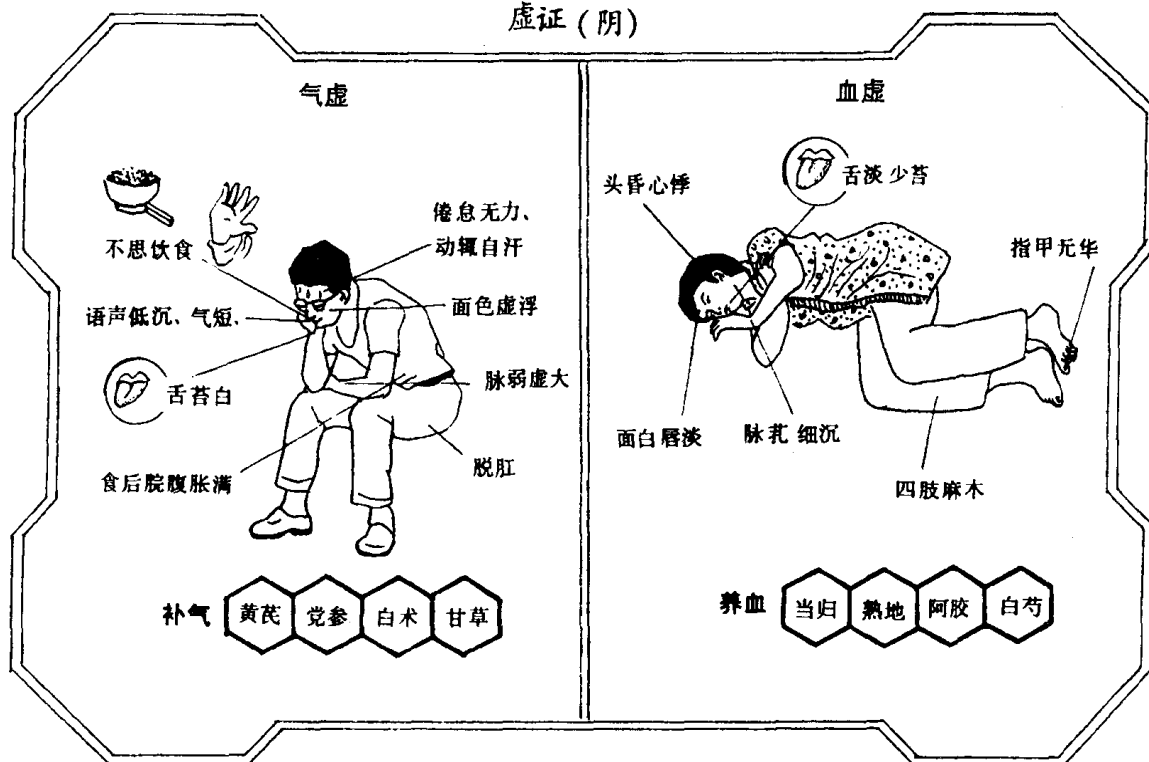
(二) 血瘀

1. 主要证候:外科的痈疡肿痛,跌仆瘀肿及心前区痛,经期、产后腹痛拒按,面唇暗滞,舌色紫暗、脉涩等。
2. 治疗参考:活血祛瘀,药物如桃仁、红花、赤芍、当归、丹参、蒲黄、五灵脂、川芎等。

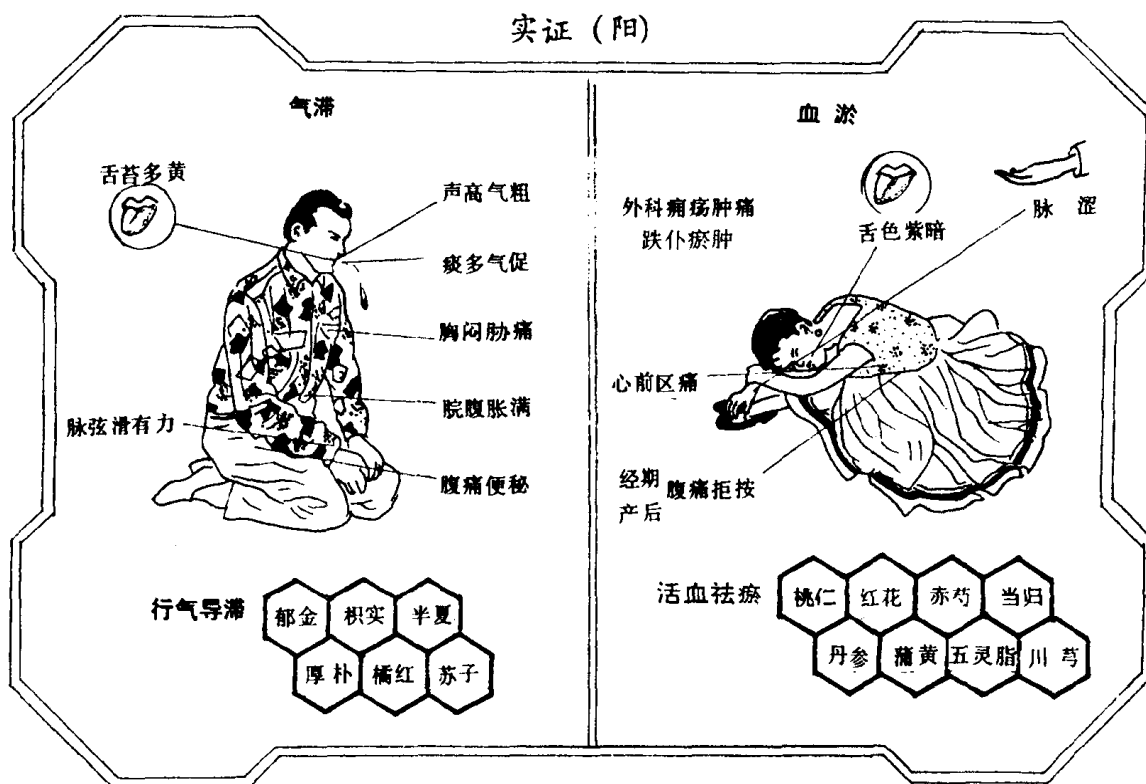
辨别虚证、实证,主要看病人形体的壮弱,精神的好坏,声音气息的强弱,痛处的喜按与拒按,以及舌苔、脉象等方面。

八纲辨证 (三)

虚证 (阴)



实证 (阳)



第四节 阴证与阳证

阴阳是概括病证类别的一对纲领,其运用大可概括整个病情,小可用于分析一个症状。阴阳又是八纲辨证的总纲,它概括了其他六纲,即把里证、寒证、虚证归于阴证,把表证、热证、实证归于阳证。同时也包括人体阴液亏损(阴虚)和阳气不足(阳虚)的证候。临床应用八纲辨证的一般顺序:首先辨别表、里——找出病变部位;然后辨别寒、热、虚、实——分清病变性质和正邪盛衰,最后再分以阴、阳加以总概。

[阴证与阳证]

(一) 阴证 指体内阳气衰虚和寒邪凝滞的病变和征象,即虚、寒证表现。

1. 主要证候:精神萎靡、面色苍白、晦暗、四肢不温、卧喜蜷缩、气短懒言、语声低微、喜静、不渴或喜热饮、腹痛喜按、大便稀溏、小便清长、舌质淡嫩、舌苔润滑、脉象多沉迟细弱,以及外科感染而不红、不肿、不热、不痛或塌陷不起。

2. 治疗参考:由于阴证包括寒证、虚证、里证,在治疗上分别应用散寒、补虚、和里等药物。

(二) 阳证 指体内热邪壅盛,阳气亢盛的病变和征象,即实、热证表现。

1. 主要证候:精神亢奋、面色发红、身热肢温、卧喜伸展、气粗多言、语声洪亮喜动、口渴喜冷饮、腹痛拒按、大便干结、小便短赤、舌质红绛、舌苔黄燥、脉象多洪数有力,以及外科感染,有红、肿、热、痛。

2. 治疗参考:由于阳证包括热证、实证和表证,在治疗上分别应用清热、泻下、解表等药物。

[阴虚与阳虚]

阴虚指阴液亏损。“阴虚生内热”,常说的虚热即指此。阳虚指阳气不足,阳虚则生寒,一般说的虚寒即指此。两者虚证鉴别于下:

类 型	临 床 表 现	舌 象	脉 象
阴 虚	午后潮热、两颧发赤、手足心热、心烦失眠、盗汗、咽干口渴、尿短黄、大便干燥(交感神经功能偏亢表现)	舌红少苔	细 数
阳 虚	形寒肢冷、面色暗淡、神疲乏力、自汗、口不渴、尿清长、大便溏泻(副交感神经功能偏亢表现)	舌淡苔白	弱

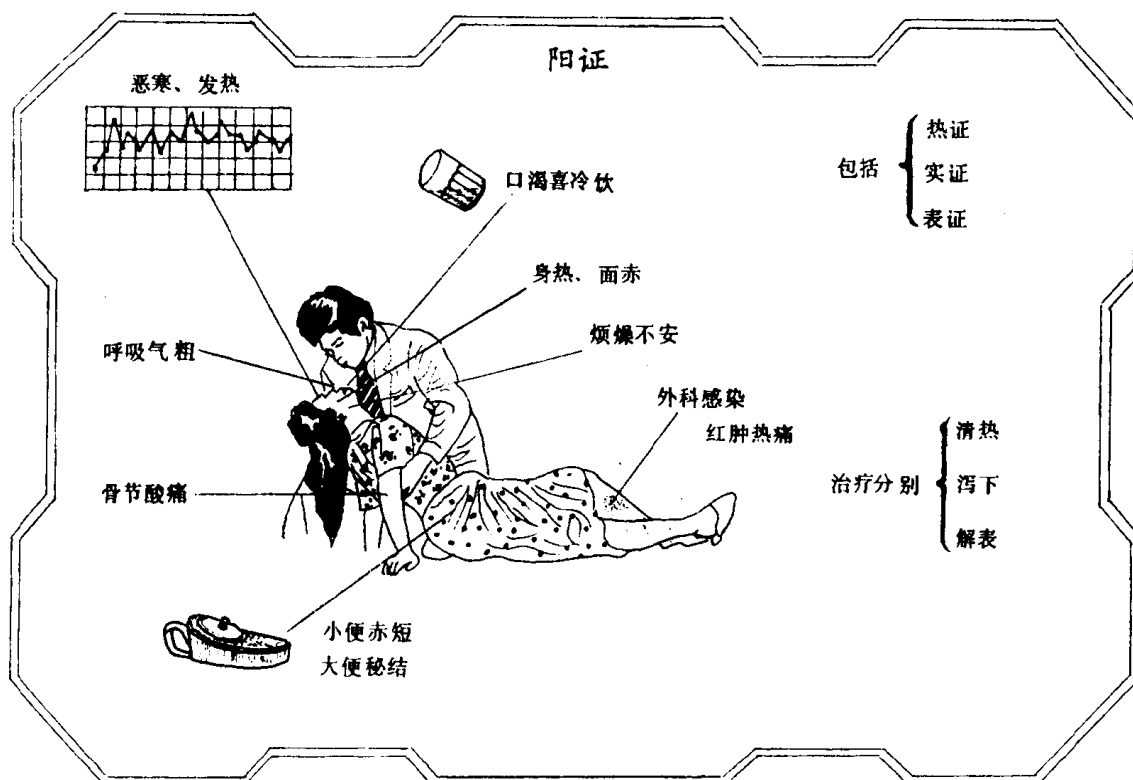
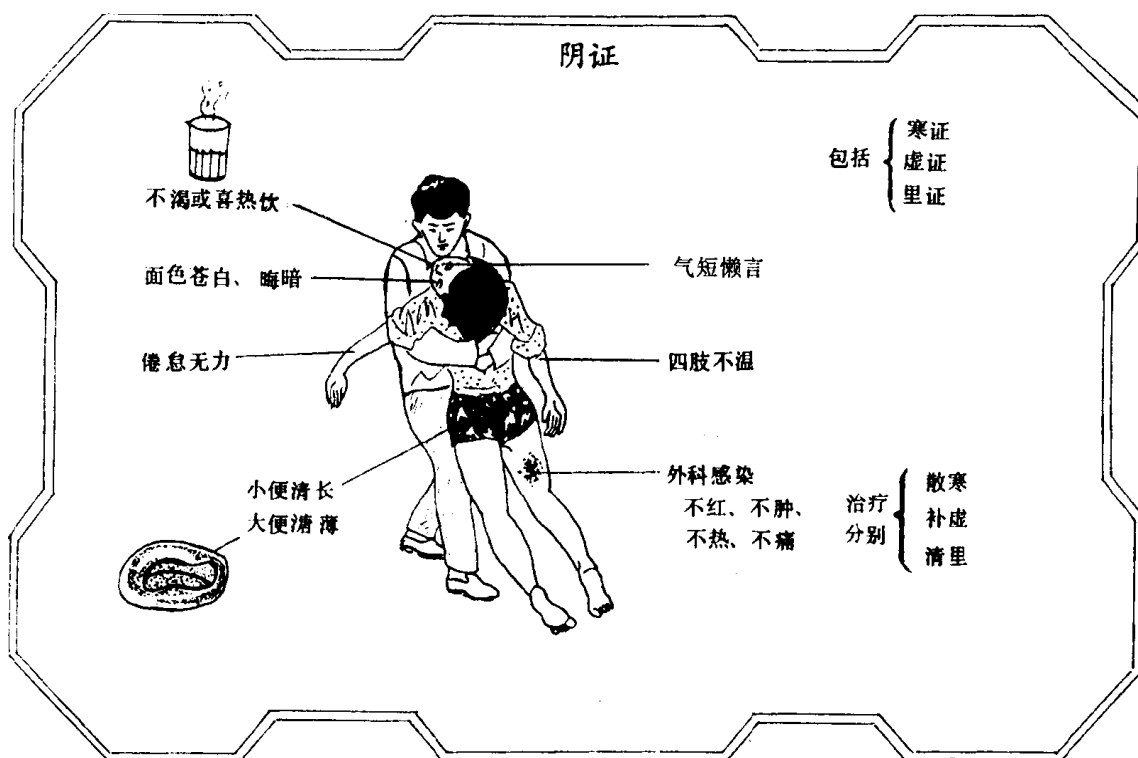
阴虚与阳虚与脏腑是不可分割的。因之,不同脏腑的阴虚、阳虚还反映有一定的证候(详见脏腑辨证)。

[亡阴、亡阳]

亡阴、亡阳证是疾病过程中的危重症候。亡阴是由于体液大量消耗所出现阴津衰竭的病变和证候,即现代医学热休克表现。亡阳指体内阳气严重损耗而表现阳气虚脱的病变和证候,即现代医学的冷休克表现。两者鉴别如下:

类 型	中医症状描述	舌 象	脉 象	西医表现与机理
亡阴 (热休克)	汗出而粘、呼吸短促、身畏热、手足温、烦躁不安、渴喜冷饮或面色潮红	舌红而干	细数无力	皮肤温热潮红、小动脉扩张、毛细血管床灌注良好、心输出量不下降或升高
亡阳 (冷休克)	汗冷如珠、呼吸气微、身畏寒、四肢厥冷、精神萎靡、面色苍白、喜热饮	舌淡而润	脉微欲绝	皮肤发冷苍白、小动脉收缩、腔静脉压下降、心输出量降低。

八纲辨证 (四)



第八章 气血津液辨证

气血津液辨证是中医六大辨证之一,主要通过分析气、血、津液的病理变化,辨证其所反映的不同证候。气血津液是脏腑活动的产物,又是脏腑功能活动的物质基础。因此,脏腑发生病变,可以影响气血津液的变化。相反,气血津液的病变,必然影响到脏腑功能。

第一节 气病的辨证

中医学的“气”,泛指一切无形的物质,如外感六淫及其他致病因子,称为邪气;食物中的营养成分,称为谷气;胃肠道所产生的气称之为气等等,这都不是本节要讨论的内容。这里所称的“气”,主要是指人体生命活动的动力(如元气、真气)和五脏六腑活动功能(宗气、营气、卫气以及肾气、肝气……),气的病变很多,一般可概括为气虚、气陷、气滞、气逆四种。

[气虚证]

气虚证是指全身脏腑功能衰退所表现的证候。常见于年老体弱、慢性疾病以及急性病重症恢复期,中医认为其病机主要是元气不足,引起脏腑机能衰退。现代医学相当于神经-体温调节功能因衰老或致病因素损害而减退。

1. 主要证候:头晕目眩,少气懒言,疲倦乏力,自汗,活动时诸症加剧,舌淡,脉虚无力。
2. 治疗参考:补气,方如四君子汤。

[气陷证]

气陷,常为气虚证的一种,中医认为是气虚机能衰减,举升无力为其主要特征。以内脏下垂如胃下垂、子宫脱垂及脱肛为主要表现。现代医学认为与先天性发育不良如胃壁肌肉、盆腔肌肉薄弱、松弛或韧带过长、腹膜反折过低、骶骨弯曲过直以及腹腔神经或盆腔肌肉损伤所致。

1. 主要证候:头目昏花,少气倦怠,腹部有坠胀感及胃下垂、子宫脱垂、脱肛的表现,舌淡苔白,脉弱。
2. 治疗参考:益气提升,方如补中益气汤。

[气滞证]

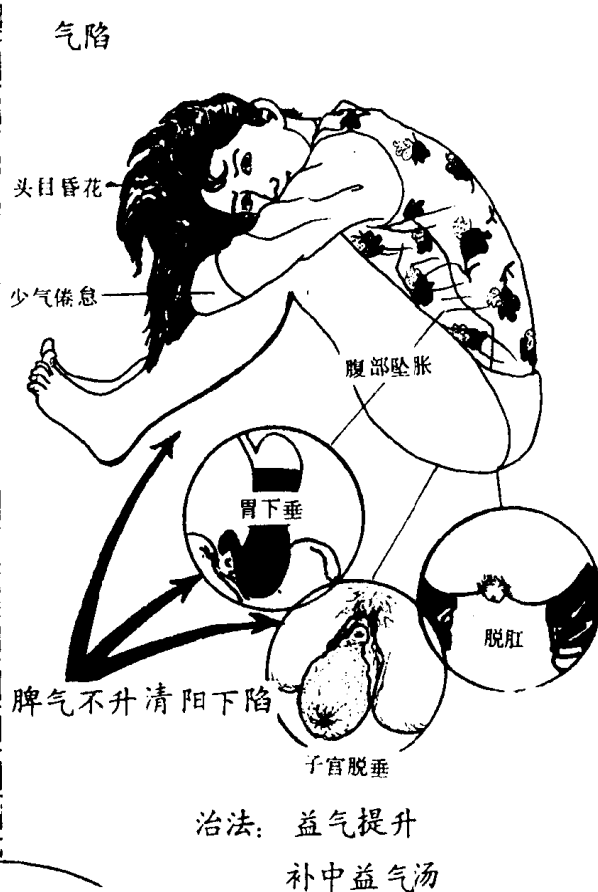
气滞证是指人体某一部分或某一脏腑气机阻滞、运行不畅所表现的证候。中医认为气滞常由精神因素、饮食失调、感受外邪或用力努伤、闪挫等因素引起气机阻滞所引起,阻滞的部位不同,所表现的症状也不同,例如由于精神因素、受凉或饮食不调所引起的肠痉挛等,表现为腹部绞痛,肠鸣音亢进;由于痢疾杆菌、阿米巴原虫等外邪引起的痢疾,也表现为腹痛、肠鸣、里急后重;由于血液和子宫内腺素 F_2 升高引起痛经或腹痛,腹胀均列为气滞。

1. 主要证候:闷胀,疼痛。
2. 治疗参考:行气,方如五磨饮子、金铃子散等。

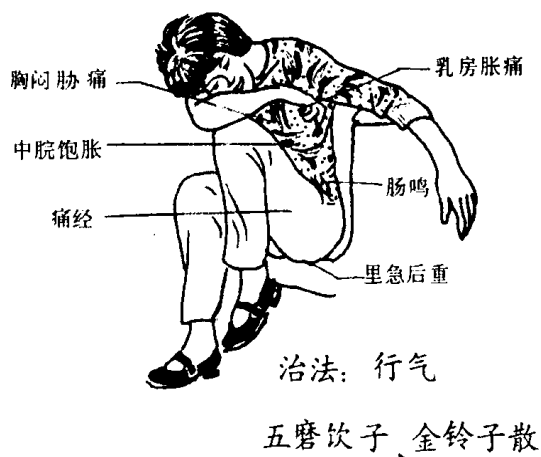
[气逆证]

气逆是指气机升降失常,气上逆不顺。一般多指肺胃之气上逆以及肝气升发太过,气火上逆引起。多由感受外邪,或痰浊壅滞(指支气管、肺部感染)使肺气不得宣降;或胃寒积饮,积食阻滞气机(如幽门梗阻)或外邪犯胃,胃气失其和降(如胃肠炎),郁怒伤肝(精神因素)引起气火上逆。

1. 主要证候:肺气上逆出现咳嗽,喘息。胃气上逆出现呃逆,嗝气、恶心、呕吐。肝升发太过,出现头痛、眩晕、昏厥、呕血。
2. 治疗参考:降气、镇逆,方如苏子降气汤,旋复代赭汤。



气病的辨证



第二节 血病的辨证

血的病证很常见,临床上主要有血虚、血热、血瘀三方面。

[血虚证]

血虚是指体内血分亏损,不能濡养脏腑、经脉而出现的证候。中医学对血虚亏损的病因归纳为三条:① 失血过多。② 脾胃虚弱:生化不足。③ 暗耗阴血:血虚,现代医学称为贫血,其病因分类与中医不谋而合,也分为三类:a. 失血性贫血:临床见于各种原因的急性、慢性失血,如外伤、肺结核咯血、溃疡病呕血、肝硬化食道、胃底静脉曲张破裂出血、宫外孕、月经过多及痔出血等。b. 造血不良性贫血:可由于造血原料不足如缺铁性贫血、巨幼红细胞性贫血(当然与“脾胃虚弱”有关)和骨髓造血功能损害(即生化不足)所致。c. 溶血性贫血:由于红细胞内在缺陷或红细胞外在溶血因素,使红细胞寿命缩短,即所谓的“暗耗阴血”造成贫血。

1. 主要证候:面色苍白或萎黄、唇色淡白、头晕眼花、心慌气促、手足麻木、妇女经行量少、衍期甚至经闭,舌质淡,脉细无力。

2. 治疗参考:补血,方如四物汤。

[血热证]

血热指血分有热,或热邪侵犯血分的证候。中医学认为血热证的病因有二:① 外感热邪:血热炽盛,扰乱心神引起心烦,甚则躁扰发狂,或血受热迫,血络易伤,出现各种出血证。所谓外感热邪泛指生物性病原体侵入机体,可引起感染性精神病,常见的如流感、败血症、急性风湿热、肺炎、伤寒、脑炎等出现精神症状:病人表现不同程度的发热,意识模糊,躁动不安,出现呓语、错觉、幻觉以及相应的情绪与行为紊乱。症状白日较轻(或白日近似常人),夜间较重。另外,感染性疾病如流脑、出血热、钩端螺旋体病、麻疹、鼠疫等重症患者,由于败血症、病毒血症损伤血管壁引起通透性、脆性增加,以及弥漫性血管内凝血等病理改变,可出现皮肤、粘膜瘀斑、咯血、呕血、衄血、鼻衄、血尿、便血,以及月经过多等出血症状。② 肝郁化火:临床可见于各种原因肝病,如血吸虫性肝硬化、肝炎后肝硬化、重症肝炎、肝癌、中毒性肝炎,长期胆道梗阻有严重肝功能受损时,同样会出现出血倾向和精神症状。出血的原因是由于肝功能减退影响凝血酶原、纤维蛋白原及其他凝血因子合成。常见齿龈出血、鼻衄、紫癜和胃肠道出血。精神症状出现的原因比较复杂,有血氨升高、代谢障碍及假性神经介质形成等因素引起大脑功能紊乱,在昏迷前期可出现性格改变,如反常的欣快、抑郁、智力减退、白天嗜睡夜间兴奋、无原因吵闹、无理的语言重复,以及错觉、幻觉逐渐发展为昏睡、昏迷。

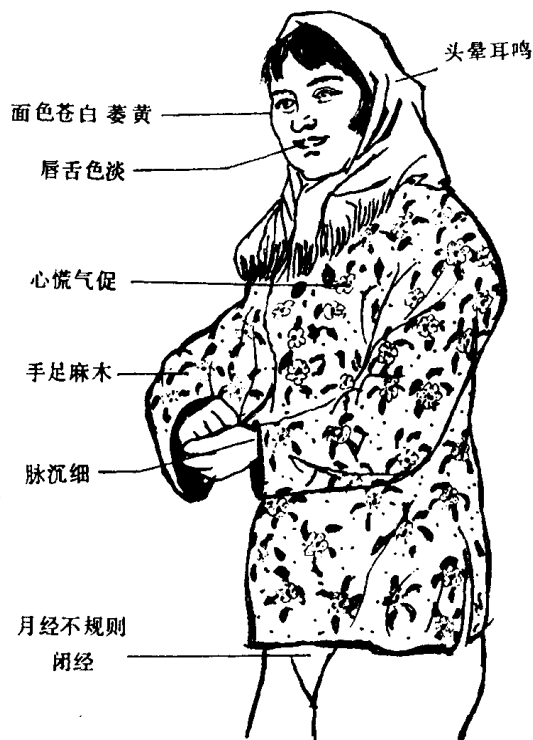
1. 主要证候:心烦,或躁扰发狂,口干不喜饮,身热,以夜间为甚,脉细数,舌红绛或见各种出血证,妇女月经前期量多等。

2. 治疗参考:清热凉血,方如清营汤,犀角地黄汤。

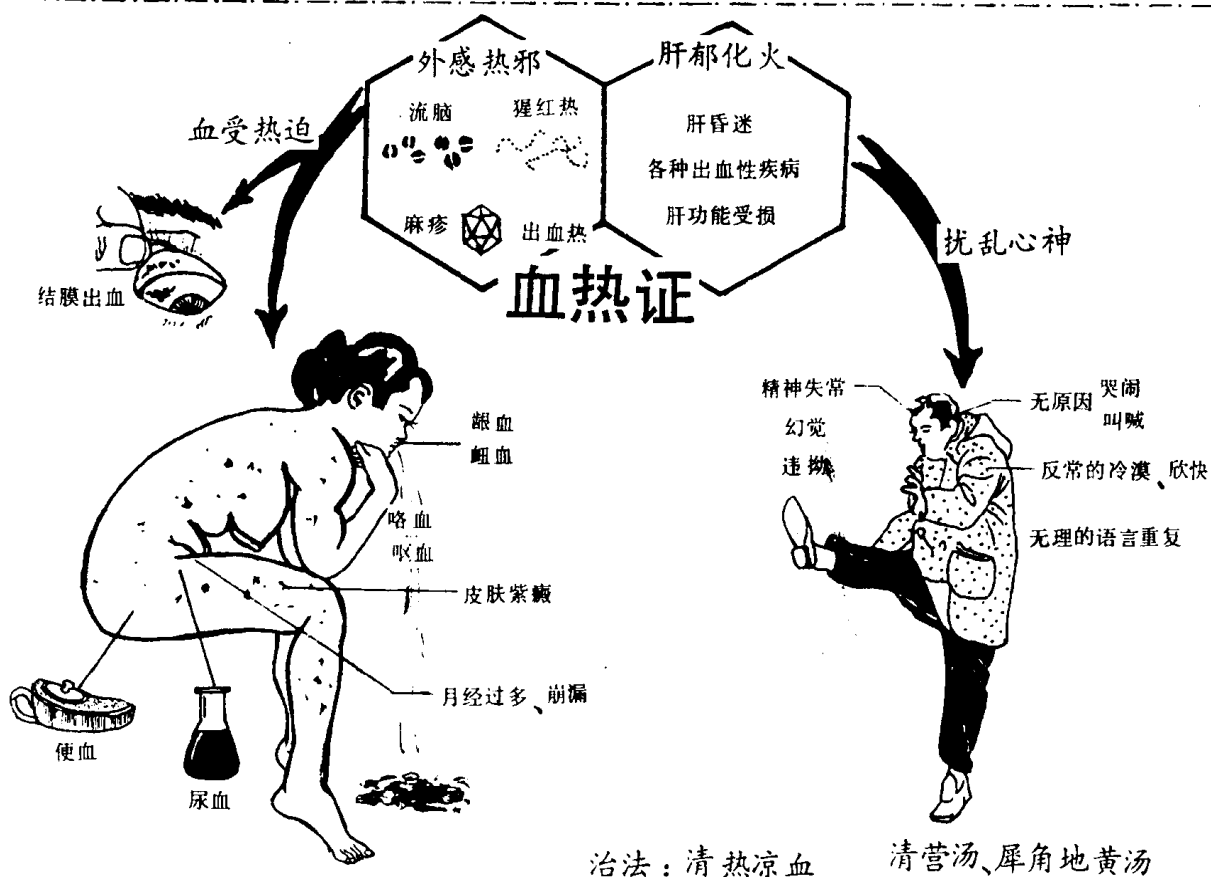
[血瘀证]

血瘀病证,已于病因辨证“瘀血”节讲述,这里不重复。

血虚证



治法：补血
四物汤



治法：清热凉血
清营汤、犀角地黄汤

第三节 气血同病的辨证

气为阳,血为阴,气与血有阴阳相随、互相依存的关系,血来源于水谷之气,心血的运行有赖于心气的推动,肺气的敷布,肝气的疏泄,“气行则血行”。气滞、气虚常引起血瘀。气之所以行血,是血能载气,“血为气母”。气血的关系概言之统一的整体。因之,气血变化的相互影响在临床上常见的。

[气滞血瘀证]

气滞血瘀证,是指由于气滞不行以致血运障碍,又出现血瘀证候者,即气滞证、血瘀证并存,既有胸、肋、腹部胀满疼痛,外伤者有局部肌肉关节疼痛的气滞证候,又有气滞血停血瘀证候。血瘀的部位不同,其证候各有不同(详见病因辨证“瘀血”节),但共同特征不变。如刺痛拒按,固定不移,出现肿块,出血,舌质紫暗有瘀点,以及皮肤紫绀或皮肉肿胀、青紫。中医学认为气滞血瘀证的原因有二:① 闪挫外伤。② 情志不遂引起肝失疏泄。

1. 主要证候:胸、肋胀满且疼痛,性情急躁,并兼见痞块刺痛拒按,舌紫暗或有瘀斑等。妇女还可见痛经、闭经、崩漏或月经不调及乳房胀痛等症状。

2. 治疗参考:行气活血,方如逍遥散加桃仁、红花、苏木、三棱等。

[气虚失血证]

气虚失血证是指气虚不能统摄血液而见失血的证候。血随气行,气虚下陷,使血从下溢出,如妇女崩漏,则称之为血随气陷。气虚,常指五脏之气不足,以肺脾之气不足为多见。

1. 主要证候:有咯血、吐血、妇女月经过多或经来不止等出血表现,同时又有气短、倦怠乏力、头昏自汗、语低懒言、面色苍白、舌淡、脉软弱细微等气虚症状。

2. 治疗参考:补气、引血归经,方如归脾汤。

[气血两虚证]

气血两虚证,是指气虚与血虚同时存在的证候,其原因有三:① 久病不愈,气血两伤所致,可见于慢性疾患如慢性肝炎、再生障碍性贫血等。② 先有失血,气随血耗。③ 先因气虚不能生化,而继见血少。

1. 主要证候:乏力自汗,面色苍白或萎黄,气少懒言,心悸失眠,舌淡而嫩,脉细弱等。

2. 治疗参考:气血两补,方如八珍汤或当归补血汤。

[气随血脱证]

气随血脱证是由于大量出血引起气随之暴脱的证候,即现代医学的出血性休克。临床见于:① 外伤,如开放性颅脑损伤、外伤性肝脾破裂及开放性骨折等。② 大咯血、呕血:如溃疡病大出血、食道胃底静脉曲张破裂出血及重症肺结核大咯血。③ 宫外孕。上述急性失血超过全身血容量 20%即可出现气随血脱证。

1. 主要证候:面色苍白或青灰,冷汗淋漓,四肢厥冷,血压下降,可有晕厥、脉微细或芤等证候。

2. 治疗参考:益气固脱,方如独参汤、参附汤。

气滞血瘀证

气滞不行

↓
血运障碍

↓
血瘀



治法:

行气活血

逍遥散加桃仁、红花、苏木、三棱

气虚失血证

气虚 → 不能统、摄血 → 失血



治法: 补气、引血归经

归脾汤

气血同病的辨证

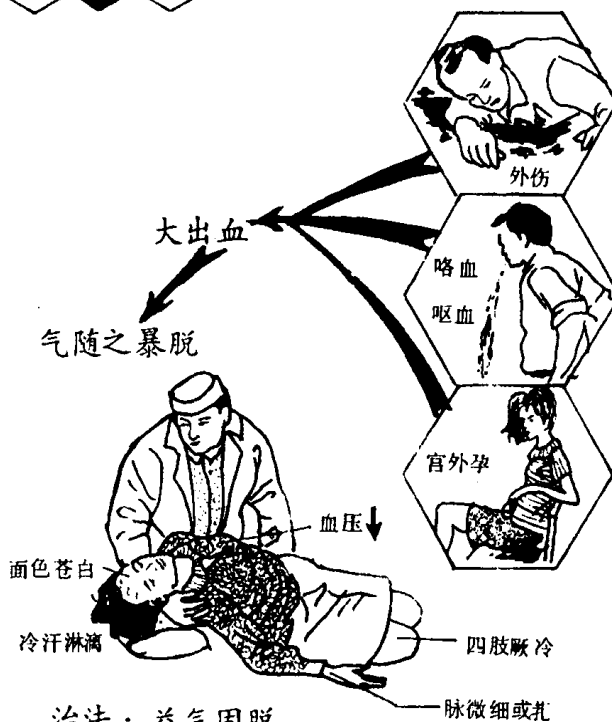
气血两虚证



治法: 气血两补

八珍汤、当归补血汤

气随血脱证



治法: 益气固脱

独参汤、参附汤

第四节 津液病辨证

一、津液不足、常见痰证

津液的病理变化很多,可分为津液不足与水液内停两个方面。

[津液不足]

津液不足,又称津亏、津伤,多由于以下因素造成:① 大汗:人体每日非显性出汗约 300~600ml,在寒冷季节也不例外。出汗湿透衬衣裤,失水约 1000ml;大汗淋漓,每小时失水可达 3000ml。炎热环境下,大量出汗每日可达 14 000ml。② 剧烈呕吐、腹泻。③ 大量出血。④ 多尿。⑤ 热度过高伤耗津液。

1. 主要证候:口渴咽干、唇焦舌燥、皮肤干燥、失弹性、便秘、尿少色深、脉细数。

2. 治疗参考:增补津液。方如增液汤。

[水液内停]

体内的津液有一定的代谢过程,它像血液一样,运行不息,滋养全身。如果脏腑机能失调,影响津液的代谢,津液停滞,聚集于人体某部,成为人体无用的物质,称为痰与饮。下面分别介绍临床常见的痰证。

(一) 风痰 有动风的症状,又有痰证的表现称为风痰。

1. 主要证候:头晕目眩、突然昏倒、喉有痰鸣、口眼喎斜、舌强不语、四肢麻木、偏瘫等,一般称为中风,见于西医的脑溢血、脑血栓形成。还有突然跌倒、昏迷、抽搐、口吐涎沫的癫痫大发作也属风痰病变。

2. 治疗参考:祛风豁痰,方如大秦芫汤。

(二) 热痰 热与痰互结。

1. 主要证候:咽喉疼痛,口吐黄痰,心中烦热,便秘,脉数,舌苔黄腻。见于西医的急性支气管炎、肺炎、肺脓肿,或发癫狂(见于西医的精神病),中医认为是“痰”引起的。

2. 治疗参考:泻热豁痰,方用清气化痰丸、礞石滚痰丸。

(三) 寒痰 指寒痰互相凝结或痰盛而又有寒象的证候。

1. 主要证候:畏寒厥冷、咳吐稀白痰,或骨关节浮肿、刺痛、四肢不举、脉沉迟、苔白润等。证见慢性支气管炎、支气管哮喘。

2. 治疗参考:温化痰涎,方用三子养亲汤或二陈汤加干姜、细辛、五味子。

(四) 湿痰 聚湿成痰。痰盛又兼湿象的证候,也称痰湿。

1. 主要证候:胸脘痞闷,痰多易咯,色白而粘,或眩晕、纳差、恶心、呕吐、身倦嗜卧、舌苔厚腻脉濡滑。证见美尼尔氏综合征、慢性胃肠功能紊乱。

2. 治疗参考:燥湿化痰,方如二陈汤。

(五) 燥痰 痰证而兼有燥象者。

1. 主要证候:口鼻干燥、咽喉干痛、咯粘稠痰、难于咯出或痰中带血丝、便秘、舌干少津、脉细滑数。证见秋季感冒、急性支气管炎、肺炎及麻疹、百日咳。

2. 治疗参考:润燥化痰,方如清燥救肺汤、百合固金汤。

综上所述,中医“痰”的概念,除肺部咳嗽咯出的有形的痰之外,还包括其他脏腑的若干证候。所以中医有“百病多属痰、怪疾多属痰”之说。

津液病的辨证(一)



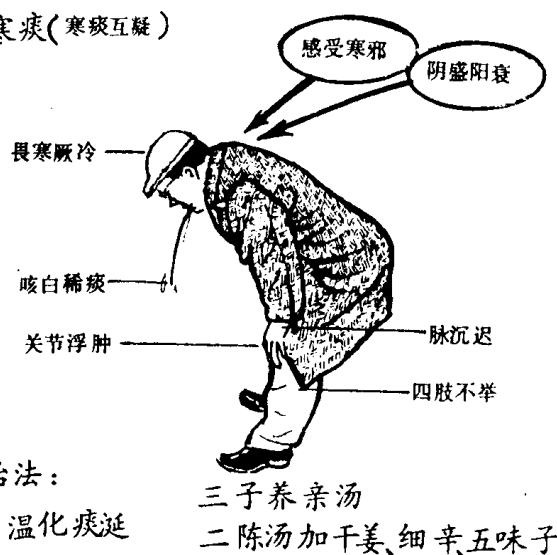
风痰(痰盛而动风)



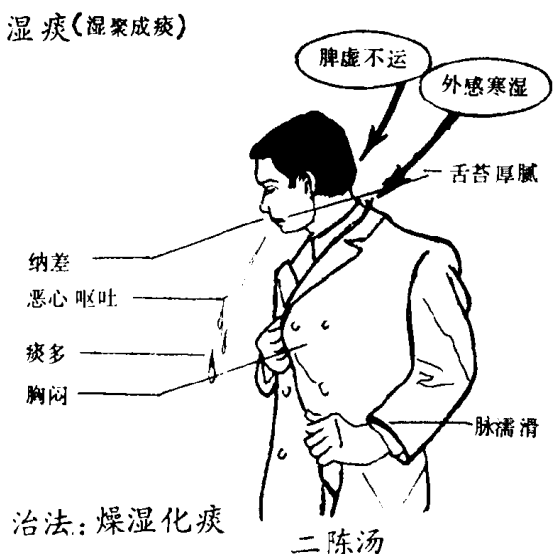
热痰(痰热互结)



寒痰(寒痰互凝)



湿痰(湿聚成痰)



燥痰(痰证兼燥象)



二、常见饮证

饮的性质与水相近,所以又叫水饮。水饮的症状与脾、肺、肾三脏的关系最为密切。它的临床表现有:①咳嗽、喘息、咯白色泡沫痰,证见于慢性支气管炎、支气管哮喘发作停止前,心脏病有肺瘀血时,过敏性支气管肺部疾患、弥漫型肺泡细胞癌。②呕吐清涎,心下(胃)部不适,肠鸣腹泻。证见急性消化道感染如沙门氏菌属感染、葡萄球菌性食物中毒,以及心力衰竭、肝硬化时肠系膜静脉、门静脉充血引起胃肠蠕动、分泌、吸收功能紊乱等。此外,水饮形成的机转,多半是在脏腑寒证的基础上产生的,可能除上述症状外,伴有一般寒证现象,如畏寒、肢冷、面色苍白、舌质淡、苔白滑、脉沉等。

水饮与湿的性质也很相似,临床上某些症状如浮肿、腹泻既可认为是水饮,也可认为是湿证。故临床上有关湿的若干治法、药物、方剂、可通用于水饮治疗。

根据水饮停积部位不同,可分为痰饮、悬饮、溢饮、支饮等,现介绍如下:

[痰饮]

水饮留于胃脘。

1. 主要证候:头目眩晕、呕吐痰涎清稀、胸胁苦满、胃脘有振水声、口不渴、渴亦不欲饮、心悸气短、苔白滑、脉弦滑等。证见急性胃潴留、急性消化道感染及急性食物中毒。

2. 治疗参考:温阳化饮。方如苓桂术甘汤。

[悬饮]

水饮留于胁肋。

1. 临床证候:胸胁引痛、咳嗽、深吸气、身体转侧时加重、呼吸困难、肋间胀满、脉沉而弦。证见肋间神经痛、胸膜炎、泰齐氏病(非化脓性肋软骨炎)。

2. 治疗参考:攻逐水饮,如十枣汤、控涎丹。

[溢饮]

水饮留于四肢肌肉。

1. 临床证候:发热、恶寒而无汗、咳喘、痰多白沫或见肢体疼痛沉重,甚则肢体浮肿,小便不利、苔白、脉弦而紧。证见慢性肺源性心脏病合并感染伴心功能不全,慢性支气管炎伴营养不良,心性、肾性、营养不良性水肿患者合并呼吸道感染等。

2. 治疗参考:温阳利水、兼外寒的宜解表化饮,方如五苓散、合五皮饮、小青龙汤等。

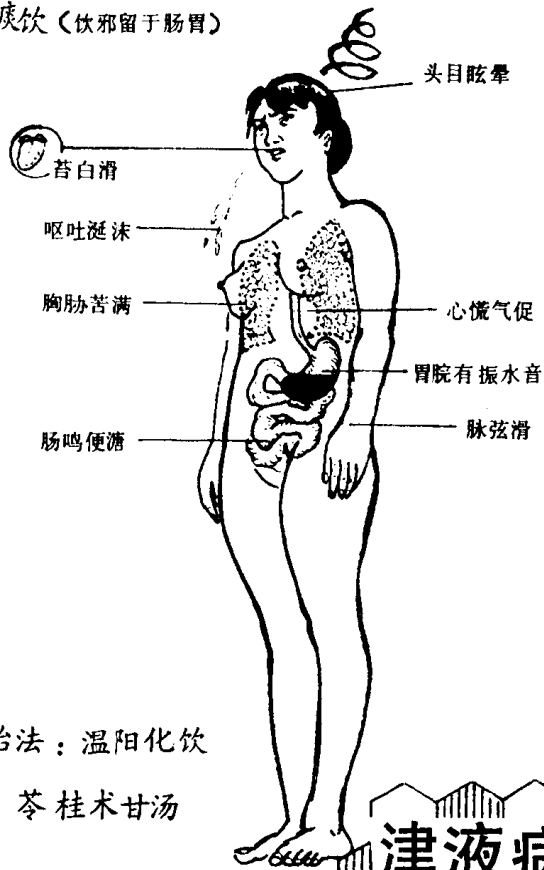
[支饮]

水饮停于胸膈、胃脘。

1. 临床证候:咳逆喘息、胸闷气短、不能平卧、浮肿多见于面部、痰色白多泡沫、苔多白腻、脉常弦紧。证见心包炎、百日咳、维生素B₁缺乏症(湿性脚气)、慢性支气管炎、支气管哮喘伴营养不良及慢性肺原性心脏病等。

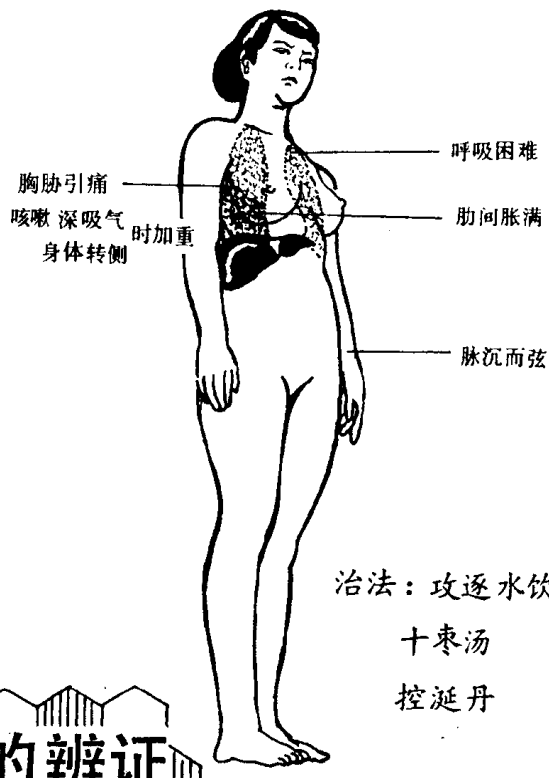
2. 治疗参考:泻肺逐饮,兼表证者宜解表化饮,方如葶苈大枣泻肺汤、小青龙汤。

痰饮（饮邪留于肠胃）



治法：温阳化饮
苓桂术甘汤

悬饮（水饮留于胁肋）



治法：攻逐水饮
十枣汤
控涎丹

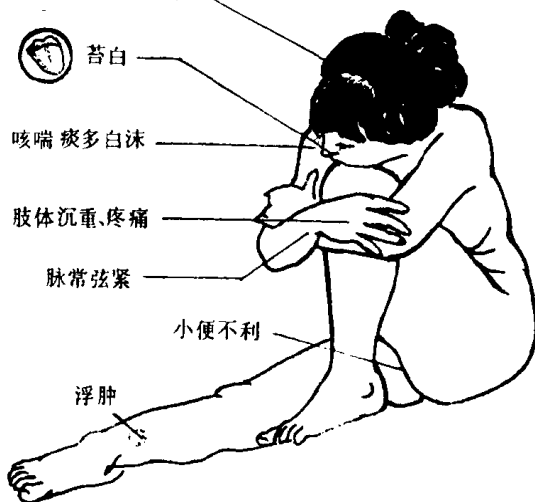
津液病的辨证

(二)

溢饮（水饮留于四肢肌肉）



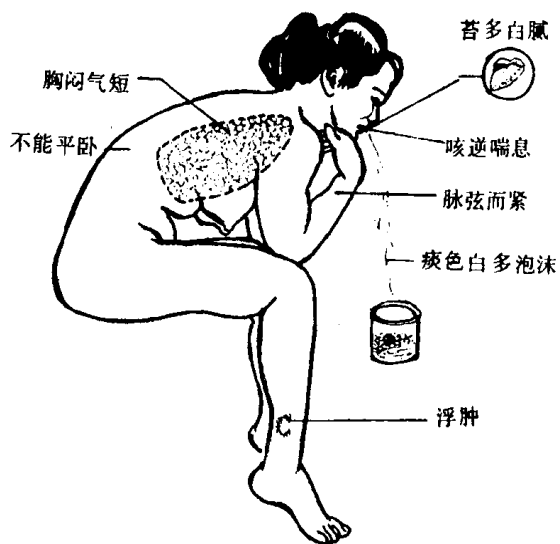
发热、恶寒、无汗



治法：温阳利水
或解表化饮

五苓散合五皮饮
小青龙汤

支饮（水饮停于胸膈胃脘）



治法：泻肺逐饮
或解表化饮

葶苈大枣泻肺汤
小青龙汤

第九章 脏腑辨证

第一节 心病辨证

一、虚 证

[心气虚、心阳虚、心阳虚脱]

1. 主要证候：心气虚、心阳虚的共同主证是心慌，气促，活动时加重，自汗，舌淡苔白。

(1) 心气虚：兼见面色苍白，神疲倦怠，脉细弱，舌胖嫩。

(2) 心阳虚：兼见形寒肢冷，面色暗滞，舌质紫，胸闷，心前区疼痛，脉细或结代。

(3) 心阳虚脱：兼见面色苍白或青灰，大汗淋漓，四肢厥冷，呼吸微弱，脉微欲绝，甚至神志模糊与昏迷。

2. 病因病机：病因有四：① 年高脏器衰弱(如衰老、冠心病)。② 风湿损伤心气(风心病)。③ 其他疾病转变(肺心病、心肌炎)。④ 禀赋不足(先天性心脏病)。主要因心气或心阳不足(心肌收缩力减弱)导致血脉推动力下降，心脏输出量减少，动脉供血不足，引起心慌气促，活动时心肌收缩力不能适应身体需要而加强，故症状加重。因心搏出量减少，血脉不得充盈，故出现面色苍白、神疲倦怠、脉搏细弱和舌质淡白等心气虚证候。心阳虚，主要为交感-肾上腺系兴奋，分泌大量儿茶酚胺引起皮肤、粘膜及内脏小动脉收缩，并可引起心律失常，故临床上出现形寒肢冷，脉有结代，胸闷，心前区疼痛，血运失常(血流缓慢，还原血红蛋白浓度升高，超过5g%时)，有唇舌青紫、面色滞暗等心阳虚表现。心阳虚脱主要是小动脉收缩引起微循环灌注不足，全身组织器官缺氧则出现面色苍白或青灰，大汗淋漓(外液外泄)、四肢厥冷、脉细欲绝、神志模糊，甚至昏迷等休克征象，中医也称为亡阳。

3. 治疗参考：心气虚治疗宜补益心气，方如养心汤。心阳虚治疗宜温补心阳，方如保元汤。心阳虚脱治疗宜回阳救逆，方如参附汤。

[心血虚、心阴虚]

1. 主要证候：心血虚、心阴虚的共同主证为心悸、健忘、失眠，多梦。

(1) 心血虚：兼见眩晕，面色苍白，唇舌色淡，脉细快。

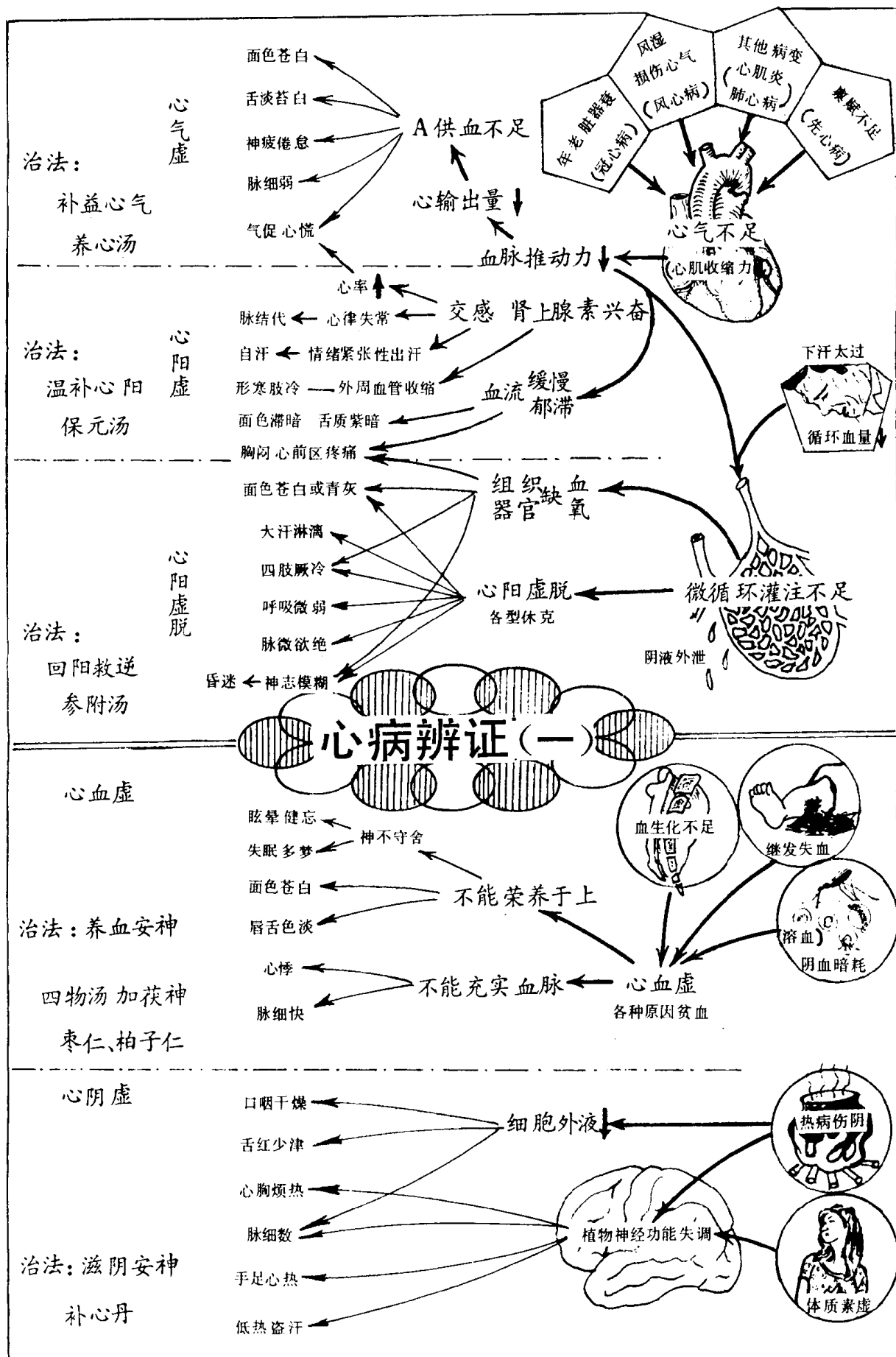
(2) 心阴虚：兼见口干咽燥，舌红少津，脉细数，心胸烦热，手足心热，盗汗，低热。

2. 病因病机：

(1) 心血虚：多因① 血生化不足：见于缺铁性贫血，巨幼红细胞性贫血，再生障碍性贫血等。② 继发于失血之后，见于各种急、慢性失血。③ 阴血暗耗：见于各种溶血性贫血。阴血不足，血不养心，神不守舍，故有眩晕、健忘、失眠，多梦等神经衰弱症状，血虚不能荣养于上(红细胞减少，血红蛋白浓度下降)，故有面色苍白，唇舌色淡。心血虚不能充实血脉(缺血、缺氧反应性引起心率加快)，则有心悸、脉细快。

(2) 心阴虚：多因① 热病伤阴，津液亏耗。② 体质素虚。③ 虚火内扰。津液耗伤，使细胞外液减少，故出现口咽干燥，舌红少津，脉细数。心阴虚则心阳偏亢(植物神经功能失调)，出现五心烦热、盗汗、低热。

3. 治疗参考：心阴虚，治宜滋阴安神，方如补心丹。心血虚，治宜养血安神，方如四物汤加枣仁、柏子仁、茯神等。



二、实 证

心病主要症状：心悸、心痛、健忘、失眠、多梦、嗜睡、神昏、谵语、痴愚、惊痫、口舌生疮、尿赤、小便淋痛等。

〔心火上炎〕

又称心火炽盛，属实证。

1. 主要证候：口舌生疮，舌尖红，面赤口渴，心悸，心烦，失眠，脉数，甚则狂躁、谵语，或兼见小便赤涩刺痛、尿血等。

2. 病因病机：心有一别络与舌直接相连，因而心的气血上通于舌，心火偏亢则舌质红赤或舌体糜烂。心与小肠相表里，小肠的生理功能是分清别浊，清的津液则渗入膀胱，故心病与现代医学泌尿系统疾病相关联。中医认为，心火上炎的病因有三：① 情志郁结化火，即与精神因素有关。② 六淫内郁：泌尿系感染、复发性口腔炎、菱形舌炎综合征都由生物性病原体引起，泌尿系统结石与泌尿系感染相关，可互为因果。③ 进食辛辣和温燥药物。口舌生疮具反复发作特点，病因不明，可能与柯萨奇病毒感染有关，菱形舌炎综合征，病因也不明，但每当摄取刺激性食物时，舌背灼热，同时出现难治的溃疡，口腔粘膜干燥，颌下淋巴结肿大。泌尿系结石与饮食、饮水、气候有一定的关系。血尿临床上见于泌尿系结石、结核、肿瘤。感染或异物常构成结石的核心，而结石形成尿路梗阻或损伤泌尿道粘膜又易造成泌尿系感染。两者均可表现为尿频、尿急、尿痛，即所谓小便淋漓刺痛。

3. 治疗参考：清心泻火，方如泻心汤。心移热于小肠，宜清心导赤，方如导赤散。

〔心血瘀阻〕

1. 主要证候：心胸憋闷或刺痛（位胸骨后或心前区），痛引肩背、内臂（左臂尺侧）时发时止，舌质暗紫或见瘀点、瘀斑，脉细涩或结代。重者暴痛欲绝，口唇青紫，肢厥神昏，脉微欲绝（原发性休克表现）。

2. 病因病机：心血瘀阻即冠脉瘀阻，其主要证候属现代医学心绞痛、心肌梗塞，其病因，中医学认为：① 继发于心气或心阳亏虚，心气（心肌收缩力）虚，能引起冠脉灌注量减少，心阳虚（指交感神经兴奋增强，冠脉收缩或痉挛），心肌供血也减少，都致气血运行不畅，故出现心悸、心痛（瘀血者刺痛，痰浊者闷痛）。② 情志内伤或劳倦、受寒。现代研究表明，情绪激动，喜怒不节，不仅是发作的诱因，同时也是病因之一，冠心病患者多属性情急躁、争强好胜的所谓“A 型性格”者。劳累过度造成心肌供血不足也是心肌梗死的原因。③ 过嗜肥腻，进食过多高脂食物是血脂升高、胆固醇、甘油三酯沉积冠状动脉形成“痰浊凝聚”（动脉粥样斑块）的重要原因。

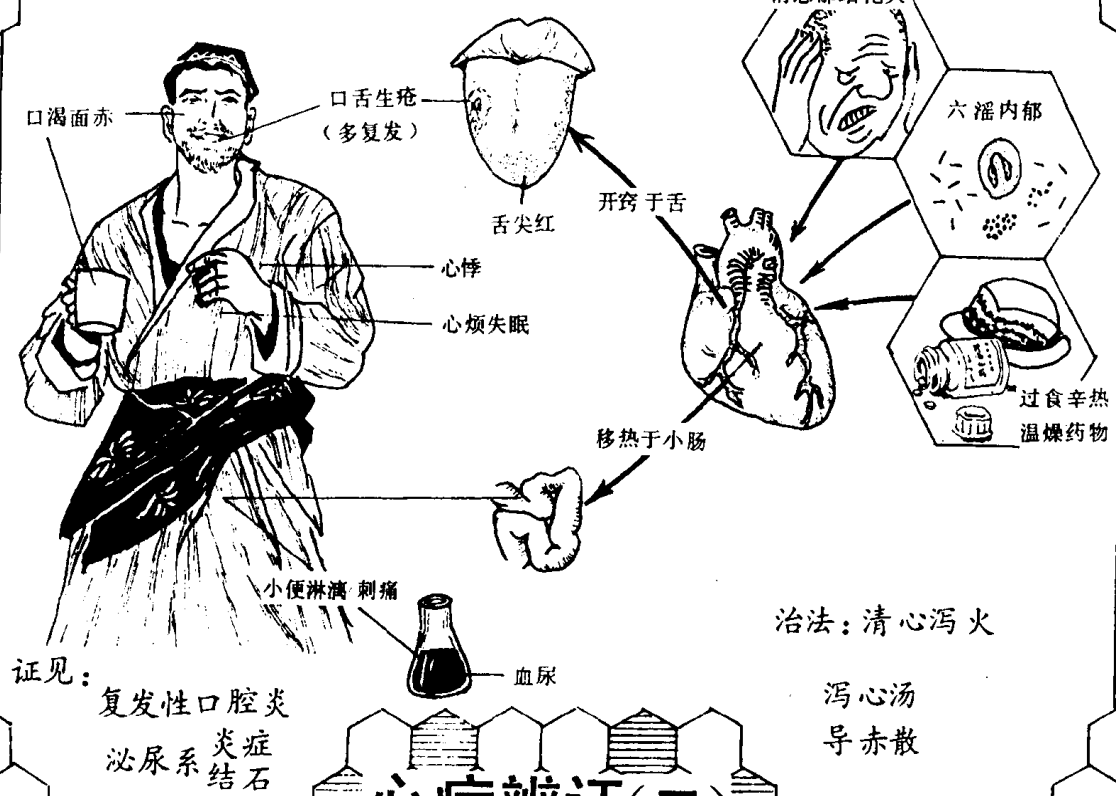
阳虚血瘀，心脉搏动失常，故脉涩或结代（发生率达 75%~95%，以室性心律失常最常见，其次为房室传导阻滞与束支传导阻滞），舌见暗紫，有瘀斑、瘀点为气滞血瘀之证。

心阳暴绝为心源性休克时表现，见于心肌梗死 20% 的病例，多发生于发病后数小时或一周内，其表现为面色苍白，口唇青紫，烦躁不安，皮肤湿冷，大汗淋漓，血压下降，脉搏细快欲绝，神志迟钝，严重者昏厥。

3. 治疗参考：通阳化瘀，方如枳实薤白桂枝汤合通窍活血汤，或瓜蒌薤白半夏汤合血府逐瘀汤。

心阳暴绝，用参附汤，急救回阳。

心火上炎



心病辨证(二)

心血瘀阻



心是生命活动的中心,是五脏六腑中最重要的器官。中医学认为“心藏神”,“心主神明”。中医的“心”,包括人体大脑的功能活动。心有病,则会出现大脑功能失调的行为,知觉、思维、情感及智能等方面的异常。下述心病实证表明中医学在精神病的病因、分类、临床表现和治疗等方面有丰富的记载。

[痰火扰心]

1. 主要证候:神志错乱,哭笑无常,躁妄动,甚则打人骂人,面赤气粗,口渴,尿赤,舌红苔黄腻,脉滑数有力。

2. 病因病机:中医学认为,本证病因有三:① 情志不遂,现代医学对精神分裂症、躁狂抑郁症的研究,始终未发现病人脑部有器质性改变,列为功能性精神病。精神因素对发病肯定有影响,躁狂-抑郁症首次发病前约半数以上有精神因素。② 气机不舒,郁而化火,灼津成痰。现代研究证明精神分裂症病人血中含有毒物质,接种于动物可引起某些精神分裂症状,推测为一种“自体中毒”。躁狂-抑郁症与脑内单胺物质紊乱(如躁狂状态病人脑内去甲肾上腺素或5-羟色胺浓度过高,而抑郁状态则相反)有关。肺脑综合征精神症状是由于碳酸血症及脑缺氧所引起,肝脑综合征发病与血氨升高、低级脂肪酸聚积以及假神经介质的存在有关。以上诸因素似乎均可理解为中医学的“痰浊邪气”或“痰”所致。③ 外感热病即现代医学的感染性精神病。常见于流感、肺炎、伤寒、菌痢、脑炎、败血症等感染性疾病所引起的谵妄状态或类似精神分裂症的表现,中医认为上述病因都能“灼津成痰,痰与火结,内扰心神”。临床以精神运动性兴奋为特征,如情感喜怒无常,动作、语言增多,有兴奋性冲动行为以及幻觉、妄想。病因于痰,故苔腻,脉滑;因于火,故有舌红苔黄,面赤气粗,口渴,尿赤。证见精神分裂症(青春型、妄想型)、躁狂-抑郁型精神病(躁狂型)、症状性精神病中的感染性精神病、肺脑综合征、肝脑综合征等。

3. 治疗参考:涤痰泻火,方如礞石滚痰丸、生铁落饮加减。

[痰迷心窍]

1. 主要证候:神志痴呆,情感淡漠,语无伦次或喃喃自语,不知饥饱,举止失常,苔白腻,脉滑。

2. 病因病机:本证多因精神所伤,气机不舒,影响津液运行,停聚凝结为痰,痰迷心窍,扰乱心神。临床以精神运动性抑制为特征,情感抑郁,淡漠,动作和语言显著减少;思维活动缓慢,常呆坐,蜷卧,不食不动,因有痰,故苔白腻,脉滑。若痰迷心窍,则见昏迷不醒,喉有痰声,舌强不语等,证见精神分裂症(紧张型),躁狂-抑郁症(抑郁状态),反应性抑郁症,脑血管意外及肝性脑病。

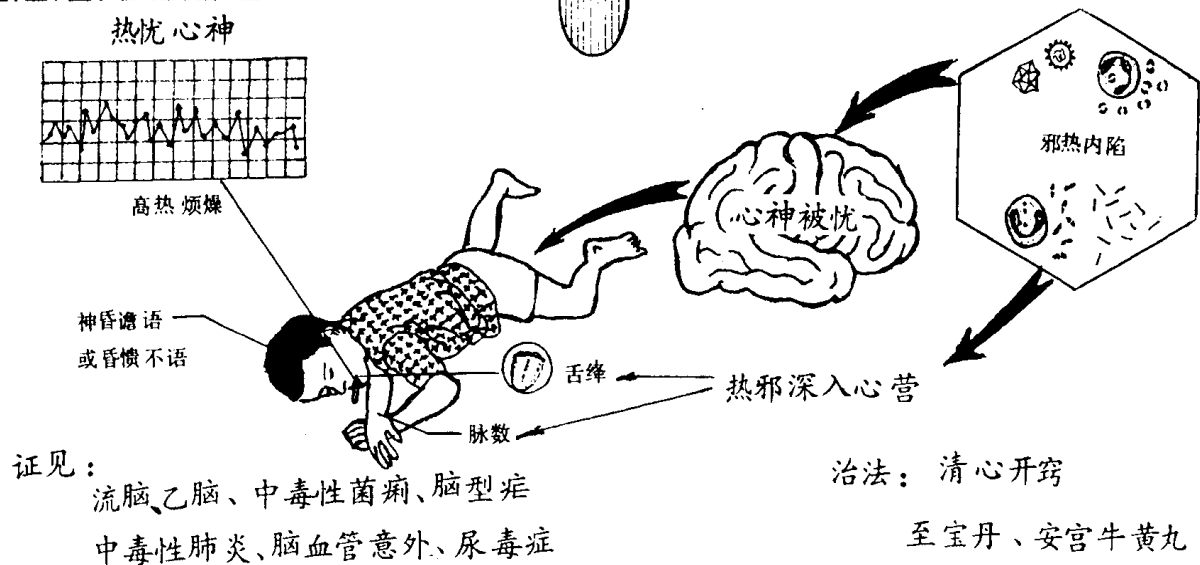
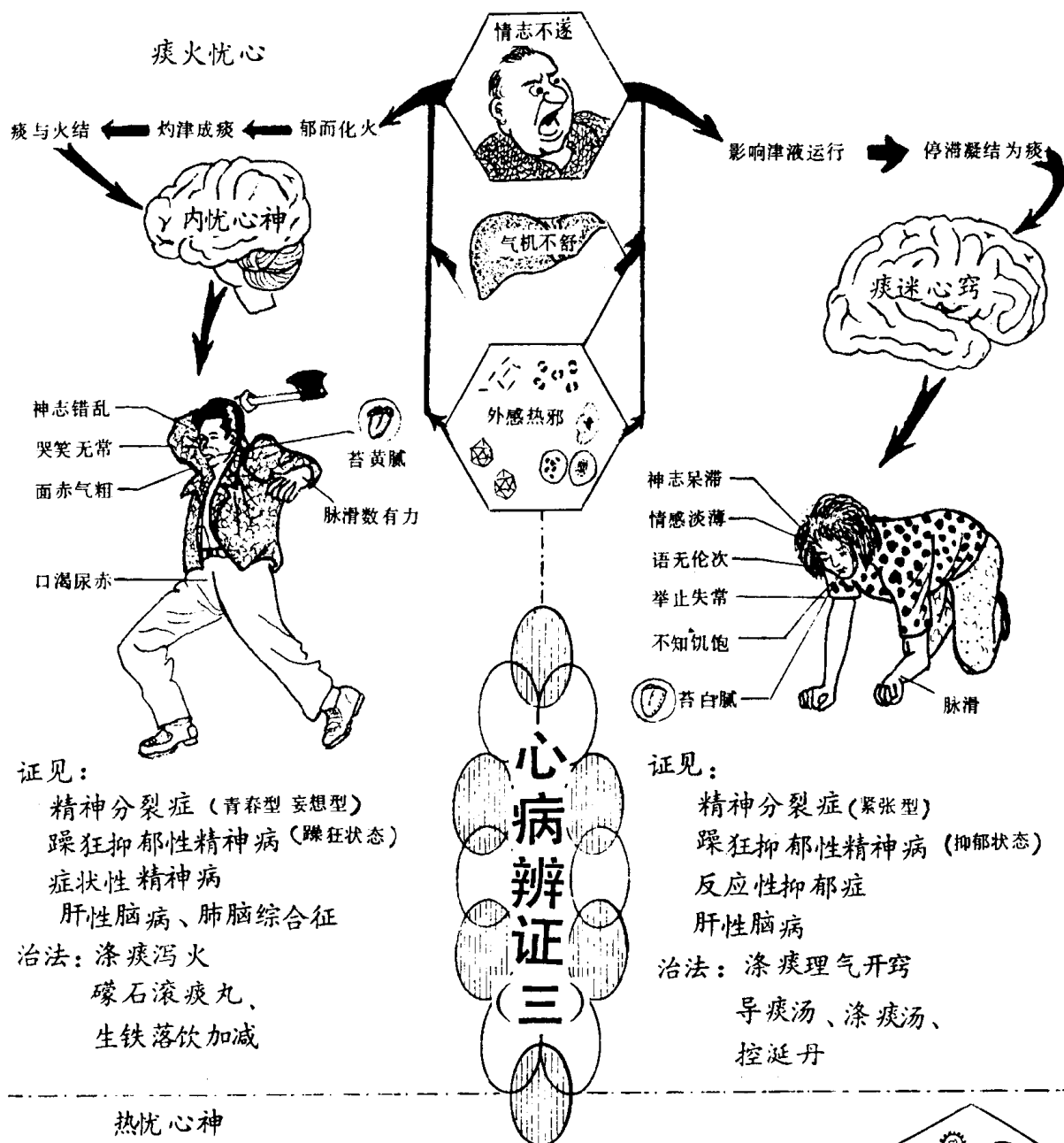
3. 治疗参考:涤痰理气开窍,方如导痰汤、涤痰汤、控涎丹等加减。

[热扰心神]

1. 主要证候:高热,烦躁,神昏,谵语或昏愤不语,语言不连贯,呓语,舌绛,脉数。

2. 病因病机:热扰心神,包括现代医学的感染性精神病,如流脑、乙脑、中毒性菌痢、肺炎、脑型疟等感染性疾病所致精神障碍和内脏病时的精神紊乱,如尿毒症、脑动脉硬化、脑血管意外引起的智能降低、情绪改变和意识障碍。中医认为是邪热内陷,心神被扰的表现。

3. 治疗参考:清心开窍,方用至宝丹或安宫牛黄丸加减。



第二节 小肠病辨证

小肠接受从胃转移来的半消化食物,主要进行分别清浊的工作,把清的部分,如水谷精微吸收到体内贮存利用,多余的水分形成尿液由膀胱排出。把浊的部分如食物残渣,送到大肠,形成大便,排出体外。中医学的小肠除指人体小肠以外,还包括了现代医学的泌尿系统。

小肠与心有经络联系,构成相互表里的脏腑关系。心病时能影响小肠,如心火上炎时,通过小肠“移热于膀胱”出现尿痛,小便短赤或尿血。小肠病辨证,属虚的有小肠虚寒,属实的有小肠实热和小肠气痛。

[小肠虚寒]

1. 主要证候:小肠部隐隐作痛,痛时喜按,肠鸣泄泻,小便不利,舌苔薄白,脉缓。

2. 病因病机:本症多因饮食失调,过食生冷,或过用寒凉药物,引起胃、小肠分泌、蠕动功能紊乱。小肠蠕动时,由于肠内容物移动时所产生的气过水声,叫肠鸣音,当上述病因使肠蠕动亢进,肠平滑肌强烈收缩则出现脐周部阵发性疼痛,肠鸣音也增强、响亮,腹胀和腹泻,粪便呈糊状或水样。临床上见于急、慢性肠炎(包括病毒性肠炎),肠结核,吸收不良综合征,金黄色葡萄球菌肠炎及情绪性腹泻(肠痉挛)等。

3. 治疗参考:温阳散寒,方如吴茱萸汤。

[小肠实热]

1. 主要证候:心烦,小便赤涩,或茎中疼痛(尿频、尿急、尿痛),血尿,脐腹胀痛,舌质红,苔黄,脉数。

2. 病因病机:小肠与心相表里,小肠的生理功能包括了人体主要的排泄系统,中医将膀胱刺激症状:尿频、尿急、尿痛和血尿等均列为“心火亢盛”通过小肠“移热于膀胱”的证候。膀胱和尿道受炎症或机械性刺激(如结石,肿瘤)使膀胱紧张度增加,就会出现小便赤涩、尿道刺痛,临床上可见于泌尿道感染、前列腺炎、肾结核、膀胱结石和肿瘤。

3. 治疗参考:清热利湿,方如导赤散,八正散。

[小肠气痛]

1. 主要证候:小腹绞痛,腹胀,肠鸣,排气则舒,或阴囊疝痛,苔白,脉沉弦或沉紧。

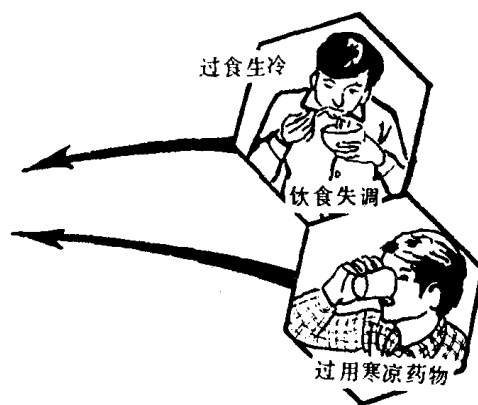
2. 病因病机:小肠气痛,中医学泛指体腔内容物向外突出的病症。如突出于腹壁、腹股沟或下突入阴囊,即现代医学的腹白线疝、脐疝、腹股沟直疝和斜疝,为腹内器官或组织,经腹壁缺损或薄弱处向体表突出。中医学认为本证多因饮食失节、寒湿不调或负重过度引起小肠气机郁滞。由于疝内容物以小肠为最多见,小肠在疝囊与腹腔相通的狭窄处常引起肠道不全梗阻,肠内容物通过困难,中医称为:“气机郁滞”。梗阻上方的肠平滑肌蠕动增强,则出现小肠气痛,肠鸣,排气则舒。负重过度可引起腹内压增高,小肠在腹内压推动下进入疝囊引起嵌顿,则出现阴囊坠胀疼痛。

3. 治疗参考:理气止痛,方如桔核丸,木香顺气汤。

小肠病辨证

小肠虚寒

肠鸣腹泻
小腹隐隐作痛
痛时喜按
小便不利



证见：肠痉挛、肠炎

治法：温阳散寒

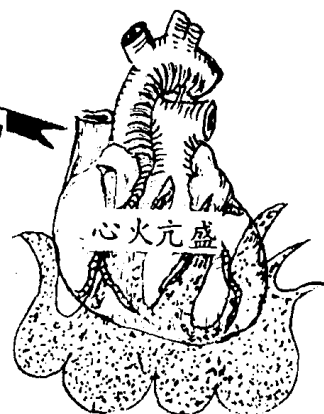
吴茱萸汤

小肠实热

舌质红、苔黄
心烦
脐腹胀痛
小便赤涩
尿道刺痛
血尿



移热于小肠



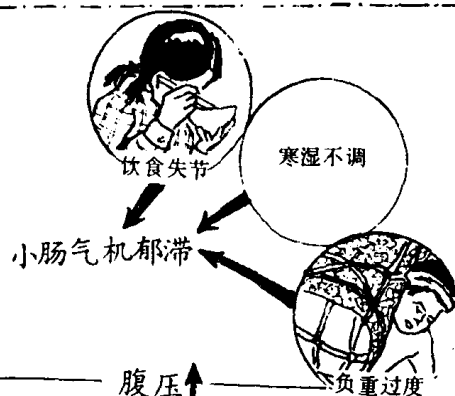
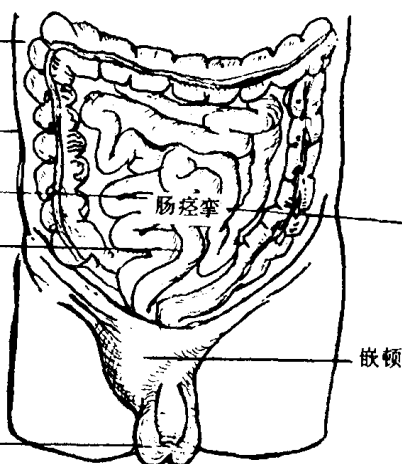
证见：肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎
泌尿系结石、前列腺炎

治法：清热利湿

导赤散、八正散

小肠气痛

苔白滑
脉沉降
腹胀肠鸣
小腹绞痛
排气则舒



证见：肠痉挛、疝气

治法：理气止痛

桔核丸、木香顺气汤

第三节 肝胆病辨证

一、虚 证

肝有贮藏和调节血液功能,并与情绪(肝主疏泄,肝喜条达)、运动(肝主筋)、眼睛(肝开窍于目)和妇女月经有关。肝病虚证有肝血不足、阴虚肝旺等,实证有肝胆湿热、肝气郁结、肝阳化风、热极生风、血虚生风、肝火上炎、寒滞肝脉等。

胆藏胆汁,参与思维活动,与判断能力和胆量有关。胆有病时出现胆怯、恐惧、易惊等症状。肝与胆相表里,关系密切,有病则相互影响,症状类同。治疗亦相似,临床多以肝病来进行辨证与施治。实证有胆郁痰扰。

[肝血不足]

1. 主要证候:眩晕,面色无华或萎黄,视物模糊,目干涩,夜盲,肢体麻木或感觉异常,筋脉拘急(指肌张力升高,伸屈不能自如),月经量少或闭经,舌淡,脉细,忧郁胆怯。

2. 病因病机:肝血不足病因有三:① 出血:血液丢失过多,如急性和慢性失血性贫血。② 生血不足:如再生障碍性贫血,血红蛋白合成障碍的缺铁性贫血,以及骨髓浸润性贫血(白血病、骨髓瘤、转移癌等)。③ 久病耗伤肝血:多见于慢性疾病如慢性肾功能不全性贫血,内分泌功能紊乱性贫血,慢性感染性贫血,蛋白质营养不良性贫血。上述慢性疾病常同时伴有消化、吸收障碍,维生素的吸收减少和消耗增加,如慢性感染性疾病,维生素消耗增多,极易出现维生素A、B等多种维生素缺乏。维生素A缺乏,出现目干涩、夜盲。维生素B₁缺乏,可引起多发性周围神经病变,早期表现为肢体感觉异常,诉肢体发胀、麻木、针刺样疼痛和烧灼感,后期可有足、腕下垂,损伤神经系统有易疲乏,失眠,多梦,易怒或抑郁。维生素B₆、B₁₂缺乏能引起贫血,由于贫血,卵巢供血减少,可引起性激素分泌紊乱和子宫内膜供血减少,而出现月经过多或闭经。中医认为肝血不足不能上荣头面及濡养肢体筋脉,是血海空虚所致。

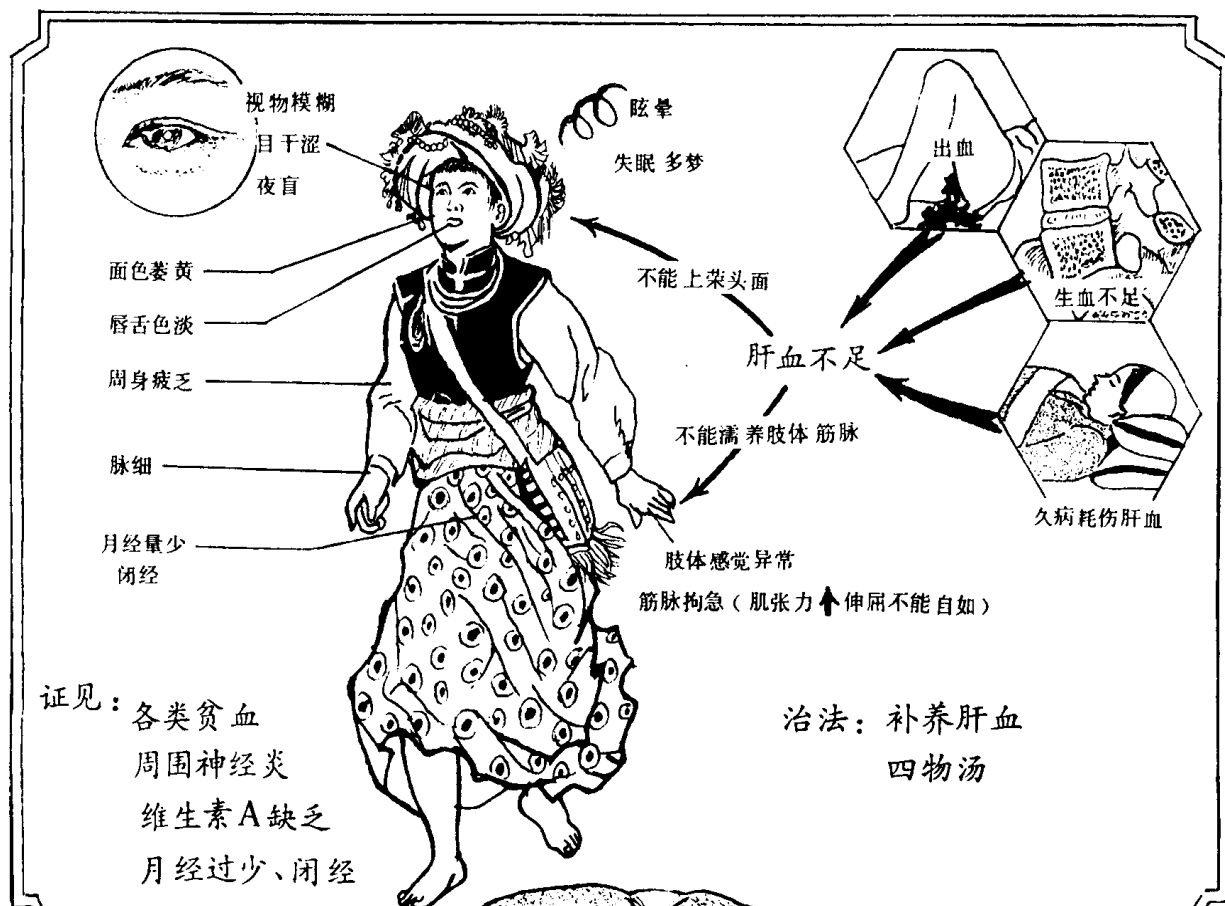
3. 治疗参考:补养肝血,方如四物汤、补肝汤。

[肝阳上亢(阴虚肝旺,肝阳亢盛)]

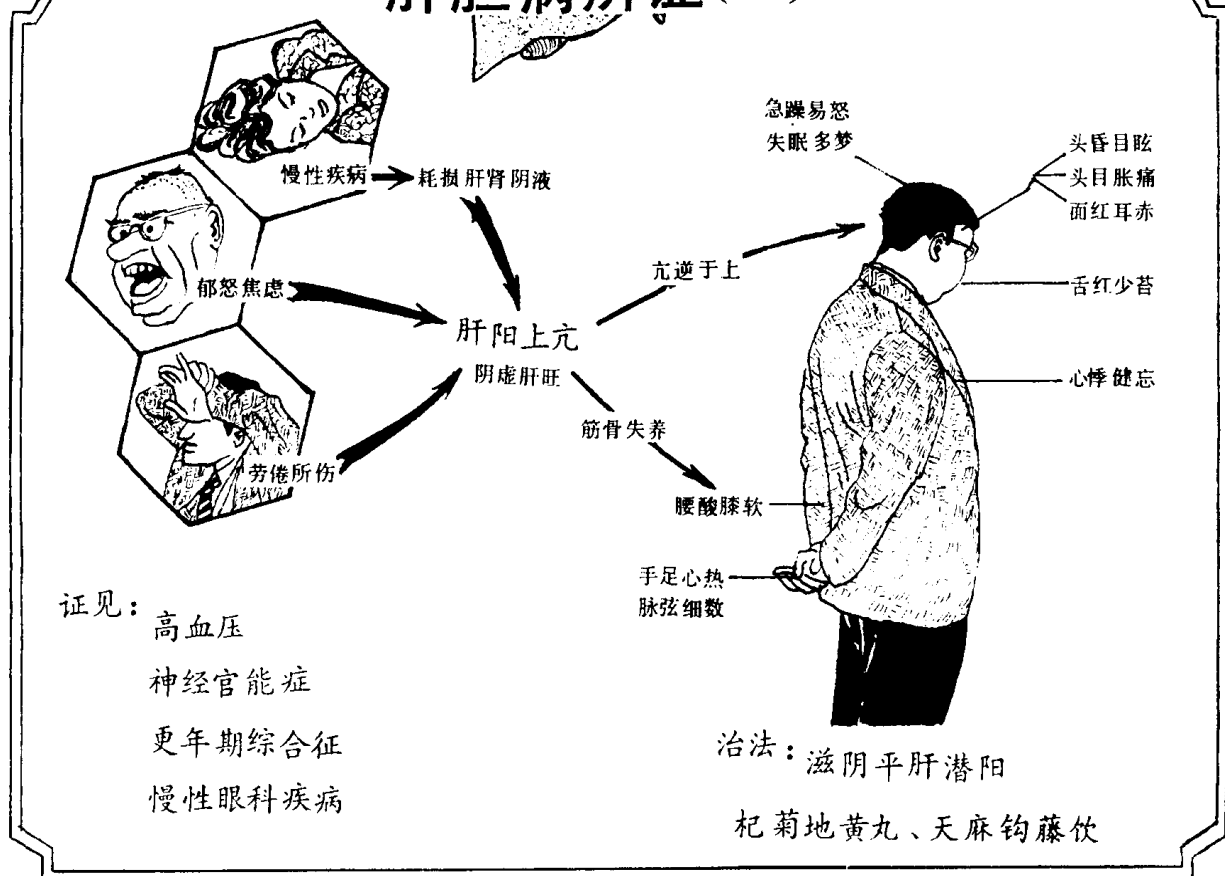
1. 主要证候:头昏目眩,头目胀痛,面红耳赤,急躁易怒,失眠多梦,心悸健忘,腰酸膝软,五心烦热,舌红少苔,脉弦细数。

2. 病因病机:肝阳上亢的病因有三:① 慢性疾病耗损肝肾阴液,肝阴不足则肝阳上亢。肝阳上亢是一组症候群,这一组症候群按现代医学观点属于植物神经功能紊乱症候群,表现为心率加快,心悸,血压偏高或偏低,眩晕,面颈皮肤潮红、灼热,手足心出汗,呼吸急促,食欲不振,腹胀腹泻或便秘,尿频,月经不调或阳萎,早泄,梦遗。植物神经功能紊乱可由慢性躯体性疾病如感染、中毒、营养不良、失血等引起神经系统功能状态削弱,继而出现内脏神经功能不稳定所致。② 郁怒焦虑,持续的紧张心情和长期的内心矛盾等精神因素超过了神经系统的耐受阈限,大脑皮层功能失调,这种失调波及内分泌及植物神经出现功能紊乱。如高血压、神经官能症均与精神因素有关,出现失眠、多梦、情绪不稳、急躁易怒、易疲劳、腰酸膝软、心悸健忘等症状。③ 劳倦所伤,指脑力活动过度。内分泌功能紊乱也可导致植物神经系统活动失调,如更年期综合征,主要为45~55岁妇女由于生殖器开始萎缩,卵巢功能衰退,造成雌性激素水平下降,反馈引起下丘脑的促肾上腺皮质激素释放因子分泌增加和植物神经功能紊乱。中医学认为均属“阴虚肝旺”之象。

3. 治疗参考:滋阴平肝潜阳,方用杞菊地黄丸,天麻钩藤饮。



肝胆病辨证(一)



二、实 证

〔肝胆湿热〕

1. 主要证候：胁肋疼痛，面目周身发黄，发热或寒热往来，口苦，纳差，恶心，呕吐，腹胀，大便不调，尿黄短，苔黄腻，脉弦数。若见阴囊湿疹，或睾丸肿大热痛，或带下黄臭，外阴搔痒，则为肝经湿热。

2. 病因病机：本证病因有二：① 感受湿热之邪，临床观察肝胆湿热见于现代医学的黄疸型肝炎（由肝炎病毒引起）、急性胆囊炎、胆石症合并感染、急性睾丸附睾炎、前庭大腺炎、子宫颈炎（均由细菌引起）、滴虫性阴道炎（由阴道滴虫引起）、霉菌性阴道炎（由白色念珠菌引起）等病，其生物性病原体均为中医学之“湿热之邪”。② 多食肥腻、酗酒，胆石症多见中年肥胖女性，肥腻食物含胆固醇高，是形成代谢性结石的原因之一。酗酒能损伤肝脏，可导致中毒性肝炎。肝胆疾患可引起消化道症状如食欲减退，厌食，口苦，恶心，呕吐，腹胀，腹泻或便秘，右季肋疼痛以及肝细胞性或阻塞性黄疸，此时出现皮肤、粘膜黄染，尿少色深，中医学认为是“肝胆湿热内蕴，疏泄功能失常，胆汁不循常道，外溢肌肤”所致。至于阴囊湿疹，现代医学认为是维生素 B₂ 缺乏引起皮肤损害改变，急性睾丸、附睾炎是成人阴囊内最常见的感染性疾病，多由后尿道炎、前列腺炎等波及。起病较急，有发热，附睾肿大疼痛。前庭大腺炎常见于育龄妇女，大阴唇一侧后方前庭大腺化脓性细菌感染，局部有红、肿、热、痛及触到脓肿；滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎均可经性生活和公共浴池、浴盆、公用洗脚巾等传播，主要症状是白带增多，外阴搔痒和灼痛。滴虫性阴道炎白带呈灰黄色、泡沫状，有臭味，而霉菌性阴道炎白带呈白色豆渣样，也可为水样或脓样，由于上述外阴疾病均为足厥阴肝经循行部位，中医统列为“肝胆湿热”。

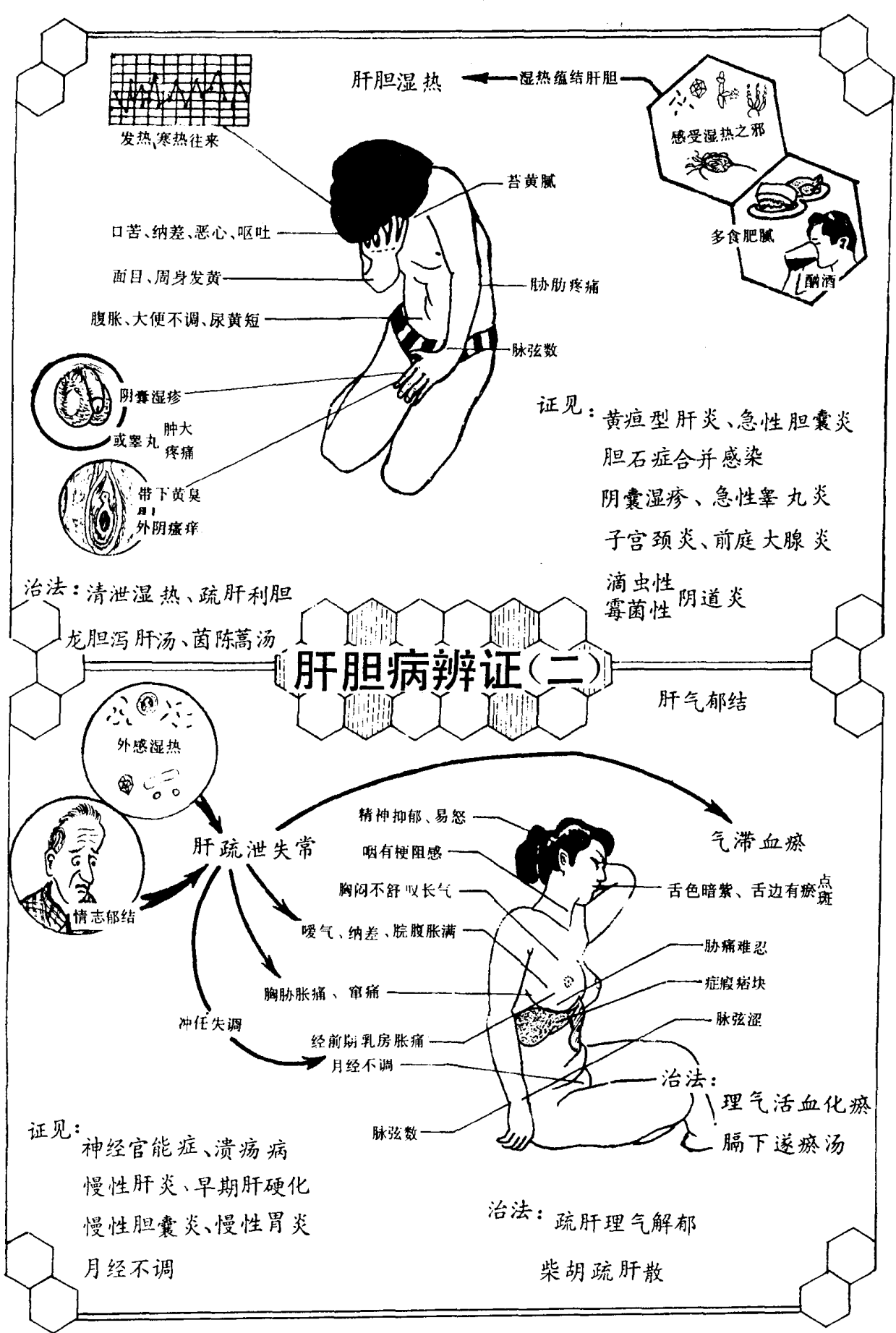
3. 治疗参考：清泄湿热、疏肝利胆，方用龙胆泻肝汤、茵陈蒿汤加减。

〔肝气郁结〕

1. 主要证候：精神抑郁、易怒，胁肋胀痛或窜痛，胸闷不舒，叹长气，纳呆噎气，脘腹胀满，大便失调，或咽部有梗阻感，妇女有月经不调、痛经或经前乳房胀痛，舌苔薄白，脉弦。若气滞血瘀，可见胁痛如锥刺，症瘕痞块，舌色紫绀，舌边有瘀点或瘀斑，脉弦涩。

2. 病因病机：本证病因有二：① 外感湿热：本证临床上可见于慢性肝炎、早期肝硬化、慢性胆囊炎、慢性胃炎等，其“湿热之邪”分别指肝炎病毒、血吸虫、大肠杆菌、变形、厌氧或弯曲杆菌等。② 情志郁结：紧张、忧伤、焦虑等精神刺激持续存在，是引起大脑皮层兴奋、抑制失调和神经、体液调节紊乱，导致精神抑郁、易怒，咽有梗阻感，胸闷不舒，月经失调等病理性心理反应，以及胃酸分泌增多，导致胃粘膜炎症，溃疡改变。中医学认为均由“肝疏泄失常”、“肝不条达”所致。若出现气滞血瘀则有舌色暗紫，舌边有瘀点、瘀斑，腹部有肝脾肿大，压痛或触及到包块，脉弦涩等表现。

3. 治疗参考：肝气郁结，宜疏肝理气解郁，方用柴胡疏肝饮加减。咽部异物梗阻感，宜理气化痰，方用半夏厚朴汤加减。气滞血瘀者，宜理气活血化瘀，方用膈下逐瘀汤加减。



肝风内动：中医学将疾病过程中出现眩晕、动摇、抽搐等症状，都称为肝风。肝风内动的主要症状除上述表现外，尚有震颤、麻木、半身不遂等。常见有三种病证：肝阳化风，热极生风，血虚生风。

〔肝阳化风〕

1. 主要证候：眩晕，头痛，肢体麻木或震颤，舌体颤动，舌红，脉弦数，甚则卒然昏倒，舌强不语，口眼喎斜，或半身不遂。

2. 病因病机：眩晕是中医内风的一个重要证候。《至真要大论》说“诸风掉眩，皆属于肝”，认为是由肝功能失调而发生的。眩晕也是现代医学的一个症状，是一种主观性感觉障碍。病人感到周围的景物向一定方向转动或自身天旋地转，这种眩晕称真发性眩晕，临床上分为周围性（见下节胆郁痰扰）和中枢性（以椎-基底动脉供血不足和脑动脉粥样硬化最为常见），其临床表现属肝阳化风。椎-基底动脉供血不足，多见于中老年人，其病证表现复杂多样。眩晕出现于早期，发作时伴单侧或双侧耳鸣、耳聋，可突然弱视或失明，持续数分钟恢复。延髓供血不足可有语言含糊不清。脑干供血不足可出现面神经麻痹，肢体单瘫、偏瘫，以及面部、口唇、舌部发麻，肢体麻木或感觉减退，有时可倾倒发作，或头颈转动时出现昏厥乃至昏迷。脑动脉粥样硬化也多见于中年以上，男性较多，起病徐缓，粥样斑块多位于威尔氏环和大脑中动脉处，早期表现头晕（头重脚轻），睡眠障碍，记忆减退，易激动，自制力减弱，头痛，可伴或不伴高血压，当锥体束受损可有肢体无力，轻瘫；皮质脑干束受损可有语言含糊不清；锥体外束受损则出现震颤，手指震颤呈搓丸样，由上肢远端开始，以后发展至下肢、颈、唇及头部。脑动脉粥样硬化若合并高血压病较易形成微动脉瘤，血压骤升时极易破裂，出现卒然昏倒，存活者有口眼喎斜，半身不遂。上述疾病临床表现中医统归为“阳动化风”所致。

3. 治疗参考：平肝熄风，方用天麻钩藤饮或镇肝熄风汤加减。

〔热极生风〕

1. 主要证候：高热，项强抽搐，两目上翻，甚则角弓反张，神志昏迷，舌红苔黄，脉弦数。

2. 病因病机：高热惊厥是婴幼儿时期最常见的惊厥原因。各种非中枢神经系统的急性感染均可引起，尤其以上呼吸道感染时多见，常发生于急骤高热（39℃以上），开始12小时内，惊厥持续仅数秒至数分钟。中枢神经感染性惊厥，见于流脑、乙脑与化脑，惊厥多反复发作，持续时间也较长。上述疾病中医均归入“高热引动肝风”所致。

3. 治疗参考：清热熄风，可用羚角钩藤汤加减。

〔血虚生风〕

1. 主要证候：眩晕，视物模糊，面色萎黄，肢体麻木或震颤，肌肉抽动，舌淡，脉弦细。

2. 病因病机：重度贫血患者，因大脑供血不足，可出现眩晕，视力模糊，面色萎黄，舌淡脉细表现，因常伴有多种维生素缺乏和营养不良，可出现肢体麻木，抽筋，无力等表现，中医学称“血虚生风”。

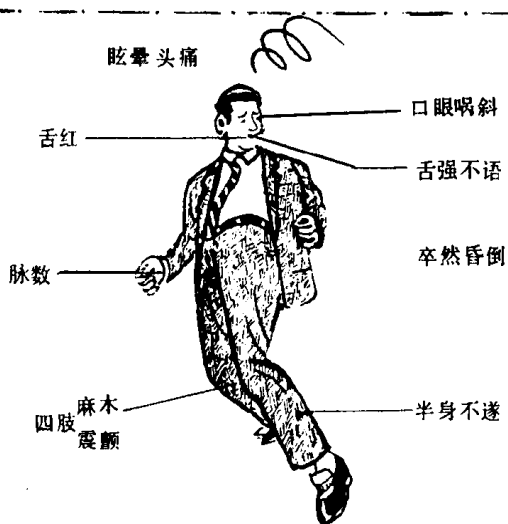
3. 治疗参考：养血熄风，可用补肝汤加减。



肝胆病辨证 (三)

肝风内动

肝
阳
化
风

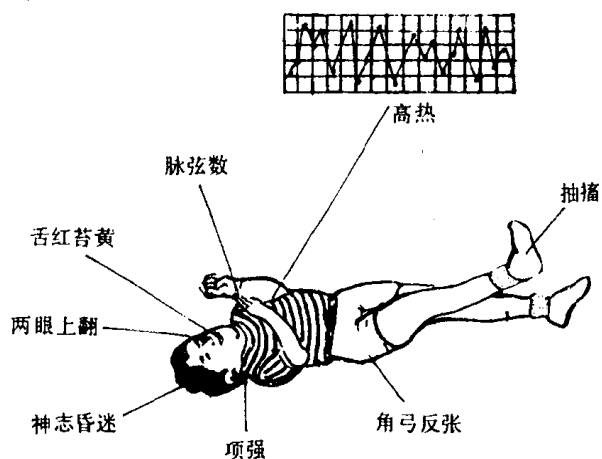


证见: 高血压、脑血管意外

治法: 平肝熄风

天麻钩藤饮

热
极
生
风

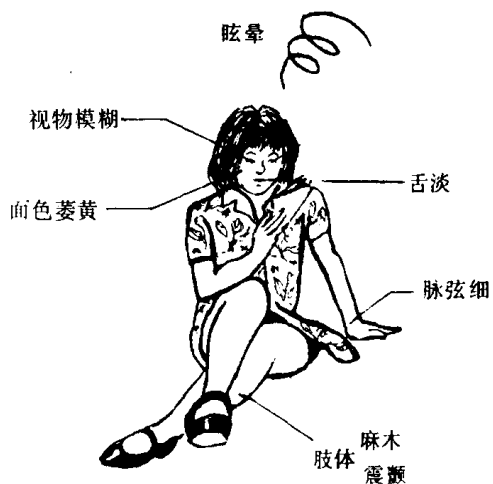


证见 小儿高热惊厥
流脑、乙脑

治法 清热熄风

羚角钩藤汤

血
虚
生
风



证见 贫血、失血

治法 养血熄风

补肝汤

[寒滞肝脉]

1. 主要证候：小腹胀痛，睾丸坠胀，遇寒加重，遇热减轻，或阴囊收缩，痛引小腹，舌苔白滑，脉沉弦。

2. 病因病机：足厥阴肝经绕阴器，至小腹，故中医将生殖器，睾丸、阴囊部位病证也列入肝胆疾病范畴，临床上见于慢性睾丸、附睾炎，附睾结核，疝，精索静脉曲张等。慢性睾丸、附睾炎，多由于后尿道炎或前列腺、精囊炎，经输精管逆行感染，见于青壮年或儿童，临床上常出现阴囊疼痛、发胀、下垂等感觉。疼痛可放射到下腹部及同侧大腿内侧，触诊附睾与睾丸界限不清，肿大，质较硬，压痛，精索粗硬，有压痛。睾丸结核，多见于20~40岁男性青壮年，常是双侧性疾病，病情发展较慢，附睾逐渐肿大，有轻微隐痛，偶有下坠感，部分可突然发作，阴囊内附睾部红肿疼痛可形成脓肿溃破。触诊时附睾肿大呈结节样，输精管增粗呈串珠状。鞘膜囊内液体积聚，使鞘膜腔呈球形增大，并包裹睾丸、附睾，多为一侧性，积液多时出现阴囊下坠胀痛，若因睾丸、附睾炎，外伤，肿瘤或丝虫等引起的继发性者，疼痛较剧。精索静脉曲张是阴囊精索蔓状静脉丛伸长、扩张、迂曲，是男性青壮年常见疾病，多见于左侧，主要症状是患侧阴囊部下坠痛和肿大，疼痛可放射到下腹部或腰部，站立过久或重体力劳动后症状加重，触诊患侧阴囊内有蚯蚓状曲张静脉，平卧时，可缩小或消失。上述疾病，中医认为多因外感寒邪，侵袭肝经，使“气血凝滞肝脉”而发病。

3. 治疗参考：暖肝散寒，方可用暖肝煎加减。

[胆郁痰扰]

1. 主要证候：头晕目眩，口苦，恶心呕吐，虚烦不寐，易惊善恐，胸闷，叹长气，舌滑腻，脉弦。

2. 病因病机：本症临床上见于美尼尔氏综合征、神经官能症。美尼尔氏综合征以眩晕发作、耳鸣、耳聋为主要特征，多见于中年人，大多数是单耳受累，具有发作性及复发性特点。发作来势凶猛，睁眼时感觉周围景物在转动，闭眼时则觉自身在旋转，因睁眼或转动头部常眩晕加重，故大多数患者发作时闭目静卧，头和躯体不敢转动，同时伴恶心、呕吐、面色苍白、出汗、脉快或慢等植物神经功能紊乱症状。其病理主要是内耳淋巴代谢失调，淋巴分泌过多或吸收障碍，引起内耳膜迷路积水所致。神经官能症是临床上相当常见的疾病，以青壮年多见，发病是由各种精神因素，引起高级神经活动过度紧张，大脑功能活动暂时失调所致。临床表现有头晕、头重脚轻感，易疲劳，情绪不稳，烦躁，易怒，失眠，焦虑，疑病，抑郁，胃神经官能症者有口苦、恶心、呕吐及胸闷叹长气等。上述疾病，中医认为是“胆郁气滞，痰浊上扰”或情志郁结，气郁痰生，痰热内扰，“胆失疏泄，胃失降胃”所致。

3. 治疗参考：除痰理气，和胆降胃，可用温胆汤加减。

寒滞肝脉

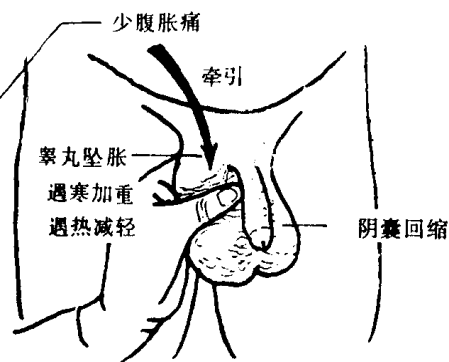


肝经气血凝滞

脉沉弦或迟



舌苔白滑



证见：慢性睾丸炎、附睾炎
附睾结核、疝
精索静脉曲张

治法：暖肝散寒
暖肝煎

肝胆病辨证(四)

胆郁痰扰

虚烦不寐

易惊善恐

胸闷 叹长气

脉弦滑



眩晕

口苦、舌苔滑腻

恶心呕吐



情志郁结

气郁痰生

痰热内扰

胆失疏泄

胃失和降

证见：美尼尔氏综合征
神经官能症

治法：去痰理气、和胆降胃
温胆汤

第四节 脾病辨证

中医学对脾胃生理功能状态十分重视,称“脾胃为后天之本”,说明脾胃在维持人体生命活动方面的重要性。胃的功能主要是接纳饮食并进行初步的消化,脾的功能是将初步消化的饮食进一步消化,吸收其中的营养物质和水(即水谷精微),并输送到全身各处,营养全身。这种进一步消化饮食和运送水谷精微的功能,中医称之为“运化”。脾的运化功能失常时,食物得不到运化,则引起腹胀、腹泻、脘腹胀满等消化不良表现以及营养不足、气血俱虚的面色萎黄、肌肉消瘦、四肢发冷、体弱无力征候。水得不到运化,引起水湿停滞,出现浮肿。脾病以虚证为多,脾虚证有:脾气虚弱,脾气下陷,脾虚水肿,脾不统血。

〔脾气虚弱〕

1. 主要证候:食少,纳呆,食后脘腹胀满,大便溏薄,少气懒言,面色萎黄,肌肉消瘦,四肢倦怠,舌淡苔白,脉缓弱。

2. 病因病机:引起本证的病因有四:① 饮食失调:最多见于婴幼儿,喂养不当是引起轻度腹泻的常见原因,多见于人工喂养儿,喂养过多,过早喂大量淀粉或脂肪食物,或突然改变食物性质,喂养不定时,突然断奶等均可引起消化功能紊乱。腹泻、热量供给不足而出现营养不良征象,也见于其他年龄,因饮食不节,或由于病毒、细菌、真菌或原虫引起肠道内感染,如溃疡病、慢性胃炎与空肠弯曲杆菌有关。慢性肠道感染如慢性阿米巴痢、慢性细菌性痢疾、慢性血吸虫病、肠结核都有慢性腹泻与营养不良表现。② 过度劳倦,指精神或体力劳倦。消化系统的心身疾病临床常见,种类繁多,如溃疡病、溃疡性结肠炎、部分慢性胃炎、胃神经官能症等。多数患者个性特征是紧张、性急、固执,具有竞争性、不良情绪反应和心理障碍,当受到不良的心理社会因素的刺激时,常以情绪反应为中介,引起恶心、呕吐、嗝气、腹痛、腹胀、腹泻等躯体症状。③ 吐泻太过:可能存在消化道梗阻或感染,日久未予消除,则将出现营养不良表现。④ 其他原因如肝病乘脾犯胃,如慢性肝炎会出现上述诸证候。上述诸病因均能损伤脾气,运化功能减退产生一系列气血生化不足表现。

3. 治疗参考:益气健脾,可用参苓白术散,或四君子汤加减。

〔脾气下陷〕

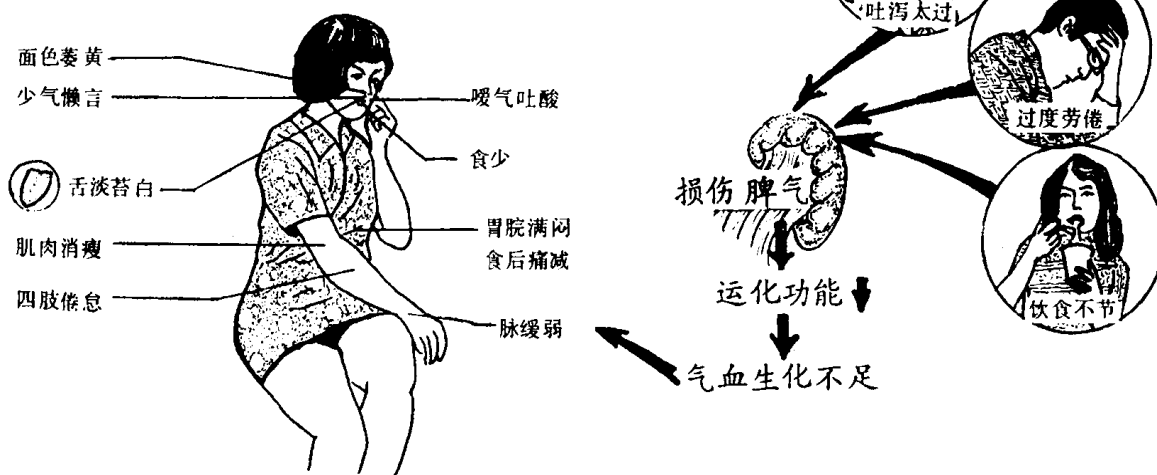
又称中气下陷,气虚下陷。

1. 主要证候:头目昏花,少气,脘腹重坠,食入则胀,便意频数,语言低怯,气短乏力,或久泻脱肛、子宫下垂、胃下垂、肾下垂等。

2. 病因病机:本证临床见于① 脱肛,患者大便时肛管直肠由肛门脱出,色泽鲜红,轻者便后可自行缩回,重者须用手托回,每当咳嗽、喷嚏、行走、排尿等动作都可脱出,常见于体弱儿童及老年人,病因是肛提肌、盆底肌及括约肌薄弱松弛,失去了对直肠的支持,以及与骶骨弯曲度过直,直肠前陷凹腹膜反折过低有关。② 子宫脱垂,产伤是子宫脱垂的主要原因,盆底肌肉尤其是肛提肌和筋膜在分娩时过度伸展或撕裂,产后修复不良,长期哺乳或绝经期,雌性激素低落、组织萎缩使子宫失去支持,在劳动或大便时脱出,卧床后自动回缩,严重者无法还纳,病人感下坠及腰背酸痛。③ 胃下垂,因胃膈韧带、胃肝韧带无力松弛,病人进食后,胃小弯弧线最低点降至髂嵴联线以下,临床多见瘦长型女性,特别是经产妇,有慢性腹痛,不适多在进食或多食后出现,伴腹胀、嗝气、恶心等,仰卧后可减轻,中医认为脾气主升,有提升各脏腑功能,使脏腑保持在一定的位置而不下垂,若脾气不升,就会出现上述诸证。

3. 治疗参考:益气升提,可用补中益气汤加减。

脾气虚弱

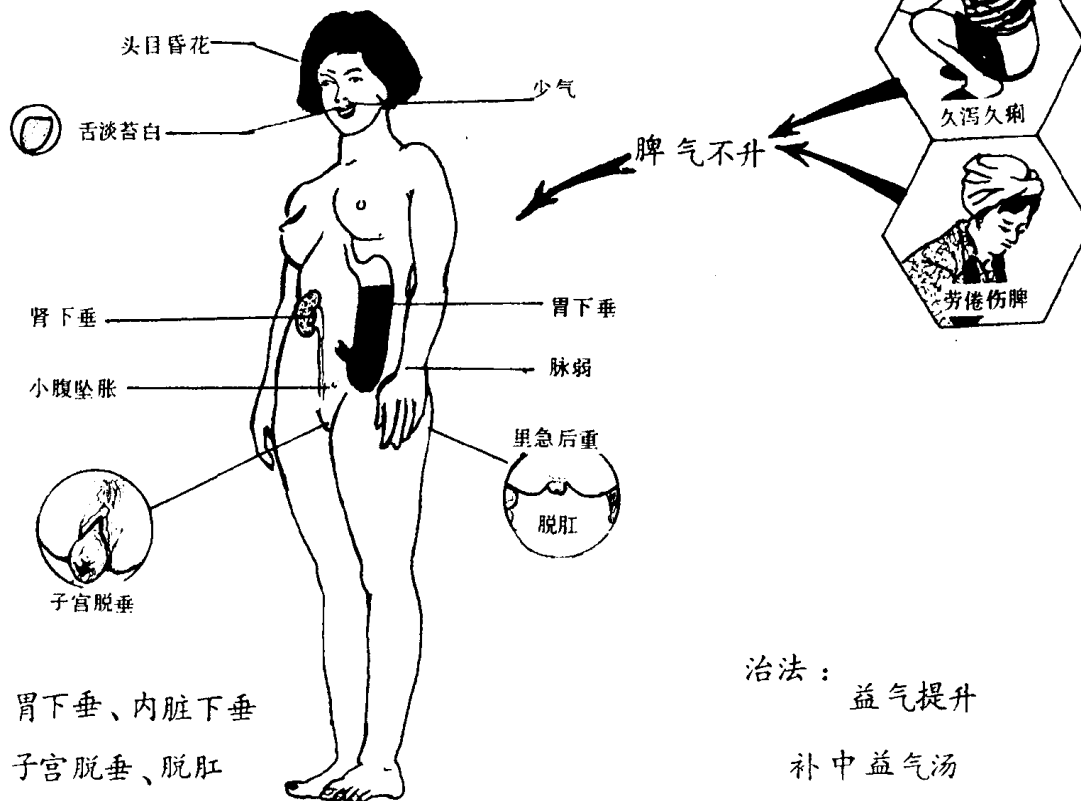


证见：溃疡病、慢性胃炎、慢性肠炎
胃肠功能紊乱、胃神经官能症
慢性肝炎、肠结核

治法：益气健脾
参苓白术散

脾病辨证(一)

脾气下陷



证见：胃下垂、内脏下垂
子宫脱垂、脱肛

治法：益气提升
补中益气汤

[脾虚水肿]

1. 主要证候:全身浮肿,腰以下较重,脘腹胀满,饮食减少,大便稀溏,小便不利,形寒肢冷,舌苔白滑,脉沉缓。2. 病因病机:中医学认为体内津液的生成、循环和排泄与现代医学水液代谢有相同处,也有不同处。不同的原因是理论体系的差异,若以现代医学为基础,“西为中用”来解释中医学的观点或术语,就可发现,这些不同点,其实是“术语”的不同。中医的津液靠胃的受纳,小肠的分清,脾的转输,肺的宣降,肾的气化,膀胱的贮藏、排泄和三焦的通调共同来完成,其中以脾、肾、肺三脏关系为重要。现代医学对水代谢研究极为透彻:人体每日饮水约 1.5L 左右,由胃受纳,进入小肠后,肠道各种消化液如胃液、胆汁、胰液、肠液分泌的水总量可达 8L 左右,这样大量的水除了随粪便(含少量约 150ml)排出外,绝大部分都被消化道所吸收。主要的吸收部位在小肠,大肠是继续吸收剩余水分。小肠吸收水分的主要力量,是肠上皮细胞吸收其他营养物质,特别是钠的主动吸收(钠泵)使上皮细胞内渗透压增加,从而促进了水的转移,这种肠上皮对营养物质和水分的吸收,中医称为“脾的运化”,当然还包括水的“输布”至全身各组织器官,因此脾失“运化”,即能引起水湿停滞发生水肿。这种因脾失健运的水肿称脾虚水肿或脾虚水泛。中医认为引起脾虚水肿的病因有二:① 久病伤脾:临床上慢性肾脏疾病、肝脏疾病、心脏病、营养不良等病程漫长,迁延日久,因而损伤脾阳,脾不健运,水湿外溢,从而引起全身浮肿,以腰以下为重。现代医学将全身性水肿,根据病因分为心源性水肿,见于各种心脏病引起的右心衰和慢性缩窄性心包炎;肾性水肿见于急、慢性肾炎,肾病综合征;肝病性水肿,见于肝硬化;营养不良性水肿,见于蛋白质和维生素 B₁ 缺乏。还有其他原因如妊娠中毒症,原发性醛固酮增多症……等水肿。② 饮食生冷,这可能是指饮食生冷易出现胃肠功能紊乱,引起脘腹胀满、腹泻症状而言。饮食生冷在西医看来不是引起全身浮肿的病因。

3. 治疗参考:温阳健脾行水,可用实脾饮加减。

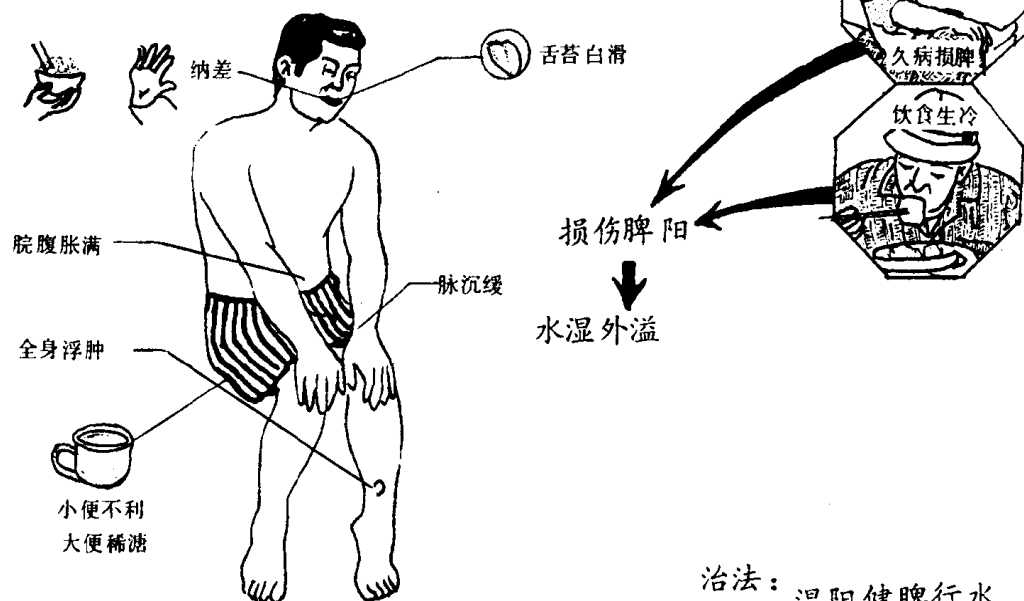
[脾不统血]

1. 主要证候:面色苍白,体倦乏力,少气懒言,食少腹满,月经过多,崩漏,便血,尿血,紫斑,舌质淡,脉细弱。

2. 病因病机:中医学认为:在生理状态下,脾能统摄或制约血液,使血液流行于脉管之中,而不溢出脉管之外,称为脾统血。如果脾的功能不足,则血液溢出脉管之外而造成出血,即所谓“脾不统血”。现代医学认为:引起多脏器出血的原因有三个:① 血管壁的异常,见于过敏性紫癜、单纯性紫癜、机械性紫癜、感染性紫癜(如流脑、出血热、败血症),等均由于血管壁扩张,脆性、通透性增加,红细胞溢出血管外所致。② 血小板异常,见于血小板破坏增加,如原发性血小板减少性紫癜,这确实与西医的脾相关,脾是产生抗血小板抗体和破坏血小板的场所,另外血小板生成减少,如再障、白血病等。血小板是维护血管壁完整、保持血管壁脆性正常和及时修复血管壁损伤的重要血液成分,当上述血小板数量和质量异常时,则出现多器官、组织的出血。③ 凝血功能异常,见于血友病(第Ⅸ,Ⅺ,Ⅷ因子缺乏)和严重肝病,维生素 K 缺乏所引起的纤维蛋白原和其他凝血因子形成障碍所致的出血。至于月经过多、崩漏,也见于内分泌功能失调所引起的子宫出血。病证中的面色苍白、体倦乏力、少气懒言、食少腹满等应是出血的后果,或同时出现。

3. 治疗参考:补气摄血,可用归脾汤或黄土汤加减。

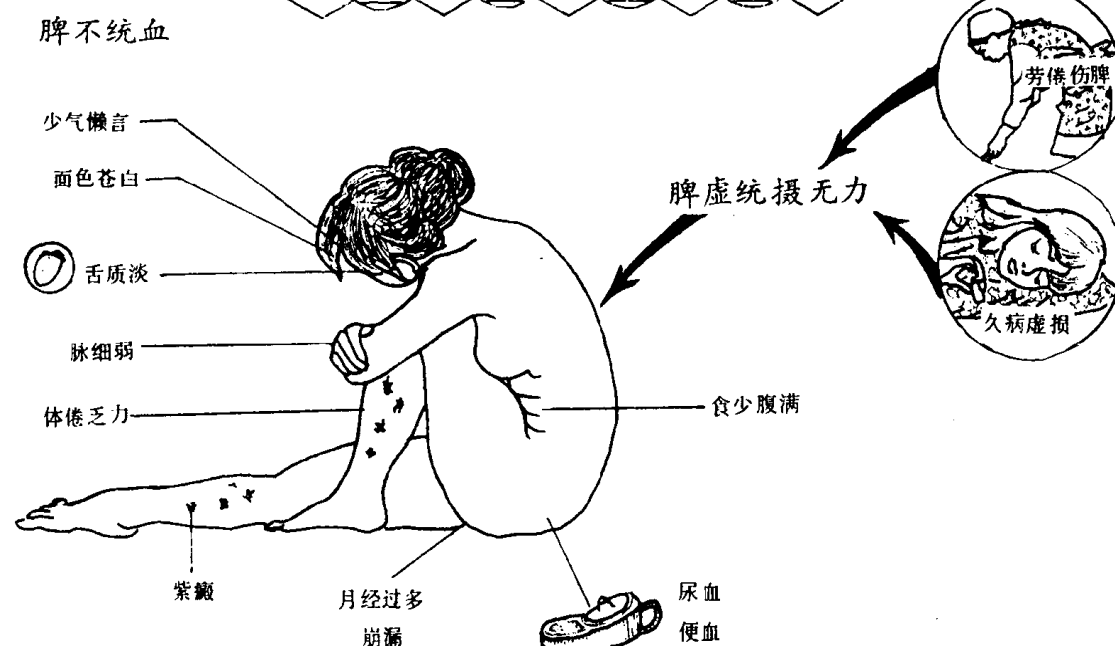
脾虚水肿



证见：肾性水肿、心性水肿、营养不良性水肿

治法：温阳健脾行水
实脾饮

脾病辨证(二)



证见：功能性子宫出血、血小板减少性紫癜
血友病、痔出血、过敏性紫癜

治法：补气摄血
归脾汤、黄土汤

第五节 胃病辨证

“胃为水谷之海”、“胃主腐熟水谷”，说明胃有容纳和消化食物的功能，食团进入胃后，受到胃壁肌肉的机械性消化和胃液的化学性消化，形成粥样食糜，逐渐地被推入小肠。胃有病时，既不能容纳食物，又不能腐熟水谷，则出现上腹饱胀，疼痛以及饮食不易消化等症状。经过胃的（从贲门开始向幽门方向）蠕动，将食团推入十二指肠，中医称为“胃气主降”，当呕吐中枢受到刺激或咽、舌根、胃、大小肠、胆总管和腹膜受到异常刺激时，胃壁可出现逆蠕动，中医称为“胃气不降”。此刻将出现恶心、呕吐、噎腐、噯气、呃逆（为膈肌痉挛）等症状。热性病时，因高热引起的口渴喜冷饮及糖尿病时出现烦渴多饮，中医都认为是胃中有热，热伤津液的表现，若病人有口臭、口腔炎、口腔溃疡、牙痛、齿龈出血或糜烂，中医认为是“胃火上炎”的表现。需要清胃火，滋胃阴。胃病常见证型如下。

〔胃火炽盛〕

1. 主要证候：胃脘灼热疼痛，渴喜冷饮，消谷善饥，呕吐，口臭，齿龈肿痛或溃烂出血，大便秘结，舌红苔黄，脉滑数。

2. 病因病机：中医学认为病因有三：① 邪热犯胃，本证可见于传染病的高热期，口腔炎、牙周炎、急性胃炎等病，病原微生物是引起高热，引起口腔炎、牙周炎、胃粘膜炎症的“邪热”。有人对 158 例胃肠疾病（慢性胃炎、胃十二指肠溃疡）调查，发现 102 例有口腔病变（口疮、慢性肥大性龈炎），糖尿病的口腔病征以牙周炎、龋齿等最为多见。② 情志不舒，溃疡病属于身心疾病，其发病与精神神经因素密切相关。③ 过食辛热之品，溃疡病的发作，急性胃炎、糖尿病加重都与饮食因素有关。上述病因导致热郁胃中，煎灼津液及胃热上蒸而出现相应证候。

3. 治疗参考：清泻胃火，可用清胃散加减。

〔胃寒证〕

1. 主要证候：胃脘疼痛，受寒加重，得暖则缓，呃逆，呕吐清水，舌苔白滑，脉迟。

2. 病因病机：病因有二：① 饮食不节：溃疡病、慢性胃炎在饮食失调时可使胃脘疼痛出现或加重，但前者有节律性，后者无节律性。两病在季节转换，或突然变寒时常加重。溃疡病合并幽门梗阻时，腹痛变为持续性，呕吐物多为隔餐或隔宿食物。② 贪凉饮冷，脘腹受寒，寒凝胃脘引起上述症候。

3. 治疗参考：温胃散寒，可用高良姜汤，或厚朴温中汤加减。

〔胃阴不足〕

1. 主要证候：口干唇燥，饥不欲食，或干呕呃逆，胃痛嘈杂，大便干结，舌红少津，脉细数。

2. 病因病机：此证多由温邪久羁，或肝火犯胃、内热伤阴所致，临床可见于热性病恢复期，溃疡病，慢性胃炎，胃神经官能症。

3. 治疗参考：滋养胃阴，可用益胃汤加减。

〔食滞胃脘〕

1. 主要证候：脘腹胀满或疼痛，噎腐吞酸，恶心，呕吐，大便秘结或泄泻，舌苔厚腻，脉滑。

2. 病因病机：本证多由① 饮食不节，如进食被细菌或细菌毒素污染的食物，常见有沙门氏菌、嗜盐菌、大肠杆菌、肠道病毒等。② 暴饮暴食，可见于急性胃扩张、急性胃肠炎。急性胃扩张早期有上腹胀及恶心，以后发生反胃性呕吐（内容物为深棕色混浊液体），腹部高度膨隆，弥漫性压痛及振水音阳性，可出现进行性脱水和尿闭，若不及时处理，可导致死亡。幽门梗阻以十二指肠溃疡者最常见，吐酸宿夜食物，上腹部膨隆，有振水音，中医认为上述病因引起食浊内阻，所致。

3. 治疗参考：消食导滞，可用保和丸加减。

胃火炽盛



证见：急性胃炎
口腔炎
牙周炎

治法：清泻胃火
清胃散

胃寒证

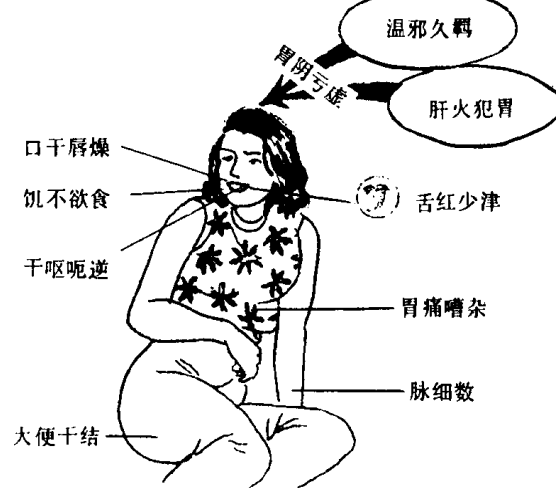


证见：胃炎
溃疡病
胃下垂
幽门梗阻

治法：温胃散寒
高良姜汤
厚朴温中汤

胃病辨证

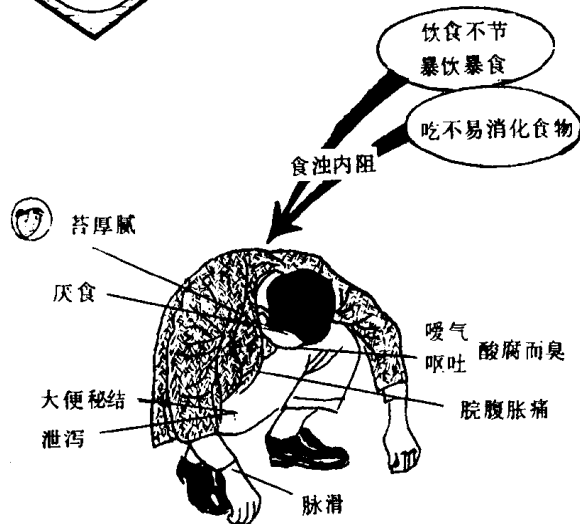
胃阴不足



证见：溃疡病
慢性胃炎
胃神经官能症
糖尿病
热性病恢复期

治法：滋养胃阴
益胃汤

食滞胃脘



证见：急性胃炎
胃扩张
急性胃肠炎
幽门梗阻
消化不良

治法：清食导滞
保和丸

第六节 肺病辨证

一、实 证

肺主气,司呼吸,主宣发肃降,通调水道,外合皮毛,开窍于鼻,与大肠相表里。肺有病时,肺气不降而上逆,则出现咳嗽、喘气。肺形成宗气不足为肺气虚,会出现气短,虚汗,易感冒。肺开窍于鼻,肺有病则出现鼻塞、流涕、鼻翼煽动等症状。肺病有虚实之分:实证有风寒束肺、热邪壅肺、痰浊阻肺、燥邪伤肺等。虚证有肺阴虚、肺气虚。

[风寒束肺]

1. 主要证候:咳嗽气喘,痰色稀白,口不渴,鼻塞,流清涕,或兼见恶寒发热,头身痛楚,苔薄白,脉浮紧。

2. 病因病机:此证多由外感风寒侵袭肺系所致。鼻塞、流清水样鼻涕、喷嚏、头痛、身痛、轻度畏寒、低热、伴有咳嗽、无痰或少量粘痰,为上呼吸道感染常见表现,其中由鼻病毒感染者为普通感冒。若由流感病毒引起者,则起病较急,症状较重,体温多在39℃以上,头痛,乏力,周身肌肉酸痛明显,为流感。急性支气管炎起病1~2天可有上呼吸道感染症状,但咳嗽较剧,痰为白色粘痰。慢性支气管炎患者,因机体和呼吸道抵抗力降低,较易感冒。患者以慢性咳嗽,咳白色泡沫痰为主要表现,合并感冒时,也出现鼻塞、流涕、恶寒、发热、头身痛楚等证候。

3. 治疗参考:宣肺散寒,方如杏苏散、华盖散加减。

[热邪壅肺]

1. 主要证候:咳喘息粗,咯吐黄稠痰,咽痛口渴,或见发热,微恶风寒,或胸痛,咳吐脓血腥臭痰,大便秘结,小便短赤,舌红,苔黄,脉浮或滑数。

2. 病因病机:恶寒发热,咳嗽,喘促,咳黄色脓性痰液,为化脓性扁桃腺炎,或气管、支气管、肺部细菌性感染的共同表现。也可见于急性热性病,如流感、麻疹合并支气管肺炎时,呈弛张热或高热不退,当病灶累及胸膜则有胸痛。支气管扩张,常以长期咳嗽、反复大量脓痰和咯血为主要表现。急性肺脓肿,起病急骤,寒战高热,开始即有咳嗽,咳少量粘液性或粘液脓性痰,伴有胸痛、脓肿破溃时,出现大量黄绿色脓痰,每日可达数百毫升,伴厌氧菌感染(占87%~94%)时痰液恶臭。上述诸病病因,中医概述为外感温热之邪或外感风寒,郁而化热,或热盛肉腐成脓所致。

3. 治疗参考:清宣肺热,止咳平喘,方如桑菊饮、麻杏石甘汤。肺痈宜清热解毒排脓,方用千金苇茎汤。

[痰浊阻肺]

1. 主要证候:咳嗽痰多,呈泡沫样或色白而粘,容易咳出,胸部满闷,喉中痰鸣,气短或气喘,甚则不能平卧,舌苔白腻,脉滑。

2. 病因病机:慢性喘息性支气管炎有咳、痰、喘、炎四大症状。痰量多,泡沫样或白色粘液样痰,可闻哮鸣音,诉胸闷,重者不能平卧,支气管扩张平时有咳嗽,咯痰,合并感染则痰量增多,日达数百毫升。阻塞性肺气肿多由慢性支气管炎、支气管哮喘等引起,原发病均有多年咳嗽、咳痰或喘息病史,呼吸困难为主要表现,活动时加重,严重者不能平卧。此证中医认为系因长期咳嗽,肺失宣降,肺津停聚为痰湿所致。

3. 治疗参考:燥湿,理气化痰,方如二陈汤合三子养亲汤。

[燥邪伤肺]

1. 主要证候:干咳少痰,痰粘难咯,或喘咳唾白沫,鼻燥咽干,咳甚则胸痛,舌干苔薄而少津,脉象细数,或兼有发热恶风寒、头痛等表证。

2. 病因病机:感冒和急性支气管炎早期均有畏寒、发热、头痛、干咳少痰,或痰粘难咯表现,急性支气管炎有胸骨后疼痛表现,中医认为是燥邪伤肺,津液受伤,故有干咳无痰、痰少而粘、口鼻舌干燥等少津表现。

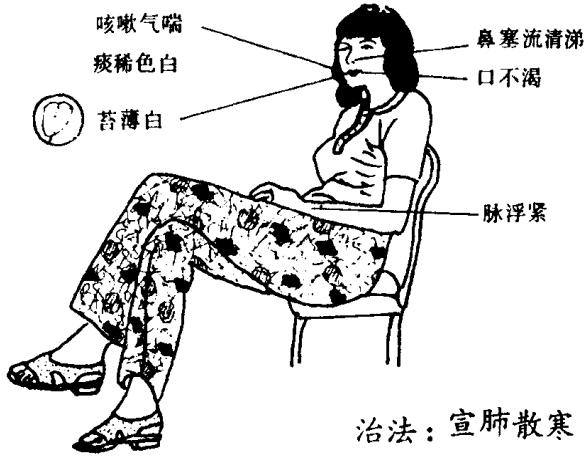
3. 治疗参考:清肺润燥,方如桑杏汤、清燥救肺汤加减。

风寒束肺



恶寒发热

外感风寒



治法：宣肺散寒

杏苏散
华盖散

证见：感冒
流感
急性支气管炎

热邪雍肺



恶寒发热

外感风热

风寒入里



证见：

急性支气管炎
感冒、流感
麻疹初起
肺炎
肺脓肿
支气管扩张

治法：清宣肺热
止咳平喘
桑菊饮
麻杏石甘汤
千金苇茎汤

肺病辨证(一)

痰浊阻肺



证见：慢性喘息性支气管炎
支气管扩张
肺气肿
结核性胸膜炎

治法：
燥湿理气化痰
二陈汤
三子养亲汤

燥邪伤肺



发热 恶风寒

感受燥邪



证见：感冒
急性支气管炎

治法：清肺润燥
桑杏汤
清燥救肺汤

二、虚 证

〔肺阴虚〕

1. 主要证候:干咳短气,痰少而稠,或咳痰带血,口咽干燥,声音嘶哑,形体消瘦,甚则午后潮热,五心烦热,盗汗,颧红,舌质嫩红少津,脉细数。

2. 病因病机:中医学认为,本证多因劳损所伤,或因久咳耗伤肺阴所致。潮热盗汗,午后颧红,手足心热,形体消瘦是结核病活动期全身中毒症状的表现。病人呈持续低热,体温常在中午以后逐渐上升,下午4~8点上升至高峰,于夜间或清晨通过出汗而退热,故称盗汗。在体温上升时常伴两颧潮红、手足心热等植物神经功能障碍的症状。由于长期发热,消耗,加之消化机能紊乱,胃纳欠佳,腹胀,便秘,胃酸分泌显著降低,营养状态低落,以致脂肪消耗、肌肉瘦弱而致形体消瘦,呈肺癆体型。病人还可有倦怠、乏力、疑虑、失眠、月经失调等诸多表现。肺部结核则出现呼吸道症状,有咳嗽,咳痰,常为干咳无痰或痰量甚少,当病变部位毛细血管受累,通透性增高时,则见痰中带血。重症开放型肺结核,结核菌常随痰液侵及支气管内膜和喉引起支气管内膜结核和喉结核。患者则有声嘶,干咳,累及咽,可有咽部不适,若咽结核形成溃疡,则有咽痛及吞咽痛。矽肺(从事石匠和粉尘作业)患者合并肺结核发病率甚高,中医所指“劳损所伤”,可能是指该职业史而言。矽肺合并肺结核时,肺结核病变发展往往加速,病灶易溶解形成空洞,病人咳嗽、咳痰重、消瘦、潮热、盗汗、咯血、气促等中毒症状进行性加剧。结核性支气管扩张,慢性支气管炎也可有肺阴虚型。上述证候中医认为是肺的阴津不足,失其清润肃降之机和热伤肺络来概括呼吸系统症状,以“阴虚失养,虚热内蒸”来解释结核中毒症状。

3. 治疗参考:滋阴润肺,或滋阴降火,方如百合固金汤加减。

〔肺气虚〕

1. 主要证候:神疲少气,咳喘无力,动则气短,声音低怯,自汗怕冷,面色苍白,舌质淡,苔薄白,脉虚弱。

2. 病因病机:本证多因久咳久喘耗伤肺气,或因气之化生不足,以致其主气的功能减弱所致。中医学认为肺的呼吸运动是由宗气来推动的。宗气是由肺吸入的清气与脾胃运化来的水谷之气结合而成,聚集于胸中。如《灵枢·邪客篇》说:“宗气集于胸中,出于喉咙,以贯心脉,而行呼吸焉”。宗气即此处所提到的肺气,是呼吸运动的原动力。现代医学的研究表明,呼吸运动是由膈肌和肋间肌的舒缩运动来完成的,它们的舒缩全靠膈神经和肋间神经的支配和控制。膈神经的运动神经元在颈髓,肋间神经的神经元在胸髓,切断动物的延髓和脊髓联系,动物的呼吸立即停止。动物实验与临床实践证明呼吸中枢位于延髓和脑桥,直接调节和控制人的呼吸运动,同时受大脑皮层的高级调节。除神经调节、控制以外,还有体液(血液中 CO_2 、 O_2 的含量和pH的改变)也参与调节呼吸机能。在病理状态下,如肺气肿时,肋骨上抬,膈肌下降,胸廓处于扩张状态,加之肺脏弹性下降也使呼吸运动明显受到限制,上述的诸多因素,中医均用“肺气”二字概括之。慢性支气管炎合并阻塞性肺气肿,重症肺结核和支气管哮喘等呼吸系统疾病只要使呼吸运动减弱,宗气不足,推动心脉无力则出现倦怠无力,面色苍白,脉虚弱。肺气虚亏,胸廓呼吸运动变小,则有呼吸气短,声音低怯,“肺气主降”,肺气不足则上逆,而出现咳嗽,喘气。

3. 治疗参考:补益肺气,方如四君子汤、补肺汤加减。

肺阴虚

潮热盗汗

午后颧红

干咳无痰

痰少而稠

有时带血

形体消瘦

舌质嫩红
无苔少津

咽干音哑

劳损所伤

结核感染

手足心热

脉细数

治法：滋阴润肺

百合固金汤

证见：肺结核

支气管扩张

慢性支气管炎

肺气虚

肺病辨证(二)

面色苍白

神疲气少

咳嗽无力

动则气短

痰多清稀

脉虚弱

自汗怕冷

舌质淡苔薄白

声音低微

久喘久咳

肺气生化不足

治法：补益肺气

四君子汤

补肺汤

证见：慢性支气管炎

肺气肿

肺结核

支气管哮喘

第七节 大肠病辨证

食物通过胃的消化、脾的运化、小肠的分清别浊,最后糟粕部分下降至大肠,在大肠内变成粪便而排出。如果大肠有病,则产生大便秘结或腹泻等症状。大肠与肺相表里,大肠的生理功能,常受到肺的影响,肺与大肠能通过经络相联系,婴幼儿呼吸系统感染时,常引起腹泻。而另一些肺部疾病,如哮喘,又往往引起便秘。大肠实证有大肠湿热,虚证有大肠津亏、肠虚滑脱等。

[大肠湿热]

1. 主要证候:腹痛,里急后重,下痢粘液脓血或果酱样便,或泻黄水,肛门灼热,小便短赤。或发热,口渴,舌苔黄腻,脉滑数。

2. 病因病机:本证的主要证候是腹痛,腹泻,发热。腹泻是指排便次数增多,大便性状稀薄,水样,或含粘液、脓血。根据起病急缓可分急性、慢性两类:急性腹泻指起病急骤,腹泻剧烈,或集体发生,或有流行病史,主要为肠道粘膜受细菌、病毒、原虫、肠毒素或其他有毒物质、高渗负荷,以及急性应激作用下引起肠粘膜器质性或功能性急性损伤所致,其疾病达百种以上,同时有腹痛,发热者为数也不少,以急性菌痢、阿米巴痢及病毒性、细菌毒素性胃肠炎为最多见,慢性腹泻系指腹泻超过2个月或反复发作,可由慢性肠道感染、肠道内疾病(如直肠癌表现酷似菌痢)和全身性疾病引起,其中也不乏有上述主要证候者,中医统称之为大肠湿热。

3. 治疗参考:清利湿热。方如葛根芩连汤或白头翁汤加减。

[大肠津亏]

1. 主要证候:大便干燥秘结,甚则如羊粪,难于解出,口干咽燥,头晕,口臭,舌红少津,苔黄燥,脉细。

2. 病因病机:大肠的主要机能是吸收水分,贮存食物残渣,形成粪便。大肠有蠕动和逆蠕动。大肠蠕动较弱,它从回盲部开始,向结肠肝曲蠕动,在这一段也常发生逆蠕动,称为“结肠分节运动”,有利于水和维生素B₁₂、K(由大肠细菌合成)吸收。大肠还有一种收缩强烈、推进较快的蠕动,叫集团蠕动,它从横结肠中段开始把粪便迅速推至乙状结肠和直肠。直肠内平时没有粪便,粪便通过集团蠕动进入直肠后,直肠壁感受器受到刺激,通过传入神经传至脊髓骶段初级排便中枢,同时也传至大脑皮层引起便意。引起便秘的原因甚多,如肠道梗阻或肠管蠕动减弱消失,或参加排便动作的肠壁肌、膈肌、腹肌、盆底肌张力减退,粪便向前推进力不足,见于多次妊娠、进食过少或食物少渣、肥胖、老年人、长期卧床等所致便秘以及急性菌痢恢复期、长期滥用灌肠或导泻药、因故经常忽视便意、抑制排便动作者都能产生便秘。便秘时,肠内有毒物质如酚、胺、吲哚等吸收,可引起头晕、口臭、舌红、苔黄燥等症状。

3. 治疗参考:润肠通便,方如增液汤或麻子仁丸。

[肠虚滑脱]

1. 主要证候:泻痢日久不愈,往往大便随矢气流出,甚则大便失禁,便后脱肛,食少神疲,腹部隐痛,喜温喜按,四肢不温,腰酸怕冷,舌淡苔薄,脉弱。

2. 病因病机:多见于久泻久痢,如慢性痢疾、慢性肠炎、过敏性结肠等。因腹泻日久,直肠粘膜的病变使直肠排便反射迟钝,肛门内外括约肌松弛或张力减退,以致出现大便失禁。肠壁粘膜或肛管、直肠以及肛提肌、盆底肌因炎症出现薄弱、松弛导致脱肛,中医认为是大肠气虚病久伤及脾肾,导致脾肾阳虚,固摄乏力和气虚下陷所致。

3. 治疗参考:温阳健中,涩肠固脱,方用养脏汤加减。

大肠病辨证

大肠湿热



发热口渴



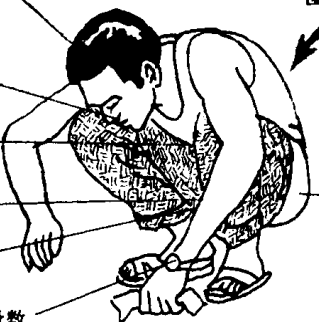
舌红苔黄腻

腹痛、里急后重

小便短赤

肛门灼热

脉滑数



湿热蕴结大肠

暑湿热毒之邪

饮食不洁
过食生冷

证见：

急性细菌性痢疾

阿米巴痢疾

急性肠炎

治法：清热利湿

葛根芩连汤

白头翁汤

大肠津亏

头晕口臭

口干咽燥



舌红、少津、苔黄燥

大便干结呈羊粪状
难于解出



脉细

老年人

妇女产后

热病后期

大肠津液不足

证见：

习惯性便秘

产后便秘

热病后期便秘

治法：润肠通便

增液汤

麻子仁汤

肠虚滑脱

食少神疲

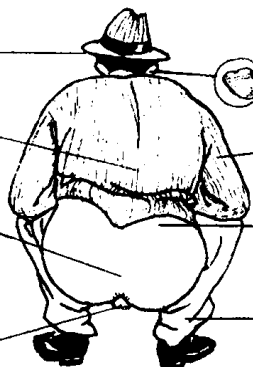
腹部隐痛

喜温喜按

泻痢日久不愈

大便随矢气流出
(大便失禁)

便后脱肛



舌淡苔薄

脉弱

腰酸怕冷

四肢不温

久痢久泻

脾肾阳虚

证见：

慢性痢疾

慢性肠炎

过敏性肠炎

治法：温阳健中

涩肠固脱

养脏汤

第八节 肾病辨证

肾为先天之本,其主要生理功能是藏精、主水、主骨、纳气,开窍于耳及二阴,其华在发,与膀胱相表里。所以肾的病变主要反映于肾精封藏不固,水液化谢失调,生长、发育、生殖的异常和肾精不足或年老肾衰时出现气短,稍一活动则见气促的“肾不纳气”现象和耳鸣、耳聋、腰膝酸软无力、牙齿动摇易脱落等诸多证候。肾病多虚证,有肾阴虚、肾阳虚、肾气不固、肾不纳气、肾虚水泛等证型。

〔肾阴虚〕

1. 主要证候:头晕,健忘,失眠多梦,耳鸣耳聋,腰膝酸痛,足跟痛,发落齿摇,两颧红赤,五心烦热,盗汗,口干咽燥。男子遗精或不育,女子崩漏或闭经不孕,舌红,脉细数。

2. 病因病机:肾阴虚,又称肾水不足,肾阴为一身阴液之根本,有滋养形体脏腑、生髓充骨养脑、抑制阳亢火动、维持正常生长发育、生殖等机能活动。本证多因①房事不节,耗伤肾精;②久病伤肾;③失血伤津;④过服温燥劫阴之品;⑤情志内伤,暗耗肾阴所致。

神经官能症是临床上最常见的疾病之一,病者以青壮年为多,常因各种精神因素引起高级神经活动过度紧张,使大脑功能活动暂时性失调所致。临床表现多种多样,可涉及全身的器官与系统,主要的神经精神症状为头晕、健忘、失眠、多梦、情绪不稳、烦躁易怒、焦虑、疑病、抑郁等,也可表现于植物神经功能紊乱,如心动过速、血压偏高、偏低、面赤或两颧红赤、手足心热或发凉、呼吸急促或出气不畅、食欲不振、腹胀、便秘或腹泻,以及男性梦遗、早泄、阳痿、女子月经不调等表现。现代医学强调神经官能症的诊断,必须完全排除器质性病变之后方能作出。因为,许多躯体性疾病如早期高血压、脑动脉硬化、脑肿瘤、早期精神分裂症、脑外伤后遗症、早期肺结核、甲亢、更年期综合征、红斑狼疮等均可出现神经衰弱症状群,故肾阴虚在临床上可见于诸多疾病,中医在接待这类病例上也是辨证施治的。

3. 治疗参考:滋补肾阴,方如六味地黄丸加减,或滋阴降火方如知柏地黄丸加减。

〔肾阳虚〕

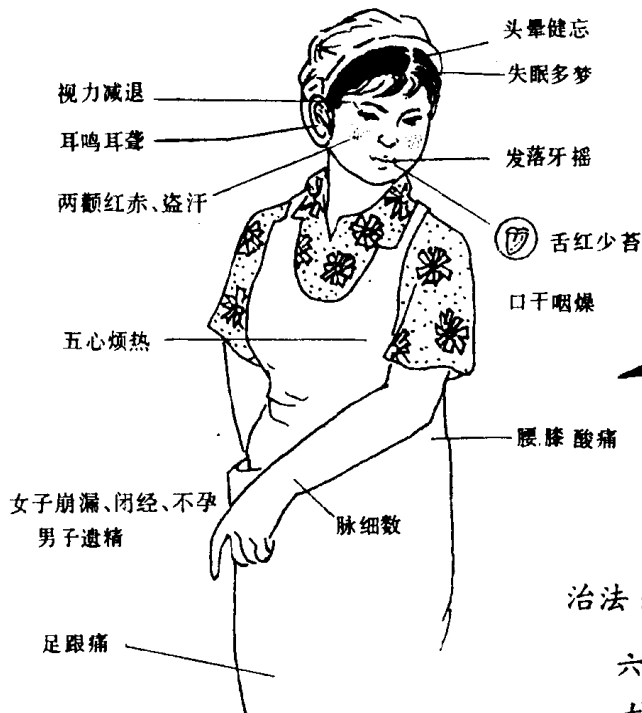
1. 主要证候:面色淡白,头昏耳鸣,神疲健忘,形寒肢冷,手足不温,腰膝酸软,自汗,阳痿,不孕,苔白质淡,脉沉迟而弱。

2. 病因病机:肾阳虚,又称命门火衰,肾阳为一身阳气之根本,具温煦形体,卫阳固表,蒸化水液,促进发育、生殖等功能。肾阳虚衰,则温煦失职;气化无权,则出现形寒肢冷,面色淡白,神疲健忘及性机能衰减,出现阳痿、不孕等病症。

内分泌系统和神经系统紧密联系,协同调节人体的物质代谢、生长、发育、生殖过程,以及其他许多的生理机能,使机体能适应复杂的不断变化的内外环境而生存、成长。本证所表现的一系列证候,可在现代医学中内分泌系统的功能减退症和神经衰弱症中见到。如腺垂体功能减退症,由于甲状腺分泌减少,表现新陈代谢率下降,而有面色苍白,表情淡漠,形寒肢冷,音调低钝,精神不振,反应迟钝。由于肾上腺皮质功能减退,表现为虚弱无力,脉搏细弱,血压偏低,抵抗力低下,面容、乳晕苍白。由于性腺分泌减少,女子出现长期闭经,外阴、子宫萎缩,男子表现性欲下降、睾丸萎缩、体力衰弱、疲乏无力等,腺垂体功能减退症的临床表现为腺垂体所调节的靶腺如性腺、甲状腺、肾上腺皮质等继发性功能减退的症状。因而在肾上腺皮质功能减退症、甲状腺功能减退症,以及性神经衰弱的患者均可有肾阳虚的证型。

3. 治疗参考:温补肾阳,方如金匱肾气丸或右归饮加减。

肾阴虚



耗伤肾阴

证见：神经衰弱
神经性耳聋
结核病、糖尿病
红斑狼疮
高血压
尿崩症
无排卵性功能性子官出血
闭经
不孕症

治法：滋补肾阴

六味地黄丸

左归丸

肾病辨证 (一)

肾阳虚



损伤肾阳

证见：肾上腺皮质功能减退
甲状腺功能减退
性神经衰弱
慢性肾炎
支气管哮喘
糖尿病
尿崩症
遗尿

治法：温补肾阳

金匱肾气丸

右归饮

〔肾气不固〕

1. 主要证候：神疲，腰膝酸软，小便频数而清，尿后余沥，或尿失禁，遗尿，夜尿频多，男子滑精、早泄，女子白带清稀，胎动易滑，舌淡苔黄，脉沉弱。

2. 病因病机：肾与膀胱互为表里，肾形成尿液，下注于膀胱贮藏。中医学认为：没有肾的“气化”，膀胱是不能主动排泄尿液的。当肾气不固，膀胱失约，则出现小便失禁、尿后余沥、夜尿、遗尿、尿频等症。现代医学的研究表明：尿失禁可分以下几种类型：① 充溢性尿失禁，多由于前列腺肥大造成尿路梗阻，膀胱充盈膨胀，当膀胱内压升高大于尿道括约肌阻力时，出现尿滴沥，膀胱无法排空，多见年事已高的男性。② 无阻力性尿失禁，多由于尿道括约肌弛缓或麻痹，使膀胱丧失了贮尿功能，站立位即可有尿液流出，见于经产妇分娩时损伤了尿道括约肌或腹下神经（也可由糖尿病引起神经病变，腹下神经为交感神经，正常时，其兴奋使逼尿肌松弛，尿道括约肌收缩而贮尿）。③ 反射性尿失禁，由于完全性上神经元病变（如脑溢血，脑外伤，截瘫），排尿依靠初级排尿中枢（腰骶髓）控制，出现尿潴留，当膀胱充盈到一定程度时出现反射性、不自主排尿。④ 急迫性尿失禁，由于部分上神经元病变或膀胱有炎症、肿瘤、结核等，使膀胱的逼尿肌收缩功能亢进。临床上出现尿频、尿急、夜尿频多、排尿不畅等症状。⑤ 压力性尿失禁，病因较复杂，在任何增加腹压（如咳嗽，喷嚏，上坡，跑步）情况下出现尿液流出。上述情况中医统归为肾气不固，“膀胱失约”。遗尿多指睡时不能控制排尿而言，3岁以内幼儿的遗尿多为生理性的，嗣后高级神经逐渐发育，大脑中枢开始能控制。绝大多数男性早泄、遗精属于神经官能症的临床表现。滑精指阴茎勃起、准备性交时尿道外口流出无色透明尿道分泌物或无性交活动情况下，睡眠中无梦自遗，前者多为生理性的，后者可由前列腺或精囊的慢性炎症所引起。清稀白带产生的原因较多，如慢性子宫颈炎、结核性子官内膜炎、老年性阴道炎或子宫肌瘤等均可见浆液样或粘液样白带增多。中医学将上述生殖系统表现，统归为“肾失封藏固摄”或“精关不固”所致。

3. 治疗参考：补肾固摄，方如秘精丸，金锁固精丸。

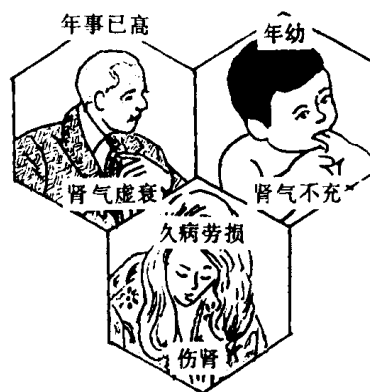
〔肾不纳气〕

1. 主要证候：呼多吸少，短气，喘促，动则喘甚，腰膝酸软，声低气怯，咳逆汗出，四肢不温，面部虚肿，舌淡，脉虚浮。

2. 病因病机：中医有“肺主呼气，肾主纳气”的说法，认为呼吸虽为肺所主，但吸入之气，必须下及于肾，由肾气为之摄纳，若久病或过度房劳损伤肾气，则气失摄纳出现呼气性呼吸困难为主的临床证候。呼气性呼吸困难以呼多吸少和阻塞性肺气肿为特征，临床上多由于呼吸道的感染、变态反应、理化因素刺激，使细支气管粘膜充血、水肿、分泌增多，支气管平滑肌痉挛收缩使细支气管管腔发生不完全性阻塞。当吸气时支气管舒张，空气进入肺泡较容易。呼气时支气管管腔缩小，气体排出困难。吸入与呼出不平衡，气体滞留于肺泡，导致肺泡过度充气而膨胀，多见于慢性支气管炎、支气管哮喘、支气管扩张、尘肺等慢性呼吸系统疾病引起，长期咳嗽或反复哮喘发作，使肺内压升高，肺泡弹性下降，形成慢性阻塞性肺气肿。病人开始时仅在劳动或登山、上楼时发生呼吸困难，随病情发展，在一般劳动、走路、说话时也发生。在受寒、气候变化、生气、饮酒后症状加重，继发呼吸道感染时，咳喘气促，严重时可出现右心衰竭，出现浮肿、四肢不温、不能平卧等证候。中医认为是肾虚阳衰、卫表不固或阳气不能化水行气所致。

3. 治疗参考：温肾纳气，可用人参胡桃汤或参蛤散加减。

肾气不固



证见：慢性肾炎

性神经官能症

糖尿病

尿崩症

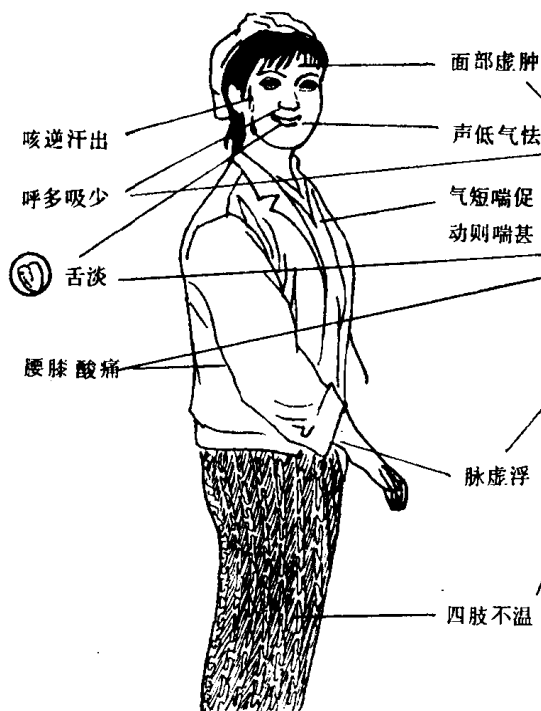
治法 补肾固摄

秘精丸

金锁固精丸

肾病辨证(二)

肾不纳气



气失摄纳

肾虚阳衰

证见：肺气肿

支气管哮喘

慢性心功能不全

治法：温肾纳气

人参胡桃汤

[肾虚水泛]

1. 主要证候:周身浮肿,下肢尤甚,按之没指,腹胀满,尿少,腰酸痛,或见心悸,气促喘咳痰鸣,苔白质淡,舌体胖,脉沉细。

2. 病因病机:中医的肾与西医的肾具有不同的概念与内容:西医的肾,是泌尿系统的主要器官,具有形成尿液、排出有害或无用的终末产物和调节、维持体内水盐平衡的生理功能;而中医的肾,除形成和排泄小便外,尚有更广泛的生理功能,涉及人体的生长发育、生殖繁衍,甚至与呼吸、循环、消化功能相关。中医认为:人体的水液通过胃的受纳,脾的传输,肺的敷布,通过三焦(水的通道)清者运行至脏腑,浊者化为汗和尿液排出体外,无一例外地需要肾气作用。肾是胃的“关口”,肾能根据胃饮入水量的多少来调节尿液的排出量。一般来说:饮得多,尿量也多;相反,饮水少,排尿也少。按现代医学观点,饮入的水通过胃的受纳,在胃内吸收的水很微量,主要在肠道内吸收,中医称为“脾的传输”。水进入血循环,流经肺循环而至全身,中医称为“肺的敷布”和“通过三焦”。在流经肾小球时,由于有效滤过压的关系,血液中的水和水分子物质透过滤过膜形成原尿,肾小球每分钟生成原尿为120ml,一昼夜原尿总量达170~180L左右,其中99%的水分在肾小管内被重吸收(60%~70%在近曲小管,10%在髓袢,10%在远曲小管,10%~20%在集合管被重吸收),只有1%(1500ml/日)左右随尿排出。若体内水分过多,肾小球滤过增加,肾小管重吸收减少,则尿量增多,尿比重低而色淡,这就是肾的稀释功能。若体内缺水,则远曲小管和集合管对水的重吸收增加,尿量减少而色深,此为肾的浓缩功能。这种肾脏对水和电解质的调节是受两种激素调节:①受下丘脑-垂体后叶分泌的抗利尿激素调节,该激素作用于远曲小管和集合管增加对水的重吸收,使尿量减少,尿液浓缩;当抗利尿激素分泌减少时,则尿量增多变稀。②受肾上腺皮质球状带分泌的醛固酮调节,醛固酮能促进远曲小管重吸收钠,水分是被动的回吸收,可见,此处所指的“肾气”包括了上述诸环节和功能。因此肾虚水泛的全身性浮肿,不仅包括现代医学的肾性水肿,还包括心性水肿和营养不良性水肿,分述如下:

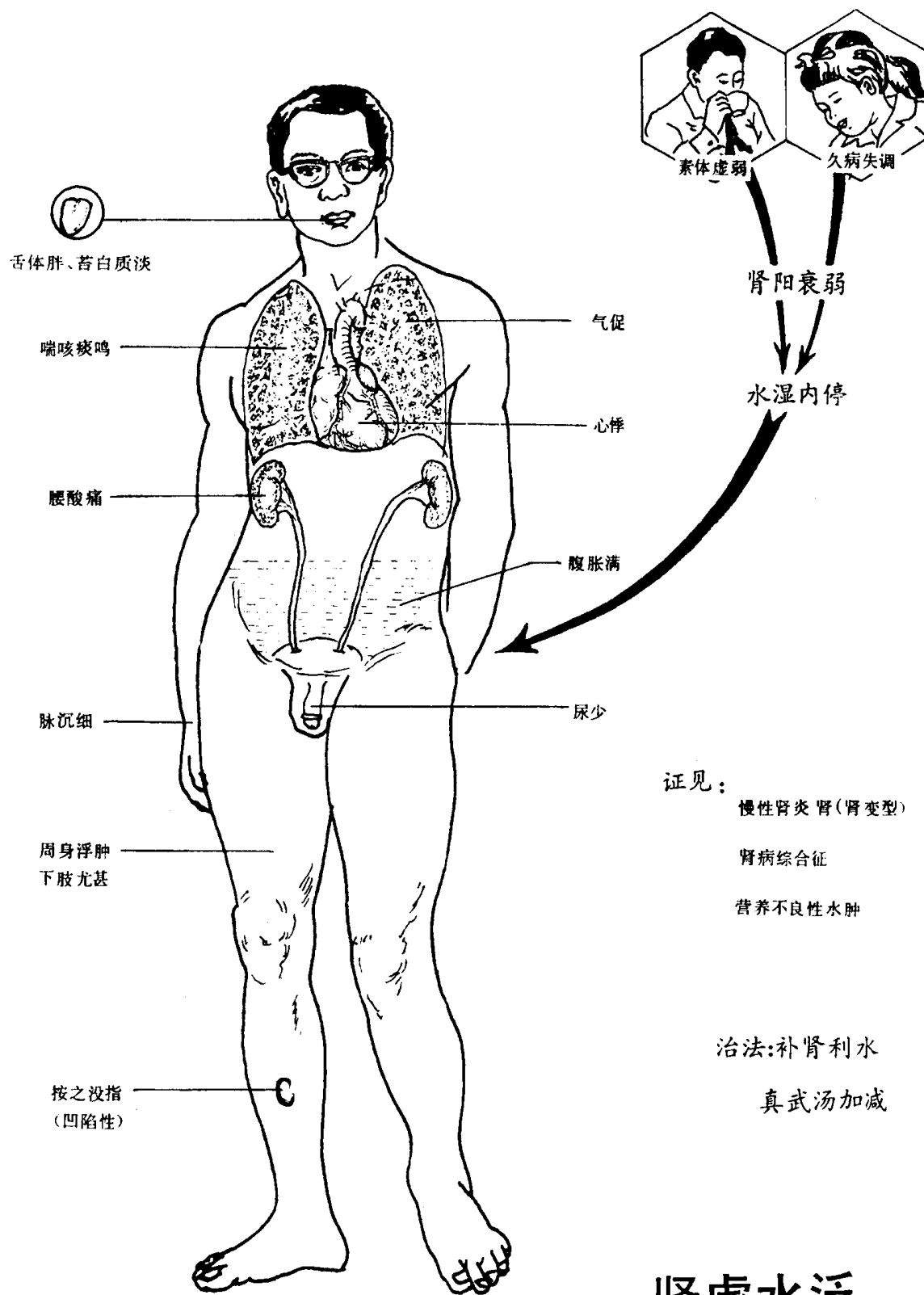
(1) 肾性水肿:临床上见于急性肾炎、慢性肾炎、慢性肾盂肾炎和肾病综合征,其特点为水肿发生较快,常从眼睑、颜面等处开始,然后蔓延全身,严重者可有胸水、腹水。水肿液软而易移动,手按之没指呈凹陷性,常伴有腰酸痛、少尿、血压升高和尿液改变(血尿、蛋白尿、管型尿)。

(2) 心性水肿:临床上见于各种病因的心脏病,右心衰或全心衰。右心衰最常见为肺心病、病人多有慢性咳喘病史,心衰时心悸气促加重,继发于左心衰的全心衰病人,因有肺瘀血也有咳嗽、咳痰或咯血症状及心慌气促表现,其特点为水肿由下垂部位开始,以后蔓延至全身,水肿移动小,手指压也呈凹陷性,常伴有颈静脉怒张、肝肿大和心脏杂音等体征。

(3) 营养不良性水肿:多由于长期营养不良或消耗性疾病如重症肺结核、糖尿病引起。患者晨起眼睑、颜面水肿,傍晚其下垂部位浮肿也明显。重症肺结核者原有慢性咳喘史,糖尿病患者因抵抗力低下,呼吸道感染极为常见,这些患者测定血浆白蛋白明显低下。

3. 治疗参考:温阳利水,方用真武汤加减。

肾病辨证 (三)



肾虚水泛

第九节 膀胱病辨证

〔膀胱湿热〕

1. 主要证候：尿频、尿急、尿痛、尿道有灼热感，小便困难，排尿中断，尿色混浊或尿血，或有砂石，小腹胀满或腰部绞痛，舌苔黄腻，脉滑数。

2. 病因病机：膀胱湿热，临床上可见于泌尿系感染，泌尿系结石，泌尿系肿瘤。现分述如下：

(1) 泌尿系感染：由于肾盂、输尿管、膀胱、尿道、前列腺、尿道旁腺的细菌或寄生虫感染，使尿路粘膜发生炎性病变。细菌性感染：特异性的细菌为结核菌。非特异性细菌 60%~80% 由革兰氏阴性杆菌（如大肠、副大肠杆菌、产气杆菌、变形杆菌、绿脓杆菌）及链球菌、葡萄球菌等引起，偶见真菌、原虫、滴虫和病毒。下面扼要叙述肾盂肾炎、肾结核、膀胱尿道炎及前列腺炎：

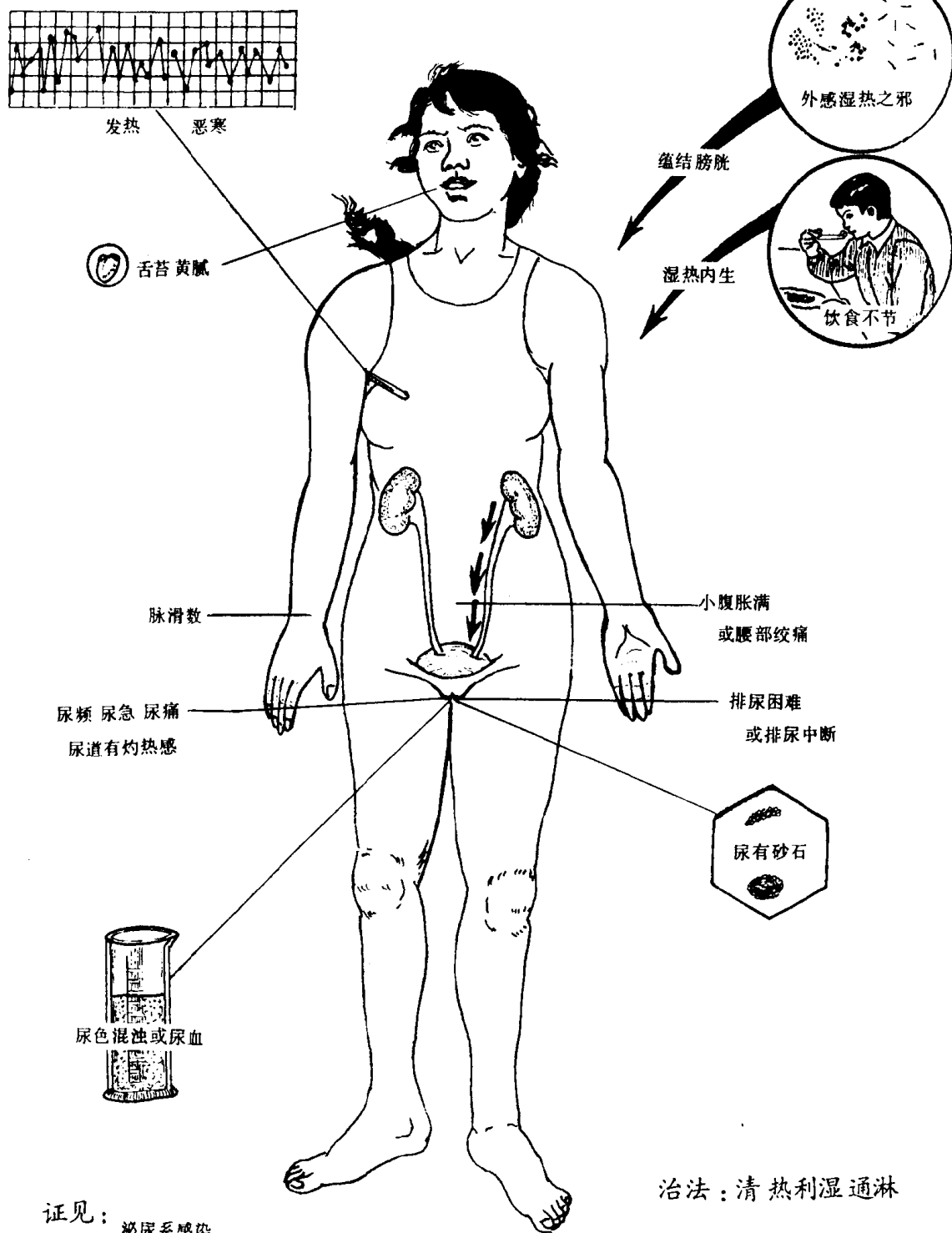
① 急性肾盂肾炎：患者多有畏冷、发热、腰痛，继而出现尿频、尿急、尿色混浊或脓尿，急性肾盂肾炎伴血尿者约 8%，慢性肾盂肾炎只占 2%。当炎症坏死组织堵塞输尿管时可出现肾绞痛。② 肾结核：发病年龄以 20~40 岁最多见。男性约为女性的 2 倍。50%~80% 的男性肾结核患者有副睾结核。首发症状最常见为尿频（78.9%）、血尿（77.6%）和尿痛（46.3%），并且呈进行性加重，几乎所有病例都有低热、盗汗、衰弱、贫血等全身结核中毒症状。③ 膀胱尿道炎：以女性最常见，由于女性尿道短而直，距肛门近，局部湿润，极易污染。女婴使用尿片未及时更换，新婚或生育期妇女与不洁性交有关，绝经期妇女由于雌性激素分泌下降，尿道粘膜萎缩和阴道酸性度降低有关，病原体以大肠杆菌、葡萄球菌、链球菌或淋球菌感染多见，大多数为急性，也可呈慢性急性发作，主要表现为脓尿、尿频、尿急、尿痛、尿道灼热感，很少有腰痛。④ 前列腺炎：成年男性较常见。本病多呈慢性经过，也可呈急性发作。急性发作者有畏寒、发热、脓尿，若炎症波及膀胱三角区，则出现明显的尿急、尿痛症状，作直肠指诊和按摩，前列腺液检查有助于确诊。

(2) 泌尿系结石：① 肾、输尿管结石是临床常见疾病，可见于任何年龄，但以 20~50 岁多见，男性多于女性，典型表现为一侧肾区突发性绞痛，呈刀割样，沿输尿管向会阴和同侧大腿内侧放射。发作期或发作后常有血尿。常伴有膀胱刺激征，尤以输尿管下 1/3 段的结石为明显。② 膀胱结石或尿道结石：多由肾输尿管结石下降而来，也可原发于膀胱或尿道，老年和 10 岁以下儿童多见。患者有明显的尿急、尿频、尿痛，伴有耻骨上或会阴部钝痛或剧痛，结石损伤粘膜则有终末血尿，有时出现尿流中断、排尿困难或尿道排出结石。

(3) 泌尿系肿瘤：临床上比较少见，① 肾癌肾盂癌，可见于 40 岁以上中老年人。男性多于女性，典型症状为无痛性全程血尿，量较少，持续约 1~2 天，呈间歇性，半数以上有持续性腰部钝痛，当血块堵塞输尿管也可呈绞痛，部分病人腰部可触及包块。② 膀胱肿瘤较常见，绝大多数为上皮细胞性肿瘤，多见于 40~60 岁的中老年患者。男性多于女性。主要表现为间歇性或持续性血尿，晚期由于肿瘤增大或继发感染可引起膀胱刺激征，堵塞尿道出现排尿困难。

3. 治疗参考：清热利湿通淋，方用八正散加减。

膀胱湿热



证见：
泌尿系感染
泌尿系结石
急性前列腺炎

治法：清热利湿通淋

八正散

膀胱病辨证

第十章 六经辨证

第一节 三阳阶段

六经辨证是东汉(公元 25~220 年)张仲景所著《伤寒杂病论》中对外感热病的辨证论治的纲领。它将外感病的发生发展过程中具有普遍性的证候,以阴阳为纲分为两大类病证,并根据临床表现的病变特点,又划分为六个证型:太阳病、阳明病、少阳病,合称三阳;太阴病、少阴病、厥阴病,合称三阴。以此说明病变部位、性质、正邪盛衰、病势趋向,以及六类病证之间的传变关系。三阳病证以六腑病变为基础。三阴病证以五脏病变为基础。实际上,六经病证基本上概括了脏腑十二经的病变。但由于其重点是分析外感寒邪所引起的病理变化和传变规律,所以其范畴较脏腑辨证要狭窄得多。

六经辨证从病变部位分,太阳病主表,阳明病主里,少阳病主半表半里。而三阴病统属于里。从邪正的关系分,三阳病多实,三阴病多虚。在治疗原则上:三阳病重在祛邪,三阴病重在扶正。因此,六经辨证,既是区分证候的纲领,又是论治的准则。

[太阳病证]

太阳主一身之表,统摄营卫,具有防御病邪侵袭的能力。

主要脉证为恶寒,发热,头颈强痛,脉浮。由于患者的体质强弱不同,病邪性质和感邪的轻重也不一样,所以太阳病证的临床表现也不尽相同,临床上分为太阳中风和太阳伤寒两种证候:

(一) 太阳中风证 风邪袭表,又称表虚证。

1. 主要证候:头痛,发热,汗出,恶风,脉浮缓。
2. 治疗参考:解肌驱风,调和营卫,方如桂枝汤。

(二) 太阳伤寒证 寒邪袭表,又称表实证。

1. 主要证候:恶寒发热,头颈强痛,身疼腰痛,骨节疼痛,无汗而喘,脉浮紧。
2. 治疗参考:发汗解表,宣肺平喘,方如麻黄汤。

[阳明病证]

阳明病证是正邪斗争的极期阶段。阳明经属胃和大肠。阳明主燥,所以外邪传入阳明胃肠多化燥化热,表现阳亢热极的证候。由于体质差异和邪气侵犯的部位不同,所以阳明病有经证、腑证之分。

(一) 阳明经证 太阳病已罢,邪气入里化热。

1. 主要证候:身大热,汗大出,口大渴,脉洪大(四“大”症为其特点),不恶寒,反恶热,面赤气粗,心烦燥扰,舌苔黄而干。

2. 治疗参考:清热生津,方用白虎汤。

(二) 阳明腑证

1. 主要证候:便秘,腹满痛,拒按,身热,午后潮热,烦燥谵语,甚则神志不清,或循衣摸床,舌苔黄燥或苔焦黄起芒刺,脉沉实有力。

2. 治疗参考:荡涤燥结,方如大承气汤。

[少阳病证]

少阳病证是邪气未除正气已虚,病邪内侵,结于胆腑,邪正分争于表里之间,又称半表半里证。

1. 主要证候:寒热往来,胸胁苦满,不欲饮食,目眩,口苦咽干,舌苔白,脉弦。
2. 治疗参考:和解表里,方如小柴胡汤。

六经辨证 (一)

太阳病证

中风证

风邪袭表

发热恶风

汗出

头痛

脉浮缓

治法：解肌驱风
调和营卫

桂枝汤

伤寒证

寒邪袭表

发热恶寒

无汗而喘

头颈强痛

脉浮紧

骨节疼痛

治法：发汗解表
宣肺平喘
麻黄汤



阳明病证

阳明经证

身大热（不恶寒 反恶热）

汗大出

口大渴

面赤心烦

舌苔黄燥

脉洪大

治法：清热生津
白虎汤

阳明腑证

午后潮热

舌苔黄燥、或苔焦黄起芒刺

烦燥谵语、或循衣摸床

腹满痛、拒按

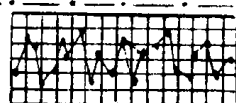
便秘

脉沉实

治法：荡涤燥结
大承气汤



少阳病证



寒热往来

胸胁苦满

心烦喜呕

目眩

食欲不振

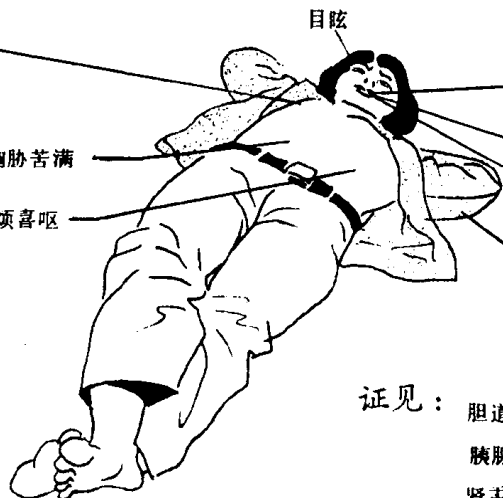
舌苔白

口苦咽干

脉弦

治法：和解表里
小柴胡汤

证见：胆道感染
胰腺炎
肾盂肾炎



第二节 三阴阶段

〔太阴病证〕

太阴为三阴之屏障,病入三阴,太阴首当其冲。太阴病主要是脾的寒湿证,病变在里。多因三阳病治疗失当而引起,也有外邪直接侵犯的。

由于是太阴脾与足阳明胃,同居中焦,又互为表里,经脉维系,脏腑沟通,其病变在一定条件下可以互相转化,而有虚实之分。腹满而痛,是太阴、阳明共有症状;太阴之腹痛,时作时止,喜温喜按,属虚。阳明为腹满硬痛,持续不减,拒按,属实。故有“实则阳明,虚则太阴”之说。

1. 主要证候:腹满呕吐,食欲不振,腹泻,口不渴,腹痛阵发,喜温喜按,舌淡苔白,脉迟或缓。

2. 治疗参考:温中散寒,方如理中汤。

〔少阴病证〕

少阴病是心肾两脏功能衰退性病变,可由他经传来,也可直中。少阴经内连心肾,心为火热之脏,属阳。肾为寒水之脏,属阴。因之邪犯少阴,即可从阴化寒,又可从阳化热。

(一) 少阴寒化证

1. 主要证候:恶寒蜷卧,精神萎靡,手足厥冷,下利清谷,欲吐不吐,口不渴或渴喜热饮,小便清,舌淡苔白,脉沉微。

2. 治疗参考:回阳救逆,方如四逆汤。

(二) 少阴热化证

1. 主要证候:心烦不寐,口燥咽干痛,小便黄,舌尖红赤,或舌绛少苔,脉细数。

2. 治疗参考:滋阴降火,方如黄连阿胶汤。

〔厥阴病证〕

厥阴为阴之尽,阳之始,阴中有阳。病至厥阴,为疾病最后阶段。由于正气衰竭,阴阳调节紊乱,因此证候比较复杂,表现为寒热错杂,厥热胜复。若阴寒由盛转衰,阳气由虚衰而转复,则病情好转。若阴寒盛极,阳气不续而先绝,则病情重笃而垂危。

1. 主要证候:口渴不止,饥而不欲食,寒热错杂,四肢厥冷,心下剧痛,呕吐蛔虫,舌苔白腻,脉弦数。

2. 治疗参考:调理寒热,和胃安蛔,方如乌梅丸。

六经的传变——根据上述划分的六个病证发展变化,可分为表里传变和并合传变两种类型。

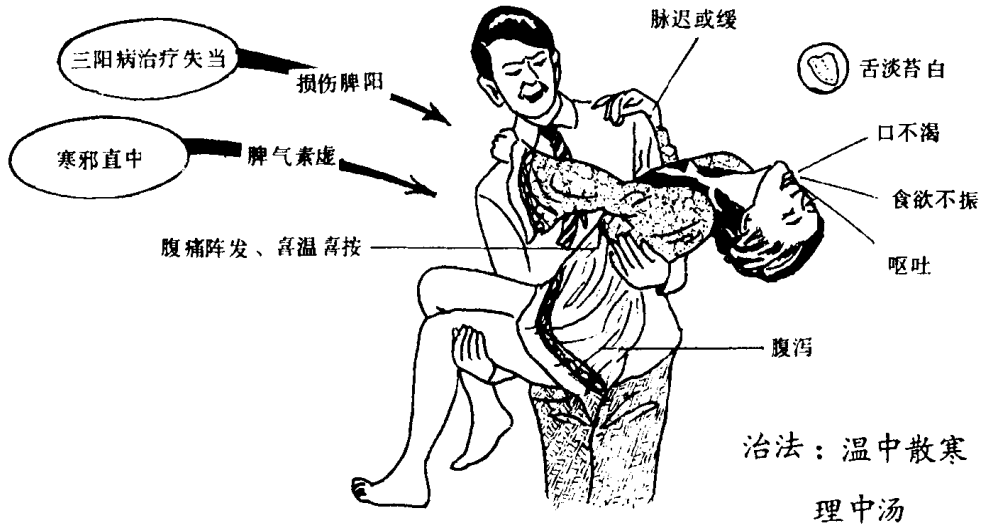
(1) 表里传变:包括循经传和越经传。① 循经传:太阳病证,如向里发展则传入阳明,阳明病证如向燥发展,可传至少阴,如向湿和寒证转化,可转入太阴或少阴。太阳病证也可向寒热错杂证发展,可以由少阳到厥阴。所以说少阳和厥阴是单独的证候类型,形成上述不同的传变,主要取决于体质强弱、外邪的质量的多少,以及治疗情况。② 越经传:就是不按原来太阳、阳明、少阳顺序传变。从太阳直传入少阴或不经三阳,直接出现三阴病证,称为“直中”。

(2) 并合传变:包括“并病合病”和“寒热错杂”。

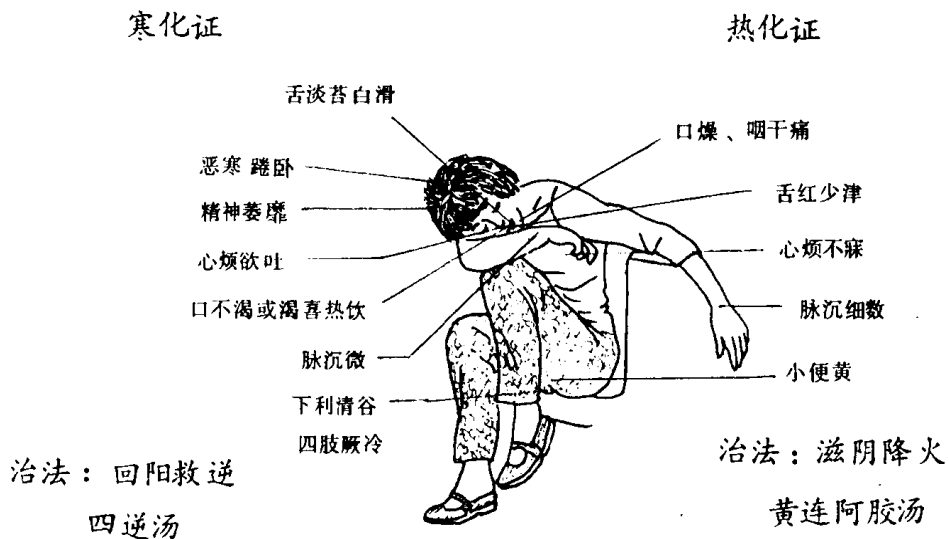
① 并病合病:并病是指一经的证候尚未消失,而另经证候已经出现,如太阳和阳明并病。合病是指两经或三经证候同时出现,如三阳合病。② 寒热错杂主要表现在少阳和厥阴阶段。由于寒热错杂,其证候常是虚实互见。

六经辨证 (二)

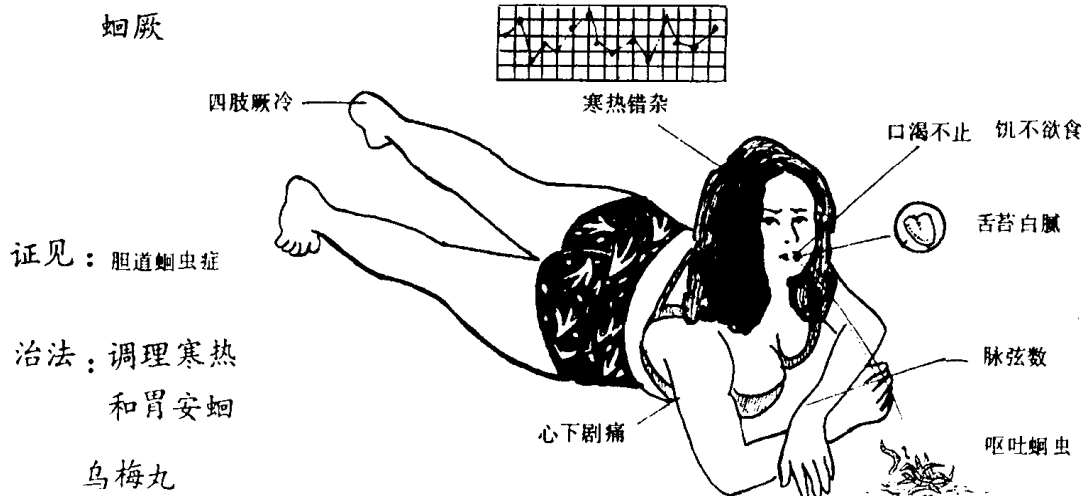
太阴病证



少阴病证



厥阴病证



第十一章 卫气营血辨证

第一节 卫分证、气血证

卫气营血辨证,是清代叶天士(1667~1746)所倡导,用于外感温热病的一种辨证纲领。卫气营血,本是中医生理学的名称,经其引申于温病学,既是对温热病四类证候的概括,又代表温热病在发展过程中,由浅入深、由轻到重的四个阶段。

外感温热病多起于卫分。卫分证主表,病在肺与皮毛,渐次传入气分;气分证主里,病在胸膈、肺、胃、肠、胆等脏腑。营分证是邪入心营,病在心与包络。血分证则热已深入肝肾,重在耗血、动血。在卫、在气病情较轻较浅,在营在血则病情笃重,这是病情发展的一般规律。但这种传变规律并非一成不变。由于体质有强弱之分,病邪有轻重之别,有的受病后在卫分即解,有的很快就出现气分、营分,甚至血分证候。有的受病不久,由于热势弥漫,不但气分有热,而且血分也受热灼,酿成气血两燔。或卫分病不经过气分阶段,而直接传入营血,即所谓“逆传心包”。因此,在临证时要根据临床表现,审慎分析,才能把握病情,作出诊断。

下面就卫气营血的主要证候及治疗原则,作一简要介绍:

[卫分证]

卫分证是温热邪气侵犯肌表,一般见于温热病的早期,病位在皮毛和肺,反映温热之邪开始侵入肤表的一系列症状。

1. 主要证候:发热,微恶风寒,头痛,无汗或少汗,咳嗽,咽喉肿痛,口干微渴,舌边尖红,苔薄白或微黄,脉浮数。

2. 证见:流行性感冒,上呼吸道感染,急性结膜炎,急性支气管炎,流行性腮腺炎,流行性脑脊髓膜炎早期。

3. 治疗参考:辛凉解表、泄卫透汗,方用银翘散、桑菊饮。

[气分证]

温邪在卫分郁而不解,向里传入气分。传入气分的典型证候是:发热、不恶寒、口渴、苔黄等。由于邪热入里,所在脏腑部位不同,反映的证候可有很多类型,常见以下类型:

(一) 热壅于肺

1. 主要证候:发热,喘咳,胸痛,咳痰黄稠,口渴,喉痛,鼻翼煽动,舌苔黄脉数。

2. 证见:急性支气管炎,大叶性肺炎,急性肺化脓症。

3. 治疗参考:清肺泄热,化痰平喘,方用麻杏石甘汤加减。

(二) 热炽阳明

1. 主要证候:大热,大渴喜冷饮,大汗出,面赤气粗,脉洪大,舌苔黄干,或谵语抽搐。

2. 证见:流行性感冒,流行性乙型脑炎,以及一切感染性疾病的高烧期。

3. 治疗参考:清热生津,方用白虎汤加减。

(三) 热结肠道

1. 主要证候:午后潮热,大便秘结,或泻黄臭稀水,腹部胀满,腹痛拒按,舌红苔黄燥,甚则焦黑起刺,脉沉数有力。

2. 证见:流行性感冒,流行性乙型脑炎中、极期。

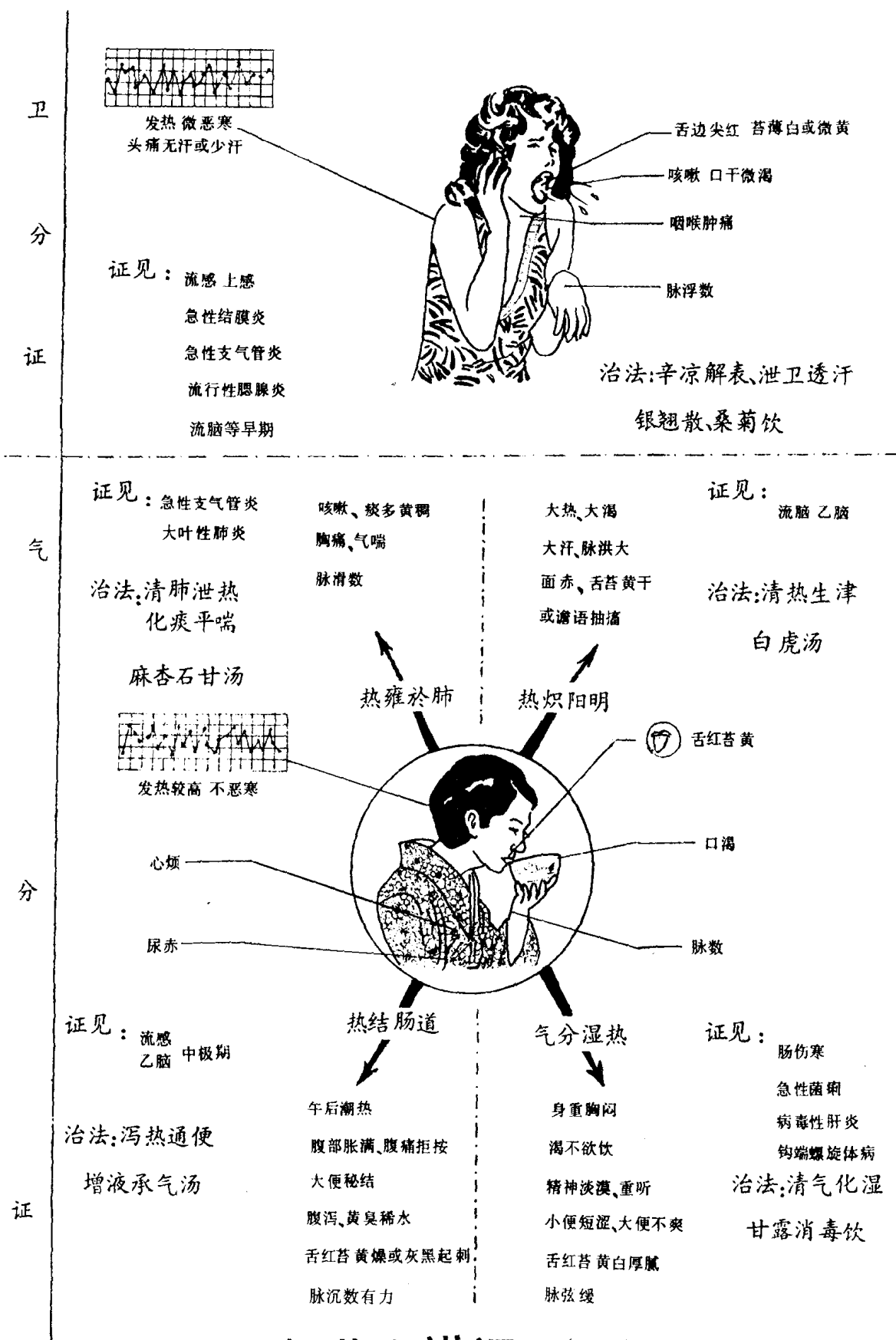
3. 治疗参考:清热润燥通便,方用增液承气汤。

(四) 气分湿热

1. 主要证候:身热不扬或起伏,身重胸闷,渴不欲饮,精神淡漠,重听,小便短赤,大便不爽,舌红、苔黄白厚腻,脉弦缓。

2. 证见:肠伤寒,急性细菌性痢疾,钩端螺旋体病,病毒性肝炎。

3. 治疗参考:清气化湿,方用甘露消毒饮或三仁汤加减。



卫气营血辨证 (一)

• 159 •

第二节 营分证、血分证

〔营分证〕

营分证,是温热病邪乘虚内陷心营,为外感热病发展进程的极期阶段。营是血中之气,为血之前身,内通于心。病期发展至营分阶段时,病邪由热化火,进一步消耗人体的津液,表现出明显伤津的现象。本来热性病在病情任何阶段,始终存在“热伤津液”这一病理变化,但对营分证来说,显得更为突出、严重,出现舌质红绛、苔少、无苔等营阴受损,严重者出现“亡阴”,可以导致死亡。因此,中医治疗热性病,常佐以“滋阴”,谓“保留一份津液,即留得一份生机”。病情发展到营分,影响“心藏神”的功能(即影响现代医学的中枢神经系统),出现一系列意识障碍,习惯上叫“热入心包”。若由湿热、痰浊引起的,称“痰迷心窍”。

(一) 热伤营阴

1. 主要证候:身热夜重,口干不喜饮,心烦不寐,舌质红绛,或见神昏谵语,斑疹隐隐,脉细数。
2. 证见:流行性脑脊髓膜炎,流行性乙型脑炎,其他各种严重感染等。
3. 治疗参考:清营透热,方用清营汤加减。

(二) 热入心包

1. 主要证候:高热,烦躁,或表情淡漠,反应迟钝,神昏谵语,幻听幻视,昏迷抽搐,舌绛,脉滑细数。
2. 证见:各种脑炎,脑膜炎,中暑,败血症,中毒性菌痢,中毒性肺炎等。
3. 治疗参考:清营泄热,清心开窍,方用清营汤加安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹。

〔血分症〕

血分与营分是温热病发展过程中相互联系不可分割的两个阶段。营是生成血的物质基础,是血中之气。病邪侵入营分,也可认为是侵入血分的前兆,只是血分证是温热病已经发展到最为深重的阶段。心主血,肝藏血,故邪热侵入血分,必然影响心肝二脏,邪热久羁,耗伤营阴更重,累及于肾,所以血分证以心、肝、肾病变为主,临床表现除具有营分证候外,更以耗血、动血、阴伤、动风为其特征。

1. 主要证候:在营分见证基础上,更见高热或持续低热,躁扰发狂,斑疹透露,或见吐血、衄血、便血、尿血、月经过多、舌质绛紫无苔,或神昏、谵语、手足抽搐、角弓反张、两眼上翻、牙关紧闭等,或见暮热早凉、五心烦热、口咽干燥、神倦耳聋、舌干少津,或见肢体干瘦、唇萎舌缩、齿干燥、目陷睛迷、昏沉欲睡、两颧潮红、脉虚数或细促。
2. 证见:肠伤寒,急性粟粒性肺结核,钩端螺旋体病,流行性脑脊髓膜炎,败血症及某些重症传染病。
3. 治疗参考:凉血解毒,方如犀角地黄汤;或凉肝熄风,方如羚羊钩藤汤;或滋阴养血,平肝熄风,方如加减复脉汤,大定风珠。

营

分

证

热伤营阴

热入心包

身热夜重
口干不喜饮
心烦不寐
舌质红绛

或神昏谵语
斑疹隐隐
脉细数

神志淡漠
反应迟钝
幻听幻视
神昏谵语
昏迷抽搐

舌绛
脉滑细数
大小便失禁

治法:清营透热
清营汤

证见:

流脑
乙脑
其他各种严重传染病

治法:清营泄热
清心开窍

清营汤加安宫牛黄丸
加紫雪丹
至宝丹

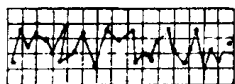
证见:

各种脑炎、脑膜炎
中暑 败血症
菌痢
中毒性肺炎

血

分

证



高热或持续低热



吐血、咯血、衄血



两眼上翻
牙关紧闭

便血、尿血、月经过多



瘀点、瘀斑

手足抽搐

颈项强直 角弓反张

神昏谵语狂躁

舌质绛紫、无苔

脉虚数或细促

五心烦热

证见:

肠伤寒、粟粒性肺结核
钩端螺旋体病、流脑
败血症 及某些重症传染病

治法:凉血解毒—犀角地黄汤
凉肝熄风—羚角钩藤汤
滋阴养血—加减复脉汤

卫气营血辨证 (二)

第十二章 三焦辨证

三焦辨证,是清代著名医学家吴塘(1758~1836)在《温病条辨》一书中提出的温热病的辨证方法。他受叶天士的影响和启发,在卫气营血分证的基础上,以三焦为温病的辨证纲领,将卫气营血贯串其中,着重阐述三焦所属脏腑在温病过程中的病理变化,并以此来概括证候类型。

三焦辨证的传变:病始于上焦,次传中焦,终于下焦。上焦包括肺与心包的证候,中焦包括脾与胃的证候,下焦包括肝与肾的证候。

温热病是感受四时不同温热病毒(现代医学的致病病原体,包括了大部分急性传染病病原体)所引起的多种急性热病的总称。它们共同的临床特点是起病急骤,初起即见热象偏盛,而且容易化燥伤阴。中医是按四季气候变化来区别病原体,或命名的,因之温热病有很多类型:如风温、春温、伏暑、暑温、秋燥、冬温、温毒、瘟疫。但就病变性质而论,可分为温热和湿热两大类。属温热者如风温、春温、暑温、秋燥、冬温等。属湿热者,如湿温、伏暑等。温热与湿热虽有共同点,但也有不同之外。湿热者,是在雨湿较盛季节、气候潮湿条件下所产生的一种“病毒”,具有湿性粘腻凝滞,不易骤化,所以起病较缓,病程较长。由于脾为湿土之脏,胃为水谷之海,所以湿温多以脾胃病变为重。即使病在初起,除有头痛、恶寒、身重肢倦、身热不扬等表湿见证外,而以胸脘痞闷、呕恶、苔腻、溲浊、便溏等里湿为主。湿为阴邪,本易伤人之阳,但郁久则湿必化热,故湿温后期,多以化燥伤阴为表现。湿性重浊下流,常延上、中、下三焦部位相传。因此,湿热病以三焦辨证更为合适。下面以外感湿热为因,介绍上、中、下三焦湿热。

〔上焦湿热〕

上焦湿热,是湿热伤人的初期阶段,其证属表,病位在肺与皮毛,即湿郁肌表。由于湿与脾胃关系密切,故上焦湿热兼有脾胃见湿之症,开始热象不甚明显,重点只在于湿,一般须数日之后,才有较明显的热象出现。

1. 主要证候:恶寒重,发热轻微或不发热,或午后发热,头重如裹,肢体困重,胸闷无汗,神识呆滞,口粘不渴,脘痞纳呆,或见肠鸣便溏,舌苔白腻,脉濡缓。

2. 治疗参考:温散表湿,方如藿香正气散。热象已显者,治宜宣化湿热,方如霍朴夏苓汤。

〔中焦湿热〕

病入中焦,为湿热病中期阶段,以湿伤脾胃为主,因肌肉与四肢为脾所主,故中焦湿热,以消化道病变及四肢肌肉酸困沉重为主要临床表现。但仍可见上焦部分症状。

1. 主要证候:身热不扬,或汗出热减,继而复热或午后热甚,肢体困重,胸脘痞闷,呕恶不饥不食,口渴不欲多饮,面色萎黄或面目淡黄,神呆少言,甚或神昏不清,尿短而赤,便溏不爽,或见白痞,苔灰白带黄,脉濡数。

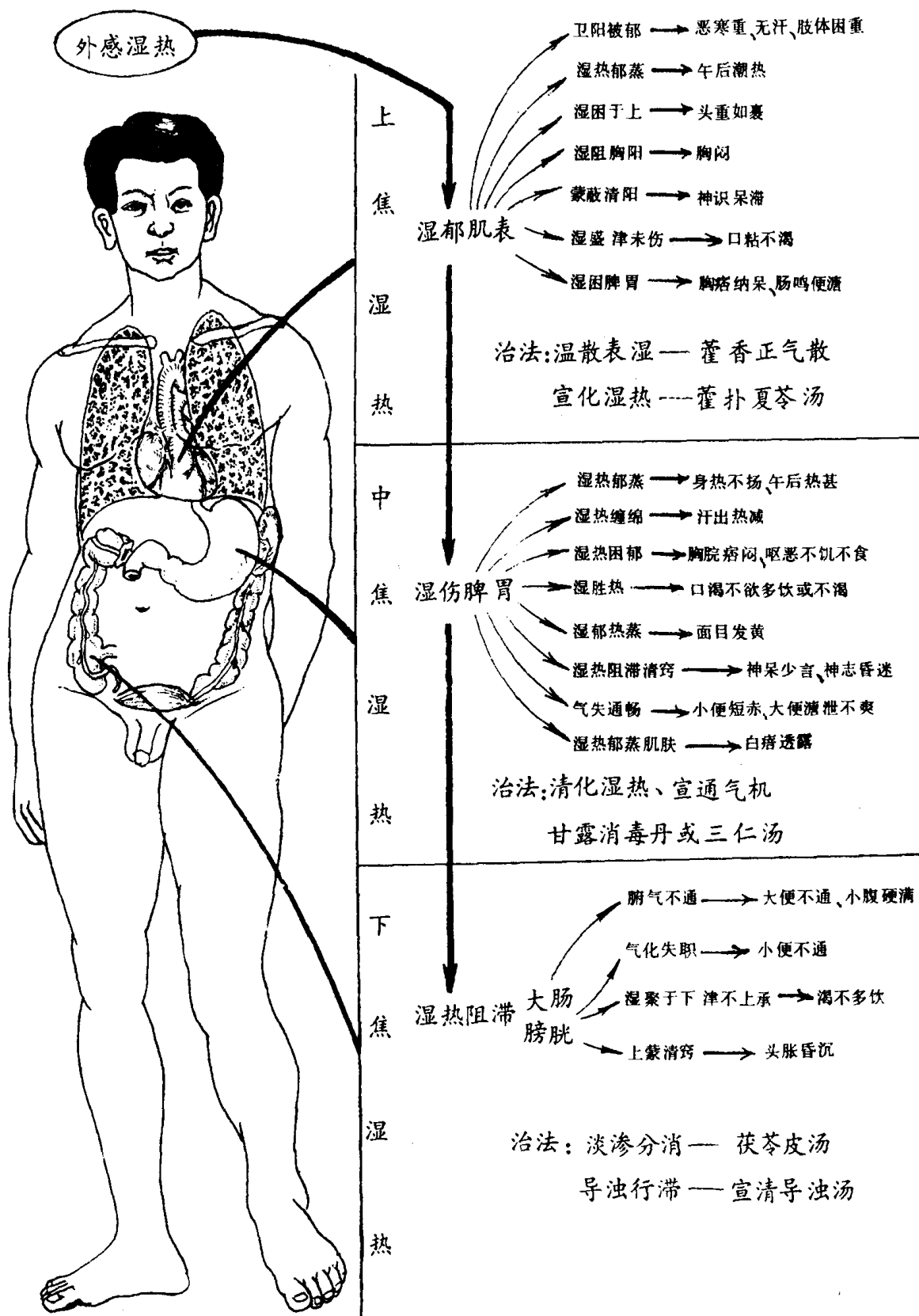
2. 治疗参考:清化湿热,宣通气机,方如甘露消毒丹或三仁汤。

〔下焦湿热〕

下焦湿热,从中焦下传而来,病变主要在大肠与膀胱。临床表现以二便的异常症候为主。

1. 主要证候:小便不通,渴不多饮,或大便不通,小腹硬满,头胀昏沉,苔灰白黄腻,脉濡数。

2. 治疗参考:淡渗分消,方如茯苓皮汤,或导浊行滞,方如宣清导浊汤。



三焦辨证

第十三章 预防与治则

第一节 未病先防

生长壮老死,是人类生命的自然规律。健康与长寿,自古以来就是人类的共同愿望和追求。几千年来,中医学在总结和积累如何确保人类健康、怎样延长人类的寿命方面做出了许多的探索和研究,有着极为丰富、种类繁多的文献记载。早在先秦(公元前 221~前 206 年)以前,中国最古老的中医经典著作《黄帝内经》就强调了“防病于未然”的预防为主的思想。《素问·四气调神大论》说:“不治已病,治未病,不治已乱,治未乱。”“夫病已成而后药之,乱已成而后治之,譬犹渴而穿井,斗而铸锥,不亦晚乎?!”这种未病先防,防重于治的思想,至今乃具有现实的指导意义。

未病先防,总结和介绍养生之道,《内经》有一段精辟的论述,认为人的生活方式应遵循“法于阴阳,和于术数,饮食有节,起居有常,不妄作劳,均适寒温,房劳有度,避绝六欲。”

(一) 法于阴阳,和于术数 人生活于天地之间,应掌握阴阳变化的规律,适应自然环境,调整身心状态,杜绝对名、权、利的不倦追求,达到怡情养性、恬淡虚无的精神境界。这就是法于阴阳之大意。和于术数是指流传于世的养生之术,即吐纳,导引,行气,炼内丹、内功,养性,摄生,修命……名目繁多的功法,通过练“气”,用于强身却病,延年益寿。它既可疏通经络,调和气血,平衡阴阳,又有强壮筋骨,健美身型,激发潜能,增长技击的功夫。

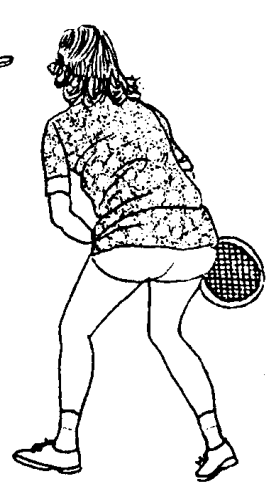
(二) 饮食有节 食物是维持人体生长、发育,供给人体营养物质,满足生命活动需要的基本条件。合理的调剂饮食,对增进健康、延年益寿是很重要的。生活于贫困线以下,营养不良,抵抗力低下,常致病魔缠身,呻吟求治。富贵者,终日美味佳肴,偏食膏粱厚味,患糖尿病、冠心病、癌症的病死率明显提高。西方世界的医生和人民在近半个世纪才认识到高糖、高脂饮食对人体的危害。可是古代中医先贤已指出“富贵者,昧养生之理,不问卫生之方;贫穷者,急养身之策,何知保身之道。”中医强调:饮食应定时、定量,不能饥饱无常,应该“未饥先食,未饱先止”,不能暴饮暴食,不宜过冷过热,食物种类调和,保证身体需要,搭配要合理,饮食要讲卫生……中医称为饮食养生。不遵循这些法则,轻则有损脏腑,重则增病促死。

(三) 起居有常,不妄作劳 起居是指日常生活作息、工作、学习、劳作、睡眠要有规律。当今社会生活节奏加快,有些因工作需要,不能按昼劳夜息的作息方式,要求人们既要适应社会需要,也要合理地安排生活,做到起居有时、劳逸结合。劳作要求“量力而行,莫强行之”。《内经》主张“不欲太劳,不欲太逸”。太劳而导致“久卧伤气、久坐伤肉、久行伤筋”。太逸,终日无所事事,寂寞空虚,也会引起气滞血瘀,肌肉萎缩,身体肥胖,产生疾病。

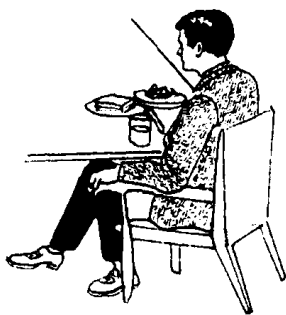
(四) 房劳有度,避绝六欲 色性是人类传宗接代的一种本能,适时婚育是年轻夫妇养生保健、有利优生优育的一项重要措施。节制房事,切忌“以酒为浆、以妄为常、醉以入房、务求其心、以欲竭其精、以耗散其真”。色情放浪导致肾虚早衰。所谓“六欲”是指“游不知疲、乐不知倦、酒不知足、色不知频、气不知满、财不知足”,图一时之快,做逆于生理之举,生命必受其累。

(五) 食疗、药疗 食疗是运用食物的寒凉热温属性以平衡人体阴阳,通过饮食的调节达到康复的目的,《本草纲目》记载常用药粥 62 种。“食能排邪,而安脏腑,清神爽志,以资气血”。人生病不可避免,如果疾病已经发生,就应争取早期诊断,早期治疗,合理用药,以求早期康复。

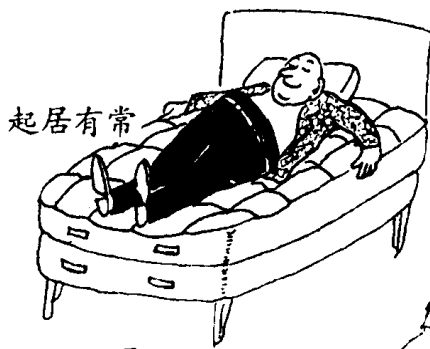
未病先防



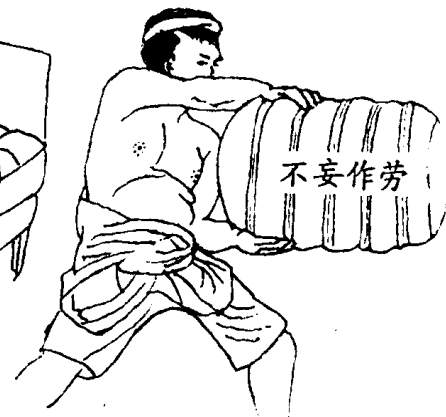
增强体质



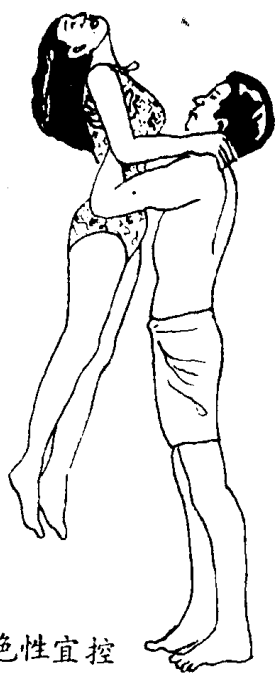
饮食有节



起居有常



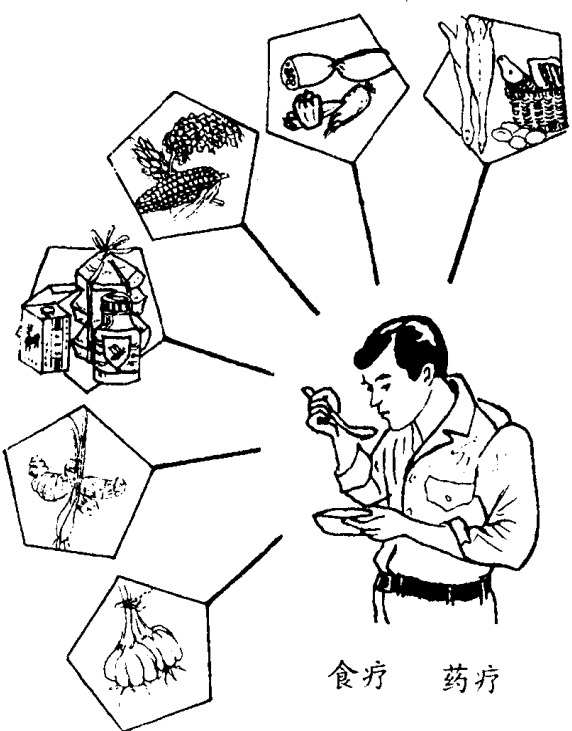
不妄作劳



色性宜控



劳逸结合



食疗 药疗

第二节 治 则

一、治病求本、因时因地、因人制宜

治则,即治疗疾病的法则。中医学的治疗法则是在长期临床实践中总结出来的治疗规律,对临床具体立法和处方用药,具有普遍的指导意义。治疗法则的主要特点是从整体观念出发,通过四诊,进行审证求因,然后加以分析归纳,得出初步的辨证,从而制定出治疗原则和具体的方法。治疗法则是用以指导治疗方法的总则,比如扶正祛邪就是治疗的总则,在这个总则的指导下,采用助阳、益气、滋阴、补血,就是扶正的具体方法,采用发汗、清热、泻下、涌吐等就是祛邪的具体方法。下面介绍中医药学有关的治疗法则:

[治病求本]

治病求本,就是治疗疾病时首先要研究和找出疾病的本质。抓住和解决了疾病的“根本”,其余各种病理现象,也就迎刃而解。这与现代医学的观点是一致的,但中医学的“本”,有更深一层的含意,“本”是相对“标”而言的。标本是一个相对的概念,有多种含意:①以正邪双方来说,正气为本,邪气为标。②从病因和症状来说,病因为本,症状为标。③从病变部位来说,内脏是本,体表是标。④从疾病先后来说,旧病是本,新病是标;原发病为本,继发病是标。⑤从局部与整体的关系来说,整体是本,局部是标。“治病必求于本”,是中医临床治疗必须坚持的原则。

[治标与治本]

疾病的发展是一个复杂多变的过程,常会出现标本主次的变化,因而在治疗上就应有先后缓急的区分:一般情况下,先治本,后治标。但在某些情况下标病甚急,如肺结核大咯血,不止血就会危及患者生命或影响本病治疗,又如慢性肝炎,突然得了感冒,须先治好感冒这个“标”,然后再治疗肝炎这个本。中医有“急则治其标,缓则治其本”,“标本俱急,标本同治”的不同:①缓则治其本,适用于病势缓和的慢性病。②急则治其标,适于高热、剧痛、剧咳、大量出血、大量胸水、腹水等患者。③标本兼治,适用于范围广泛,既有正虚又有邪实者。

[祛邪与扶正]

任何疾病都不外是“正”与“邪”相争的过程。因此在治疗上,也就离不开“祛邪”与“扶正”两个方面。①扶正,就是使用扶助正气的药物,并配合适当的营养和功能锻炼等辅助疗法,增强体质,提高机体抵抗力,适用于正虚为主的疾病。临床上常运用益气、助阳、滋阴、补血等补法。②祛邪,使用攻逐邪气的药物,祛除病邪,适用于邪盛而正虚不显的疾病。临床上可采用发汗、攻下、清解、消导等驱邪外出的方法。③攻补兼施,适用于正虚邪实的病证。在扶正祛邪同时并用时,应以扶正不留邪、祛邪不伤正为原则。

[因时、因地、因人制宜]

治疗疾病要根据季节、地区以及人体的年龄、体质等不同而制定适宜的治疗方法。①因时制宜,要根据不同季节特点来考虑治疗用药的原则,如以感冒发热为例,在隆冬严寒感受风寒,宜以辛温发汗;盛夏炎暑,感冒风寒,宜用祛暑解表。②因地制宜,根据不同的地理环境,考虑治疗用药的原则,叫因地制宜。我国幅员辽阔,北方地势高而寒冷少雨,其病多燥寒,治宜辛润,东南方气候潮湿而温热,故病多湿热,治宜清化。③因人制宜,根据病人性别、年龄、体质、生活习惯等不同特点,考虑治疗用药的原则,叫因人制宜。人的年龄不同,对老年人和婴幼儿,用药剂量,一般不宜过大。“年老多虚,宜补宜温,年壮多实,宜泻宜清”;治疗小儿,忌投峻剂,慎用补剂。人的体质不同,同样患流感,有的体质偏寒,宜用辛温解表;有的体质偏热,则宜辛凉解表;若偏湿则需燥湿发汗。总之具体情况,具体分析,才能取得较好的治疗效果。

治则（一）

治病求本

缓则治其本



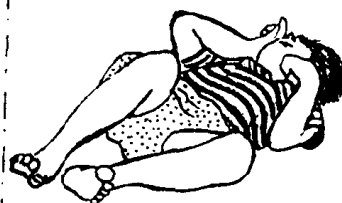
适于病势缓和的慢性病

急则治其标



适于高热、剧痛、剧咳、大量出血
大量胸腹水等患者

标本兼治



适用范围广泛，既有正虚
又有邪实者

扶正祛邪

扶正



适于以正虚为主的疾病

祛邪



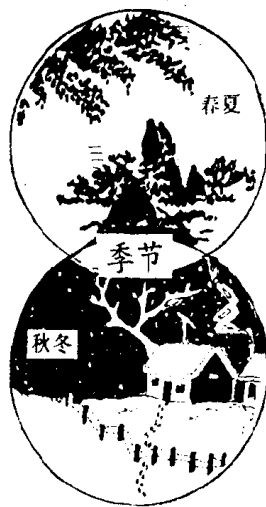
适于邪盛而正虚的疾病

攻补兼施



适于正虚而邪实的疾病

因时制宜



因地制宜



因人制宜



二、同病异治、异病同治、正治与反治

〔同病异治、异病同治〕

1. 相同的疾病,不同的病因,用不同的方法治疗。同一疾病,在不同的阶段,反应疾病的性质不同,也用不同的方法治疗,这就是同病异治。例如:感冒病,有风寒、风热、暑湿的不同病因,治疗时就有辛温解表、辛凉解表和清暑祛湿之分。即使是同一风寒感冒,在它的初起阶段和病情进展到入里化热的治疗,其治法也有解表与清里的区别。

2. 不同的疾病,相同的病因,用相同的方法治疗;或不同的疾病,在其发展的过程中,出现了同一性质的阶段,也用相同的方法治疗,这就是异病同治。例如,气虚下陷的脱肛久痢、崩漏下血和气虚发热是几种截然不同的疾病,但因为它们都是由于中气虚所致,所以都可以用补中益气的方法来治疗。再如失眠、心悸、妇女月经不调等病证,在它们病变过程中,若均处于心脾两虚的相同病变阶段,就可用补益心脾的同一方法来治疗。外感病热入于里,热结肠道所致的大便秘结,与伤食病发展到食滞肠道的大便秘结,都须用泻下法进行治疗。

〔正治与反治〕

1. 正治法适于人体感受病邪后,能如常地反映邪正相争的情况。简单地说,就是当热证表现热象时,用寒凉药来治疗;寒证表现寒象时,用温热药来治疗;实证表现实象时,用攻泻药来治疗;虚证表现虚象时,用补药来治疗。因为这种治法,在一般情况下最为常用,含有“正规”和“常规”的意思,所以叫正治法。

2. 反治法适用于病势严重,机体不能如常地反映邪正相争的情况时,即临床表现的症状与疾病的本质不符而出现一些假象时,采用顺从其症象而治的一种法则。反治法有以下四种情况:

(1) 寒因寒用:用寒性药物治疗恶寒的症状,用于内真热而外假寒证。如热邪郁遏在里,阳气不能外达,而反见四肢厥冷“假寒”证,要用顺从疾病证象的寒性药治疗其里热(有高热口渴表现)的病变本质,里热得清、阳气外达、四肢厥冷症状可随之消失,这就是以寒治寒的“寒因寒用”。

(2) 热因热用:用热性药物治疗发热的症状,用于内真寒而外假热证。如阴寒之邪盛于内,阳气格于外,而反见肤热、面赤等内真寒而外假热者,就要用温热药物治疗其里寒的病变本质,里寒消散、阳气回复、外在的热象亦随之消失,这就是以热治热的“热因热用”。

(3) 通因通用:用通利的药物治疗通泄病证,如因食积所致的腹泻,用消导泻下药以泻热去实。因瘀血引起的崩漏,用活血逐瘀的药物治疗。因实热坚结引起的腹泻用泻热去实的药物治疗,都属于以通治通的“通因通用”。

(4) 塞因塞用:用补塞的药物治疗闭塞不通的病证。如因中气不足、脾虚不运而致的腹胀,用补脾益气的方法治疗。气虚血枯引起的闭经,用补养气血的药物治疗等,都是以补开塞的“塞因塞用”。

从以上分析可以看出,反治法虽然是顺从疾病证象而治疗的一种方法,但它仍是针对疾病的本质而治疗的,所以反治法和正治法从本质上讲,都是“治病必求于本”的。

治则 (二)

同病异治



流感

风寒证 — 辛温解表

荆防败毒散

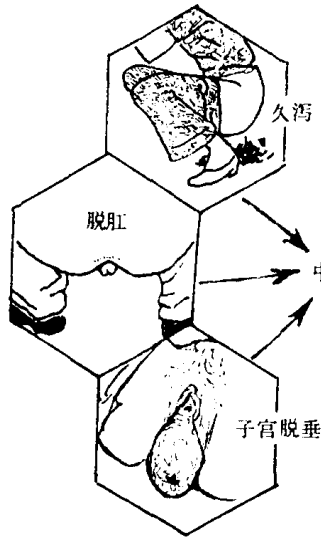
风热证 — 辛凉解表

银翘散

暑湿证 — 清暑祛湿

藿香正气散

异病同治



久泻

脱肛

子宫脱垂

中气下陷 — 补中益气

正治与反治

寒病见寒象



寒者热之

热病见热象



热者寒之

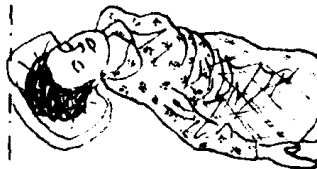
正治

虚病见虚象



虚则补之

实病见实象



实则泻之

寒因寒用 — 以寒治寒



用于内真热而外假寒证

用寒性药物治疗

热因热用 — 以热治热



用于内真寒而外假热证

用温性药物治疗

反治

通因通用 — 以通治通



食积所致腹泻 泻热去实

瘀血引起的崩漏 活血祛瘀

实热坚结所致腹泻 泻热去实

塞因塞用 — 以补开塞



脾虚不运的腹胀 补脾益气

气虚血枯的闭经 补养气血

第三节 常用治法

临床常用的治疗方法,一般概括为:汗、吐、下、和、温、清、补、消八种,原称“八法”。吐法现今基本上不用了,而有些常用方法,又不是“八法”所能概括。经过重新整理和补充,共分解表法、清热法、泻下法、消散法、和解法、温里法、补益法、固涩法、调气法、利尿法、开窍法和重镇摄纳法等十二种。分别介绍如下。

一、解表法

解表法,主要利用具有解表发汗作用的药物,以达到驱除表邪的目的,所以解表法又叫汗法。

[临床应用]

1. 适用于外感热性病发病初期的证候,其表现具有两方面特点:① 表现头面、四肢、皮毛、经络的症状,如恶风(寒)、发热、头痛、身痛。恶风(寒)与发热同时出现,是热性病(卫分)表证辨证的要点。② 因“肺主皮毛”,表证常以上呼吸道感染的症状如鼻塞、流涕、打喷嚏、咳嗽为主要表现。表证不影响其他脏腑,因此没有其他脏腑的症状。

根据上述临床表现特点,现代医学下列疾病可按表证来辨证治疗:① 上呼吸道感染,如感冒、咽扁桃腺炎、咽结膜热、疱疹性咽炎等。② 呼吸系统的其他感染性疾病,如急性支气管炎、肺炎、流感、流脑、麻疹、百日咳等病发病初期,上呼吸道感染症状比较明显时,一般先按表证论治。③ 其他系统的急性感染性疾病初期,尽管无明显上呼吸道症状,只要有恶风(寒)、发热、头痛、身痛等症状者,也可当表证来处方用药。

2. 适用于急性肾炎初起阶段,表现为上半身水肿明显,兼有恶风、发热者,用辛温解表以消散水肿。也可用于风湿在表,引起身痛、骨关节疼痛如风湿性关节炎、风湿性纤维织炎等疾病。

3. 适用于出疹性疾病如风疹、荨麻疹及麻疹初期疹出不畅的透发皮疹。

[药物方剂]

用以解除表证的药物,叫解表药,多具辛味,辛味能发散。解表药具有退热、止痛、消肿、透疹的功能。解表药分辛温与辛凉两类:

1. 辛温解表药:药味辛温,发汗力强。适用于寒重热轻,身痛无汗的风寒表证。常用的药物有:麻黄、桂枝、紫苏、荆芥、防风、葱白、生姜等。常用的方剂有麻黄汤、荆防败毒散等。

2. 辛凉解表药:药味辛凉,发汗力弱。适用于有汗的风热表证。常用的药物有:薄荷、牛蒡子、桑叶、菊花、葛根、柴胡、淡豆豉、升麻、蝉蜕等。常用的方剂有银翘散、桑菊饮等。

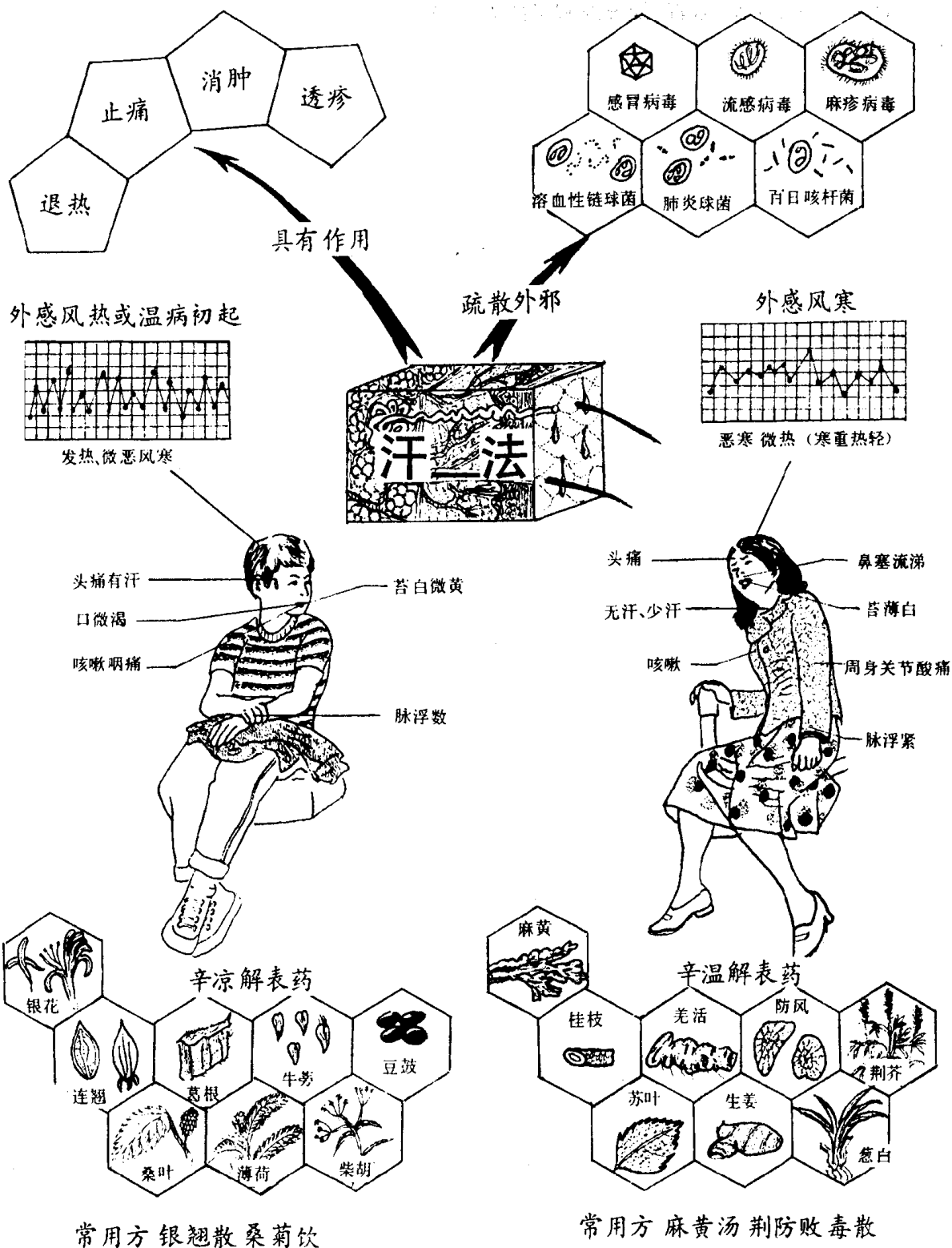
[注意事项]

1. 应用解表药,要注意体质:身体虚弱者,宜扶正达邪。要注意季节:时令炎热,用量宜小;时令寒冷,用量可稍大,注意适可而止,以汗出邪去为度,不宜过汗,以防过度消耗津液。对表证已解或已转化为里证,宜停止使用。

2. 凡用发汗剂时,应告诉患者,服药后应避风寒,忌食油腻厚味食物。

3. 凡身体极度衰竭及剧烈呕吐,腹泻所致衰竭者,或患有淋浊,疮疡日久和失血者,原则上都在禁汗之例,如必须使用汗法时,则应配合滋阴养血、清热解毒等其他方法进行治疗。

常用治法（一）解表法



汗法注意：1. 只适于表证发热，里证或内脏功能障碍所致发热者不宜使用。

2. 身体极度衰竭及剧烈吐、泻所致衰竭者不宜用

二、清 热 法

用清热、泻火、凉血、解毒、燥湿或解暑的方药来治疗血热、热毒、湿热、暑热,以及脏腑内热(包括实热与虚热)等里热证的方法,称清热法。由于热证在气、在营、在血的不同,故清热法可分为清热泻火、清热解毒、清热凉血、清热燥湿等四类。

〔临床应用〕

1. 清热泻火,用清热泻火药以清除热邪的治法,适用于温热病热入气分,出现高热、烦躁、谵语、口渴、多汗、脉宏大、舌红苔黄等邪热伤津之证。临床应用于肺炎、麻疹、流脑等热性病具有上述证候者。

2. 清热解毒,这里所指的毒,是火热壅盛引起,也称热毒或火毒所引起的各种感染性疾病,如细菌性痢疾、流行性腮腺炎、急性肺脓肿、疔疮痈肿、化脓性扁桃腺炎、扁桃体周围脓肿、泌尿系、消化道感染及丹毒等。包括一切热性病,无论在表在里、在气分或在血分均可应用。

3. 清热凉血适用于温热病热入营分、血分。临床上有高热,常以夜间更高,烦躁不安,谵语,神志恍惚或昏迷,口干,舌质红绛,苔少或无苔,脉细数,以及血热妄行而出现皮肤有出血点,瘀斑,或吐血、便血、鼻衄、月经过多、抽搐、角弓反张等证候者,临床上可应用于败血症、流脑、乙脑、中毒性菌痢、中毒性肺炎、中毒性消化不良等。

4. 清热燥湿,适用于湿邪化热或湿热互结。临床上出现发热、心烦、口渴、目黄、火眼、耳痛、流脓、腹痛、下痢泄泻、小便涩痛等诸症者,可见于急性病毒性肝炎、细菌性或阿米巴性痢疾、化脓性中耳炎、淋病性尿道炎、滴虫性阴道炎、猩红热等。

〔药物方剂〕

清热药,性偏寒凉,味多苦甘,具有清热降火的作用。热与火的概念,只是轻重程度的不同。轻者为热,重者为火,热为火之渐,火为热之极。凡发热,皮肤灼热,热较弥漫,中医称为热证,而高热,有口舌糜烂、咽喉肿痛、目赤羞明、火较集中而上炎者,中医称为火证。清热药中,性凉者偏于清“热”,性寒者偏于泻“火”,但彼此并不能截然加以划分,凡能清热的药也都能泻火。

1. 清热泻火药,多入气分,能清气分实热或直折邪火。常用的清热泻火药:石膏、知母、芦根、竹叶、栀子、莲子心、龙胆草、夏枯草等。常用方剂如白虎汤。

2. 清热解毒药,应用非常广泛,既可用于局部感染,又可用于全身性感染。常用的清热解毒药:金银花、连翘、蒲公英、大青叶、板蓝根、败酱草、鱼腥草、白头翁等。常用方如黄连解毒汤、普济消毒饮。

3. 清热凉血药,应用于血(营)分证,尚有养阴滋液的作用,常用的清热凉血药有:生地黄、玄参、赤芍、丹皮、紫草、地骨皮、犀角、牛黄(犀角现用水牛角尖代替),方剂如清营汤、化斑汤。

4. 清热燥湿药,多为苦寒药,苦能燥湿,寒能清热,适于湿热并见者,常用清热燥湿药:黄连、黄芩、黄柏、苦参、青蒿、栀子、龙胆草等。方剂如:甘露消毒丹、茵陈蒿汤。

〔注意事项〕

1. 清热药不能用于寒证。

2. 体质虚弱或产后要慎用。苦寒药易伤脾胃,使用时以中病为度,不宜滥用。

常用治法（二） 清热法

清热泻火

用于温热病热入气分



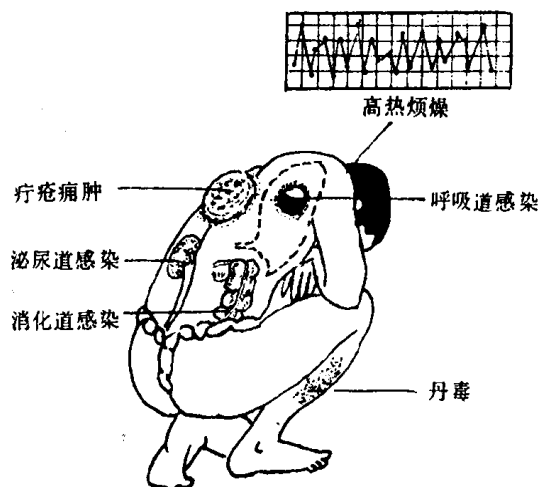
常用药物：

石膏 知母 栀子 莲子心 龙胆草 夏枯草

方剂如：白虎汤

清热解毒

用于热毒引起的各种感染性疾病



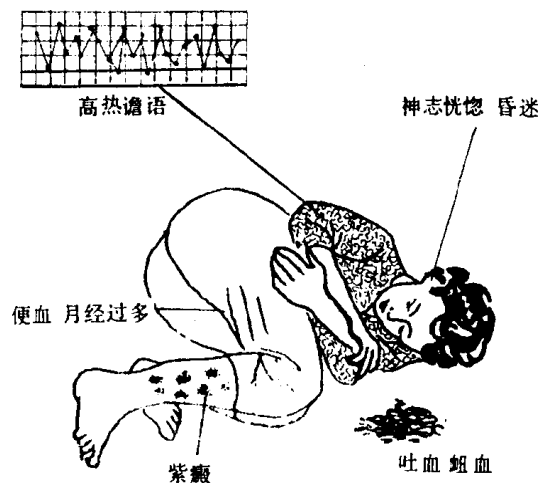
常用药物：

银花 连翘 蒲公英 大青叶 板蓝根 败酱草 鱼腥草 白头翁

方剂如：黄连解毒汤、普济消毒饮

清热凉血

用于温热病热入营分 血分



常用药物：

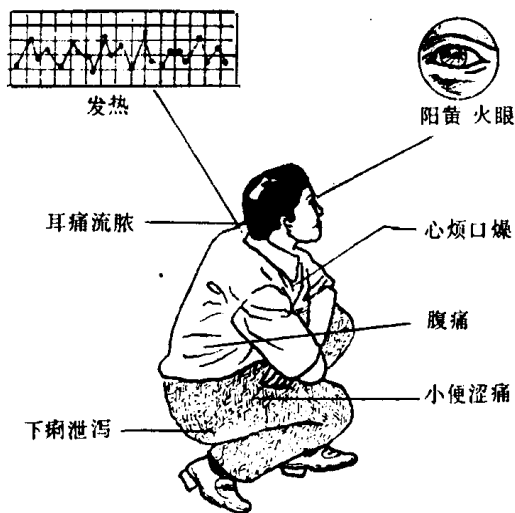
犀角 生地 黄牡丹皮 玄参 赤芍 紫草 地骨皮

方剂如：清营汤 化斑汤

注意：1. 清热法不能用于寒证。
2. 体虚与产后要慎用。

清热燥湿

用于湿邪化热或湿热互结



常用药物：

黄连 黄芩 黄柏 苦参 青蒿 栀子 龙胆草

方剂如：甘露消毒丹、茵陈蒿汤

三、泻下法

泻下法原称下法,就是通便的方法。通过通便达到泻火、逐水、攻痰、逐瘀、导滞、驱虫、润肠、温下作用。一般分为急下、缓下两大类。急下包括泻火、逐水、攻痰、逐瘀。缓下包括导滞、驱虫、润肠和温下。泻下的药物,一般以大黄、芒硝为主,配合其他有关药物。泻下的目的,不一定是通便,主要祛除病邪。

[临床应用]

1. 泻火:适于里实热证,实热壅滞,大便燥结,腹胀满而痛,高热,谵妄;或湿热下痢,里急后重;或风火眼病等大肠热结的病症,如①急性感染性疾病的中、极期。②药物或食物中毒。

③结膜炎、脑充血、肺出血、鼻衄等。

2. 逐水:适用于水液运化失常,胸腹水饮内停,有胸脘痞闷、大便秘结、苔黄脉弦、全身水肿等实证者。

3. 攻痰:适用于顽痰凝结、阻塞经隧的病症,如①痰黄稠、咯痰不畅的呼吸系统疾病。②癫痫、惊厥等神经系统疾病。

4. 逐瘀:适用于瘀血内结、热性病而有少腹硬满、大便黑、谵语烦渴、至夜发热、狂躁等下焦蓄血证,或症瘕肿块等。

5. 导滞:适用于积食停滞所引起的中脘饱闷,泄泻腹痛,里急后重等食滞兼湿热的病例。

6. 驱虫:适用于肠寄生虫所引起的腹胀、腹痛,必须根据寄生虫性质、种类和体质强弱选用相应的药物,配伍泻下药,以增强排出能力。

7. 润肠:适用于肠燥便秘之症:①病后、产后、老年体弱所致便秘。②习惯性便秘。③痔疮、肛门裂病人便秘。

8. 温下:适用于肾阳不足,寒气内结或脾虚寒积,脐下硬结,便秘,脉沉迟者。

[药物方剂]

1. 泻火药:选用苦寒和咸寒的药物如大黄、芒硝等。方剂如大承气汤、调胃承气汤、凉膈散等。

2. 逐水药:选用逐水攻下药甘遂、芫花、大戟、牵牛子等药物,有时可配合大黄。方剂如控涎丹、十枣汤、舟车丸等,此种方法为权宜之计,不可过量。

3. 攻痰药:选用攻痰药如南星、半夏、礞石,配合泻下药如大黄、巴豆霜。方剂如桔梗白散、礞石滚痰丸,取其攻痰通便、解痉开窍的作用。这种方法也要慎用,不宜过量,以免伤正气。

4. 逐瘀药:一般选用破血药,如桃仁、红花、土鳖虫;破气药如三棱、莪术;消肿药如穿山甲、皂角刺;泻下药如大黄等配合使用,以达破血逐瘀,散结止血。方剂如桃仁承气汤、过期饮。

5. 导滞药:选用行气导滞药如木香、槟榔、枳实等配合泻热通便的大黄等。方剂如木香槟榔丸、枳实导滞丸。

6. 驱虫药:驱虫药种类较多,不同的驱虫药对不同的寄生虫有选择性作用,要因虫选药。驱虫药有苦楝皮、使君子、榧子、鹤虱等配合大黄、芒硝。方剂如化虫丸、万应丸。

7. 润肠药:选用润肠的药物如麻仁、杏仁、苁蓉、苏子等。方剂如脾约麻仁丸、润肠丸。

8. 温下:选用辛温大热的药物如附子、干姜、配合其他调气导滞药物,如厚朴、枳实、泻下的大黄,以温中通阳,散寒解结。方如大黄附子汤、温脾汤。

泻下法,特别是急下的方法,对妇女月经期、妊娠期和衰弱病人,要慎重使用。

常用治法（三）泻下法

主要药物

甘遂 芫花 大戟 牵牛子

方剂如 控涎丹 十枣汤 舟车丸

适用于胸腹水饮内停

1. 重症水促
2. 胸水或腹水患者



主要药物南星 半夏 礞石 巴豆霜 大黄

方剂如 桔梗白散、礞石滚痰丸

适用于逐顽痰、通便、解痰开窃

1. 痰黄稠咳痰不畅的呼吸系疾病
2. 癫痫、惊厥等神经系疾病



主要药物

大黄 芒硝等

方剂如：大承气汤

调胃承气汤 凉膈散

对症处理 不宜久用

适用于：大肠热结的病症

1. 感染性疾病中、极期
2. 药物或食物中毒
3. 结膜炎 充血肺出血 鼻衄等



逐水

攻痰

主要药物

桃仁 红花 三棱
莪术 丹参 牛膝 大黄等

方剂：桃仁承气汤、过期饮

适用于 瘀血内结、症瘕肿块



逐瘀

主要药物

木香 槟榔 枳实 大黄等

方剂如 木香 槟榔丸 枳实导滞丸

适用于积食 停滞引起的中脘饱满
泄泻腹痛 里急后重等症候



导滞

温下

主要药物

附子 干姜 大黄等

方剂：大黄附子汤 温脾汤

适用于 脾肾阳虚
冷积阴于胃肠的症候



驱虫

润肠

主要药物

苦楝子 使君子 榧子
鹤虱等

方剂如 化虫丸 万应丸

主要药物

麻仁 杏仁 苁蓉 苏子等

适用于肠寄生虫引起的
腹胀、腹痛



方剂：脾约麻仁丸 润肠丸

适用于 肠燥便秘

1. 病后 产后 老年体弱所致便秘
2. 习惯性便秘
3. 痔疮病人便秘



四、消 散 法

消散法原称消法,有消除的意思。应用范围较广,可分为消导与消积两种:消导即消食导滞的意思,是针对食滞而拟订的一种治法;消积即消坚磨积的意思,主要用于有形包块(症瘕或痞块)以及痈肿等。这类病证多由气滞、血瘀、痰逐渐凝结而成,临床上应用行气、破气、活血逐瘀以及消痰软坚等类药物以消除之的治疗方法。消散法具有消食、消瘀、化痰、化湿的作用。

[临床应用]

1. 消食:适于因脾胃运化功能失调而引起的食滞,或伤食、食积引起的消化不良,如急性胃炎、急性胃扩张、急性胃肠炎和功能性幽门梗阻。临床上有厌食、噯腐吐酸、呕吐、噯气如败卵臭、腹胀、腹痛、腹泻等症。

2. 消瘀:血液运行不畅,瘀滞于某部,出现下列临床表现者,中医称血瘀或血滞。① 疼痛,呈刀割样或锥刺样,部位固定而不动,多见于新、旧外伤引起的疼痛、顽固性风湿痛、身痛、头痛、坐骨神经痛、胸腹胁痛、心绞痛、痛经等。② 色泽紫暗,如软组织外伤时呈青紫,麻疹出疹时疹色紫暗,经色紫暗,舌质紫斑或瘀点等,上消化道出血中医也认为是血瘀。③ 症块,包括可扪及或看到的有形包块,如肿瘤、肝脾肿大、外伤血肿、痈肿等。任何疾病具有上述任何一种症状时,就可诊断为血瘀。可见血瘀证包括的疾病范围很广。

3. 化痰:中医“痰”的概念,除肺部咳嗽咯出的有形的痰之外,还包括某些脏腑的若干病证,如颈淋巴结结核、甲状腺肿、眩晕、抽风、癫狂、中风,中医都认为是“痰”的病证。此处的化痰主指呼吸系统疾病的咯痰,包括寒痰(见于慢性支气管炎、支气管哮喘),热痰(见于急性支气管炎、肺炎、肺脓肿),燥痰(秋天感冒及肺炎、麻疹、百日咳等病后期和恢复期)等不同原因的多痰。

4. 化湿:适于外湿由表入里,或因脾虚不能运化水谷所致内湿证,表现有发热或无热,面色黄秽头重,身重困倦,口中粘腻无味,胸腹胀闷,食欲极差,大便稀薄,舌苔白厚腻,脉濡,还可有泻痢、黄疸、浮肿、淋浊、带下等症。

[药物方剂]

1. 消食:凡能帮助消化、促进食欲、消除食积的药物,叫消导药。常用药物有神曲、麦芽、谷芽、山楂、鸡内金、莱菔子。积食引起气滞腹胀的、配理气药,食滞郁久化热的配苦寒轻下药,因脾胃不健的配用健胃药。常用方剂:保和丸,枳实消导丸,午时茶。

2. 消瘀:应用活血药有疏通血脉、消散血瘀、促进血行的作用,配伍行气药以消除瘀肿、减轻疼痛,常用活血药有红花、丹参、赤芍、没药、益母草、桃仁、三棱、莪术、川芎等;常用方剂:桂枝茯苓丸、鳖甲煎丸、大黄牡丹汤等。有些活血药能增强子宫收缩,故孕妇禁用。

3. 化痰:凡具有消除痰涎或使痰变稀薄、易于排出的药物,叫化痰药,使用时应注意适当配伍。寒痰宜温化,须配祛寒药。热痰宜清化,须配清热药。以此类推。常用止咳祛痰药:杏仁、桔梗、半夏、前胡、干姜、贝母、苏子、桑白皮等。常用方剂:二陈汤、清金化痰汤、小青龙汤、泻白散等。

4. 化湿:利用芳香性质的药物,或苦燥药,淡渗利湿药物,以除去体内湿浊。常用药物:藿香、佩兰、石菖蒲、茵陈、半夏、陈皮、苍术、厚朴、猪苓、茯苓、泽泻、米仁、滑石等。方剂:甘露消毒饮、胃苓汤、平胃散、茵陈蒿汤。

消食

药物 神曲 麦芽 山楂 枳实 鸡内金

方剂：保和丸

枳实消导丸

午时茶



适用于：伤食食积之证

如消化不良 急性胃炎 幽门梗阻（功能性）

急性胃扩张 急性胃肠炎

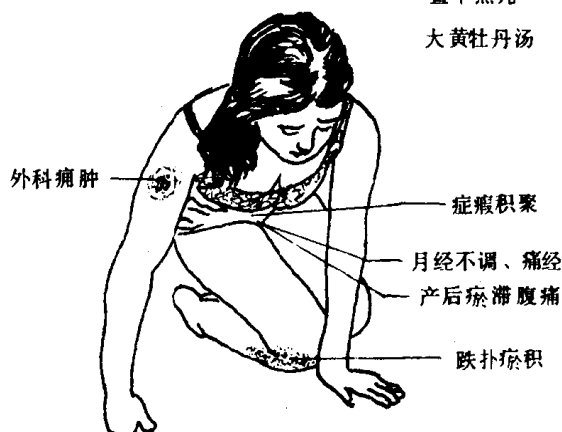
消瘀

药物 红花 丹参 赤芍 泽兰 乳香 没药 益母草 桃仁 三棱 莪术 土鳖虫 穿山甲

方剂：桂枝茯苓丸

鳖甲煎丸

大黄牡丹汤



适用于：外伤血瘀、气滞血瘀、寒凝血瘀所致的肿胀疼痛痞块（子宫外孕、卵巢囊肿、阑尾脓肿）

常用治法（四） 消法

化痰

药物 苏子 杏仁 半夏 陈皮 前胡 干姜 桔梗 麻黄 瓜蒌 牛蒡子 冬瓜仁 地骨皮 知母 贝母 桑白皮

方剂：二陈汤

清金化痰汤

小青龙汤

泻白散



适用于：不同原因的多痰

化湿

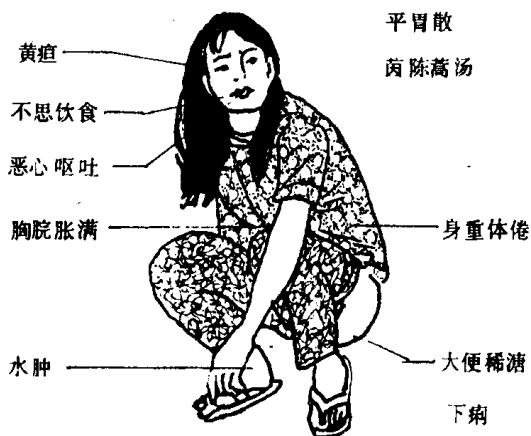
药物 藿香 佩兰 石菖蒲 茵陈 半夏 陈皮 苍术 厚朴 茯苓 猪苓 泽泻 米仁 滑石

方剂：甘露消毒饮

胃苓汤

平胃散

茵陈蒿汤



适用于：治疗腹泻、黄疸、下痢、水肿、湿疹

五、和解法

和解法也简称为和法。和法即调和、调整 and 调理的意思。它有祛邪扶正、调整脏腑功能活动偏盛偏衰的作用。凡是病情不适宜用汗、下、温、清、补、消等法治时,都可应用和解法论治。和解法与理气(有气滞者宜疏通、气逆者宜平降)关系密切,常相互配合应用。临床上和解法常用于和解表里、调理肝脾及调合营卫。

[临床应用]

1. 和解表里:表里主要指病变部位的深浅。凡病在皮毛、肌肉、经络的属表,病在五脏六腑的属里。在分辨表证和里证时,不能单纯从解剖部位来划分,重要的是通过观察人体对病邪的侵袭所产生的反应——如寒、热等症状,脉象、舌苔等表现来辨别。外界病邪侵犯人体,大多首先侵犯人的体表,然后由表到里,表里除说明病变深浅外,也可反映病情的轻重,表证较轻,里证较重。和解法不是治疗表证或里证的方法,而是用于热性病邪在半表半里症。所谓半表半里是正气与病邪作斗争时,呈“拉锯战”的形式,即时而倾向于表,时而倾向于里的综合表现。外感病由表入里,并不一定都要经过半表半里阶段。半表半里可以说是外感病的另一种类型,如疟疾。或者是表证和里证同时出现,即既有恶寒、发热、头痛等表证症状,又有胸胁闷胀、腹痛呕吐等里证,临床见于上感、急性肝炎、疟疾、胆道结石、胆道蛔虫症及急性腹膜炎有寒热往来、胸胁苦满、心烦欲呕、口苦咽干等症候者。

2. 调理肝脾:中医认为肝与人的情绪有关。正常情况下,“肝主疏泄,性喜条达”,人的精神情绪舒畅。倘若肝失疏泄时,病人就会出现精神苦闷、情志抑郁、性情急躁、容易发怒以及胸闷、胁痛等症状,中医称“肝气郁滞”,常常累及脾胃消化吸收功能,而出现心下痞塞、呕恶不食、肠鸣、腹痛、腹泻以及出现月经不调和痛经,乳房胀痛等妇科心身疾病。临床上可见于胃肠神经官能症、慢性肝炎、慢性肠炎、肋间神经痛、痛经、月经不调及经前期紧张症等。

3. 调合营卫:适用于外感风邪,营卫不和,有时见形寒怕风,鼻塞流涕;有时寒时热、微热不退、自汗等症候;或病后、产后体虚而营卫不和者。在这种情况下,由于营弱卫强不能单纯发汗祛邪,而应解肌发表,调和营卫。

[药物方剂]

和解法只是一种治法,有许多和解的方剂,但没有专用的和解药物。组成和解方剂的药物,见于其他各类药物之中。

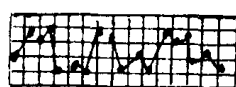
1. 和解表里:药物有柴胡、黄芩、黄连、半夏、干姜、槟榔、厚朴、草果等。方剂如小柴胡汤、大柴胡汤,达原饮等。

2. 调理肝脾:选用药物有苏梗、香附、白芍、金铃子、郁金、柴胡等。方剂如柴胡疏肝汤、逍遥散、半夏泻心汤等。

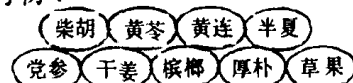
3. 调和营卫:选用药物有桂枝、芍药、生姜、大枣等。方剂如桂枝汤、小建中汤等。

常用治法（五）和解法

和解表里



药物：

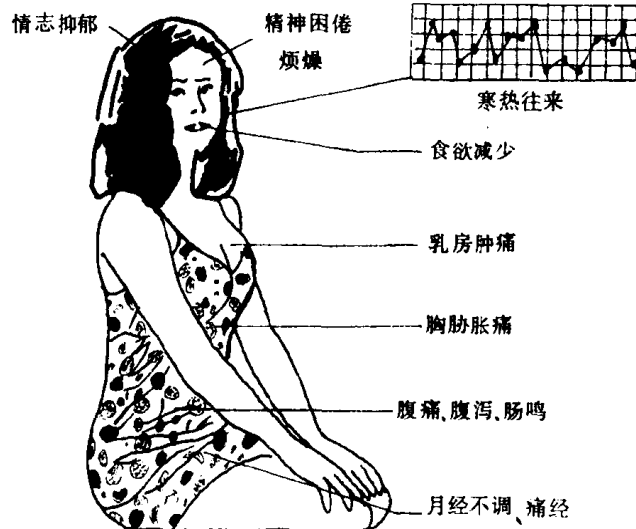


方剂：小柴胡汤、大柴胡汤

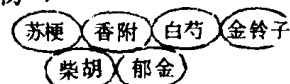
适用于：

感染性疾病，病变部位在半里半表
上感、急性肝炎、疟疾、急性胆囊炎、急性胰腺炎
胆道结石、胆道蛔虫、急性腹膜炎

调理肝脾



药物：

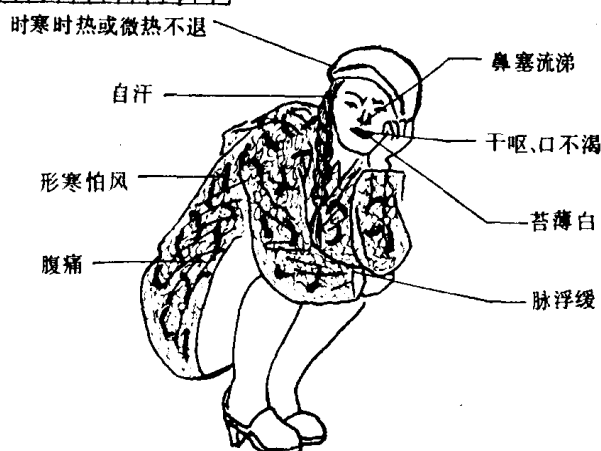


方剂：逍遥散

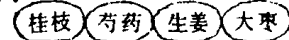
适用于：

肝气郁结、肝脾不和病证
如肋间神经痛、胃肠神经官能症
慢性肝炎、月经不调、慢性肠炎

调和营卫



药物：



方剂：如桂枝汤

适用于：

外感风邪表虚证及病后 产后体虚营卫不和

六、温里法

温里法又简称温法,是祛除寒邪和补益阳气的一种治法。寒证可分外寒与内寒两种证候。外寒即热性病的表寒证,其证、治、方、药,见热性病表证。内寒即里寒证或脏腑寒证,是温里法治疗对象,使用气味辛温的药物来促进和提高内脏的功能活动,从而达到祛除体内寒湿阴邪的一种治疗方法,可分为回阳救逆、温中散寒、通阳利水、温经活血四个证候类型。

〔临床应用〕

1. 回阳救逆:是寒邪直接侵袭脏腑,使脏腑功能突然受到抑制,来不及代偿,功能急剧下降,中医学常称为“寒邪直中”、“阳气欲脱”的亡阳证候,如起病急骤,体温骤降或体温不升,面色苍白或灰白,四肢冰冷,常冷至肘关节以上(逆冷),大汗淋漓,脉搏细微,不易扪及,血压降至正常值以下或不易测及,临床见于循环衰竭的证候,如各种原因的休克、虚脱。治疗要急用大剂温热药以挽回阳气,配以益气药。

2. 温中散寒:由于寒邪直中脏腑或阳虚内寒,即在脾、肾阳虚的基础上产生的寒象,叫阳虚生寒,中医学简称为阳虚证或虚寒证,起病多较缓慢,有怕冷肢凉、下半身尤甚、面色苍白、体倦无力、食欲减退、腹部隐痛、得温则减、大便稀薄、小便清长等表现,凡慢性虚损或消耗性疾病,如消化性溃疡、慢性胃炎、胃肠功能紊乱、慢性非特异性结肠炎等均可应用。

3. 通阳利水:适用于脾肾阳虚:体内水与营养物质的吸收和运送主要由脾来进行。当脾阳虚,脾的“运化”功能失常,水液得不到运化,引起水湿停滞,发生浮肿,食物得不到运化,则出现腹胀、腹泻等消化不良证候。肾主水,体内多余水分经肾形成尿液贮藏于膀胱,经肾气作用而排出体外,当肾阳虚时,肾的气化功能减弱,而引起全身浮肿,小便量少,甚至尿潴留。现代医学见于慢性肾炎、肾病综合征,心脏病充血性心力衰竭,或慢性缩窄性心包炎等所引起的严重水肿。

4. 温经活血:适用于寒邪凝滞所致经络不通或寒留血脉,气血凝滞出现的证候,如类风湿性关节炎、肥大性关节炎、风湿性关节炎非活动期、肢端动脉痉挛症、所表现的关节活动不便,四肢疼痛发冷、以及月经不调、男子阳痿等证候。

〔药物方剂〕

1. 回阳救逆:选用附子、干姜、人参、黄芪、肉桂等。方剂:四逆汤、参附汤、六味回阳饮等。

2. 温中散寒:选用药物有干姜、吴茱萸、党参、白术、甘草、附子、肉桂、草豆蔻、蜀椒。方剂:理中汤、吴茱萸汤等。

3. 通阳利水:选用药物有附子、生姜、茯苓、白术、白芍、黄芪、党参、泽泻、肉桂等。方剂:真武汤、术附汤、桂附八味丸等。

4. 温经活血:选用桂枝、细辛、附子、吴茱萸、川乌、当归、红花、川芎、白芍、黄芪、炙甘草等;方剂:当归四逆汤、黄芪桂枝五物汤、大温经汤等。

应用温法应注意辛温大热的药物,容易伤阴,凡是阴虚的疾病及“热厥”的病证属禁用。

常用治法（六） 温里法

回阳救逆

选用药物：

附子	干姜	人参
黄芪	肉桂	

方剂：四逆汤
参附汤

体温下降

恶寒倦卧

大汗淋漓

四肢厥冷

脉细微 沉伏

适用于：循环衰竭的病证
各种原因休克、虚脱

温中散寒

选用药物：

干姜	吴茱萸	党参	白术	甘草
附子	蜀椒	肉桂	草豆蔻	

方剂：理中汤

食欲不振

肢体倦怠

腹痛腹泻

四肢不温

怕冷肢凉

呕吐

适用于：脾胃阳虚所致内寒证候
慢性胃炎、消化性溃疡、胃肠功能紊乱、慢性结肠炎、肠痉挛

通阳利水

选用药物

附子	生姜	茯苓	白术	白芍
黄芪	党参	泽泻	肉桂	

方剂：真武汤

头昏

全身浮肿

尿少

腹泻

脉沉细弱

适用于：脾肾阳虚、水湿泛滥
慢性肾炎、充血性心力衰竭所致严重水肿

温经活血

选用药物

桂枝	细辛	附子	吴茱萸	川乌	当归
红花	川芎	白芍	黄芪	炙甘草	

方剂：当归四逆汤、黄芪桂枝五物汤

妇女宫冷不孕

月经不调

男子阳痿

血脉不畅 脉细如丝

关节活动不便

四肢疼痛发冷

适用于：寒邪凝滞所致经络不通
类风湿性关节炎、风湿性关节炎非活动期、肥大性关节炎、肢端动脉痉挛症

七、补 益 法

补益法简称为补法,用于补益人体阴阳气血不足,或补益某一脏腑虚损的一种治法。它运用补益的药物,扶助人体的正气,消除各种虚弱症状,即中医的“虚者补之”的意思,以增强和改善人体功能活动及抗病能力,协调阴阳的偏衰,使之恢复阴阳平衡。根据虚证(气、血、阴、阳)的四个类型,补益法也分以下四类。

[临床应用]

1. 补气法(益气):气的形成与脾的运化及肺主气的正常功能有密切关系,脾肺虚弱,尤其是脾虚就会形成气虚。气分不足,会出现神疲体倦、懒言、气短、动见气喘、声低、头晕、自汗、食欲不振、舌淡苔薄、脉虚弱、内脏下垂等气虚证候。治疗上补气就是补益脾肺,主要是补脾或健脾。临床气虚证,见于慢性阻塞性肺气肿、老年性肺气肿、神经衰弱、热性病恢复期、内脏下垂、溃疡病、脱肛、子宫脱垂等。

2. 补血法(养血):血液由脾运化饮食产生的精微物质,由心生成。所以补血必须补脾(气)。又因心主血、肝藏血,补血应该补心血、肝血的不足。血分不足,临床上会出现面、唇、指甲淡白,疲乏无力,头晕目眩,心悸失眠,月经少而色淡或闭经等血虚证候。补血法适用于各种病因的贫血(如缺铁性贫血、巨幼红细胞性贫血、恶性贫血、再生障碍性贫血、骨髓病性贫血)、溃疡病出血、月经过多、痔出血、慢性肾炎的贫血等。

3. 滋阴法(补阴、养阴、育阴):阴虚即精和津液不足,往往出现潮热颧红、五心烦热、盗汗失眠、消瘦、口干咽燥、耳鸣目眩、小便短赤、遗精、腰膝酸软、脉细数等虚热证候。临床用于各种原因脱水、消耗性疾病(如重症结核、糖尿病)尿崩症。滋阴通常可分两个方面:① 补肾:用于肾阴不足的症候。② 增补津液:用于热盛伤津。

4. 补阳法(助阳、温阳):阳衰往往出现怕冷、手足不温、自汗、虚喘、水肿、泄泻、小便频数、腰膝酸软、阳痿早泄、月经不调、女子不育等阳虚内寒证候。用于阳痿、早泄、一般衰弱及久病之后有上述证候者,慢性腹泻患者如慢性非特异性溃疡性结肠炎、慢性阿米巴痢疾,常在夜间肠蠕动增强促使患者醒来排便称“五更泄”。

[药物方剂]

1. 补气:可选用补气的药物如黄芪、党参、白术、红枣、炙甘草、淮山药等配合调气升提药物如枳壳、升麻、柴胡等。方剂:四君子汤,治脾气虚;生脉散,治肺气虚;补中益气汤,治中气不足而致的内脏下垂症。

2. 补血:选用补血药物如当归、熟地、何首乌、皂矾,配合补气;补阳的药物,如黄芪、党参、鹿角、紫河车等联合应用。方剂:四物汤、当归补血汤等。

3. 补阴:选用北沙参、麦冬、生地、元参、石斛、杞子、女贞子、龟板、鳖甲等。方剂:大补阴丸,左归饮。

4. 补阳:选用仙茅、仙灵脾、鹿茸、肉苁蓉、葫芦巴、阳起石、补骨脂、覆盆子、菟丝子、巴戟天。方剂:右归丸、金匱肾气丸。

运用补法首先要照顾脾胃,这是使用补法的一个关键,对实证或邪盛而又有虚象时禁用补法或纯补法,以防“误补益疾”或“因补留邪”。

补气

药物 黄芪 党参 白术 大枣 淮山药
枳壳 升麻 柴胡 炙甘草

方剂：四君子汤、补中益气汤



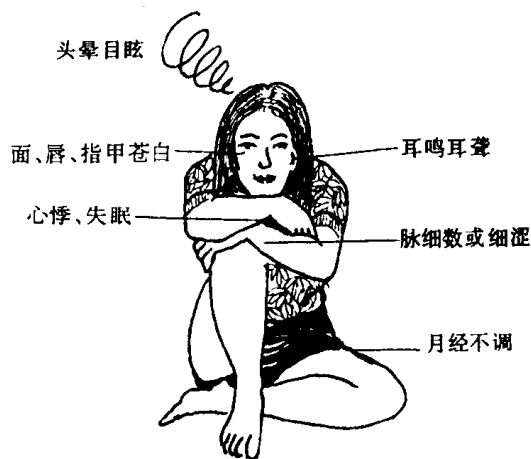
适用于：气虚证

肺气肿、神经衰弱、热性病恢复期
内脏下垂、溃疡病、脱肛

补血

药物 熟地 当归 芍药 首乌 枸杞 桑椹
阿胶 龙眼肉 黄芪 黄精 党参

方剂：四物汤、当归补血汤



适用于：各种原因血虚证

各种贫血、溃疡病出血、月经过多
痔出血、慢性肾炎贫血



补阳

药物 鹿茸 肉苁蓉 仙灵脾 葫芦巴 阳起石
补骨脂 覆盆子 菟丝子 巴戟天

方剂：右归丸、金匮肾气丸



适用于：阳虚证

阳萎、遗精、五更泄、一般衰弱及久病之后

补阴

药物 天冬 沙参 麦冬 石斛 女贞子
白芍 知母 龟板 鳖甲

方剂：大补阴丸
左归饮
六味地黄丸



适用于：阴虚病证

各种原因的脱水、消耗性疾病（结核病、糖尿病）、尿崩症

八、固 涩 法

虚证常见自汗、盗汗、久咳、久泻、脱肛、子宫脱垂、遗尿、遗精、崩漏、带下等症。中医认为汗，为心之液，心阳虚则自汗，心阴虚则盗汗。肺虚则久咳，大肠虚则久泻不止。肾藏精，肾合膀胱，肾虚，精关不固，则遗精、滑精、带下、白浊。膀胱不约则遗尿、失禁。肝藏血，肝虚血不归藏，则崩漏下血。这些症状，总称为滑脱症。在治疗上除酌情补虚外，宜运用收敛固涩作用的药物，以达涩滑固脱的方法，叫做固涩法。

[临床应用]

1. 固表敛汗：常用的敛汗药有浮小麦、五味子、煅牡蛎、麻黄根等，适用于自汗、盗汗等症。

① 成人的自汗，以气虚居多，以补气卫固为主，药物如黄芪、白术、党参、炙甘草等。方剂如玉屏风散等。② 儿童的自汗，以实证居多，治疗以滋阴降火为主，药物如生地、白芍、麦冬、五味子等。方剂如生脉散、导赤散配合应用。汗多有阴虚、阳虚的不同。③ 阴虚盗汗，以滋阴为主，如熟地、白芍、鳖甲、龟板、阿胶等，配浮小麦、麻黄根、糯稻根、稻豆衣、瘪桃干、煅牡蛎同用。方剂如当归六黄汤。④ 阳虚自汗，以补阳为主，选用附子、桂枝，配合白芍、龙骨、牡蛎。方剂如桂枝加龙骨牡蛎汤、二加龙骨汤等。

2. 敛肺止咳：适用于肺虚久咳、干咳无痰，咳痰不畅。药物如诃子、五味子、海蛤粉、川贝、百合、马兜铃等配合应用，以补肺润燥、敛肺止咳。方剂如宁咳丸、补肺阿胶汤等。

3. 涩肠止泻：适用于慢性腹泻、滑脱不禁、脱肛等。可选用药物如赤石脂、禹余粮、诃子、五味子、肉果、石榴皮，配合补益脾胃的药物同用。方剂如四神丸、桃花汤等。

4. 固精：适用于滑精和遗精。滑精、遗精有阴虚和阳虚之分。① 阴虚引起者，选用药物如黄柏、生地、天麦冬、党参、知母。方剂如三才封髓丹，取以滋阴固精。② 阳虚者选用肉桂、附子、党参、黄芪配伍。方剂如桂枝加龙骨牡蛎汤，取其助阳固精。

5. 缩尿：适用于肾和膀胱气虚，有小便清长、频数、遗尿、夜尿、尿失禁等，选用药物，如桑螵蛸、覆盆子、补骨脂、菟丝子、芡实、金樱子，配合益智仁、乌药、蚕茧等温肾涩尿药同用。方剂如桑螵蛸散、缩泉丸等。

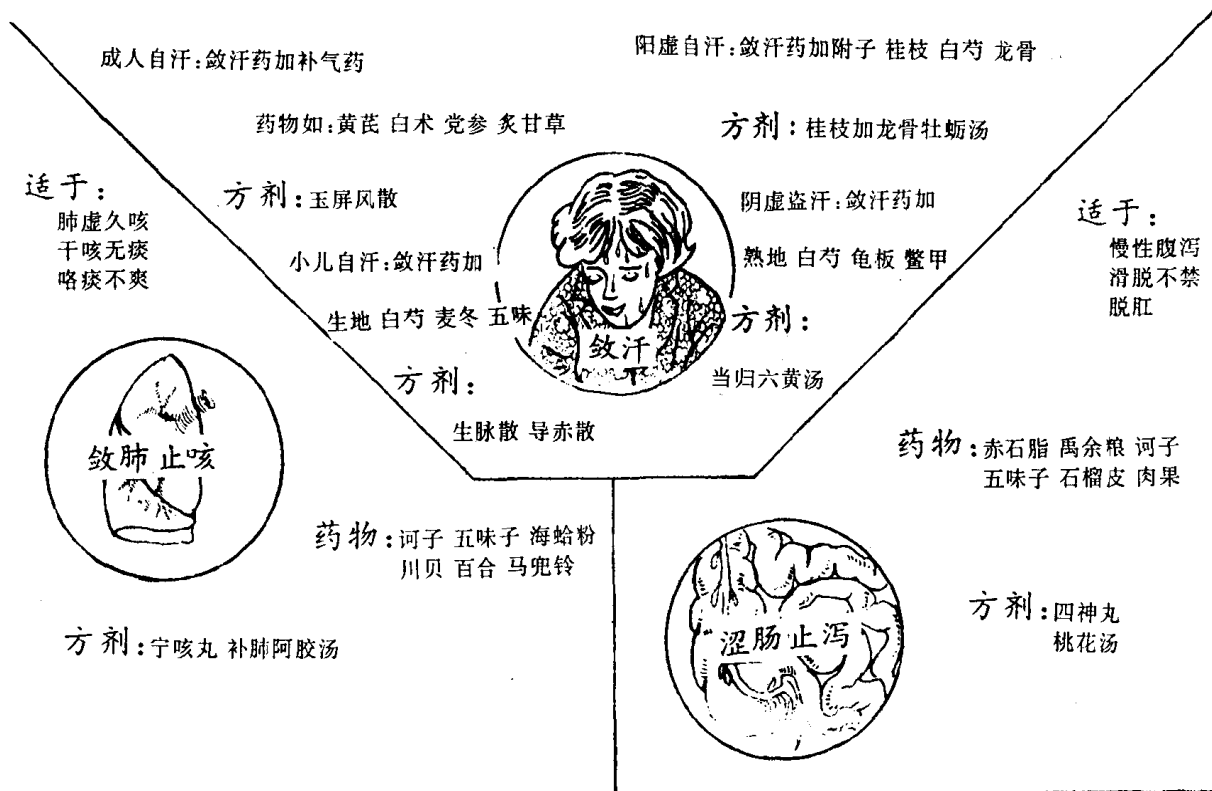
6. 固经：适用于月经过多、经期过长、色淡、淋漓不尽等。应选用补气止血药物配伍乌贼骨、牡蛎、椿根皮、石莲肉等固涩药。方剂如固经丸、升阳举经汤等以补气、养血固经。

7. 止带：适用于脾肾阳虚、白带过多等。一般除选用补益脾肾药物外，还须配伍止带固涩的药物如鹿角霜、石莲肉、鸡冠花、牡蛎、乌贼骨、莲须、芡实、菟丝子等。方剂如参苓白术丸、四乌贼骨一藟茹丸等。

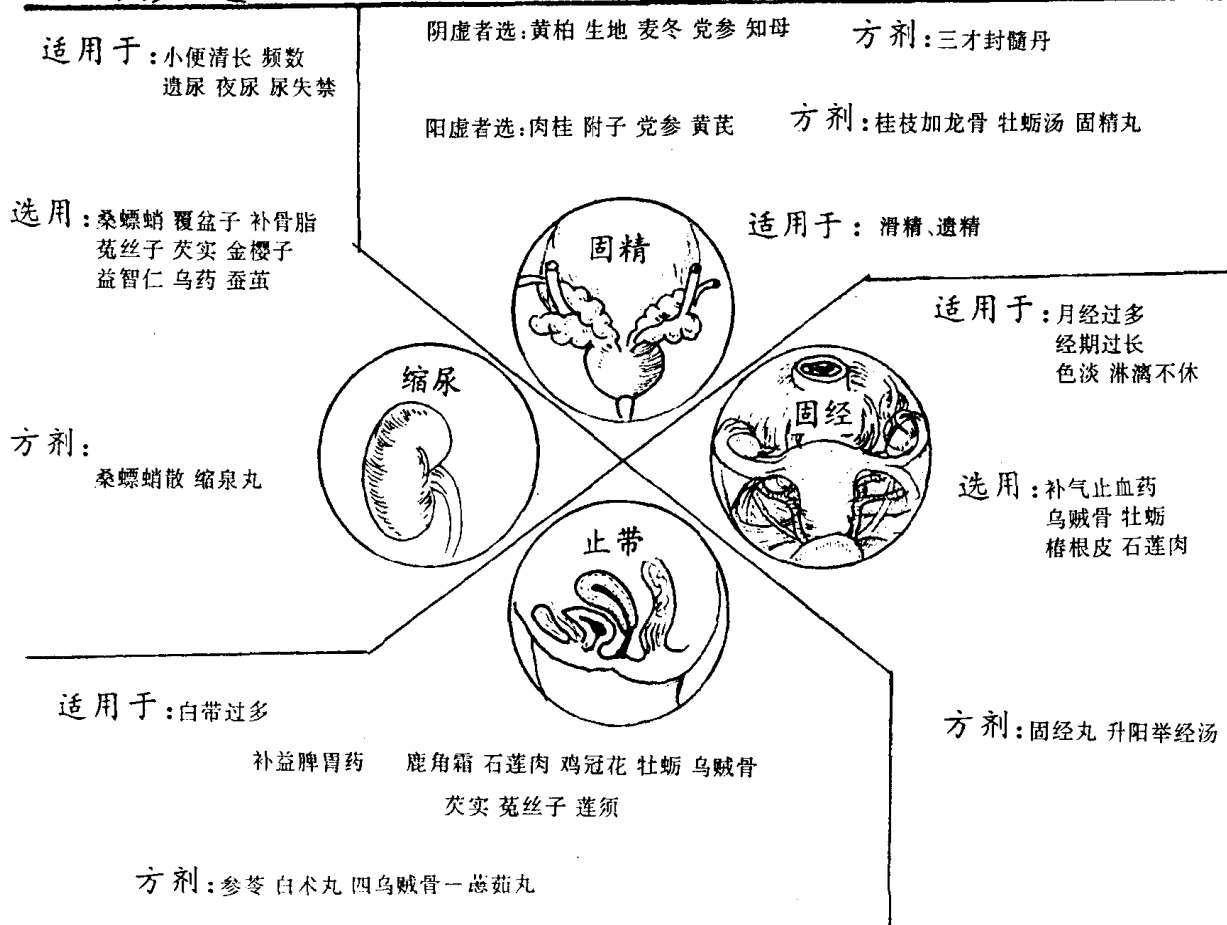
[注意事项]

1. 固涩法：主要是对症治疗，用于止汗、止咳、止泻等，因此，辨证时，须与治本药物配伍应用，才能达到标本兼治的目的。

2. 对有表证，或内有湿滞、热邪内郁，或湿热未尽的均勿应用，以免恋邪。



常用治法（八）固涩法



九、理 气 法

用行气、解郁、降气的方药来调理气分，舒畅气机，治疗气滞、气逆等病证的方法，称理气法。

气滞为气的运行发生停滞，究其原因，可由饮食不节、寒温失调所引起。痰饮、水湿、瘀血也可阻滞气机的流通。情志不畅，可引起肝郁气滞。气滞的症状以程度分：轻者为满，稍重者为胀，再重者为疼痛，更严重者为痞块。气滞轻者宜调和，流通不畅须“行气”，肝气郁结须“疏肝”，这些都是调气。

气逆是指脏腑气机上逆的意思，常见于有胃气上逆和肺气上逆。胃气和肺气均以下行为顺。出现气逆，须“降气”镇纳为主，气结成痞块，须“破气”，以上统称为理气。

〔临床应用〕

1. 行气：是针对气滞拟定的一种治疗法。适用于脾胃气阻引起的脘腹或脐周围的胀满、疼痛和肝郁气滞引起易发“脾气”、胸胁胀痛、乳房胀痛、小腹疼痛或痛连会阴部位、痛经等。选用药物有砂仁、香附、苏梗、陈皮、枳壳、青皮、厚朴、郁金、乌药。如脾胃气阻、胸膈满闷、噯气恶心者，可用越鞠丸，取其行气解郁、开胸止痛的作用。如肝胃气滞、经来腹痛、乳房胀痛、精神抑郁、胸闷泛恶、苔薄白、脉涩滞，可用加味乌药汤，取其行气止痛的作用；如七情郁结、痰涎凝聚、咽中梗阻、吞咽不利，其特点吞之不下，吐之不出，称为“梅核气”，可用半夏厚朴汤，或麦门冬汤，取其行气开郁、降逆化痰的作用。如大肠气阻、下腹胀满、大便秘结，可用小承气汤，取其行气宽肠、通便导滞的作用。

2. 降气：适用于胃气上逆所发生的恶心、呕吐、呃逆、噯气或肺失肃降引起的咳嗽、喘气证候。一般选用药物如半夏、苏子、旋覆花、代赭石、降香、沉香、陈皮、竹茹、乌药、槟榔等，如由痰浊内阻，胃气上逆引起噯气、呃逆、呕吐、中脘满闷，可用旋覆代赭汤，取其益胃降逆的作用。如中焦升降失司，胃气上逆，胸膈痞闷，甚或胀痛，可用四磨饮，取其补气降逆的作用。如痰浊渍肺，肺失肃降，喘咳气短，胸膈满闷，可用苏子降气汤。

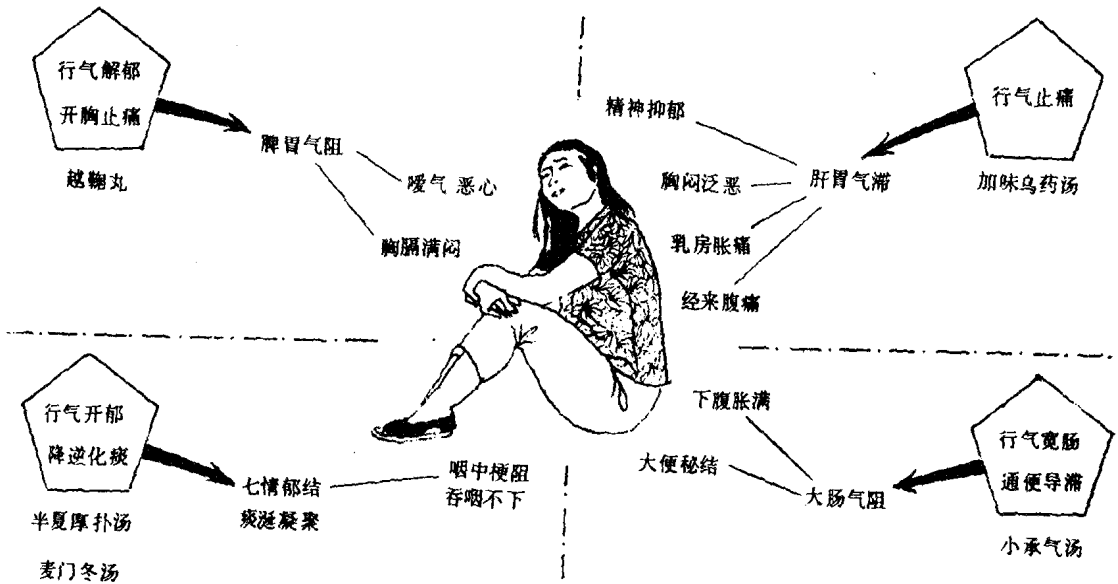
〔药物及注意事项〕

理气药的性味多数是温苦辛香。温药能祛寒邪。苦能燥湿，又能降逆。辛则开通气结，走而不守，降逆通滞。芳香能化浊通络。理气药大都具有舒畅气机、宽中解郁、行气止痛、降逆止呕，降气平喘、理气化痰的功效，兼有开胃健脾的作用。根据中医“气行则血行，气滞则血滞”的原理，一般对外伤痛、痛经等血分证，理气药常与活血药配伍使用。

1. 理气药多辛香走窜之品，易于耗伤阴液，不宜过量或持续使用。
2. 理气药煎煮不宜过久以免气味俱失影响药效。
3. 理气药与活血祛瘀药配伍，可加强行瘀之功效。
4. 理气药与补养药同用，可防因补而壅滞之虞。
5. 凡伤阴或气虚者慎用。
6. 凡降气、破气之品，体虚与孕妇慎用。

行气

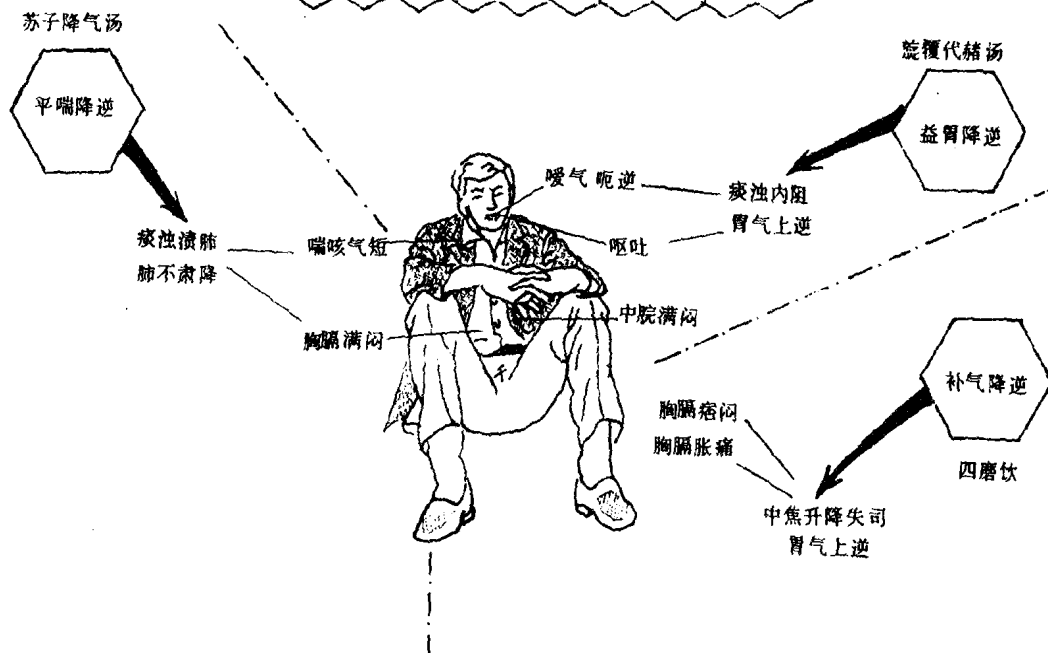
药物 砂仁 香附 苏梗 陈皮 枳壳 青皮 厚朴 郁金 乌药



常用治法(九)理气法

降气

药物 半夏 苏子 旋覆花 代赭石 降香 沉香 陈皮 竹茹 乌药 槟榔



十、利尿法

利尿法,也称利湿法,就是利用增加尿液排泄的药物,使湿邪从小便排出的治法,相当于西医的利尿剂。但这些中药除有利尿消除浮肿的作用外,还适于下焦的寒湿或湿热病证,如用于治疗黄疸、腹泻、白带和淋浊等多种证候。前人有“治湿不利其小便,非其治也”的说法,说明利湿法的重要性。根据药物的性质,利湿法可分甘淡渗湿(即淡渗利湿)和泻热通淋(清热利湿)两种。

[临床应用]

1. 甘淡渗湿:选用性味甘淡,具有渗湿的药物。其性不偏寒热,适用于一般的水湿内聚、尿量减少而引起的水肿病证:面目、四肢甚至全身浮肿,以下肢为甚,按之没指,尿少,可伴有腹胀满(腹水或胃肠瘀血)、腰酸痛(肾区压痛、叩击痛),或有心悸、气促、咳喘痰鸣(心肺症状)。它包括现代医学的以下水肿。① 心性水肿:临床见于各种心脏病(如风心病、肺心病、先心病)并发右心功能不全及慢性缩窄性心包炎。由于心衰和缩窄程度不同,浮肿由轻度踝部浮肿以至全身浮肿,可合并胸腔、腹腔、心包腔积水,诊断可根据病者有心脏病病史及颈静脉怒张、心杂音、肝肿大等体征确定。② 肾性水肿:临床见于急性、慢性肾炎、慢性肾盂肾炎、肾病综合征等。水肿早期见于眼睑、颜面,以后蔓延全身,伴有血压高、尿液改变(混浊尿、血尿、蛋白尿、管型尿)等表现。③ 肝性水肿:临床见于各种原因肝硬化(如门脉性肝硬化、血吸虫病性肝硬化、坏死后性肝硬化等)功能失代偿期,浮肿以腹水为主,下肢多呈轻度浮肿,常有腹壁静脉怒张、脾肿大以及肝功能异常表现。④ 营养不良性水肿:临床见于重症糖尿病、重症结核病及长期慢性腹泻所致吸收功能障碍,患者常先有极度消瘦,后出现浮肿,测定血浆蛋白可明确诊断。以上诸种不同原因水肿,均可酌用。

2. 泻热通淋:“淋者,欲尿而不能出,胀急痛甚;不欲尿而点滴淋漓”,指小便急迫、短、数、涩痛的病症。中医认为是因“湿热结聚、流注膀胱”或“肾虚气化无力”,临床见于泌尿系感染、结石、结核、前列腺炎等多种疾病,选用具有清热利湿、清除热邪以排除水湿的治法,也称清热利湿法。

[药物、方剂]

1. 甘淡渗湿:一般选用茯苓皮、桑白皮、大腹皮、冬瓜皮、通草、猪苓、玉米须等,配合通阳化气和健脾化湿的药物如桂枝、白术、陈皮、生姜皮等同用。方剂如五皮饮、五苓散。

2. 泻热通淋:一般选用药物如海金沙、木通、车前子、车前草、石韦、瞿麦、萆薢、滑石、金钱草等,配伍清热药如一见喜、蒲公英、金银花、黄柏等同用。方剂如八正散、萆薢分清饮等,取其泻热通淋的作用。

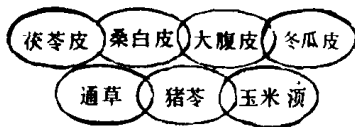
应用利尿法,应分析小便短少或小便不通的原因,如果属于肾阳虚弱、气化功能减退,当以温肾阳、利气化为主。

[注意事项]

1. 利湿药物与西药利尿剂相似能伤津伤阴,凡阴津不足及老幼体弱者慎用。
2. 利湿药物多有通利降泄作用,孕妇与遗精病人须慎用。

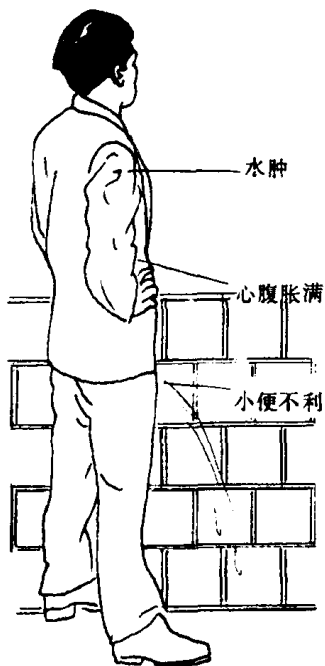
甘淡渗湿

选用：选用甘淡渗湿药

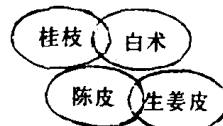


适用于：水湿内聚、尿量减少
所引起的水肿病证

心性、肾性、营养不良性水肿、肝硬化腹水



配合 通阳化气药
健脾化湿



方剂：五皮饮

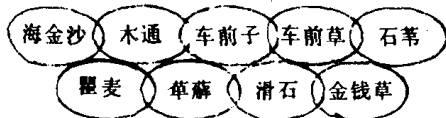
五苓散

常用治法(十)

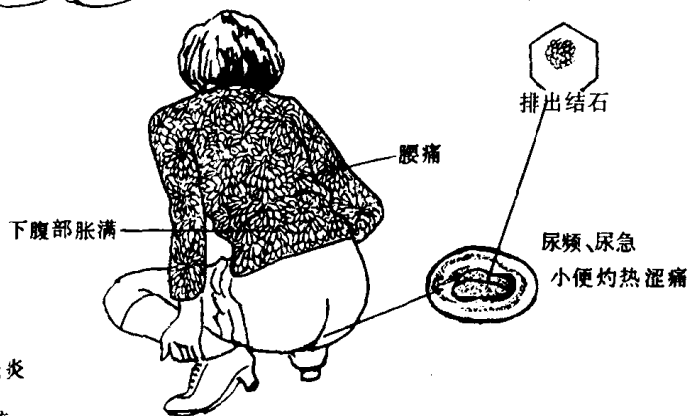
利尿法

泻热通淋

选用：选用清热利湿药



适用于：热淋、砂淋、石淋等证
急性肾炎、急性肾盂肾炎、膀胱炎
泌尿道结石、泌尿道结核



配合清热药



方剂：八正散

萆薢分清饮

十一、开 窍 法

开窍法,又称宣窍法,是用辛香走窜的药物以宣通开窍,治疗窍闭神昏的方法。中医学对神志昏迷分为脱证和闭证两种。凡中风昏倒后表现为“汗出如珠,口开目合,四肢厥冷,手撒尿遗”者为脱证,是阴阳相离,生命垂危的证候,不能用开窍法。凡中风昏倒,有“牙关紧闭,双手握固”者为闭证。开窍法就是针对此证以通窍开闭、苏醒神志的一种方法,相当于西医的咖啡因、可拉明类药物的作用,可促使患者从昏迷中苏醒过来。昏迷是脑功能的严重障碍,主要是大脑皮层和皮层下网状结构发生高度抑制的一种状态。从闭证的表现分析,可能属于轻度昏迷范畴。所谓“中风”,主要指内风,即具有眩晕、震颤、四肢麻木、抽风、角弓反张、中风不语、口眼歪斜等表现的病证,类似于自然界的风象,所以用“风”来命名。中风的闭证又有热闭和寒闭之分,所用的宣窍方药性质正好相反,如热闭用辛凉开窍药如牛黄、冰片、郁金香之类;寒闭用辛温开窍药,如麝香、苏合香、石菖蒲等。

[临床应用]

1. 热闭:所谓热闭是指热邪内陷心包,阻塞心窍或兼有肝风内动、风热内闭,即用于发热在前,神昏在后,同时伴有烦躁谵语、惊厥、四肢抽搐、脉数、舌质红绛、苔黄糙或芒刺焦黑。这类患者多半是骤起高热,体温在39℃以上,或高热不退。发病于冬春者多见于流行性脑脊髓膜炎、斑疹伤寒、回归热、大叶性肺炎等;发病于夏秋季者多见于乙型脑炎、脑干型脊髓灰质炎、脑型疟疾、中毒性菌痢、伤寒等。在高温或烈日下工作或跋涉而突然昏迷者,多考虑热射病和日射病(日射病有昏迷或惊厥,但体温正常或微升,按中医的辨证应列为寒闭)以及感染中毒性脑病(见于2~10岁儿童),见于急性感染早期或极期,系机体对感染毒素产生过敏反应所致,有高热、烦躁不安、谵妄惊厥、昏迷及病理反射等。脑部症状多在1~2天内消失。

2. 寒闭:由于寒邪或湿痰闭阻心窍,出现突然昏倒、牙关紧闭、苔白脉迟者为寒闭,昏迷前有经常头痛,或伴有呕吐者,应考虑脑占位病变。原有高血压、动脉硬化的老年人突然昏迷、痰涎上涌、牙关紧闭者,多是脑血管意外。原有肾脏病、肝脏病、糖尿病、癫痫病史随后出现烦躁不安、谵妄、扑翼样震颤、昏迷者,则为尿毒症性昏迷、肝性昏迷、糖尿病性昏迷及癫痫大发作等。

[药物与方剂]

1. 热闭:用凉开法。用辛凉宣窍的方药,如紫雪丹、至宝丹、安宫牛黄丸分别配合清热、解毒、凉血、化痰等药物同时使用。

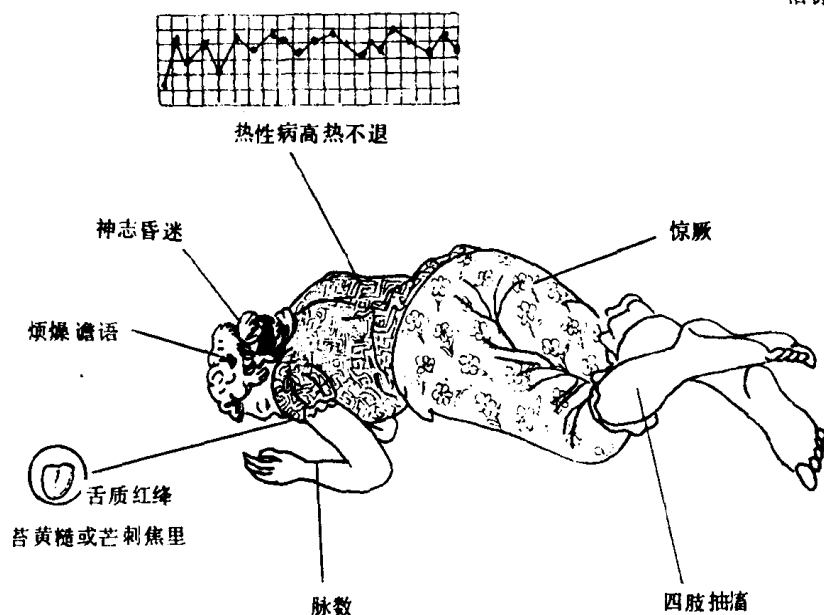
2. 寒闭:用温开法。用辛温开窍的方药,如苏合香丸、安宫牛黄丸、至宝丹等开窍,脑血管意外可配合竹沥、石菖蒲、郁金等化痰开窍。对日射病,可用通关散搐鼻取嚏,内服行军散,或玉枢丹、苏合香丸等治标。

[注意事项]

1. 开窍法只用于神志昏迷的闭证,不可用于脱症患者。开窍药芳香化燥易伤阴液,对温热病后期有阴液耗竭而至肝风内动,出现神昏痉厥,宜用滋阴熄风法治疗。

2. 开窍药走窜性强,易引起流产、早产,故孕妇慎用。

清热开窍



治标选用成药：

安宫牛黄丸 紫雪丹 至宝丹

须与治本药配伍

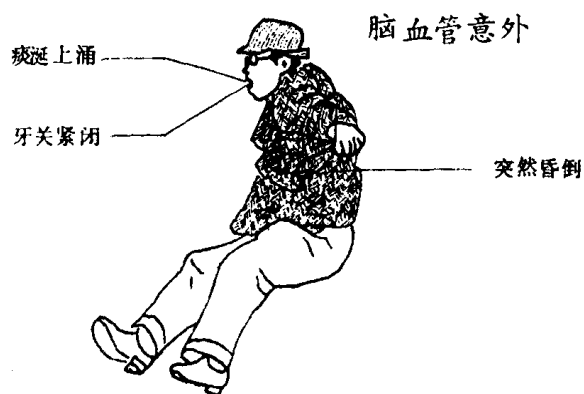
证见 流脑 乙脑 结脑

中毒性菌痢 脑型疟 金葡菌肺炎

败血症及其他热性病昏迷

常用治法(十一) 开窍法

芳香开窍



治标选用成药：

苏合香丸 安宫牛黄丸 至宝丹

配合竹沥 石菖蒲 郁金等，化痰开窍

中暑（暑犯心包）



十二、重镇摄纳法

重镇摄纳，是选用某些金石矿物或甲壳类的药物，取其有镇静、解痉、降逆作用的一种治疗方法。这类治法相当于现代医学的镇静催眠药和抗精神病的药物。镇静催眠药是对中枢神经系统产生抑制作用的药物，其抑制程度随药物剂量大小而异。小剂量产生镇静，能使病人的紧张、焦虑、烦躁、失眠等精神过度兴奋症状受到抑制，使其安静，并使睡眠得到改善。中等剂量产生催眠。大剂量具有抗惊厥作用。抗精神病药具有选择性抑制精神活动，能解除精神病患者的精神紊乱，有效地消除病人躁狂兴奋、妄想和幻觉，从而达到安神定志的效果。中医的重镇安神药物，如朱砂、磁石、珍珠、琥珀、龙骨、牡蛎、生铁落等药物除有上述西药的镇静、安神、止痉抗惊狂作用外，还分别具有多种药物效应，如解毒、敛汗、止泻、止痛、利尿纳肾气、平肝潜阳作用。平肝潜阳药物如石决明、代赭石、天麻、钩藤，除能减轻头痛、眩晕、手足震颤、抽搐外，尚有扩张周围血管、降压等多种药物作用，因而适用于癫狂、心神不安、肝阳上亢、肾不纳气、肝风内动，以及小儿惊风等病证，具体应用有镇惊安神、平肝潜阳、固肾纳气等三种。

〔临床应用〕

1. 镇惊安神：由于心气虚或心肾不交而致心神不宁，出现不同程度的大脑功能障碍，引起感知、思维等紊乱，出现情感失调、行为动作失常、幻觉妄想、意识紊乱等一系列精神失常，或大脑功能活动暂时性失调而出现多梦、失眠、心烦、心悸等表现，证见癫痫的精神运动性发作、精神分裂症、躁狂抑郁性精神病、更年期精神病、反应性精神病及神经官能症。

2. 平肝潜阳：由于肝肾阴虚而致的肝阳上亢出现的眩晕、头痛、烦热、手足震颤。适用于高血压病、美尼尔氏综合征、中风后遗症等，也适用于热性病高热、热极生风出现的神昏、惊厥、四肢抽搐等症候，如乙脑、流脑、破伤风、中毒性脑病有上述证候者。

3. 固肾纳气：适于肾不纳气，如慢性阻塞性肺气肿、老年性肺气肿患者，出现呼吸短促，动则加重，伴有自汗、面色苍白，或青晦发绀、四肢发冷，或真阳上越、面红升火、舌质淡而胖嫩、脉沉细等。

〔药物方剂〕

1. 镇惊安神：一般选用重镇安神的药物，如磁石、铅丹、朱砂、龙骨、龙齿、紫贝齿、牡蛎、珍珠母等配合补血养心或清热化痰药同用。方剂如磁珠丸、朱砂安神丸、柴胡加龙骨牡蛎汤等，取其清热降火、镇惊安神的作用。

2. 平肝潜阳：珍珠母、牡蛎、磁石、龙骨、龟板、鳖甲、紫贝齿等，配合平肝药物白芍、钩藤、菊花、桑椹子和滋阴降火药如生地、元参、麦冬、女贞子、夏枯草、丹皮、山栀等，以及解痉厥药物如蜈蚣、地龙、全蝎、僵蚕等同用。方剂如建瓴汤、天麻钩藤汤，热极生风可选用羚羊钩藤汤、止痉汤、撮风散。

3. 固肾纳气：一般用补肾阳为主的药物，配伍黑铅、磁石、紫石英等。方剂如黑锡丹，取其重镇降逆、固肾纳气的作用。

〔注意事项〕

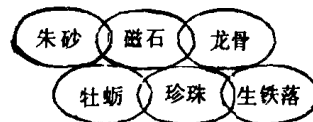
应用重镇摄纳法，对素体阳虚、脾湿久阻、胃纳不佳和孕妇等都应慎重，镇潜药物有沉降作用，凡有表证不宜用。

常用治法（十二）重镇摄纳法

镇静安神



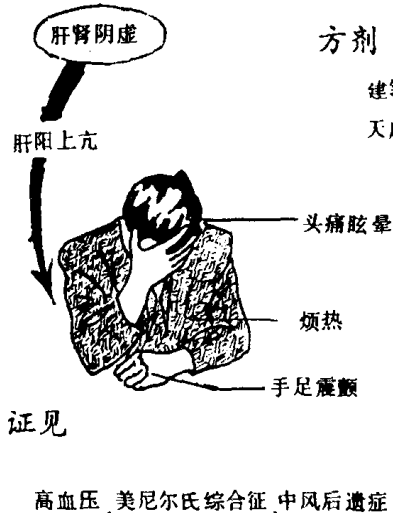
重镇安神药



配合 补血养心药
清热化痰药

方剂 磁珠丸
朱砂安神丸
柴胡加龙骨牡蛎汤

平肝潜阳



方剂

建瓴汤
天麻钩藤汤

热性病高热

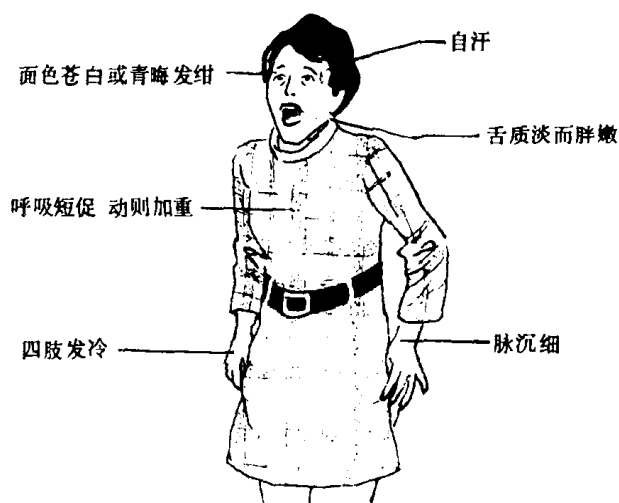
热极生风



方剂

羚羊钩藤汤
止痉散
撮风散

固肾纳气



选用补肾阳为主药物

加黑铅、磁石、紫石英

方剂 黑锡丹

证见 慢性阻塞性肺气肿、老年性肺气肿、
代偿性肺气肿、间质性肺气肿

内 容 提 要

本书为国内首次以图解形式来表达古老而深奥的中医学基础理论;用西医现代科学知识和理论来诠释中医学的阴阳、脏腑、精、神、气、血、津、液和病因、病理、辨证等富含哲理的中医术语及其理论;为架通中西医两大医学体系,作出了大胆的尝试。

本书的模式图,内涵丰富,一目了然,形象生动,易于记忆。文字说明,通俗易懂,概括性强。可供大中专医学院校师生和各级临床医护人员及广大中医药爱好者学习参考。

2J95/38

中医精髓图解

汤泰元 主编

责任编辑 马素卿

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号
邮政编码:100717

中国科学院武汉分院科技印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1997年8月第一版 开本:787×1092 1/16
1997年8月第一次印刷 印张:12 3/4
印数:1~3000 字数:300 000

ISBN 7-03-006011-3/R·309

定价:18.00元

1 0 0 0 0